



2021년도
사회복지사 교육교재



Contents

Part 01

노인장기요양보험제도의 이해 13

1. 도입배경과 제도변화 14

가. 도입배경 14

나. 「노인장기요양보험법」 제정과 제도변화 16

2. 2021년 주요 제도변경사항 안내 20

가. 가족상담 지원 사업 확대 운영 20

나. 급여제공 기준 및 가감산 제도 개편 20

다. 부당청구 가담종사자 급여제공제한 및 신고 포상금
지급기준 신설 21

3. 부당청구 예방 22

가. 부당청구의 개념 22

나. 「노인장기요양보험법」의 부당청구 등에 대한 처벌규정 22

다. 기타 부당청구 사례 24

라. 신고·포상금 제도 안내 25

4. 노인인권 및 노인학대 예방 26

가. 노인인권 26

나. 노인학대 27

Part 02

장기요양 사례관리와 한국형 케어매니지먼트 29

1. 노인과 노인문제 30

가. 노인의 정의 30

나. 고령화와 노인문제 30

다. 노인의 특성 32

2. 장기요양의 주요 개념과 영역 33

- 가. 장기요양의 기본 개념과 수급자 33
- 나. 장기요양 상태 및 인정 34
- 다. 장기요양 제공인력 35
- 라. 장기요양 인프라 및 서비스 35
- 마. 장기요양 이용지원과 사례관리 36
- 바. 장기요양 서비스의 질과 평가 37
- 사. 장기요양 관련 기타 개념 38

3. 사례관리의 기본 개념과 절차 40

- 가. 사례관리의 개념 및 특징 40
- 나. 사례관리의 구성요소 42
- 다. 사례관리 과정 43

4. 한국형 케어매니지먼트 47

- 가. 한국형 케어매니지먼트의 추진 배경 47
- 나. 한국형 케어매니지먼트의 개념 49
- 다. 공단 케어조정자와 사례관리자의 역할 50
- 라. 공단 케어조정자의 장기요양 이용지원 52
- 마. 기관 사례관리자의 업무 54

Part 03

장기요양기관 사례관리실무 기본 57

1. 초기면접단계 58

- 가. 초기면접의 개념 58
- 나. 초기면접의 경로 58
- 다. 초기면접의 기본원칙 59
- 라. 초기면접의 실제 60
- 마. 초기면접과 기록 63

Contents

2. 사정단계	67
가. 사정의 개념	67
나. 사정단계의 내용	67
다. 사정의 기본원칙	71
라. 장기요양의 욕구사정 내용	72
마. 사정의 실제	74
바. 사정단계와 기록	76
3. 계획수립단계	89
가. 계획수립의 이해	89
나. 계획수립의 실제	90
다. 계획수립과 기록	94
4. 실행단계	104
가. 실행의 이해	104
나. 실행의 실제	107
다. 실행단계와 기록	109
5. 평가 및 종결 단계	119
가. 평가 및 종결의 이해	119
나. 평가 및 종결단계의 실제	121
다. 평가 및 종결단계와 기록	124

Part 04

장기요양 사례관리 작성실습 133

1 사례관리 작성실습(Case1)	134
1. 사례 개요	134
2. 욕구사정기록지	136

가. 신체상태(ADL, IADL, 일상생활 수행능력)	136
나. 질병상태	137
다. 재활상태	139
라. 간호처치상태	139
마. 인지상태(인지기능저하, 정신상태, 감정, 문제행동 등)	139
바. 의사소통	140
사. 영양상태	141
아. 주거 상황	141
자. 가족 및 환경상태	142
차. 사회관계 및 사회적지지 실태	142
카. 공식적 자원 이용 현황	143
타. 수급자 및 보호자 개별 욕구	143
파. 총평	144
3. 장기요양급여 제공계획서	145
4. 사례회의기록지	147
5. 사례관리 모니터링 업무수행 일지(양식)	149
6. 사례관리 종결보고서(양식)	152
[2] 사례관리 작성실습(Case2)	155
1. 사례 개요	155
2. 욕구사정기록지	157
가. 신체상태(ADL, IADL, 일상생활 수행능력)	157
나. 질병상태	158
다. 재활상태	159
라. 간호처치상태	160
마. 인지상태(인지기능저하, 정신상태, 감정, 문제행동 등)	160

Contents

바. 의사소통	161
사. 영양상태	161
아. 주거 상황	162
자. 가족 및 환경상태	162
차. 사회관계 및 사회적지지 실태	163
카. 공식적 자원 이용 현황	163
타. 수급자 및 보호자 개별 욕구	164
파. 총평	164
3. 수급자의 생활상의 문제 또는 욕구 도출해보기	165
가. Case2의 상황(작성양식)	165
나. Case2의 보호자(가족 등)의 상황(작성양식)	167
다. Case2의 공식 및 비공식 지원의 이용상황(작성양식)	169
4. 수급자의 문제 및 요구를 생활욕구로 전환하기	171
가. Case2의 생활욕구 도출하기(작성양식)	171
나. 도출 생활욕구 중 우선순위가 높은 욕구를 3개 제시하고, 목표 수립하기(작성양식)	173
5. 장기요양급여 제공계획서	175
가. 장기요양급여 제공계획서(양식)	175
나. 장기요양급여 제공계획서(작성예시)	176
6. 사례회의기록지	178
가. 사례관리 회의록(양식)	178
나. 사례관리 회의록(작성예시)	179
7. 사례관리 모니터링 업무수행 일지(양식)	181
8. 사례관리 종결보고서	184
가. 사례관리 종결보고서(양식)	184
나. 사례관리 종결보고서(작성예시)	186

Part 05

장기요양 사례관리 심화과정①
(노인상담과 의사소통) 189

1. 노인상담의 이해 190

가. 노인상담의 개념 및 필요성 190

나. 노인의 특성 190

2. 노인상담과정 192

가. 관계형성단계 192

나. 사정단계 192

다. 중재단계 193

라. 종결단계 193

3. 의사소통기술 194

가. 언어적 의사소통 194

나. 비언어적 의사소통 195

4. 효과적 의사소통을 위한 실제 196

가. 어르신들과 의사소통 시 관심을 전달하는 방법 6가지 196

나. 의사소통 기법 적절히 사용 196

다. 의사소통 기본원리 적용 196

라. 의사소통 개선방법 197

마. 나의 의사소통기술 198

5. 치매노인과의 의사소통 200

가. 치매노인과의 의사소통 특성 200

나. 치매노인과의 의사소통 기술 201

다. 치매노인 의사소통 기본원칙 201

Contents

Part 06

장기요양 사례관리 심화과정② (자원개발의 이해와 활용) 205

1. 자원개발의 필요성 206

2. 지역사회자원의 종류 206

3. 지역사회자원 개발 208

가. 지역사회자원 개발 208

나. 자원동원의 3가지 방식 208

다. 지역사회 자원개발의 과정 209

라. 발굴된 자원의 목록화 210

4. 지역사회연계를 위한 네트워킹 211

가. 지역사회자원 네트워크의 등장 211

나. 개념과 중요성 211

다. 네트워킹 과정 213

5. 지역사회자원의 관리 217

참고문헌 218

표 목차

〈표 1- 1〉 인구구성 변화 전망	14
〈표 1- 2〉 치매환자수와 유병률	14
〈표 1- 3〉 노인만성질환 진단현황	15
〈표 1- 4〉 노인(65세 이상)의 가치관 변화	15
〈표 1- 5〉 1인 가구 및 독거노인 비율	16
〈표 1- 6〉 노인장기요양보험 도입과 주요 변화	19
〈표 1- 7〉 가족상담 지원 사업 내용	20
〈표 1- 8〉 가족상담 지원 사업 운영센터	20
〈표 1- 9〉 노인을 위한 유엔원칙	26
〈표 1-10〉 「노인복지법」에 규정된 금지행위	27
〈표 1-11〉 노인학대의 유형별 정의	27
〈표 1-12〉 「노인복지법」 제39조의6의 노인학대 신고의무와 절차	28
〈표 2- 1〉 노화의 3가지 영역(Breen, 1976)	30
〈표 2- 2〉 기대수명 및 건강수명	31
〈표 2- 3〉 장기요양의 개념적 특성 및 실천적 함의	33
〈표 2- 4〉 등급판정 기준	35
〈표 2- 5〉 재가급여 종류	36
〈표 2- 6〉 사례관리 주요 정의	40
〈표 2- 7〉 학자에 따른 사례관리 과정 분류	46
〈표 2- 8〉 제2차 장기요양기본계획(정책목표 2)	48
〈표 2- 9〉 사례관리 실천과정	55
〈표 3- 1〉 초기면접지(예시)	66
〈표 3- 2〉 욕구의 영역	69
〈표 3- 3〉 노인에게 대한 사정의 6가지 영역	70
〈표 3- 4〉 내부 장애물의 유형	71
〈표 3- 5〉 사정기록지(예시 1)	79

Contents

〈표 3- 6〉 사정기록지(예시 2)	81
〈표 3- 7〉 사정기록지(예시 3)	86
〈표 3- 8〉 사례회의의 세부적인 운영절차	92
〈표 3- 9〉 장기요양급여 제공 계획서(방문요양, 방문목욕, 방문간호)	96
〈표 3-10〉 장기요양급여 제공 계획서(작성예시)	97
〈표 3-11〉 사례회의 기록지 양식(예시 1)	98
〈표 3-12〉 사례회의 기록지 양식(예시 2)	99
〈표 3-13〉 사례회의 기록지 양식(예시 3)	100
〈표 3-14〉 서비스제공계획 및 점검표(예시)	102
〈표 3-15〉 실행단계에서 사례관리자가 견지하여야 할 관점	107
〈표 3-16〉 점검에 따른 모니터링 결과	109
〈표 3-17〉 과정기록의 예시	110
〈표 3-18〉 요약기록의 예시	111
〈표 3-19〉 장기요양급여 제공기록지(방문요양)	112
〈표 3-20〉 사례관리 서비스 진행일지 양식(예시)	113
〈표 3-21〉 사례관리 상담일지 양식(예시)	114
〈표 3-22〉 사례관리 모니터링 양식(예시)	115
〈표 3-23〉 사례관리 과정 기록지(예시)	116
〈표 3-24〉 타 기관 서비스 의뢰서(예시)	117
〈표 3-25〉 성과평가의 내용 및 기준	120
〈표 3-26〉 평가의 구조	122
〈표 3-27〉 사례관리 만족도 평가(예시)	126
〈표 3-28〉 사례관리 종결보고서(예시)	127
〈표 3-29〉 급여제공평가(예시)	128
〈표 3-30〉 사례관리종결 및 평가기록지(예시 1)	129
〈표 3-31〉 사례관리종결 및 평가기록지(예시 2)	130
〈표 5- 1〉 관심을 전달하는 6가지 방법	196
〈표 5- 2〉 의사소통 기법	196
〈표 5- 3〉 의사소통 예시	196

〈표 5- 4〉 의사소통 개선방법(예시)	197
〈표 5- 5〉 의사소통기술 척도	198
〈표 5- 6〉 치매노인과의 의사소통 기술(예시)	201
〈표 5- 7〉 치매노인과의 의사소통 원칙	201
〈표 6- 1〉 노인욕구별 필요한 자원	207
〈표 6- 2〉 지역사회 활용 및 강화방식	209
〈표 6- 3〉 지역주민 설득방식	209
〈표 6- 4〉 집단활동 동기부여방식	209
〈표 6- 5〉 지역사회자원 목록표(예시)	210
〈표 6- 6〉 네트워크 찾기(예시)	214
〈표 6- 7〉 지역사회자원관리 주요내용	217
〈표 6- 8〉 지역사회 내 주요기관 역할	217
〈표 6- 9〉 지역사회자원 발굴 및 관리방법	217

Contents

그림 목차

[그림 2- 1] 80세 이상 노인 인구비율의 증가 전망	31
[그림 2- 2] 노인의 특성	32
[그림 2- 3] 장기요양인정 및 이용절차	34
[그림 2- 4] 등급판정 절차	34
[그림 2- 5] 장기요양인정점수 구간별 장기요양인정등급	34
[그림 2- 6] 노인장기요양보험제도의 사례관리 운영체계(안)	37
[그림 2- 7] 탈시설화와 지역사회, 정상화의 흐름	38
[그림 2- 8] 사례관리의 개념	41
[그림 2- 9] 사례관리의 구성요소(한국사례관리학회)	42
[그림 2-10] 사례관리의 일반적 과정	43
[그림 2-11] 한국형 사례관리체계의 이미지	50
[그림 2-12] 장기요양 사례관리의 기본 절차 및 내용	51
[그림 2-13] 상담관리와 사례관리	54
[그림 2-14] 기관 사례관리 운영체계(방문요양)	54
[그림 3- 1] 초기면접에서 수급자와 상담자의 앉는 각도와 거리	61
[그림 3- 2] 사정의 3가지 영역	68
[그림 3- 2] 매슬로우(Maslow)의 욕구단계설	69
[그림 3- 4] 가계도 및 생태도 양식사용(예시)	77
[그림 3- 5] 가계도와 생태도의 상징들	77
[그림 3- 6] 인생 및 하루기록표(예시)	78
[그림 3- 7] 국제장애분류(ICIDH) 이미지	90
[그림 3- 8] 국제기능·장애·건강분류의 구성 요소들의 상호작용	90
[그림 3- 9] 상태의 진행에 따른 케어 시점의 변화	92
[그림 3-10] 우선순위 설정	94
[그림 3-11] 실행단계의 참여 주체와 실천내용 및 기술	104
[그림 6- 1] 네트워크가 중요한 이유	213

제 1 장



노인장기요양 보험제도의 이해

1. 도입배경과 제도변화	14
2. 2021년 주요 제도변경사항 안내	20
3. 부당청구 예방	22
4. 노인인권 및 노인학대 예방	26



01

노인장기요양보험제도의 이해

학습목표

- 노인장기요양보험의 도입배경과 주요 제도변화를 파악한다.
- 장기요양 부당청구의 개념을 이해하고 사례를 통해 부당청구를 예방한다.
- 노인인권과 노인학대의 내용을 파악하고 장기요양현장에 적용할 수 있다.

1

도입배경과 제도변화

가. 도입배경

- 1) 인구고령화
- 우리나라는 인구고령화로 노인인구가 지속적으로 증가하여 장기요양서비스 제공의 필요성이 증가하였다. 2021년 6월 기준 65세 이상 노인인구는 865만 명으로 전체인구의 16.7%이지만, 불과 약 10년 후 2030년에는 1,297만 명으로 500만 명 가까이 증가할 전망이다. 특히, 건강상태가 악화되어 장기요양서비스 수급자가 될 가능성이 높은 80세 이상 노인인구도 2021년 204만 명에서 2030년 297만 명으로 급격히 증가할 것으로 추계된다.

● 표 1-1 인구구성 변화 전망 (단위: 명)

구 분	2021년 6월	2030년	2040년	2050년	2060년
전체인구	51,672,400	51,926,953	50,855,376	47,744,500	42,837,900
65세 이상 (구성비)	8,652,198 (16.7%)	12,979,573 (25.0%)	17,223,537 (33.9%)	19,007,129 (39.8%)	18,814,555 (43.9%)
80세 이상 (구성비)	2,048,477 (4.0%)	2,976,932 (5.7%)	5,170,804 (10.2%)	7,457,393 (15.6%)	8,221,386 (19.2%)

※ 자료: 국가통계포털(<http://kosis.kr>). 장래인구추계(2021.4.5.반출), 주민등록인구(2021.8.6.반출)

- 2) 치매노인 증가와 노인건강 악화
- 장기요양 5등급과 인지지원등급 수급자가 될 가능성이 있는 치매환자가 급격히 증가하고 있다. 2018년 65세 이상 치매환자수는 75만 명(10.15%)이었으나 2021년 87만 명(10.21%)으로 증가하였고 2030년에는 136만 명(10.48%)에 이를 것으로 예상된다.

● 표 1-2 치매환자수와 유병률 (단위: 명, %)

구 분	치매환자 수(65세 이상)	치매 유병률
2021년	871,329	10.21
2030년	1,360,864	10.48
2040년	2,173,089	12.62
2050년	3,023,404	15.91
2060년	3,325,602	17.68
2065년	3,303,415	17.79

※ 자료: 보건복지부, 중앙치매센터(www.nid.or.kr), 치매현황(2021.4.5.반출)

2017년 노인실태조사에서 노인만성질환(의사진단 기준)을 파악한 결과 89.5%가 만성질환을 진단받은 것으로 나타났으며, 평균 2.7개를 가지고 있었다. 질병 개수별로는 51%가 3개 이상 만성질환을 가지고 있고, 가구형태별로는 ‘독거노인’, 기능상태별로는 ‘기능상태에 제한’이 있는 경우 만성질환 진단율이 높았다.

● 표 1-3 노인만성질환 진단현황

(단위: %)

구 분		존재여부		질병 개수별			평 균 (개)
		없 음	있 음	1 개	2 개	3개 이상	
전 체		10.5	89.5	16.5	22.0	51.0	2.7
성 별	남 자	14.6	85.3	21.2	23.5	40.6	2.3
	여 자	7.4	92.5	13.0	20.9	58.6	3.0
가구형태별	독거노인	6.5	93.4	11.0	20.6	61.8	3.2
	노인부부	11.0	89.0	19.5	23.2	46.3	2.5
	자녀동거	12.8	87.1	15.3	21.6	50.2	2.6
	기 타	13.7	86.3	20.8	18.9	46.6	2.6
기능상태별	제한없음	12.7	87.4	18.9	23.5	45.0	2.5
	제한있음	3.5	96.6	9.0	17.4	70.2	3.6

※ 주: 2017년 전국노인실태조사 재분석

※ 자료: 보건복지부, 보건사회연구원 전국노인실태조사 2017년

3) 노인부양 가치관의 변화

전통적으로 가족은 노인을 보호하는 역할을 수행해 왔지만 가족규모의 감소 및 자녀와의 동거율 감소 등은 사적 부양 가능성을 저하시키고, 공적 보호서비스의 필요성을 높이고 있다. 합계출산율은 2000년 1.48명에서 2010년 1.226명으로 감소하였고, 2018년에는 0.977명까지 감소하여 자녀동거와 사적 부양 가능성은 크게 감소할 전망이다.

비공식 보호와 공식 보호서비스 이용에 대한 노인의 태도변화도 매우 크다. 노인실태조사에 따르면 ‘노년기에 자녀동거가 필요하다’고 생각하는 비율이 2004년 26.6%에서 2017년 15.2%로 낮아졌다. 경제적인 노후생활비 마련과 관련해서도 ‘스스로’ 34%, ‘본인과 국가(사회보장제도)’ 33.7%로 높은 비율을 보이고 있으며, ‘가족 및 자녀’라는 응답은 급감하여 7.6%에 불과하였다.

● 표 1-4 노인(65세 이상)의 가치관 변화

(단위: %)

구 분	2004년	2014년	2017년
노년기 자녀 동거 필요	26.6	19.1	15.2
선호하는 노후생활비 마련방법			
스스로	40.2	31.9	34.0
가족 및 자녀	18.7	7.9	7.6
본인과 자녀	-	6.9	10.2
국가(사회보장제도)	40.9	18.6	14.1
본인과 국가(사회보장제도)	-	34.3	33.7
기 타	0.2	0.5	0.4

※ 주: 각 연도 전국노인실태조사 재분석

※ 자료: 보건복지부, 보건사회연구원 전국노인실태조사 각 연도

한편, 전체 가구 중 독거노인가구의 비율도 2000년 약 54만 가구 3.8%에서 2019년 153만 가구 7.5%로 증가하였다. 독거노인가구의 증가로 자녀동거와 가족돌봄의 가능성은 더욱 감소하고 있다.

● 표 1-5 1인 가구 및 독거노인 비율

(단위: 가구, %)

구 분	2000년	2005년	2010년	2015년	2019년
65세 이상 독거가구 수	542,690	782,708	1,066,365	1,223,169	1,532,847
독거노인가구비율	3.8	4.9	6.1	6.4	7.5

※ 자료: 국가통계포털(<http://kosis.kr>, 2021.4.5. 반출)

나. 「노인장기요양보험법」 제정과 제도변화

1) 노인의 간병, 장기요양문제를 사회연대원리에 입각하여 정부와 사회가 공동으로 해결하기 위하여 사회보험방식으로 노인장기요양보험제도를 도입하게 되었다. 이를 통하여 노인의 노후생활안정을 도모하고 그 가족의 부양부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하고자 하였다. 「노인장기요양보험법」 제1조는 법의 목적을 ‘고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인등에게 제공하는 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여에 관한 사항을 규정하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하도록 함을 목적으로 한다’고 규정하고 있다.

급격한 인구고령화로 노인돌봄의 문제가 심각해지고 있는 상황에서 사회보험제도인 노인장기요양보험의 도입으로 국민 모두가 노인의 건강상태나 가족환경, 경제수준에 관계없이 노인돌봄의 문제를 미리 준비할 수 있게 되었다. 아울러 노인장기요양보험은 개인과 가족의 노인돌봄 부담을 사회·국가적 부담으로 전환시켰다.

2) 노인장기요양보험제도는 2007년 4월 「노인장기요양보험법」 제정으로 2008년 7월 1일부터 시행되었으며 법 시행 이후 주요 변화를 살펴보면 다음과 같다. 2009년 차상위대상자와 저소득 대상자에게 장기요양급여 본인부담금의 100분의 50을 감경할 수 있는 법적 근거를 마련하였고, 도서·벽지·농어촌 등 일정지역에 거주하는 자에 대하여 별도 기준을 적용함으로써 해당 지역에 거주하는 수급자의 경제적 부담을 완화하였다.

3) 2010년 3월 장기요양기관의 장에게 노인장기요양급여 제공자료 기록·관리업무를 부여하였고, 국민건강보험공단이 직접 장기요양기관을 설치·운영할 수 있는 근거를 마련하였으며, 이에 근거하여 2014년 11월 서울요양원을 개원하였다.

4) 2013년 8월 장기요양기관 운영질서를 확립하고 장기요양기관에 대한 관리를 강화하기 위하여 장기요양기관 등의 본인부담금을 면제·할인하는 행위 등을 금지하였다. 또한, 장기요양기관이 거짓으로 급여청구를 한 경우 위반사실을 공표할 수 있도록 하며 행정제재처분의 효과가 양수인, 합병 후의 법인 또는 폐업 후 같은 장소에서 장기요양기관을 운영하는 직계혈족 등에게 승계하도록 하였다.

5) 2014년 7월 경증치매노인을 위한 장기요양 5등급이 신설되었으며, 2015년 12월 기타재가 급여의 복지용구가 일상생활·신체활동 지원위주로 되어 있어서 기타재가급여의 범위에 치매노인의 인지기능의 유지·향상을 위한 복지용구를 추가하고, 장기요양기관의 휴업·폐업 또는 지정취소 등의 경우 서비스 중단에 따른 수급자의 불편이 있으므로, 장기요양기관 휴·폐업 등의 경우에 수급자

권익보호조치를 하도록 의무화하였다. 또한, 장기요양기관이 전국적으로는 어느 정도 확충되어 있지만 농어촌이나 도서벽지 등 취약지역에는 충분한 장기요양기관 확보가 어려워 지역 간 서비스 편차가 발생하고 있으므로 공단의 장기요양기관 설치 시 노인인구 및 지역특성을 감안한 지역 간 불균형 해소를 고려하도록 하고, 장기요양기관의 투명한 운영을 위해 장기요양기관 설치자의 결격 사유를 신설하는 등 장기요양기관의 개설·운영에 대한 요건을 강화하였다.

- 6) 2016년 5월 장기요양기관의 투명한 회계운영을 위해 장기요양기관 재무·회계기준을 마련하되 사회복지시설인 장기요양기관의 경우는 「사회복지사업법」에 따른 재무·회계기준을 따르도록 하고, 국가 및 지방자치단체의 책무로 장기요양요원의 처우개선 및 복지증진을 위해 노력하도록 규정하고 장기요양기본계획에 장기요양요원 처우에 관한 사항을 포함하도록 하며, 장기요양사업의 실태 파악을 위해 3년 마다 실태조사를 실시하도록 하였다. 아울러 장기요양기관이 지급받은 장기요양 급여비용 중 일부를 장기요양요원의 인건비로 지출하도록 하고, 지방자치단체가 장기요양요원의 권리보호를 위한 장기요양요원지원센터를 설치·운영할 수 있도록 하였다.
- 7) 2016년 7월 치매전담형 장기요양기관을 도입하였고, 2017년 1월 수급자 수가 15명 이상인 방문 요양기관은 사회복지사를 의무적으로 배치하도록 하였다.
- 8) 2018년 1월 장기요양 인지지원등급을 신설하여 주야간보호(8시간) 월 12회 이용 등 장기 요양서비스를 이용할 수 있도록 하였다. 가정에서 치매노인을 돌보는 가족의 휴식을 지원하기 위해 도입된 치매가족휴가제는 기존에는 '망상이나 폭력 등 문제 행동이 있는 치매 수급자'만 이용할 수 있었지만, 2018년 1월부터는 치매 수급자라면 누구나 제도를 이용할 수 있게 문턱을 낮추었으며, 종일 방문요양 제공기관을 방문요양과 방문간호를 제공하는 기관에서 방문요양과 방문간호, 주·야간보호, 단기보호를 제공하는 기관으로 확대하여 기관 부족으로 이용에 어려움을 겪지 않도록 하였다.
- 9) 2018년 3월 노인 학대를 예방하고 노인 인권을 제고할 수 있도록 장기요양기관의 설치·운영자 및 그 종사자, 수급자에 대하여 인권교육을 실시하도록 하였으며, 과징금 제재처분의 실효성을 확보하기 위하여 과징금 상한금액을 5천만 원에서 2억 원으로 상향 조정하였다.
- 10) 2018년 7월부터 본인일부부담금 감경대상을 확대하여 중위소득 50%(보험료 순위 25% 이하) 까지 50%를 감경하던 것을 중전 대상 보험료 순위 25% 이하는 60%까지 감경하고 보험료 순위 25% 초과 50% 이하는 40% 감경하도록 하였다. 또한, 최초로 장기요양 등급을 받은 1~5 등급 치매수급자는 월 한도액에 관계없이 치매전문교육을 이수한 간호인력이 가정을 직접 방문 건강관리, 치매돌봄 정보제공 등의 간호서비스를 제공받을 수 있게 되었다. 이 간호서비스는 등급을 받고 60일 이내에 최대 4회(월 2회)까지 이용할 수 있는데 대상이 되는 치매수급자는 의사소견서에 치매상태가 있거나 최근 2년 이내 치매진료 내역이 있는 경우이다. 이용자 본인부담 없이 국민건강보험공단이 전액 부담하며, 방문간호서비스 이용을 위해서는 의료기관에서 방문간호지시서를 발급받아야 한다.
- 11) 2018년 12월 재가급여를 제공하는 장기요양기관에 대한 지정의제 제도를 폐지하고 「노인복지법」상 재가노인복지시설로 인정받은 시설만 재가급여를 제공하는 장기요양기관으로 지정받을 수 있도록 하여 현행법상 장기요양기관에 대한 인정 제도를 지정제로 단일화하고, 장기요양기관 지정의 유효기간을 6년으로 설정하여 유효기간이 도과하기 전에 지정기준 재심사를 통해 지정을

갱신받도록 하였다. 또한, 장기요양기관이 수급자와 계약을 체결할 때 개인별장기요양이용계획서*를 바탕으로 장기요양급여 제공 계획서를 작성하여 국민건강보험공단에 통보하도록 함으로써 개인별장기요양이용계획서의 실효성을 강화하고, 장기요양요원에 대한 급여외행위 제공 금지 규정을 법률로 상향하고 이에 관한 제재 및 고충 처리 규정을 신설하여 장기요양요원을 효과적으로 보호하고자 하였다.

(* 「노인장기요양보험법」 [제17777호, 2020.12.29.] 개정에 의하여 2021.6.30.부터 '표준장기요양이용계획서'가 '개인별장기요양이용계획서'로 명칭 변경됨)

- 12) 2019년 1월부터 종일 방문요양의 1회 최소 제공시간을 12시간으로 조정하고, 2회 연속 서비스가 가능하도록 하여 본인부담액을 낮추고 필요한 때 원하는 만큼 나누어 서비스를 이용할 수 있도록 개선하였다. 또한 국민건강보험공단의 업무에 '수급자의 가족에 대한 정보제공·안내·상담 등 장기요양급여 관련 이용지원에 관한 사항'을 추가하였다.
- 13) 2019년 4월 장기요양인정 신청 등을 직접 수행할 수 없는 치매환자를 위하여 치매안심센터장이 신청을 대리할 수 있도록 하고, 장기요양기관 폐업 또는 지정취소 등의 경우 해당 장기요양기관을 이용하는 수급자가 다른 장기요양기관을 선택하여 이용할 수 있도록 하고, 수급자가 부담한 비용 중 정산하여야 할 비용을 정산하도록 하여 수급자 권익보호조치를 강화하였다.
- 14) 2019년 8월부터 통합재가급여 예비사업을 운영하고 있다. 통합재가급여사업은 방문요양 위주의 분절적 재가서비스 제공 구조에서 이용자 중심의 통합적 서비스 제공체제로 전환하는 것을 목적으로 한다. 이는 고령사회 진입에 따른 장기요양 수급자의 생활 및 욕구특성 변화에 대응하여 지속적인 재가생활을 지원하기 위함이다.
- 15) 2019년 12월 국민건강보험공단이 거짓이나 부정한 방법, 고의 또는 위법 행위로 장기요양 인정을 받은 자에 대해 직권으로 재조사를 할 수 있게 된다. 그동안은 장기요양 등급을 인정받은 경우 본인이 신청하지 않으면 등급을 조정할 수 없어 부정 인정자에 대해 직권으로 재조사를 할 수 없었다. 하지만 직권 재조사를 통한 재판정으로 등급을 조정할 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 재조사를 거부하면 장기요양급여가 제한되고, 부정 인정자로 최종 확인되면 부정한 방법으로 등급 인정 시부터 소급해 급여비용에 상당하는 금액을 환수할 수 있다.
 - 가) 2019.12.12.부터 거짓이나 부정한 방법, 고의 또는 위법행위로 장기요양 인정을 받은 경우 직권 재조사 실시
 - 나) 재조사를 거부할 경우 장기요양급여가 제한되며, 부정 인정자로 확인될 경우 부정한 방법으로 등급인정 시부터 소급하여 그 급여비용에 상당하는 금액 환수 진행
- 16) 2020년 3월 장기요양급여비용을 부정청구한 장기요양기관이 위반사실을 숨기기 위하여 행정조사를 기피하는 행위를 방지하고, 장기요양급여비용 부정청구·부정수급에 대한 제재의 실효성을 높이기 위하여 장기요양급여를 받고 있거나 받을 수 있는 자가 장기요양기관이 부정한 방법으로 장기요양급여비용을 받는 데에 가담한 경우 급여를 중단하거나 1년의 범위에서 횡수 또는 제공기간을 제한할 수 있도록 하였으며, 장기요양기관의 부당청구 또는 자료제출 거부로 지정 취소 등의 처분이 확정된 경우 위반사실 등의 공표를 의무화 하고, 장기요양기관이 정당한 사유 없이 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 질문·검사를 거부·방해·기피하는 경우 장기요양급여비용의 지급을 보류할 수 있도록 하였다.

17) 2020년 7월, 장기요양 수급자의 잦은 갱신에 따른 불편을 해소하기 위해 장기요양인정 유효기간을 1년에서 2년으로 연장하였다. 이는 심신상태가 회복되기 어려운 장기요양 수급자의 특성을 반영하여 제도를 개선·보완한 것이다.

18) 2020년 12월 수급자의 심신 기능상태 및 장기요양욕구, 급여종류 등을 작성하는 양식인 표준장기요양이용계획서의 명칭을 목적에 맞게 개인별장기요양이용계획서로 변경하였고, 장기요양기관의 지정 심사 시 검토 대상인 행정처분 내용의 범위와 대상을 확대하였으며, 장기요양기관에서 부정하게 급여비용을 청구한 경우 벌칙규정을 마련하여 부정 청구 제재의 실효성을 강화하였다.

● 표 1-6 노인장기요양보험 도입과 주요 변화

구 분	주요내용
2007. 4.	「노인장기요양보험법」(법률 제8403호)제정
2008. 7.	노인장기요양보험제도 실시
2009. 5.	도시·벽지·농어촌 등 일정 지역에 거주하는 자 감경조치 근거 마련
2010. 3.	장기요양기관의 장에게 급여제공자료 기록·관리 업무 부여 공단의 장기요양기관 설치·운영 근거 마련
2013. 8.	장기요양기관 본인부담금 면제·할인행위 금지와 행정제재처분 효과의 승계
2014. 7.	장기요양 5등급을 시행(장기요양등급체계 개편 3등급 → 5등급으로 전환)
2015. 12.	장기요양기관 휴·폐업시 수급자 권익보호조치 의무화 지역특성을 감안한 장기요양기관의 설치 고려 노력 장기요양기관 설치자의 결격사유 신설
2016. 5.	장기요양기관의 회계운영의 투명성 강화 장기요양요원의 처우개선 노력과 장기요양사업 실태조사 규정
2016. 7.	치매전담형 장기요양기관 도입
2017. 1.	수급자수 15명 이상인 방문요양기관 사회복지사 의무 배치
2018. 1.	장기요양 인지지원등급 신설 치매가족휴가제 이용 수급자 및 기관 확대
2018. 3.	장기요양기관 종사자 등에 대한 인권교육 실시 규정 본인부담금 감경 확대 규정 마련
2018. 7.	본인부담금 감경 대상 확대 최초 장기요양 등급인정 치매수급자 방문간호 서비스 제공(월 한도액 외)
2018. 12.	장기요양기관 지정제 단일화 및 지정 갱신제 도입 장기요양요원의 급여외행위 제공금지 규정
2019. 1.	공단업무에 '수급자의 가족에 대한 정보제공·안내·상담 등 장기요양급여 관련 이용지원에 관한 사항'을 추가
2019. 4.	장기요양기관 폐업 또는 지정취소 등의 경우 수급자가 다른 기관을 선택해 이동할 수 있도록 하는 등 권익보호 조치 강화
2019. 8.	방문요양·목욕·간호·주야간보호 서비스 통합재가급여 예비사업운영(본 사업 시행 전까지)
2019. 12.	거짓이나 부정한 방법, 고의 또는 위법행위로 장기요양 인정을 받은 경우 직권 재조사 실시
2020. 3.	부당청구 가담자에 대한 급여제한 신설, 지정취소등 위반사실 공표 의무화 자료제출거부 및 질문·검사 거부·방해·기피 시 장기요양급여비용 지급 보류 신설
2020. 7.	심신상태가 회복되기 어려운 수급자의 잦은 갱신 절차 불편을 해소하기 위하여 장기요양인정 유효기간을 1년에서 2년으로 연장
2020. 12.	표준장기요양이용계획서를 개인별장기요양이용계획서로 변경 장기요양기관 지정심사 시 행정처분 내용의 범위와 대상 확대, 부당청구 시 벌칙 신설

2 2021년 주요 제도변경사항 안내

가. 가족상담 지원 사업 확대 운영

- 1) 노인장기요양보험 재가급여 수급자 어르신 가족들의 부양부담 완화를 위한 상담 등 서비스 제공사업으로, 1:1 심리상담 및 지역사회자원연계 등 다차원적 프로그램을 제공하는 사업이다.

● 표 1-7 가족상담 지원 사업 내용

	개별상담(6회)	집단활동(4회)
10주 프로그램	돌봄익히기, 스트레스 다루기, 나의 건강 챙기기 등 심리·정서적 부담 감소를 위한 맞춤형 상담 ※ 6회 이수 완료 시, 자조모임 3회 지원	다른 가족들과 함께 원예·미술 활동, 응급처치 등을 배우며, 서로 공감하고 힘을 주는 활동

※ 2020년 가족상담 지원사업 만족도 조사 결과, 응답자 중 91.7% 만족, 94.5% 타인에게 추천의향 있음

2021년 가족상담 지원 사업 확대 운영에 따라, 기존 60개 사업 운영센터에서 65개로 확대 운영이 이루어진다.

● 표 1-8 가족상담 지원 사업 운영센터

지역본부	사업 운영센터(65개)
서울강원(11)	강서, 양천, 노원, 관악, 성북, 중랑, 송파, 원주, 은평, 춘천, 동작
부산경남(6)	부산중부, 부산남부, 부산진구, 부산동래, 창원마산, 사천
대구경북(8)	대구달서, 경주, 대구동부, 대구북부, 대구수성, 대구중부, 포항남부, 달성
호남제주(12)	광주동부, 익산, 광주서부, 군산, 광주북부, 여수, 전주남부, 전주북부, 제주, 남원, 나주, 해남
대전충청(9)	대전동부, 대전서부, 대전중부, 청주서부, 청주동부, 천안, 예산, 당진, 논산
인천경기(19)	고양일산, 용인서부, 남양주, 안양, 부천북부, 인천부평, 수원서부, 인천미추홀구, 인천남동, 고양덕양, 의정부, 안산, 평택, 파주, 화성, 수원동부, 인천계양, 부천남부, 김포

- 2) 재가기관은 가족상담 지원 프로그램을 신청하거나 희망하는 대상자에 대해 가족상담 희망자 통보서를 작성하여 팩스로 관할 운영센터에 통보하면 공단의 선정조사를 거쳐 가족상담 지원서비스를 받을 수 있다.

나. 급여제공 기준 및 가감산 제도 개편

- 주야간보호 월한도액 추가 산정률
 - (기존) 50% ⇒ (변경) 20%로 축소
 - 월한도액 추가산정기준이 (기존) 1일 8시간, 월 20일 이용에서 (변경) 1일 8시간, 월 15일 이용으로 변경
- 방문요양 및 방문간호 오후가산(18:00~22:00) 20% 폐지
- 방문요양 및 방문간호 유급휴일(일요일 제외), 근로자의 날 급여비용 가산을 인상
 - (기존) 30% ⇒ (변경) 50%로 인상

다. 부당청구 가담종사자 급여제공제한 및 신고 포상금 지급기준 신설

공단은 노인장기요양보험 재정 누수를 방지하고 올바른 수급질서를 확립하기 위하여 부당한 방법으로 장기요양급여비용을 청구한 장기요양기관을 신고할 경우 포상금을 지급하고 있다. 이에 따라 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가급여비용 또는 시설급여비용을 청구하는 행위에 가담한 장기요양 종사자는 12개월 범위의 급여제공 제한 및 300만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

또한 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 장기요양급여를 받거나 다른 사람이 장기요양급여를 받도록 한 사람을 신고한 경우의 포상금 지급기준을 신설하여 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하도록 하였다.

3 부당청구 예방

가. 부당청구의 개념

- 1) 노인장기요양보험에 앞서, 국민건강보험은 '부당청구'의 개념을 광의의 개념으로 보아 '허위청구', '과잉청구', '착오청구'를 포괄하는 개념으로 보고 있다. 이는 단순히 악의나 고의가 아닌 단순 착오로 발생하는 문제도 '부당'으로 간주하고 있다. 국민의 보험료와 국가부담 등으로 조성된 재원의 누수에 있어서 고의성의 문제가 중요하지는 않은 것이다.

「노인장기요양보험법」 제43조에서 언급한 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 비용을 청구하여 지급받은 경우라 함은 장기요양급여비용을 지급받기 위하여 허위자료를 제출하거나 허위사실을 적극적으로 은폐할 것을 요하는 것은 아니고, 관련 법령에 의하여 장기요양급여비용으로 지급 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 이를 청구하여 지급받는 행위를 모두 포함하므로 실제로 요양보호사로 볼 수 없는 인력을 요양보호사로 기재하여 장기요양급여비용을 지급받은 경우에도 거짓이나 부정한 방법에 해당하는 것으로 본다(서울행정법원 판례).

- 2) 미국 보건부의 「부당청구정보법」에서는 '부당청구'를 기록오류(Errors)와 과잉진료(Waste), 남용(Abuse), 부정청구(Fraud)로 규정하고 기록오류를 포함하고 있어서 기록오류와 같은 착오의 문제도 부당한 것으로 판단하고 있다(김옥 외, 2013).

나. 「노인장기요양보험법」의 부당청구 등에 대한 처벌규정

- 1) 장기요양기관의 부당청구 등에 대한 처벌규정

법 제43조는 부당이득의 징수 대상으로 등급판정의 결과 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 장기요양인정을 받은 경우, 고의로 사고를 발생하도록 하거나 본인의 위법행위에 기인하여 장기요양인정을 받은 경우, 월 한도액 범위를 초과하여 장기요양급여를 받은 경우, 장기요양급여의 제한 등을 받을 자가 장기요양급여를 받은 경우, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가 및 시설 급여비용을 청구하여 이를 지급받은 경우, 그 밖에 이 법상의 원인 없이 공단으로부터 장기요양급여를 받거나 장기요양급여비용을 지급받은 경우로 규정하고 있다.

- (벌칙 등) 법 제67조에 장기요양기관의 급여비용 부정청구에 대한 벌칙규정이 신설되어 2021년 6월 30일부터는 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 장기요양급여비용을 청구한자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있게 되었고, 2020년 10월부터 장기요양기관이 지정취소 등 대상이 되거나 과징금 부과 대상으로 확정된 경우에는 해당 장기요양기관은 공표대상이 되었다.

- (지정의 취소 등) 법 제37조에 장기요양기관 지정의 취소 등을 언급하고 있다. 구체적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우, 급여 외 행위(수급자의 가족만을 위한 행위, 수급자 또는 그 가족의 생업을 지원하는 행위, 그 밖에 수급자의 일상생활에 지장이 없는 행위)를 제공한 경우, 지정기준에 적합하지 아니한 경우, 장기요양기관 지정의 결격사유에 해당하는 자가 지정받은 경우, 정당한 사유 없이 장기요양급여를 거부한 경우, 본인부담금을 면제하거나 감경하는 행위를 한 경우가 있다.

또한 수급자를 소개, 알선 또는 유인하는 행위 및 이를 조장하는 행위를 한 경우, 장기요양요원에게 급여외행위의 제공을 요구하는 행위, 수급자가 부담하여야 할 본인부담금의 전부 또는 일부를 부담하도록 요구하는 행위, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가 및 시설 급여

여비용을 청구한 경우, 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 자료제출을 한 경우나 질문 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 거짓으로 답변한 경우가 있다.

2) 장기요양기관의 현지조사의 거부 등에 관한 처벌규정

- 보건복지부장관 및 시·도지사, 시·군·구청장은 법 제61조에 따라 장기요양사업 전반을 관리·감독하고, 청구의 적절성을 확인하기 위하여 현지조사를 수행하고 있으며 장기요양기관이 정당한 사유없이 현지조사를 거부하거나 방해 또는 기피하는 경우 업무정지 6개월을 명할 수 있다.
- 또한, 지급보류에 관한 규정이 법 제38조에 신설되어 2020년 10월부터 공단은 장기요양기관이 정당한 사유없이 자료제출명령에 따르지 않거나 조사를 거부·방해하는 경우 급여비용 지급을 보류할 수 있게 되었다.
- 한편, 현지조사를 거부하는 기관에 대해 500만 원 이하의 과태료를 부과하던 것을 2020년 10월부터는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 벌칙을 상향하였고, 자료제출 거부 등의 이유로 지정취소 등의 처분이 확정된 기관이 공표대상에 포함되었다.(보건복지부 및 지방자치단체 홈페이지, 노인장기요양보험 홈페이지 공표).

「노인장기요양보험법」 제37조제1항제5호, 제61조제2항, 「행정조사기본법」 제10조, 제11조 및 제17조의 규정에 따라 자료의 제출, 관계인에게 질문 또는 관계서류를 검사할 수 있으며, 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 거짓으로 답변한 경우 장기요양기관의 지정의 취소 등 및 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제29조와 관련 행정처분의 기준에 근거하여 현지조사 거부기관에 대한 행정처분 등 수행함

3) 수급자가 부당청구 등에 가담한 경우(장기요양급여의 제한)

- 법 제29조는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 장기요양인정을 받은 경우, 고의로 사고를 발생하도록 하거나 본인의 위법행위에 기인하여 장기요양인정을 받은 경우 등 공단이 장기요양급여의 전부 또는 일부를 제공하지 아니하게 할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 수급자가 장기요양기관이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 장기요양급여비용을 받는 데에 가담한 경우 장기요양급여를 중단하거나 1년의 범위에서 장기요양급여의 횟수 또는 제공기간을 제한하는 규정이 2020년 10월부터 시행되고 있다.

4) 종사자가 부당청구 등에 가담한 경우 등(장기요양급여 제공의 제한)

법 제37조에 종사자 등이 수급자의 신체에 폭행을 가하거나 상해를 입히는 행위, 수급자에게 성적 수치심을 주는 성폭행, 성희롱 등의 행위, 자신의 보호·감독을 받는 수급자를 유기하거나 의식주를 포함한 기본적 보호 및 치료를 소홀히 하는 방임행위, 수급자를 위하여 증여 또는 급여된 금품을 그 목적 외의 용도에 사용하는 행위, 폭언, 협박, 위협 등으로 수급자의 정신건강에 해를 끼치는 정서적 학대행위 등 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우, 업무정지기간 중에 장기요양급여를 제공한 경우 등도 포함된다.

- (처분 등)장기요양기관의 종사자가 부당청구에 가담한 경우 해당 종사자에게는 다음과 같은 처분이 이루어지고 급여제공 제한기간 동안에 장기요양급여를 제공하고 비용을 청구한 경우 해당 급여비용은 환수 될 수 있다.

「노인장기요양보험법」 제37조의5(장기요양급여 제공의 제한) 제69조(과태료) 장기요양기관의 종사자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 장기요양급여비용을 청구하는 행위에 가담한 경우 해당 종사자가 장기요양급여를 제공하는 것을 1년의 범위에서 제한하는 처분과 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

- (부당청구 가담종사자 급여제공제한 범위) 장기요양급여제공 제한처분을 받은 종사자는 급여 제공제한 기간 중 처분 받은 당시 장기요양기관 뿐 아니라 재직중인 전 장기요양기관에서 처분 받을 당시 직종을 포함한 모든 직종(시설장, 조리원, 위생원, 관리인, 사무원 등)으로 「노인장기요양보험법」 제23조(장기요양급여의 종류)에 따른 장기요양급여를 제공할 수 없다.

부당청구 가담종사자의 정의

- ① 종사자가 장기요양급여제공자료*를 거짓 작성하는 경우
※ 장기요양급여제공자료: 급여제공기록지, RFID 태그 등
- ② 종사자가 장기요양급여제공자료를 거짓 작성하도록 지시하는 경우
- ③ 종사자가 장기요양급여제공자료를 근거로 거짓 청구하는 등 청구담당자로 부당청구 하는 경우
- ④ 그 밖에 부당청구행위에 가담한 경우라고 판단되는 경우

다. 기타 부당청구 사례

노인장기요양보험에 있어서 확인되는 부당청구 다빈도 사례는 다음과 같다. 장기요양 종사자 등은 업무수행에 있어서 이를 유념하여 부당청구가 발생하지 않도록 서비스를 제공하여야 한다.

1) 인력추가배치 가산기준 위반 청구 사례(사회복지사)

- G재가기관은 사회복지사를 배치하고 사회복지사가 수급자 가정을 매월 1회 이상 급여 제공 시간 중에 방문하지 않았음에도, 급여제공시간에 방문하여 업무를 수행한 것으로 사실과 다르게 업무수행일지를 작성하고 급여비용을 가산하여 청구함

2) 부당청구 공모(담합) 사례

- H재가기관의 요양보호사와 수급자는 2018.9월~2019.9월까지 총 12개월 동안 방문 요양을 제공하지 않는 조건으로 월 10만 원씩 지급받기로 담합하고 허위로 청구함

3) 고의로 서비스제공시간 증량 청구 사례

- I재가기관은 2017.5월~10월, 2018.4월~2019.12월까지 총 29개월 동안 요양보호사가 작성한 급여제공기록지의 제공시간과 다르게 급여제공기록지를 임의 변경하여 늘려서 작성하고 청구함

4) 가족인 요양보호사가 직업에 종사하면서 서비스 제공 후 청구사례

- J재가기관의 요양보호사는 2017.8월~2019.6월까지 23개월 동안 타 재가기관의 시설장(관리 책임자)으로 상근하면서 월 160시간이상 근무하였음에도 수급자 1명에 대하여 가족인 요양보호사로 방문요양서비스 급여비용 청구

※ 「노인장기요양보험법」 시행규칙 제32조, 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 등에 따라 수급자의 가족인 요양보호사가 일정한 직업에 종사하면서 수급자에게 급여를 제공한 경우에는 장기요양급여비용을 산정할 수 없음

5) 본인부담금 면제 사례

- K재가기관은 2019.5월~2019.10월까지 총 6개월 동안 수급자 4명에 대해 본인부담금을 전액 면제하였고, 수급자 1명에 대해서는 매월 일정액의 본인부담금이 발생 하였음에도 정액으로 매월 3만 원씩 수납하여 본인부담금을 감경

※ 「노인장기요양보험법」 제35조에 따라, 장기요양기관은 영리를 목적으로 수급자가 부담하는 본인부담금을 면제·감경하는 행위를 하여서는 아니 됨

6) 무자격자 서비스 제공 후 타인으로 청구 사례

- L재가기관은 2018.12월~2019.11월까지 총 12개월 동안 요양보호사 자격이 없는 인력 1명이 방문요양서비스를 제공한 후 자격이 있는 타 요양보호사 명의로 허위 등록하고 급여 비용을 청구

※ 「노인복지법」 제39조의2에 따라 노인복지시설의 설치·운영자는 노인 등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 전문적으로 수행하는 요양보호사를 두어야 함

7) 비밀누설의 금지 위반 사례

- M복지용구사업소는 복지용구를 수급자에게 제공하기 위하여 인근의 다수(N재가기관 등 9개소) 재가기관에서 등급을 인정받은 수급자 정보를 불법적으로 제공받아 복지용구를 제공함

※ 「노인장기요양보험법」 제62조, 「개인정보보호법」 제59조제2호에 따라, 장기요양기관에 종사하고 있거나 종사한 자는 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위를 하여서는 아니 되며, 제공받는 자 또한 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인정보를 제공받는 행위를 하여서는 아니 됨

8) 부당청구 가담종사자 급여제공제한 처분 사례

- C사회복지사는 실제 서비스 제공하지 않고 서비스를 제공한 것처럼 D요양보호사 몰래 D요양보호사 이름으로 급여제공기록지를 허위작성하고 급여비용을 청구하여 6개월 동안 장기요양급여 제공제한 처분을 받고 과태료 100만 원 처분을 받음
- E요양보호사가 각각 다른 지자체 관할 장기요양기관 두 개소에 소속되어 실제 서비스는 제공하지 않고 제공한 것처럼 부당청구하도록 자격증을 빌려준 대가를 지급받는 등 부당청구에 적극 가담하여 지자체별 각각 장기요양급여제공제한 6개월 처분 및 과태료 100만 원 처분을 받음
- F요양보호사가 주 2일만 서비스 제공하고, 나머지 3일은 서비스를 제공하지 않고 태그를 떼어 소지하고 다니면서 요양보호사 본인 집에서 태그전송 후 급여비용 청구하게 하여 장기요양급여제공제한 6개월 처분 및 과태료 100만 원 처분을 받음

라. 신고·포상금 제도 안내

- 1) 장기요양급여 받은 내용 신고·포상금 제도: 『장기요양급여 받은 내용 통보서』를 받은 수급자 본인 또는 그 배우자 및 직계 존·비속이 장기요양급여 받은 내용 불일치로 신고한 내용을 확인하여 장기요양기관에서 부당하게 급여비용을 청구한 사실이 확인되어 환수결정이 된 경우 최고 5백만 원을 지급한다.
 - 2) 부당청구 장기요양기관 신고·포상금 제도: 전 국민 누구나 장기요양급여비용 부당청구와 관련된 모든 유형에 대하여 신고가 가능하다. 포상금은 내부종사자는 최고 2억 원, 수급자 또는 그 가족/일반인은 최고 5백만 원이다.
 - 3) 신고방법
 - 가) 방문·우편: 국민건강보험공단 전국지사(운영센터), 지역본부, 본부 접수
 - 나) 인터넷
 - 노인장기요양보험 홈페이지(www.longtermcare.or.kr)/민원상담실/포상금제도안내
 - 「The건강보험」 모바일앱 고객센터/ 신고센터/ 부당청구장기요양기관신고
- ※ 인터넷 신고는 실명/익명 신고 가능하며, 익명신고는 포상금을 지급하지 않음
- 담당자 출장방문 접수

4 노인인권 및 노인학대 예방

가. 노인인권

노인인권이란 노인이 인간답게 살아갈 권리를 의미한다. 세계인권선언에서는 ‘모든 인간은 태어날 때부터 자유롭고, 존엄성과 권리에 있어서 평등하다’고 하였다. 다른 인권의 주체와 같이 노인 역시 존엄성과 권리에 있어서 평등하며, 자기 삶의 주체로 살아갈 자격이 있는 것이다.

1991년 12월 유엔총회를 통해 노인인권의 근간이 되는 ‘노인을 위한 유엔원칙’이 결의되었다. 노인 권리보장을 위해 정부가 관련 사업을 운영하는데 있어 반영해야 할 의무와 원칙을 ‘독립, 참여, 돌봄, 자아실현, 존엄성’이라는 5개 군 18개 항목으로 구성하였으며, 특히 돌봄과 존엄성의 원칙을 통해 학대방지를 제시하였다.

● 표 1-9 노인을 위한 유엔원칙

독립 (Independence)

1. 소득, 가족과 지역사회 지원 및 자조를 통하여 적절한 식량, 물, 주거, 의복 및 건강보호에 접근할 수 있어야 한다.
2. 일을 할 수 있는 기회를 제공받거나, 다른 소득을 얻을 수 있는 기회에 접근할 수 있어야 한다.
3. 직장에서의 언제 어떻게 그만둘 것인지에 대한 결정에 참여할 수 있어야 한다.
4. 적절한 교육과 훈련 프로그램에 접근할 수 있어야 한다.
5. 개인의 선호와 변화하는 능력에 맞추어 안전하고 적응할 수 있는 환경에서 살 수 있어야 한다.
6. 가능한 오랫동안 가정에서 살 수 있어야 한다.

참여 (Participation)

1. 사회에 통합되어야 하며, 그들의 복지에 직접 영향을 미치는 정책의 형성과 이행에 적극적으로 참여하고, 그들의 지식과 기술을 젊은 세대와 함께 공유하여야 한다.
2. 지역사회 봉사를 위한 기회를 찾고 개발하여야 하며, 그들의 흥미와 능력에 알맞은 자원봉사자로서 봉사할 수 있어야 한다.
3. 노인들을 위한 사회운동과 단체를 형성할 수 있어야 한다.

돌봄 (Care)

1. 각 사회의 문화적 가치체계에 따라 가족과 지역사회의 보살핌과 보호를 받아야 한다.
2. 신체적, 정신적, 정서적 안녕의 최저 수준을 유지하거나 되찾도록 도와주고 질병을 예방하거나 그 시작을 지연시키는 건강보호에 접근할 수 있어야 한다.
3. 그들의 자율과 보호를 고양시키는 사회적 법률적인 서비스에 접근할 수 있어야 한다.
4. 인간적이고 안전한 환경에서 보호, 재활, 사회적 정신적 격려를 제공하는 적정 수준의 시설보호를 이용할 수 있어야 한다.
5. 그들이 보호시설이나 치료시설에서 거주할 때도 그들의 존엄, 신념, 욕구와 사생활을 존중받으며, 자신들의 건강보호와 삶의 질을 결정하는 권리를 존중받는 것을 포함하는 인간의 권리와 기본적인 자유를 향유할 수 있어야 한다.

자아실현 (Self-fulfillment)

1. 자신들의 잠재력을 완전히 발전시키기 위한 기회를 추구하여야 한다.
2. 사회의 교육적, 문화적, 정신적 그리고 여가에 관한 자원에 접근할 수 있어야 한다.

존엄성 (Dignity)

1. 존엄과 안전 속에서 살 수 있어야 하며, 착취와 육체적 정신적 학대로부터 자유로워야 한다.
2. 나이, 성별, 인종이나 민족적인 배경, 장애나 여타 지위에 상관없이 공정하게 대우받아야 하며 그들의 경제적 기여와 관계없이 평가되어야 한다.

UN은 1999년을 ‘세계 노인의 해’로 정하여 전 세계적으로 노인에 대한 관심을 촉구하였고, 2002년 스페인 마드리드에서 개최된 제2차 UN 세계고령화총회에서 마드리드 국제고령화행동계획 (MIPAA)이

채택되었다. MIPAA에서는 선진국뿐 아니라 개발도상국 내 고령화와 노인의 권리에도 눈을 돌리고, 안전과 존엄이 보장된 노후를 위한 시민권 및 지속적 사회참여 보장원칙을 제시하였다.

나. 노인학대

1) 노인학대의 정의 및 금지행위

「노인복지법」 제1조의2제4호에 노인학대를 ‘노인에 대해 신체적·정신적·정서적·성적 폭력 및 경제적 착취 또는 가혹 행위를 하거나 유기 또는 방임을 하는 것’으로 정의하고 있다. 아울러 「노인복지법」 제39조의9 각호에 금지행위를 다음과 같이 규정하고 있다.

● 표 1-10 「노인복지법」에 규정된 금지행위

1. 노인의 신체에 폭행을 가하거나 상해를 입히는 행위
2. 노인에게 성적 수치심을 주는 성폭행·성희롱 등의 행위
3. 자신의 보호·감독을 받는 노인을 유기하거나 의식주를 포함한 기본적 보호 및 치료를 소홀히 하는 방임행위
4. 노인에게 구걸을 하게 하거나 노인을 이용하여 구걸하는 행위
5. 노인을 위하여 증여 또는 급여된 금품을 그 목적 외의 용도에 사용하는 행위
6. 폭언, 협박, 위협 등으로 노인의 정신건강에 해를 끼치는 정서적 학대행위

2) 노인학대의 유형

「노인복지법」의 노인학대 정의에 따라 노인학대의 형태적 유형은 ‘신체적 학대, 정서적 학대, 성적 학대, 경제적 학대, 방임, 유기’ 등 총 6가지로 구분할 수 있으며 유형별 정의는 다음과 같다.

● 표 1-11 노인학대의 유형별 정의

유 형	정 의
신체적 학대	물리적인 힘 또는 도구를 이용하여 노인에게 신체적 혹은 정신적 손상, 고통, 장애 등을 유발시키는 행위
정서적 학대	비난, 모욕, 위협 등의 언어 및 비언어적 행위를 통하여 노인에게 정서적으로 고통을 유발시키는 행위
성적 학대	성적수치심 유발행위 및 성폭력(성희롱, 성추행, 강간)등의 노인의 의사에 반하여 강제적으로 행하는 모든 성적 행위
경제적 학대 (착취)	노인의 의사에 반하여 노인으로부터 재산 또는 권리를 빼앗는 행위로서 경제적 착취, 노인 재산에 관한 법률 권리 위반, 경제적 권리와 관련된 의사결정에서의 통제 등을 하는 행위
방 임	부양의무자로서의 책임이나 의무를 거부, 불이행 혹은 포기하여 노인의 의식주 및 의료를 적절하게 제공하지 않는 행위(필요한 생활비, 병원비 및 치료, 의식주를 제공하지 않는 행위) * 자기방임: 노인 스스로가 의식주 제공 및 의료 처치 등의 최소한의 자기보호 관련행위를 의도적으로 포기 또는 비의도적으로 관리하지 않아 심신이 위험한 상황이나 사망에 이르게 하는 행위
유 기	보호자 또는 부양의무자가 노인을 버리는 행위

3) 신고의무자와 노인보호전문기관

인권침해가 일상적이고 반복적으로 나타나는 현실을 바로 잡기 위해서는 무엇보다 「노인복지법」 제39조의6제2항 각 호에 따른 노인학대 신고의무자의 역할이 중요하다. 노인학대 신고의무제도는 노인학대 예방제도와 사례발굴의 중요한 축으로, 노인학대를 알게 된 즉시 신고하는 것을 의무화하고 있다. 신고의무제의 도입은 피해자 스스로 신고가 어렵다는 인식에서 출발하였으며, 숨겨진 문제를 현실 밖으로 끌어내는 역할이 주요기능이다.

● 표 1-12 「노인복지법」 제39조의6의 노인학대 신고의무와 절차

- ① 누구든지 노인학대를 알게 된 때에는 노인보호전문기관 또는 수사기관에 신고할 수 있다.
- ② 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 그 직무상 65세 이상의 사람에 대한 노인학대를 알게 된 때에는 즉시 노인보호전문기관 또는 수사기관에 신고해야 한다.
- 장기요양기관의 장과 그 종사자
 - 방문요양과 돌봄이나 안정확인 등의 서비스 종사자, 노인복지시설의 장과 그 종사자 및 노인복지상담원
 - 의료기관에서 의료업을 행하는 의료인 및 의료기관의 장
 - 장애인복지시설에서 장애인에 대한 상담·치료·훈련 또는 요양업무를 수행하는 사람
 - 가정폭력 관련 상담소 및 가정폭력피해자 보호시설의 장과 그 종사자
 - 사회복지 전담 공무원 및 사회복지관, 부랑인 및 노숙인보호를 위한 시설의 장과 그 종사자
 - 119구급대의 구급대원
 - 건강가정지원센터의 장과 그 종사자
 - 다문화가족지원센터의 장과 그 종사자
 - 성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호시설의 장과 그 종사자
 - 응급구조사
 - 의료기사
 - 국민건강보험공단 소속 요양직 직원
 - 지역보건의료기관의 장과 종사자
 - 노인복지시설 설치 및 관리 업무 담당 공무원

신고의무자는 노인학대 상황이 위급한 경우 경찰 또는 노인보호전문기관 상담원이 현장에 도착하기 전 피해노인의 안전을 최대한 확보하며, 조사가 진행될 경우 조사원에게 적극 협조하여 노인학대 사례 조사가 원활히 진행될 수 있도록 돕는다. 노인학대 신고와 사례개입의 모든 과정은 법적으로 보호를 받으며 신고인의 신분은 「노인복지법」과 「공익신고자보호법」을 통해 보장받을 수 있으며, 필요시 노인보호전문기관을 통해 법률적 도움을 받을 수 있다. 노인학대 신고는 다음번호로 할 수 있다.

노인보호전문기관(1577-1389)	경찰(112)
보건복지상담센터(129)	정부민원안내콜센터(110)

제 2 장



장기요양 사례관리와 한국형 케어매니지먼트

1. 노인과 노인문제	30
2. 장기요양의 주요 개념과 영역	33
3. 사례관리의 기본 개념과 절차	40
4. 한국형 케어매니지먼트	47



02

장기요양 사례관리와 한국형 케어매니지먼트

학습목표

- 노인장기요양보험의 도입배경과 주요 제도변화를 파악한다.
- 장기요양 부당청구의 개념을 이해하고 사례를 통해 부당청구를 예방한다.
- 노인인권과 노인학대의 내용을 파악하고 장기요양현장에 적용할 수 있다.

1 노인과 노인문제

가. 노인의 정의

국제노년학회(1951)에서 정의한 노인의 일반적인 정의는 ‘생리적·행동적·심리적·사회적으로 노화와 정의 변화가 복합적으로 작용하는 사람’으로, ‘노화의 과정 또는 그 결과로서 생물, 심리, 사회적 기능이 약화되어 자립적 생활능력과 환경에 대한 적응능력이 약화되고 있는 사람’이다. 이때 노화의 3가지 영역(Breen, 1976)을 동시에 고려하는 것이 중요하며, 그 영역은 아래와 같다.

● 표 2-1 노화의 3가지 영역(Breen, 1976)

- ① 생리적 및 생물학적 면에서 퇴화에 있는 사람
- ② 심리적인 면에서 정신기능과 성격이 변화되고 있는 사람
- ③ 사회적인 면에서 지위와 역할이 상실되어 가는 사람

이러한 노인의 다면적 특성과 변화의 방향성은 노인의 신체적, 정신적, 사회적 측면의 복합적 욕구(Needs)와 연결되며, 이에 대응한 활동으로 보건의료복지의 필요성을 강조하게 되는 근거가 된다. 이상의 개념을 기초로 노인을 개인의 자각, 사회적 역할상실, 기능적 연령, 발달단계로 보다 조작적으로 정의해볼 수 있겠으나, 가장 보편적으로 활용되는 것이 역연령(曆年齡, Chronological-Age)에 따른 노인의 개념이다. 출생 이후부터 달력상의 나이로 계산한 만 나이가 일정 연령 이상일 경우를 의미하며, 개별법이나 사업에 따라 다양한 연령 기준을 사용하고 있다. 「노인복지법」과 「노인장기요양보험법」에서는 65세 이상을 노인으로 규정하고 있다.



point

노인은 신체·정신·사회적인 측면에서 퇴화·상실의 과정에 있는 사람을 의미하며, 특히 장기요양 수급자인 노인은 이러한 과정(퇴화, 상실 등)이 상대적으로 급속히 진행되었으며, 앞으로도 지속적으로 악화가 예상되는 상대적으로 고위험군의 대상이라는 점에 유의하여야 한다.

나. 고령화와 노인문제

세계적 인구구조 변화의 가장 큰 특성은 노인인구의 절대수와 상대적 비율의 증가로 요약해볼 수 있다. 우리나라는 2000년 고령화사회(Aging Society, 노인인구 7% 이상)를 지나, 2018년 고령사회(Aged

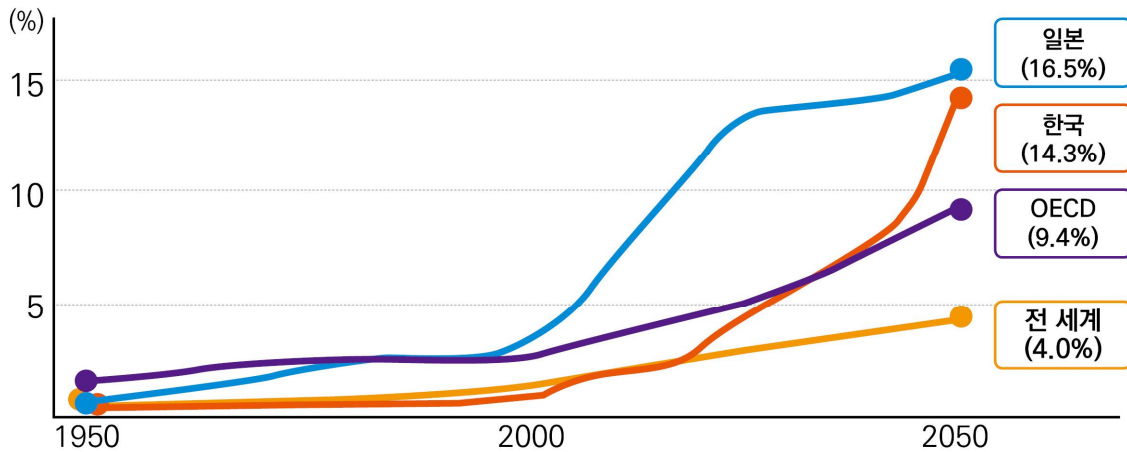
Society, 노인인구 14% 이상)를 넘어섰으며, 불과 몇 년 후인 2025년에는 초고령사회(Super Aged Society, 노인인구 20% 이상) 진입이 예상된다.

이미 초고령사회로 접어든 일본(23.3%, 2011) 등 다른 OECD 국가(15.4%, 2011)에 비해 고령화율은 상대적으로 낮으나 고령화 속도는 매우 가파른 상황으로, 급격한 고령화 속도는 우리사회에 커다란 고령화의 충격으로 예상된다. 특히, 가족 또는 사회적 요양에 대한 필요도가 높은 80세 이상 인구증가가 특히 가파를 것으로 예상되고 있다.(2050년 기준 일본 16.5%, 한국 14.3%, OECD 9.4%, 전세계 4.0%).

고령화 속도의 2가지 의미

- 양적 심화: 노인 인구수의 급격한 증가
- 질적 심화: 가족 또는 사회적 요양에 대한 필요도가 높은 80세 이상 인구의 가파른 증가

●● 그림 2-1 80세 이상 노인 인구비율의 증가 전망



우리 사회는 지속적으로 '기대수명'이 증가할 것으로 전망되고 있으나, 이를 '건강수명'이 따라잡지 못할 것으로 예상하고 있다. 기대수명에서 건강수명을 제외한 부분은 누군가의 도움이 필요한 질병 또는 장기요양의 상태라고 할 수 있으며, 따라서 동일한 노인인구수라도 장기요양에 대한 필요도와 수요는 더욱 늘어날 수밖에 없을 것으로 생각된다.

●● 표 2-2 기대수명 및 건강수명

기대수명		건강수명		장기요양상태
0세의 아이가 앞으로 생존하리라 생각되는 나이, 출생 시 평균 생존년수	(-)	온전히 건강한 상태로 살아갈 수 있는 평균년수	(=)	누군가의 도움이 필요한 상태
(예시) 90년		(예시) 70년		(예시) 20년



point

급속한 고령화는 앞으로 장기요양서비스가 필요한 노인의 증가와 함께, 장기요양서비스를 필요로 하는 기간이 늘어날 수 있음을 의미한다. 조기에 적절한 사례관리와 개입활동을 통해 장기요양상태가 더욱 악화되지 않고 가급적 건강한 상태로 나이 들어갈 수 있도록 지원하는 것이 중요하다. 이때 노인이 지닌 건강 또는 질병 상태 만이 아니라, 경제적 상태, 가족구성, 여가활동 등에 대한 문제를 함께 살펴볼 필요가 있다.

다. 노인의 특성

노인의 신체적 특성으로 세포조직의 재생능력 퇴화와 골근육의 위축, 피하지방의 감소, 소화기능 및 청력, 시각의 저하가 있다.

그리고 정서적 특성으로는 정신신경기능의 저하와 기억력 및 지능의 감퇴가 일어나게 된다.

욕구와 관련해서는 식욕과 성욕, 활동욕이 저하되는 것이 일반적이며, 특히 심리적으로는 통합 대 절망이라고 불리는 노인 특유의 상태를 나타내게 된다.



‘통합 대 절망(Erikson, 1959)’의 개념에서 ‘통합’은 현실의 자신과 자신이 지금까지 맞이했던 모든 사건과 상황들이 자신의 삶이라는 것, 그리고 그것이 바로 현재의 자신이라는 것으로 긍정하며, 죽음도 이런 사건의 일부로 인식함으로써 자신의 과거와 현재의 상황을 자기 내부로 통합할 수 있는 긍정적 능력과 상태를 말한다.

반면, ‘절망’은 지나온 삶과 현재의 자신을 부정적으로 인식하며, 수정될 수 없는 자신의 과거에 절망하고 다가오는 죽음 앞에서 좌절하는 심리상태를 의미한다.



point

‘통합 대 절망’은 노인의 심리상태를 파악하는데 유용한 실천적 함의를 제공한다. 장기요양현장에서 사례관리자가 노인을 만날 때 특정 시점의 일회적 만남으로 해당 노인의 특성을 일반화하거나 선입견을 가져서는 안 되며, 심리적 상태의 주기(사이클)의 수준과 강도가 있음을 이해해야 한다. 따라서 일회적 접촉 보다는 정기 및 수시 형태의 반복적 만남을 통해 해당 노인의 특성을 파악하는 접근이 바람직하다.

2 장기요양의 주요 개념과 영역

가. 장기요양의 기본 개념과 수급자

현재 우리나라가 사용하고 있는 '장기요양'이라는 용어는 영어의 'Long-Term Care'에 해당한다. 장기요양의 기본개념은 3가지 요소를 포함하고 있는데, 첫째, 장기요양이 필요한 자를 신체적이나 정신적인 제한을 지니고 있어 타인에게 의존하는 자로 정의하고 있으며(Pratt, 1999; Binstock, 1998; Kane, et al, 1998; Evashwick, 1996; OECD, 1996), 둘째, 신체적 또는 인지정신적인 제한이 장기간 지속적이어야 하고(Doty, et al, 1985; Evashwick, 1996; Kane, et al, 1998; Binstock, 1998; Pratt, 1999; OECD, 1996), 셋째, 그러한 장기요양 수급자에게 제공되는 서비스는 복지서비스뿐만 아니라 보건의료서비스 및 기타 사회서비스까지 총망라(Doty, et al, 1985; Pratt, 1999; Evashwick, 1996; OECD, 1996)하는 것으로 되어 있다. 이러한 장기요양의 개념적 특성이 가지는 실천적 함의들을 차례로 정리해보면 다음과 같다.

● 표 2-3 장기요양의 개념적 특성 및 실천적 함의

- ① 신체적 정신적 제한으로 타인에게 의존
 - 신체적, 정신적, 사회적 제한과 이로 인한 의존성에 적절한 대응 필요
 - 직접 인적 서비스 제공이 중심
- ② 의존 및 제한 상태가 장기간 지속
 - 단기간에 종결되는 것이 아니라 장기간 지속되는 것
 - 지속적인 악화의 과정과 죽음이라는 종결, 제공자의 소진 경험
- ③ 보건의료복지 및 기타 사회서비스를 포함
 - 단일 영역이 아닌 복지, 보건의료, 일반 사회서비스를 포괄
 - 다양한 직종과 자격의 역할 수행 기대
 - 인력의 역량과 전문성 및 팀어프로치의 중요성 부각
 - 이용자 중심 서비스와 통합이 강조되는 이유

「노인장기요양보험법」의 목적(제1조)은 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여를 제공하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하는데 있다. '65세 이상의 노인' 또는 '65세 미만의 자로서 치매·뇌혈관성 질환 등 노인성질환을 가진자 중 6개월 이상 혼자서 일상생활을 수행하기 어렵다고 인정되는 자'를 그 대상으로 하고 있으며, "건강이 매우 안 좋다", "큰 병에 걸렸다." 등과 같은 주관적인 개념이 아닌 "심신의 기능상태에 따라 일상생활에서 도움(장기요양)이 얼마나 필요한가?"를 지표화한 장기요양인정점수를 기준으로 수급자 등급판정을 하고 있다.

국민건강보험은 질환의 진단, 입원 및 외래 치료, 재활 등을 목적으로 주로 병·의원 및 약국에서 제공하는 서비스를 급여 대상으로 하는 반면, 노인장기요양보험은 고령이나 노인성질환 등으로 인하여 혼자서의 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 수급자에게 노인요양시설이나 재가기관을 통해 신체활동 또는 가사지원 등의 서비스를 제공하는 제도라고 할 수 있다. 기존 「노인복지법」 상의 노인요양은 주로 국민기초생활보장수급자 등 특정 저소득층을 대상으로 국가나 지방자치단체가 공적부조방식으로 제공하는 서비스 위주로 운영되어 왔으나, 「노인장기요양보험법」 상 서비스는 소득에 관계없이 심신기능 상태를 고려한 요양필요도에 따라 장기요양인정을 받은 수급자에게 서비스가 제공되는 보다 보편적인 체계로 운영되고 있다. 장기요양인정절차는 아래와 같다.

●● 그림 2-3 장기요양인정 및 이용절차



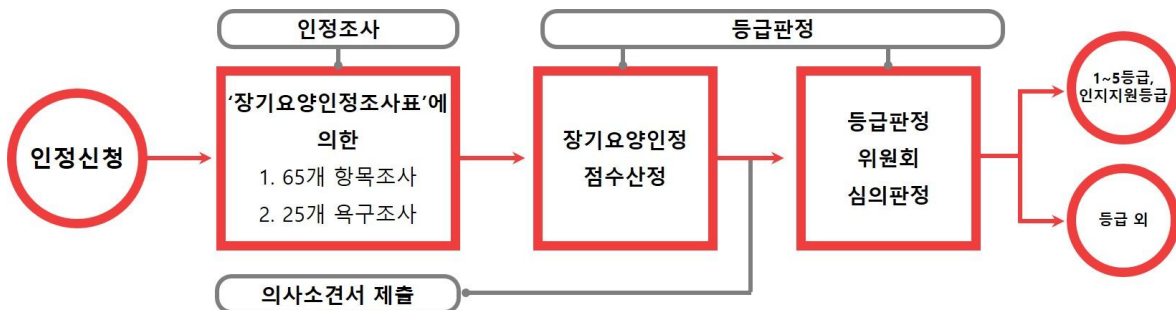
나. 장기요양 상태 및 인정

장기요양 상태에 대한 학자들의 일반적 정의(Kane, 1987; Atchley, 1994)를 보면, 일상생활 상의 (신체적 및 인지적) 기능장애가 존재하고 있는 상태로 요약해 볼 수 있다.

대부분의 국가에서는 피보험자, 또는 가입자가 보험급여로서 장기요양서비스를 받을 수 있는 조건을 충족하고 있는지를 확인(Screening)하기 위해 장기요양인정에 대한 조사를 실시하고 있다. 공적체계의 장기요양 평가·판정도구는 욕구사정(Assessment)보다는 수급자 선정의 특징을 갖고 있어 제도의 대상 집단을 결정하는 데 활용되고 있다. 즉, 정확한 욕구사정도 중요하지만 한정된 자원의 배분(Allocation)의 중요한 우선순위로 도구가 작동된다는 점을 간과하지 않을 수 없으며, 따라서 등급판정체계는 국가 재정부담과도 관련이 높은 정책적 과제라고 볼 수 있다.

장기요양의 욕구에 대한 평가 기준은 일상생활동작(ADL; Activities of Daily Living)의 제한으로 나타나는 신체기능이나 인지장애나 문제행동의 출현과 관련된 인지기능을 합친 기능상태(Functioning), 전반적인 건강상태를 포함하는 허약성(Frailty), 수발부담과 독립성과 같은 의미의 의존성(Dependency)이 종합적으로 판정에 활용되고 있다.

●● 그림 2-4 등급판정 절차



●● 그림 2-5 장기요양인정점수 구간별 장기요양인정등급



● 표 2-4 등급판정 기준

장기요양 등급	심신의 기능상태
1등급	심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인 자
2등급	심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자
3등급	심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자
4등급	심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자
5등급	치매환자로서(「노인장기요양보험법 시행령」 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자
인지지원등급	치매환자로서(「노인장기요양보험법 시행령」 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자

다. 장기요양 제공인력

일반적으로 장기요양 제공인력은 직업적으로 케어 서비스를 제공하는 공식적 인력과, 직업으로 하지 않는 비공식적 인력을 모두 지칭하는 용어로 사용되고 있다(이해영, 2003; 최희경, 2009).

장기요양 제공인력의 업무 및 기능에 대한 견해는 크게 다음과 같이 5가지의 이슈로 구분해 볼 수 있다. ‘첫째, 요양서비스가 특화된 전문가의 역할인가, 일반적 수준에서 실행되는가. 둘째, 요양서비스의 내용이 시설 유형에 따라 다른가. 셋째, 요양서비스 제공인력이 어떤 방식으로 채용되어야 하는가. 넷째, 케어를 직업으로 하는 노동자들의 자격을 어떻게 규정할 것인가. 다섯째, 노동자들의 보수교육과 지속적 훈련은 어떻게 이루어져야 하는가’이다.

요양보호사 자격제도는 2008년 노인장기요양보험제도의 도입과 함께 만들어진 국가자격으로, 「노인장기요양보험법」 제2조와 「노인복지법」 제39조의2에 법적 근거를 두고 있다.

「노인장기요양보험법」에서 요양보호사를 포함하는 ‘장기요양요원’에 대한 정의로 ‘장기요양기관에 소속되어 노인 등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 수행하는 자’로 규정하고 있으며, 「노인복지법」에서는 요양보호사를 ‘노인 등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 전문적으로 수행’하는 인력으로 정의하고 있다.

라. 장기요양 인프라 및 서비스

노인장기요양보험제도에서 장기요양서비스를 제공하는 장기요양기관의 종류에는 시설 장기요양기관인 노인요양시설과 노인요양공동생활가정(9인 이하)과 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주·야간보호, 단기보호, 기타 재가급여 등을 제공하는 재가장기요양기관이 있다.

● 표 2-5 재가급여 종류

급여종류	내 용
방문요양	요양보호사가 수급자의 가정 등을 방문하여 신체활동 및 가사활동 등을 지원 〈인지활동형 방문요양〉 치매전문교육을 이수한 요양보호사가 인지훈련도구를 활용한 인지가극활동 및 일상생활을 수급자와 함께 수행하여 남아있는 신체·인지기능의 유지·향상을 위한 훈련을 제공
방문목욕	2명의 요양보호사가 목욕설비를 갖춘 장비를 이용하여 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕을 제공
방문간호	간호사, 간호조무사, 치과위생사가 의사, 한의사 또는 치과의사의 방문간호지시서에 따라 수급자의 가정 등을 방문하여 간호, 진료의 보조, 요양에 관한 상담 또는 교육, 구강위생 등을 제공
주야간보호	수급자를 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하여 신체·인지활동지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공
단기보호	수급자를 일정 기간 동안 장기요양기관에 보호하여 신체활동 지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공
기타 재가급여 (복지용구)	수급자의 일상생활·신체활동 지원 및 인지기능의 유지·향상에 필요한 용구를 제공

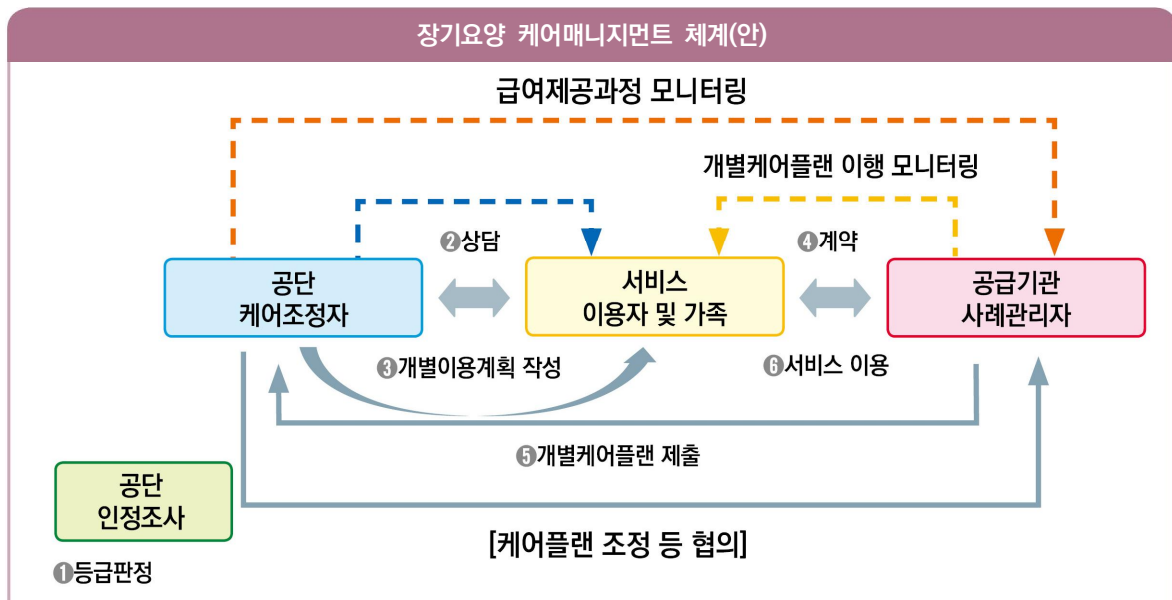
마. 장기요양 이용지원과 사례관리

노인은 다양한 생활요소에서 장기요양 욕구가 발생하고 개별적이며 중장기적으로 지속되므로 개개인의 욕구에 맞춘 연속적인 지원이 반드시 필요하다. 수급자와 그 가족은 다양한 장기요양서비스를 적절하고 효율적으로 받기 위한 접근이 쉽지 않고 공식서비스와 비공식서비스의 조종자 역할을 하기 어려운 것이 현실이다. 또한 다수의 제공자가 참여하는 장기요양현장에서도 이용자의 욕구에 맞는 적절한 장기요양서비스제공이 어렵고 자원을 분산시키거나 중복 지원하는 비용의 낭비가 발생하기 쉬운 구조를 가지고 있다.

장기요양서비스의 제공 방향은 ‘개별화’와 ‘표준화’의 달성이라고 요약해 볼 수 있다. 즉, 장기요양서비스가 추구하는 방향성으로서 개별화와 표준화를 의미하는데, 이용자 케어의 개별화에 대한 것은 케어플랜(급여제공계획)으로, 이용자 케어의 표준화와 관련한 것은 매뉴얼로 대응하는 것이 기본이다. 개별화는 좀 더 이용자의 욕구에 충실한 것이고, 표준화는 수준 높은 케어의 기준을 계속 유지하는 것이다. 결국, 현장에서의 활동은 ‘개별화와 표준화’를 통해 이용자에게 질 높은 케어 서비스를 제공하는 것이라고 할 수 있다.

이러한 특성에 따라 장기요양서비스 지원체계의 중요성이 커지게 되는데, 우리제도는 공식적인 이용지원체계를 마련하여 운영하고 있으며, 한국형 사례관리체계 내에서 공단 ‘케어조정자’와 기관 ‘사례관리자’가 연계하여 수급자 욕구에 기초한 개별케어플랜 작성 및 사례관리를 수행하는 등 향후 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

● 그림 2-6 노인장기요양보험제도의 사례관리 운영체계(안)



※ 자료: 보건복지부, 2018, 제2차 장기요양보험 기본계획(2018-2022)

바. 장기요양 서비스의 질과 평가

장기요양서비스의 질이나 적정성을 논의하기 위해서는 장기요양서비스의 질 및 성과 측정의 제한점을 인식할 필요가 있다. 장기요양서비스는 일반적인 서비스가 가지는 특성인 주관성을 기본적으로 가지고 있으며, 서비스 질은 가치를 함축하고 있는 추상적이고 주관적인 개념으로 질을 보장하기 위한 프로그램은 질의 주관적인 현상을 검증하는 객관적인 방법을 찾는 것이 관건이다(Coulton, 1991). 특히 보건의료 등 타 서비스 영역에 비하여 장기요양서비스 제공을 통해 나타나는 성과는 상대적으로 불분명하며, 단기적으로 측정하기 어렵다는 근본적인 한계가 있다.

서비스의 질이 가지는 일반적인 특성과 장기요양서비스가 가지는 독특한 특성으로 인해, 이용자 보다는 제공자(기관)를 중심으로 한 평가, 성과보다는 구조와 과정에 대한 평가가 강조되며 상대적으로 높은 비중을 차지할 수밖에 없다는 현실적인 이유가 있다. 그러나 이러한 제한점 속에서도 서비스 질의 본질적인 측면인 이용자와 성과를 중심으로 한 접근과 측정을 위한 시도는 계속되어야 할 필요가 있다.

국민건강보험공단은 「노인장기요양보험법」의 관련규정(제54조 장기요양급여의 관리·평가)에 근거하여 매 3년 마다 장기요양기관평가를 실시하고 있으며, 이용지원과 관련한 평가항목은 다음과 같다(재가급여 평가매뉴얼(2020) 평가기준 참고).

- 수급자의 낙상 및 욕창 위험도, 인지기능 상태를 정기적으로 파악
- 정기적으로 방문상담을 실시하고 수급자의 상태를 관리
- 수급자에게 급여이용에 대한 정보를 제공하여 급여선택권 보장을 위해 노력
- 개인별장기요양이용계획서를 반영하여 급여계약을 체결하고 급여계약통보서 적기 통보
- 수급자의 욕구평가를 정기적으로 실시
- 수급자별 급여제공계획을 세우고 수급자(보호자)에게 동의를 받음
- 수급자별 급여제공계획에 따른 급여를 제공, 기록하고 변경된 경우 사유를 기록
- 사례회의를 정기적으로 실시
- 수급자는 개별적인 욕구를 반영한 급여를 제공받음
- 수급자는 급여제공직원이 바뀌어도 동일한 수준의 급여를 제공받음
- 수급자는 탈수예방, 배변도움, 노인학대예방, 관절구축예방 등에 대한 설명을 듣고 자료를 제공받음
- 수급자는 신체기능 유지, 향상을 위한 급여를 제공받음

사. 장기요양 관련 기타 개념

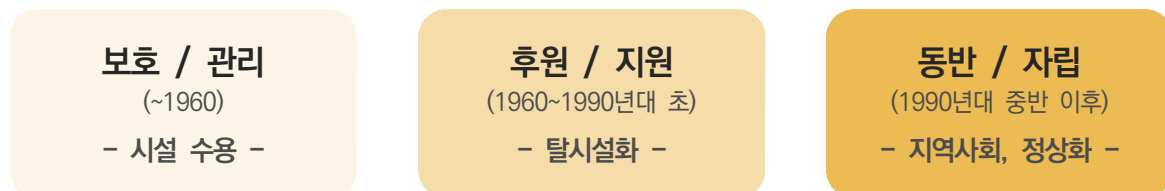
장기요양분야와 관련하여 탈시설화(Deinstitutionalization)외에도 지역사회보호(Community Care), 정상화(Normalization), AIP(Aging in Place) 등과 같은 개념이 관련 정책형성과 현장에서의 실천 원칙으로 주목받고 있다.

1) 탈시설화와 지역사회보호, 정상화

탈시설화(Deinstitutionalization)가 사회문제로 등장하면서 시설보호의 한계와 비효율성의 인식에 따른 물결이었다면, 지역사회보호(Community Care)는 지역사회의 욕구를 지역사회 안에서 해결하기 위한 서비스라고 할 수 있다.

이들을 포괄하는 정상화(Normalization)의 개념은 가능한 만큼 사람들에게 가치 있는 사회적 역할을 습득, 정립, 유지시키기 위해 문화적으로 가치 있는 수단을 이용하는 것을 의미한다.

●● 그림 2-7 탈시설화와 지역사회, 정상화의 흐름



2) AIP(Aging In Place)

장기요양의 정책 및 실천 철학으로서 주목받고 있는데, 보통 거주지에서의 노화 또는 삶터에서의 요양 등으로 번역되며, 가능한 인생을 마칠 때까지 익숙한 장소(공동체)에 남아서 생활하기(Harris, 1988: 18; Frank, 2001에서 재인용), 시설보다는 독립성을 지니면서 지역사회 공동체 안에 남아서 생활하기(Davey, et al., 2004) 등을 의미한다(임정기, 2015). 즉, 노인이 살고 싶은 곳이 있으면, 해당 지역 내에서 여러가지 필요한 서비스를 제공할 수 있는 체계를 구축하는 것이다.

이때 주의할 것은 AIP 개념은 본인의 가정에서 거주하는 노인만이 아니라, 입소시설에서 거주하는 노인도 포괄하는 개념으로 재가 및 시설장기요양서비스 모두에 적용 가능한 개념으로 보아야 한다는 점이다.

AIP를 구현하기 위한 다양한 정책적 또는 실천적 시도가 이루어지고 있으나, 이의 궁극적인 실현을 위해서는 이용자를 중심(User-centered)으로 다양한 보건, 의료, 복지서비스가 ‘통합(Integration)’ 적으로 전달될 수 있는 체계를 갖추어야만 한다. 통합적 케어(Integrate Care)란 치료영역과 요양 영역 간 영역 내의 제도운영 및 재정 그리고 서비스 제공의 연계, 조정, 통합하기 위한 모형 및 정책을 의미한다(WHO, 2003; 유애정, 2017). 구체적 실행방법으로는 장기요양서비스 관련 행정 조직의 통합, 서비스 제공장소 및 전달체계의 단일화, 주거와 요양서비스의 통합, 수급자 욕구 중심의 케이스, 케어매니지먼트 기능 활성화를 포함한다.

3) 인간다움(Humanitude) 케어

장기요양서비스의 실천적 기법으로 주목 받고 있다. 지각, 감정, 언어에 따른 포괄적 의사소통에 연결된 케어 기법으로, 그 사람의 사람다움을 존중해 가는 상황, 존엄성의 최대한 보장, 케어를 받는 사람과 케어를 하는 사람 모두에게 행복한 관계성립에 중점을 두는 특징을 지니고 있다. 인간다움 케어는 단순히 철학적 개념이 아니다. 인간다움의 4가지 중심은 바라보기, 말하기, 접촉하

기, 서기 등 장기요양현장에서 종사자가 행하여야 할 실천적인 기법을 담고 있으며, 목욕, 옷갈아 입기 도움 등 실제 장기요양서비스의 실천과정에서 유의해야할 지식과 기술, 태도를 포함하고 있다(本田美和子, 2014).

특히 장기요양서비스를 받는 이용자만이 아니라 장기요양서비스를 제공하는 종사자를 포괄한 개념으로 이들 모두에게, 장기요양서비스 제공의 모든 과정에서 ‘행복한 관계’를 어떻게 설정할 것인가에 주목한다는 점에 유의해야 한다.

인간다움(Humanitude) 케어 실천을 위한 5가지 단계

- ① 만남의 준비: 방문하였음을 알린다.
- ② 케어의 준비: 상대와의 관계를 구축한다(친구가 된다).
- ③ 지각(감각)의 연결: 기분 좋은 케어를 실시한다.
- ④ 감정의 고정: 케어의 기분 좋은 점을 상대의 기억에 남긴다.
- ⑤ 재회의 약속: 다음의 케어를 쉽게 하기 위해 준비한다.

* 출처: <https://helpmanjapan.com>

4) 장기요양서비스의 지향점으로서 자립과 인권의 보장

실천현장에서의 핵심적인 서비스 제공 목표로 ①잔존기능을 활용한 제한적 자립과 ②그 과정에서 인권의 보장이 있다.

정책방향으로서 AIP(Aging In Place)의 실현(지역사회단위)을 강조하거나 실천전략으로서 인간다움(Humanitude)의 구현(기관, 제공-이용자 단위)을 추구하는 것과 함께, 수급자 개개인의 장점을 발견하고 제한적이거나 이를 이용하여 자립적인 일상생활을 유지할 수 있도록 하는 것, 그리고 이러한 지원의 방향이나 개입과정에서 인간으로서의 존엄성이 함께 고려되어야 한다. 이러한 합의된 이념과 인식을 기초로 장기요양서비스 제공체계 내에서 보건의료와 복지 분야의 다양한 직종이 팀을 이루어 참여(Team Approach)하게 되고, 공통된 목표를 달성하기 위해 협업하는 것이 가능할 것이다.

3 사례관리의 기본 개념과 절차

가. 사례관리의 개념 및 특징

1) 사례관리의 개념

사례관리와 관련한 유사 용어로 ‘케이스 매니지먼트’, ‘케어매니지먼트’, ‘케어 코디네이션’, ‘서비스 코디네이션’ 등이 사용되고 있는데, 일반적인 사회복지 영역에서는 ‘케이스 매니지먼트’를, 노인 영역에서는 주로 ‘케어매니지먼트’를 사용하는 경향이 있다. 이는 노인의 경우 단일한 케이스로 접근하기 어려우며, 이들의 개별적이고도 복합적인 욕구나 문제에 대응하여 복지만이 아니라, 보건의료서비스를 포함한 포괄적 접근이 필요하기 때문이다.

사례관리는 학자에 따라 아래와 같이 다양하게 정의되고 있다(한국사례관리학회, 2014).

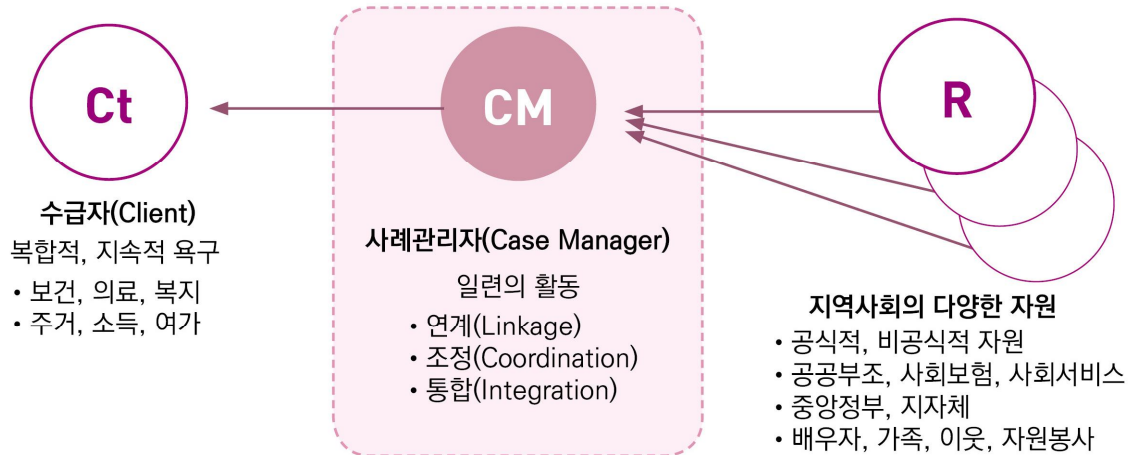
● 표 2-6 사례관리 주요 정의

주요 학자	사례관리 정의
피터 존슨 (Peter Johnson, 1983)	클라이언트가 적절한 서비스를 받게 하는 것으로 서비스의 방법은 사회복지사가 책임을 지고, 클라이언트를 다양한 서비스체계에 연결시켜 문제를 해결하는 것
미국사회복지사협회 (NASW, 1984)	서비스들을 연결하고 조정하여 개인의 욕구를 충족시킬 수 있는 포괄적인 프로그램
목슬레이 (Moxley, 1989)	복합적인 욕구를 가진 사람들의 기능화와 복지를 위해 공식적, 비공식적 지원과 활동의 네트워크를 조직·조정 유지하고, 이러한 활동을 통해서 클라이언트의 생활기술을 증진시키고, 사회적 망과 관련된 대인복지서비스 제공자들의 능력을 발전시키며, 제공되는 서비스의 효율성과 효과성을 증진시키는 것
마에다 (前田大作, 1990)	각종 서비스나 자원을 이용할 수 없는 취약계층이 욕구에 부합하는 서비스를 받도록 하고 지역사회와 다양한 자원으로부터 가능한 범위의 지원을 받도록 서비스 네트워크 내에서 상호 협력 활동을 하는 것
베이커&인탈리아타 (Baker&Intagliata, 1992)	클라이언트 옹호, 서비스조정, 자원 통제, 서비스 구입 등의 통합적이고 효율적인 개입을 통해 기관이 클라이언트를 책임지는 활동
시라사와(1993)	수급자가 사회생활에서 복수의 욕구를 충족할 수 있도록 적절한 사회 자원과 연결시키는 절차의 총체로 클라이언트의 욕구에 대한 사정과 서비스 계획과 연계 및 모니터링의 절차
벨로&밍크 (Ballew&Mink, 1996)	여러 사람의 원조자로부터 동시에 도움이 필요한 다양한 문제가 있어서 삶이 만족스럽지 못하거나 생산적이지 못한 사람들을 돕는 하나의 과정으로 이용 가능한 자원망과 이 자원을 이용할 수 있는 클라이언트의 자신감을 강조
쿠마 (Kumar, 2000)	클라이언트 욕구에 대한 사정, 계획, 조정, 전달과 모니터링을 통해 서비스 통합을 달성하기 위한 전문적 서비스 실천 과정
사례관리자 자격 위원회 (Mullahy & Jenson, 2000)	사정, 계획, 실행, 조정, 점검하고, 클라이언트의 건강 욕구를 충족시키는 데 필요하고, 삶의 질과 비용효과적인 성과들을 촉진하기 위해 의사소통과 자원을 활용하는 대안과 서비스를 평가하는 협력적인 과정
권진숙, 박지영(2008)	생태체계적 관점을 기반으로 만성적이고, 복합적인 문제를 가진 개인 및 가족과 함께 일하면서 그들과 자원 제공자들의 기능을 향상시켜 환경 속에서 자신들에게 필요한 서비스와 자원을 스스로 획득하고, 사회적 기능을 원활히 수행할 수 있도록 돕는 통합적인 접근 방법. 사례관리자는 임상 및 치료적 측면과 행정 특히, 조정 및 옹호의 측면에 관심
한국보건복지인력개발원 (2009)	장기적이고 복합적인 문제를 가진 클라이언트를 대상으로 사례관리자가 오랜 기간 동안 책임지고 필요로 하는 서비스들을 다양한 원천으로부터 동원하여 연결하고 모니터링하는 활동

※ 자료: 한국사례관리학회, 사례관리론, 2014.

이상의 정의들을 종합해보면, 사례관리는 ‘사례관리자가 수급자의 복합적이고 지속적인 욕구에 대응하여 지역사회와 다양한 자원을 연계-조정-통합하는 일련의 활동’이라 할 수 있다(서동민, 2018).

●● 그림 2-8 사례관리의 개념



이상의 정의를 기준으로, 각 요소별 세부 개념을 정리해보면 다음과 같다.

- 가) ‘사례관리는 사례관리자가 수행하는 활동’이다. 당연한 이야기일 수도 있으나, 사례관리현장에서 사례관리자가 객관적으로 판단한 욕구(Needs)보다 오히려 수급자가 주관적으로 바라는 요구(want)에 따라 서비스가 제공되는 경우가 있다. 사례관리는 전문적인 영역으로 전문성을 가진 사례관리자가 수행하는 개입활동임을 명확히 인식해야 한다.
- 나) ‘사례관리는 수급자가 가진 복합적이고 장기적인 욕구에 대응한 활동’이다. 수급자는 신체적, 정신적, 사회적 문제는 물론, 주거와 소득, 여가 등에 걸친 다양한 욕구를 가지고 있으며, 대개의 경우 이러한 욕구는 단기간에 해소 또는 충족되는 것이 아니라 장기간에 걸쳐 지속되게 된다.
- 다) ‘사례관리는 지역사회의 다양한 공식적, 비공식적 자원을 활용하는 활동’이다. 지역사회에는 보건의료복지 분야의 다양한 전문가와 기관 등 자원이 존재하며, 이를 개발하여 수급자의 욕구에 대응할 수 있도록 개입활동을 수행하는 것이 필수적이다.
- 라) ‘사례관리는 그 수준에 따라 단순한 연계에서부터, 조정, 통합의 수준으로 발전’시킬 수 있다. 사례관리자는 수급자에게 자원에 대한 정보를 단순히 제공하여 연계(Linkage)하거나, 실제 서비스 제공과정에 개입하여 그 양과 질을 간접적으로 조정(Coordination) 할 수도 있다. 또는 실제 직접적 서비스 제공을 담당하여 통합(Integration)하는 역할을 수행할 수도 있다.

2) 사례관리의 목적

방문요양기관에서의 사례관리는 방문요양서비스를 받는 어르신과 그 가족들의 욕구와 어려움을 해결하여 건강하고 행복한 생활을 유지할 수 있도록 하는데 목적이 있다. 수급자의 측면에서는 사례관리를 통해 수급자의 사회적 기능이 향상되고, 문제해결 역량이 강화되어서 수급자의 삶의 질이 향상되는데 있다. 한편 서비스 전달체계 측면에서 사례관리는 서비스의 효율성과 효과성의 증진이 목적이다. 이를 위해 통합적인 서비스의 제공, 포괄적인 서비스의 연속적인 제공 뿐 아니라 서비스의 불필요한 중복이나 누락을 방지하고 비용효과성을 높이는 것이 목적이다(이근홍, 2014).

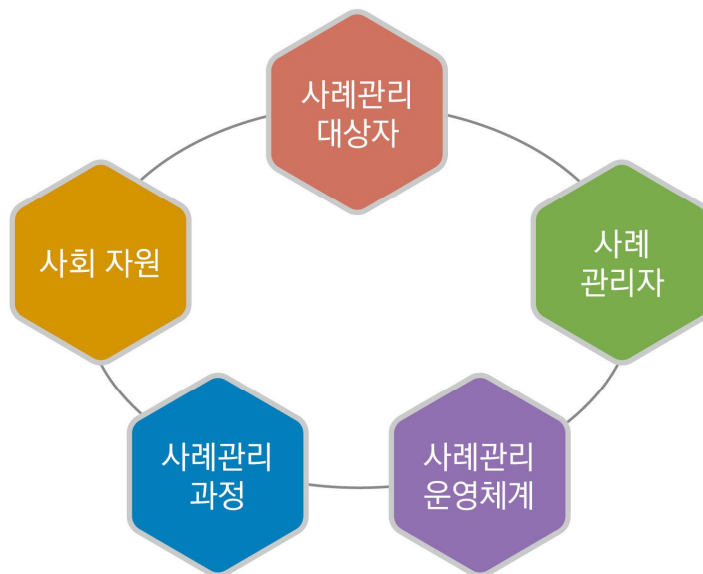
3) 사례관리의 특징

일반적인 사회복지실천과 차별되는 특징을 가지고 있다. 사회복지실천은 수급자의 '문제해결'에 초점을 두지만 사례관리는 수급자의 '욕구'에 관심을 둔다는 점, 자원 개발 및 네트워크가 중시된다는 점, 3개월 이상 장기간의 서비스가 요구되는 수급자를 대상으로 한다는 점에서 그 특징이 있다. 즉, 사례관리는 수급자의 욕구에 기반을 둔 개별맞춤형 서비스라는 점, 다양한 원조가 제공되고 장기간의 서비스 제공이 필요한 사람이 대상이라는 점, 서비스와 자원의 개발이 중시되며 자원 간의 네트워크가 중요하며, 주기적인 점검과 평가와 사례관리의 운영체계가 강조된다는 점에서 일반 사회복지실천과 차이가 있다.

나. 사례관리의 구성요소

사례관리가 실천되기 위해서는 사례관리를 필요로 하는 수급자(사례관리 대상자), 수급자의 욕구를 충족시키는 사회자원, 사례관리를 실시하는 기관에 배치되어 있는 사례관리자, 그리고 사례관리자가 속해있는 사례관리 기관들이 필요한 구성 요소로 제시되고 있다(김만두, 1993). 사례관리 구성 요소를 입체적으로 파악해보면 사례관리 과정, 사례팀과 운영팀으로 구성될 수 있는 사례관리의 운영체계가 포함될 수 있다(한국사례관리학회, 2014).

●● 그림 2-9 사례관리의 구성요소(한국사례관리학회)



1) 수급자(사례관리 대상자)

사례관리에 있어 수급자는 일반적으로 복합적인 욕구를 가지고 있어 하나 이상의 사회 자원을 필요로 하지만 자원의 소재와 이용 방법에 대해 잘 모르는 사람을 의미한다(한국사례관리학회, 2014). 사례관리에서 수급자는 단순히 서비스를 제공받는 수혜자가 아니라 사례관리자와 함께 당면한 문제를 해결하고 필요한 욕구충족을 위해 환경을 변화시키고 자원을 찾아 활용할 수 있는 수급자로 바라보아야 한다. 수급자 입장에서는 필요한 서비스 자원을 모르고 서비스 연계 방법에 익숙하지 않으므로 이에 대한 전문가인 사례관리자의 도움을 받아 함께 작업해나가는 과정이 사례관리로 이해되어야 한다. 따라서 사례관리자는 수급자가 겪는 어려움과 관심, 욕구에 맞는 서비스를 찾아 조직화하고 자신의 삶을 독립적으로 유지해나갈 수 있는 역량강화 내용을 사례관리과정에 필수적으로 포함시켜야 한다.

2) 사례관리자

수급자와 가족을 대상으로 초기 정보수집 및 사정, 개입, 계획의 수립과 실행, 평가 및 종결 등 사례관리 전 과정을 총괄하는 전문가이다. 사례관리자는 수급자와 그들의 가족 문제와 욕구해결에 필요한 직접적 서비스와 간접적 서비스를 제공 또는 연계한다. 그리고 사례관리에 필요한 모든 정보를 기록하고, 보고하며, 슈퍼바이저의 지도감독을 받는다. 사례관리자는 수급자의 문제와 욕구의 특성에 따라 적절한 역할을 수행해야 하므로 임상적인 능력과 함께 자원조정, 네트워크 그리고 옹호적인 실천기술 등을 가지고 있어야 한다. 직접적 개입에서는 위기 개입 이행자, 교육자, 안내자, 협력자, 진행자, 정보전달자, 지원자 등의 역할을 하며, 간접적 개입에서는 중개자, 연결자, 조정자, 옹호자, 협동가, 협의자 등의 역할을 수행한다. 또한 개인 혹은 팀 단위로 구성될 수 있다.

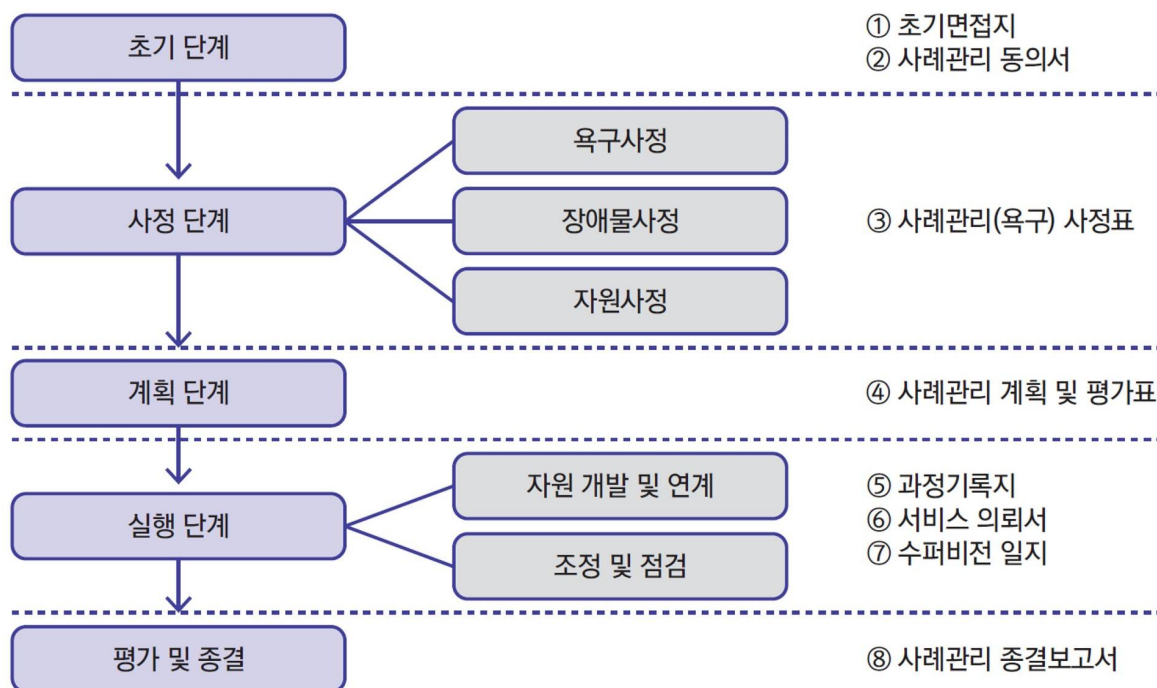
3) 사례관리운영체계

사례관리자 개인적인 역량에 좌우될 수 있는 사례관리 실천의 질을 안정적으로 높일 수 있는 요소로, 내부운영체계와 외부운영체제로 구분할 수 있다.

내부운영체계는 사례관리자와 사례관리팀으로 구성되며, 외부운영체계는 통합사례관리팀, 전문 슈퍼바이저, 솔루션위원회, 통합사례관리 지원단 등으로 구성된다.

다. 사례관리 과정

●● 그림 2-10 사례관리의 일반적 과정



1) 초기단계

사례발굴과 접수 및 초기면접과정으로 이루어진다. 발굴은 사례관리가 필요한 잠재적인 사례관리 수급자 군을 효과적으로 찾아내고 접근하기 위한 과정이다(이준우, 최희철, 2014).

사례관리에서 사례 발견 또는 초기접촉은 사례관리자와 도움을 필요로 하는 사람이 최초로 접촉하게 되는 과정과 방법으로 수급자의 직접 요청, 기관 내부 의뢰, 타 기관 의뢰, 아웃리치(사례관리자에 의한 발굴) 등의 방법이 있다(사례관리학회, 2012).

초기면접은 사례관리의 의미 및 주요과정을 설명하는 과정에서부터 시작하여 사례관리자와의 관계형성, 좀 더 세부적인 삶의 상황을 이해하는데 필요한 정보 수집을 위한 과정이 모두 포함된다(이기연, 2012). 초기면접은 수급자와 신뢰를 쌓는 첫 단추이다. 찾아와 부탁하는 어려움, 그 어려움이 생기게 된 배경, 평소 그런 어려움을 누구와 상의하는지 또 어떻게 하면 해결할 수 있을지, 어떤 도움을 드리면 좋을지 등을 확인하며(김세진, 2014), 그동안 잘 살아왔고, 나름대로 문제를 해결하기 위해 애썼던 여정을 존중하는 자세가 필요하다.

2) 사정단계(Assessment)

사례관리자와 수급자가 함께 수급자의 욕구에 관한 정보를 수집하고, 분석하며, 우선 순위화하고, 종합화하는 과정이다(이기연, 2012). 이 과정에서 사례관리자는 생태체계적 관점에서 수급자 개인과 환경의 상호작용에 초점을 맞추어 사정한다. 즉, 수급자의 문제를 규명하고, 개인의 신체적, 심리적 요소를 포함한 내부 체계에 대해 사정하며, 가계도를 활용하여 가족체계를 사정하고, 생태도를 이용하여 수급자의 사회적 환경체계에 대해 사정한다. 사정은 사정 단계뿐 아니라 사례관리 과정에서 계속되는 과정이며 수급자와 상호성을 기초로 하여 이루어져야 하며 수급자의 관여가 절대적으로 필요하다. 이 때 문제해결에 있어 걸림돌이 되는 장애물을 점검할 뿐 아니라 수급자가 가진 강점과 자원을 반드시 탐색한다.

사례관리자는 욕구(Needs)의 이면에 깔린 권리의 문제를 확인해야 한다. 욕구는 그것 자체가 목적이 아니라 다른 바람직한 목표를 달성하기 위한 수단이며, 권리의 충족이라는 측면에서 우선순위를 결정할 수 있는 기준이 되기 때문이다(Ife, 2001). 이 단계에서는 수급자가 표현한 요구 뒤에 숨은 또 다른 욕구가 있는지 확인하고, 수급자 본인에게 유익이 되는지 여부를 확인하도록 한다. 욕구(Needs)는 변화목표, 성과와 직접적인 관련이 있으므로, 수급자가 원하는 서비스를 요청하는 요구(Want)와는 구분되어야 한다.

3) 계획단계

사정을 통해 얻은 자료를 바탕으로 달성하고자 하는 변화목표를 분명히 하며, 이러한 변화목표를 달성하는데 필요한 전략과 방법을 구성해가는 과정이다. 즉 수급자의 삶의 문제해결을 위해 어떠한 방법으로 서비스를 제공한다면 문제가 해결될 수 있을 것인지에 대한 논리적인, 실천적인 근거가 확보된, 개별화된 서비스 제공 계획이다(이기연, 2012). 사정과정을 통해 수급자의 해결해야 할 문제와 보호의 목적을 확인하였다면, 계획과정에서는 확인된 욕구를 충족시킬 수 있는 적절한 자원과 수단을 선택하여 연결하는데 초점을 둔다.

계획단계에서 수급자의 변화를 촉진하기 위해서는 첫째, 사례관리자와 수급자가 신뢰관계를 바탕으로 함께 구체적이고 세부적인 목표를 설정한다. 둘째, 사정에서 확인된 주요 문제나 욕구의 해결을 위해 우선순위를 정하고, 셋째, 목표달성을 위한 선택방법을 함께 수립한다. 넷째, 목표는 수급자의 현재 상황을 기반으로 현실과 실행가능성이 고려되어야 한다. 서비스 계획 수립 시 수급자와 가족의 합의에 유의하고, 합의한 내용은 기록하여 둔다.

4) 실행 및 점검단계

실행단계는 정보수집 및 계획 단계에서 작성된 계획의 목적 달성을 위한 과정을 의미한다. 실행과정은 사례관리의 전 과정에서 가장 가시적인 과정이며(Sheafor et al., 2000), 사례관리의 중심기능이라 할 수 있는 서비스의 조정이 강조되는 단계이다(Libassi, 1992; Murer & Brick, 1997). 이는 수급자의 상황에 변화를 가져오기 위한 방향으로 초점화 되어야 하며, 이를 위해 계획 내에

포함되어 있는 다양한 서비스 제공자와의 협력적 관계를 바탕으로 서비스가 연결될 수 있도록 노력하며, 서비스의 이용가능성을 높이기 위한 옹호활동(Walsh, 2000), 변화의 지속성을 보장하기 위한 다양한 활동이 요구된다(Hepworth et al, 1997; Gursansky, Harvey, & Kennedy, 2003 재인용).

점검과정은 사례관리자와 수급자를 대상으로 이루어지는데, 사례관리자를 대상으로는 사례관리 실행계획이 계획대로 이행되고 있는지, 수급자에게 제공되는 서비스가 적합한지 등을 점검하며, 수급자를 대상으로는 수급자가 사례관리 과정에 적극적으로 참여하며 만족하고 있는지, 수급자가 충족해야 할 욕구의 내용과 수준이 변화되고 있는지를 확인한다. 이 단계에서는 수급자의 변화정도, 서비스와 지원계획의 목표 성취도, 사회적 지지의 산출 정도, 수급자의 만족도 등을 점검하고 파악하여 서비스 계획의 변화여부를 검토한다. 수급자가 중복서비스를 받거나 지원체계를 남용하지 않는지도 점검한다.

5) 평가 및 종결단계

사례관리평가는 사례관리 과정에 참여한 수급자가 욕구와 변화 목표에 부합되는 서비스를 적절히 제공 받고 이를 통해 원하는 변화를 성취하였는지를 확인하는 과정이다(한국사례관리학회, 2012). 종결의 사유는 다양하며 원했던 변화가 일어나거나 사망, 거주지 이전, 요양시설(병원)입소 등이 종결의 사유가 된다. 종결은 수급자에게 예고되어야 하며 종결단계에서 수급자의 불안과 부정적 정서를 다루기 위해서 그동안 사례관리 과정에서 일어난 변화의 내용을 점검하면서 수급자가 문제해결을 위해 노력했던 행동과 긍정적 경험과 성과 등을 격려하고 지지한다.

사후관리는 서비스 종결 이후 일정 기간을 두고 종결 이후의 변화 상황 안정화 여부를 모니터링하고 재개입 필요성을 조기에 판단하기 위한 목적으로 수행된다.

● 표 2-7 학자에 따른 사례관리 과정 분류

학 자	사례관리 과정에 대한 이해	사례관리 과정
목슬레이 (Moxley, 1989)	사례관리의 핵심을 개발하는 결정적 요소로 과정을 서술함	1. 사정 2. 서비스 계획 3. 실행 4. 점검 5. 검토 및 평가
로스만 (Rothman, 1991)	사례관리서비스에서 수행되는 기능과 이 기능 간의 상호관계를 중심으로 과정을 서술함	1. 기관에 대한 접근 2. 접수, 사정과 목표설정 3. 서비스 계획, 자원의 확인 4. 클라이언트와의 연결 5. 점검과 재사정 6. 결과 평가
벨로&밍크 (Ballew&Mink, 1996)	사례관리서비스 수행 과정으로 설명, 단선적 과정이 아니며 재개입, 재사정, 서비스 계획, 실행 등의 과정이 동시에 발생한다고 봄	1. 초기 개입 단계 2. 사정 단계 3. 계획 단계 4. 자원사정 및 접근 단계 5. 조정 단계 6. 철수 단계
우드사이드&맥클램 (Woodside&McClam, 2006)	사례관리의 핵심기능을 중심으로 설명함	1. 사정 2. 서비스 계획 3. 실행
미국사회복지사협회 (NAWS, 1996)	'Social work case management'로서 생태체계적 접근으로 설명함	1. 클라이언트의 발견과 접수, 계약 2. 사정 3. 서비스 계획 수립 4. 서비스의 실행 5. 점검 및 조정 6. 자원연결 및 옹호 7. 재사정 8. 종결
이근홍(2006)	사례관리 서비스의 공통된 과정으로 서술함	1. 접수 2. 사정 3. 기획 4. 실행 5. 점검 6. 평가
권진숙, 박지영 (2008)	한국형 사례관리 모델과 사례관리 서비스의 공통된 과정 중심으로 서술함	1. 초기 사정 2. 사정 과정 3. 개입 계획 4. 조정과 점검 5. 평가와 분리

※ 자료: 한국사례관리학회, 사례관리론, 2014.

4 한국형 케어매니지먼트

가. 한국형 케어매니지먼트의 추진 배경

노인장기요양보험제도의 기본 구조에 따르면, 장기요양 인정 및 욕구조사를 통해 도출된 등급과 개인별장기요양이용계획서 상의 욕구를 기초로, 구체적인 장기요양급여의 유형과 이용량을 수급자 및 가족과의 협의를 통해 결정해야 한다.

「노인장기요양보험법」에서는 보험자인 국민건강보험공단의 업무로 수급자 및 그 가족에 대한 정보제공·안내·상담 등 장기요양급여 관련 이용지원에 관한 사항을 규정하고, 등급판정 후 수급자의 심신상태 및 생활환경과 욕구를 종합적으로 고려하여 개인별장기요양이용계획서를 제공하도록 하고 있다. 이에 따라, 국민건강보험공단은 수급자가 효율적인 장기요양서비스 이용계획을 수립하고 급여를 원활히 이용할 수 있도록 지원하며, 월 한도액 범위 내에서 비용효과적인 서비스를 이용할 수 있도록 돕고자 수급자에게 개인별장기요양이용계획서를 제공하고 있다(이정석 외, 2008).

그러나 실제 장기요양현장에서는 주로 제공자인 장기요양기관의 주도에 따라 일방향적으로 서비스 계약과 제공이 이루어지는 상황이며, 이를 통해 다양한 문제들이 야기되고 있다는 우려가 지속적으로 제기되었다. 특히, 재가의 경우에는 방문요양에 편중된 제공으로 월 한도액 내에서 다른 장기요양서비스의 이용이 실질적으로 제한받고 있으며, 이는 우리사회가 사회보험으로 보장하는 가입자의 장기요양 서비스에 대한 접근 및 수급권에 대한 침해의 가능성과도 연결된다는 점에서 우려가 있었다.

이에 보다 효과적으로 질 높은 장기요양서비스를 제공하기 위해서는 케어매니지먼트 과정에 근거하여 국민건강보험공단과 장기요양기관, 관련 서비스 제공기관, 지자체 간 효과적인 업무 연계 및 협력체계가 구축될 필요가 있고, 이를 위해서는 국민건강보험공단이 보험자로서 케어매니지먼트체계를 안정적으로 구축함과 동시에, 이를 활성화시켜 나가기 위한 제도적 보완체계가 마련되어야 한다는 과제가 강조되었다(유애정 외, 2017). 이러한 필요성과 제도개선에 대한 인식은 제2차 장기요양기본계획과 지역사회 통합돌봄 기본계획, 이용지원 강화사업으로 연결되어 추진되고 있다.

1) 제2차 장기요양기본계획

‘존엄한 노후생활을 보장하는 지역사회 돌봄 구현’이라는 비전 아래 4대 정책목표와 14개 과제를 구성하였다. 4대 정책 목표는 보장성 확대, 지역사회기반 서비스 이용, 장기요양 인프라 조성, 지속가능성 담보이다(보건복지부, 2018).

특히, ‘이용자 삶의 질을 보장하는 지역사회 돌봄 강화(정책목표 2)’를 실현하기 위하여 지역 내 다양한 돌봄 자원과 연계한 지역사회 중심의 통합적 장기요양서비스 이용체계로의 전환 계획을 제시하고, 등급판정부터 사후관리까지 책임지는 케어매니지먼트 체계의 도입과 수급자의 욕구와 필요 서비스를 반영하는 등급판정도구 개선 등 장기요양서비스 이용의 체계적인 관리 강화에 대한 대책을 발표하였다.

● 표 2-8 제2차 장기요양기본계획(정책목표 2)

정책목표 2. 이용자 삶의 질을 보장하는 지역사회 돌봄 강화 (지역사회기반 서비스 이용)			
추진과제	1. 장기요양 서비스 이용의 체계적인 관리 강화 2. 지역사회 맞춤 돌봄을 보장하는 재가서비스 개편 3. 가족수발자에 대한 사회적 인정과 지원체계 강화 4. 수요자 중심의 노인 의료·요양 체계 개선		
주요내용	과제	현황 및 문제점	개선방향
	1. 서비스 이용체계	이용지원 강화사업 (2017년 시범사업)	수급자 욕구, 지역사회 자원과 연계된 사례관리 체계화
	2. 재가 서비스 제공	기관·급여유형별로 분절적인 재가서비스 이용 (재가서비스 이용률 69%)	수급자에게 맞춤형으로 통합적인 재가서비스 제공 (재가서비스 이용률 75%)
	3. 수급자 가족지원	가족상담지원서비스 시범사업 (1차 12개 지역, 2차 13개 지역)	서비스 지역확대 (‘22년까지 전국 110개 운영센터로 확대)
	4. 노인 의료·요양체계	요양병원-시설 기능 미정립	지역사회 중심의 노인의료-시설-재가서비스 연계

2) 지역사회 통합돌봄 추진

지역사회통합돌봄이란 돌봄이 필요한 노인, 장애인 등 주민 누구자 병원 혹은 시설에 가지 않고 살던 곳에서 지역사회와 함께 어울려 살아갈 수 있도록 주거·보건의료·요양·일상생활 지원 등 정책의 종합적 변화를 추진하는 전략이다.

정부는 2018년 11월 ‘어르신이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낸다’는 슬로건 아래 「지역사회 통합돌봄 기본계획(1단계: 노인 커뮤니티 케어)」을 발표하였다.

이에 따라 2021년 1월 화성 및 춘천지역에 노인돌봄 전달체계 개편 시범사업을 실시하였고, 2021년 3월부터 융합형 선도사업(8개 지역)을 운영하고 있다.

융합형 선도사업이란 2026년부터 전국에서 보편적으로 지역사회 통합돌봄을 실행할 수 있도록 지역단위의 다양한 통합돌봄모형(모델)을 마련하기 위한 현장중심의 사회서비스 정책이다. 기존 유형별(노인, 장애인, 정신질환자) 개별 돌봄체계에서 노인-장애인 등 대상 유형과 관계없이 종합적 돌봄 수요에 대응 가능한 통합 돌봄체계 구축을 시도하여, 여러 유형에 중첩적으로 해당하는 대상자들의 공통된 특성, 문제 상황 및 욕구에 대한 통합적·효율적 접근을 의미한다.

현재까지 공단은 성공적인 지역사회 통합돌봄의 추진을 위하여 기반조성, 지역단위 거버넌스 참여 및 관계기관과 협업체계 구축, 의료·요양 연계, 법 제정과정 참여 및 지원을 수행해왔다.

2021년 강화된 공단의 역할로는 선도사업 공단역할 강화(특화)모형을 실행하고, 노인돌봄 전달체계 개편 시범사업을 추진하고 있다.

나. 한국형 케어매니지먼트의 개념

제2차 장기요양기본계획과 이용지원강화사업 등 관련 정책에서 논의된 한국형 케어매니지먼트 또는 한국형 사례관리 체계의 주요 특성을 정리해보면 다음과 같다.

- 1) 보험자인 국민건강보험공단과 제공기관인 장기요양기관의 상호연계를 통한 협업모델에 기초하고 있다. 공단은 케어조정자로, 제공자는 기관 사례관리자로 사례관리의 제반 과정에 함께 참여한다.
- 2) 수급자를 중심으로 한 사정과 계획수립, 실행과 평가의 순환체계를 구성하고 있다. 장기요양 수급자를 중심으로 장기적인 관점에서 사례관리를 단계적으로 시행하는 체계성을 확보하고 있다.
- 3) 수급자의 기능상태와 욕구에 따른 개별화된 서비스 계획수립과 실천을 강조하고 있다. 개인별장기요양이용계획서를 반영하여 개별 급여제공계획서로 작성함으로써 수급자 개인의 욕구에 대응할 수 있도록 한다. 공단의 개별이용계획은 인정조사 및 욕구조사에 기초하여 대분류(목표, 욕구, 필요서비스 내용 등) 포괄적으로 작성, 기관의 개별케어플랜은 목표 달성을 위한 세부 필요서비스 중심으로 작성한다.
- 4) 사례관리의 목적으로서 수급자의 욕구 충족과 문제해결과 함께 사회보험제도로써 장기요양급여의 책임성과 효율성을 높일 수 있어야 한다. 노인장기요양보험이 사회보험제도로 운영되는 만큼, 수급자 수준에서 사례관리의 목적을 달성하는 한편, 제도수준에서 노인장기요양보험의 목적을 달성하는데 기여할 수 있어야 한다.

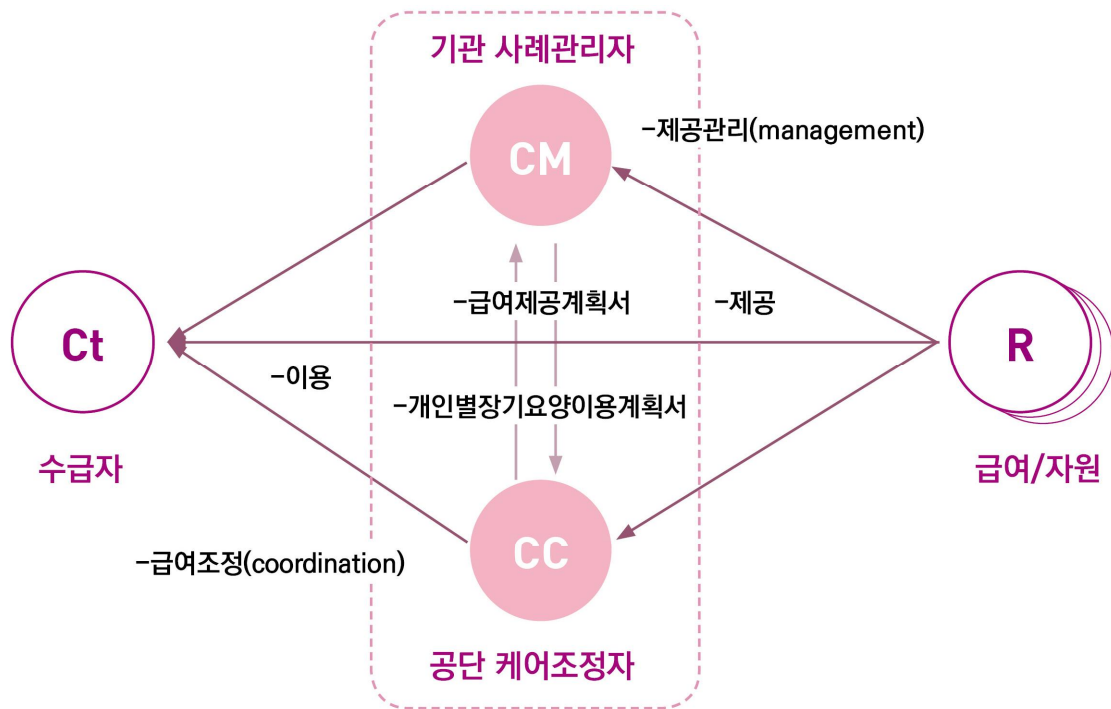
사례관리의 일반적인 개념정의와 한국형 케어매니지먼트 체계가 가지는 특성에 대한 검토를 바탕으로, 아래와 같이 개념을 정리해 볼 수 있다.

한국형 케어매니지먼트 체계는 ‘보험자인 국민건강보험공단의 케어조정자와 제공자인 장기요양기관의 기관 사례관리자가 개인별장기요양이용계획서와 개별 급여제공계획서를 통한 상호협력에 기초하여, 복합적인 욕구를 지닌 장기요양수급자를 대상으로 노인장기요양보험에서 보장하는 장기요양급여와 관련 자원을 연계, 조정, 통합하는 일련의 활동’이라고 할 수 있다.

이상의 특성들과 개념은 한국형 케어매니지먼트 체계의 성공적인 운영을 위한 조건들을 의미하기도 한다. 즉, 보험자와 제공자의 협업 및 의사소통, 사례관리의 체계성 확보, 개인별장기요양이용계획서와 개별 급여제공계획서의 연결 및 개별성 향상, 사회보험제도 내의 책임성 강화 등이 그것이다.

이상의 논의를 종합하여 한국형 사례관리체계의 전반적인 구조를 다음과 같이 도식화해볼 수 있다.

● 그림 2-11 한국형 사례관리체계의 이미지

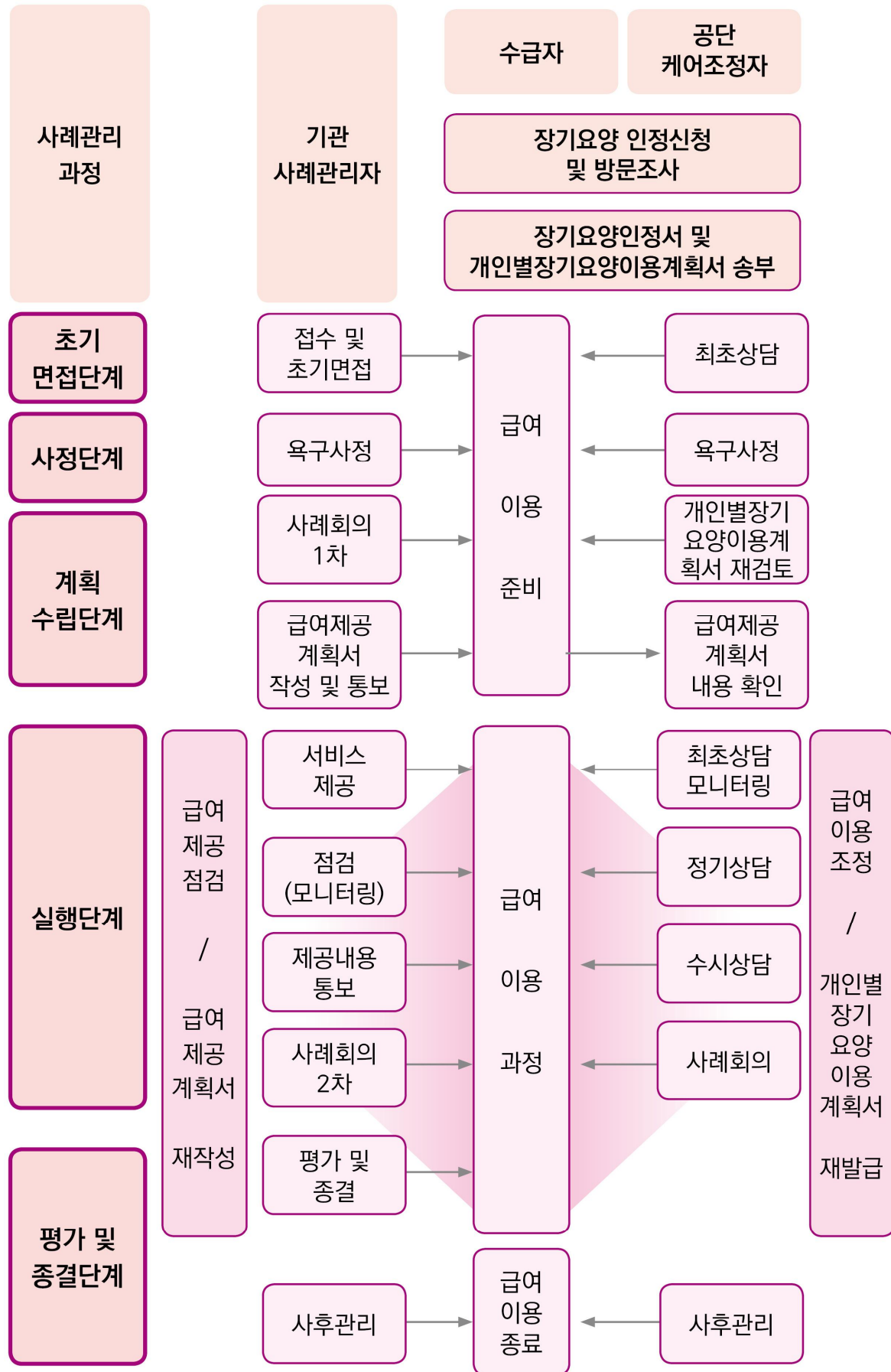


다. 공단 케어조정자와 사례관리자의 역할

넓은 의미에서 장기요양 사례관리의 시작을 장기요양인정 신청자에 대한 방문조사 시점까지 거슬러 올라갈 수 있겠으나, 이는 장기요양인정 및 등급판정을 통해 사례관리 수급자로서의 기본 자격을 확인하는 사전 단계로 보는 것이 타당하다. 본격적인 장기요양 사례관리의 시작은 장기요양인정신청 및 방문조사에 따라 장기요양인정서와 개인별장기요양이용계획서를 송부 받고, 실제 장기요양현장에서 수급자가 공단 케어조정자와 기관 사례관리자와의 접촉을 통해 급여이용을 위한 준비에 들어가는 시점부터라고 할 수 있다.

장기요양 사례관리의 과정은 일반적인 사례관리의 과정과 마찬가지로 초기면접단계, 사정단계, 계획수립단계, 실행단계의 순서로 진행한다. 다만, 각 단계에서 수급자를 중심으로 기관 사례관리자와 공단 케어조정자는 협력관계를 기반으로 각자 역할을 분담하게 되며, 이에 따라 각자 고유의 업무 내용을 수행하게 된다.

● 그림 2-12 장기요양 사례관리의 기본 절차 및 내용



공단 케어조정자는 상담을 통해 욕구사정, 개인별장기요양이용계획서 재검토, 급여제공계획 내용 확인을 실시한다.

앞의 그림은 공단(케어조정자)과 장기요양기관(사례관리자), 수급자의 사례관리 및 서비스 제공과정을 도식화한 것으로, 장기요양 서비스제공과 한국형 케어매니지먼트가 앞으로 나아갈 이상적인 방향이라고 할 수 있다.

공단과 장기요양기관은 수급자를 사이에 둔 카운터-파트너(Count-Partner) 역할로, 각 업무수행에 따라 파트너가 어떠한 업무를 진행할지 파악하여 수급자에게 질 높은 장기요양서비스가 제공되도록 노력해야 한다.

라. 공단 케어조정자의 장기요양 이용지원

1) 공단 케어조정자의 장기요양 이용지원 개요

「노인장기요양보험법」에서는 법 제48조에 따라 제도의 관리운영기관인 국민건강보험공단이 수급자 및 그 가족에 대한 정보제공·안내·상담 등 장기요양급여 관련 이용지원에 관한 사항을 관장하도록 하고 있으며(법 제48조제2항제7호), 수급자의 심신기능 상태와 욕구에 따라 급여이용과 관련된 정보제공·안내, 개인별장기요양이용계획서 작성·제공, 장기요양급여 이용 시 필요한 사항을 안내·지원하거나, 급여 미이용자에 대한 지속적 상담으로 수급권자의 욕구 파악 및 적절한 급여이용을 안내하고, 지역사회자원 연계 등 이용지원 수급자에게 다양한 정보를 제공하고 지원하도록 하고 있다.

이용지원은 장기요양 수급자가 오랫동안 지역생활을 영위할 수 있도록 관련 기반을 공고히 하는데 그 방향성을 두고 있으며, 이용지원 과정을 통해 장기요양 수급자는 인정조사단계에서 파악된 욕구에 맞춘 적절한 서비스를 이용할 수 있도록 안내하거나, 인정조사 당시와 비교하여 욕구가 변경된 경우 변경된 욕구를 반영한 개인별장기요양이용계획서를 제공받게 되며, 장기요양기관은 수급자별 개인별장기요양이용계획서를 바탕으로 세부적인 서비스 제공계획을 수립하여 요양서비스를 제공할 수 있게 된다. 또한, 장기요양기관과 국민건강보험공단의 정기적인 방문(모니터링) 및 상담과정을 통해 수급자는 변화하는 욕구 및 상태에 맞는 적절한 서비스를 제공받게 되는 등 긍정적인 효과를 기대할 수 있다.

2) 개인별장기요양이용계획서

수급자를 대상으로 장기요양현장의 기관 사례관리자와 공단 케어조정자가 수행하는 모든 장기요양 사례관리 과정과 이에 따른 업무수행의 기초가 된다.

현행 노인장기요양보험제도에서 개인별장기요양이용계획서는 ① 월 한도액 범위 내에서 수급자가 효율적인 장기요양이용계획을 수립하고 급여를 이용할 수 있도록 지원하고, ② 제공기관이 급여제공계획서를 작성하고 수급자에게 적절한 급여를 제공하도록 지원하며, ③ 종합적이고 효과적인 급여 제공을 위해 이용자와 서비스 제공자 간의 원활한 급여 이용을 돕고, ④ 수급자와 가족의 효과적인 이용계획의 수립을 지원하기 위한 목적으로 도입되었다.

따라서 개인별장기요양이용계획 수립에서는 수급자가 장기요양급여를 원활하게 이용 할 수 있도록 수급자별 적절한 장기요양급여의 종류와 양, 필요한 급여의 구체적인 내용 등 개별욕구를 반영하여 작성·제공하도록 하고 있다.

이용지원과정에서 수급자의 기능상태 변경, 목표 변경 시 개인별장기요양이용계획서를 재작성하여 발급할 수 있으며, 동일 수급자가 등급변경신청 등으로 인해 새로운 등급판정을 받게 되는 경우에는 등급판정 결과에 대한 개인별장기요양이용계획서를 신규로 발급하도록 하고 있다.

개인별장기요양이용계획서를 발급받은 수급자는 지역사회에서 해당 서비스를 제공하는 장기요양 기관들에 대한 정보를 취합하여 이용할 기관을 선택·결정한 후에 급여계약을 체결한다. 기관은 급여를 시작하기 전에 공단의 개인별장기요양이용계획서를 바탕으로 기관에서 실시한 수급자와 가족의 욕구조사 결과를 포함하여 세부적인 급여제공계획서를 작성하여 수급자와 그 가족의 동의를 받은 이후부터 장기요양급여를 제공한다.

3) 상담관리와 사례관리

상담관리란 수급자나 그 보호자인 가족 등이 수급자의 개별적 특성에 맞는 장기요양급여를 이용할 수 있도록 필요한 정보를 제공하고, 장기요양급여이용 절차와 방법 등을 안내하며, 수급자가 장기요양급여를 이용함에 있어 변화된 심신의 기능상태와 서비스 욕구를 개인별장기요양이용계획서에 반영하여 맞춤형 장기요양급여이용이 가능하도록 수급자의 급여이용에 대한 사례관리를 수행하는 과정이다.

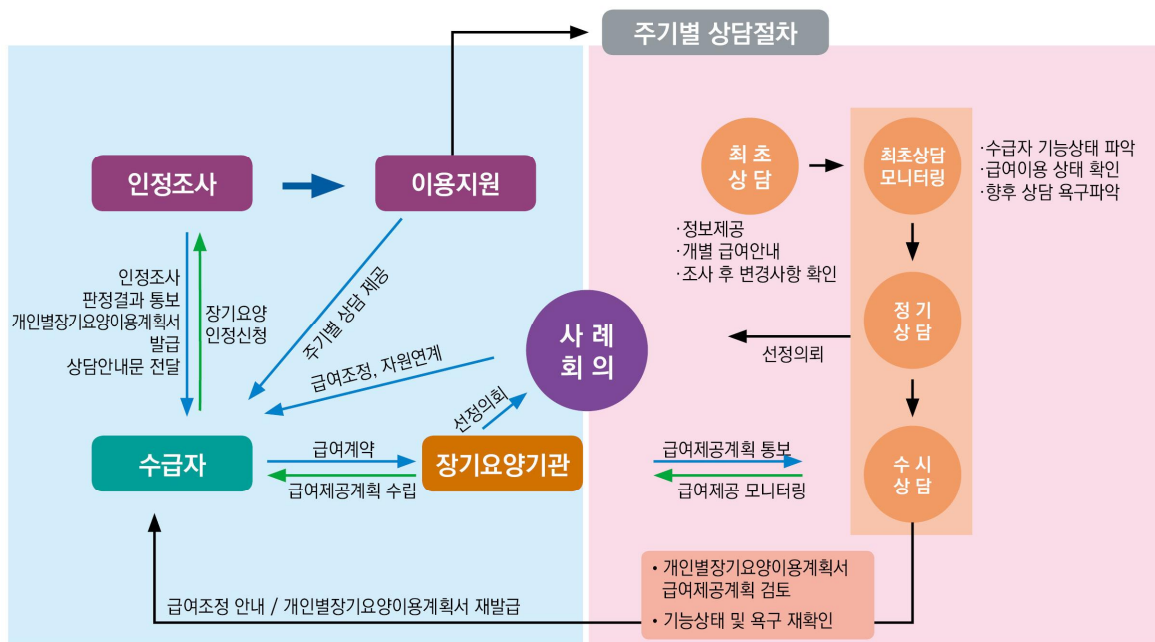
기본적 사례관리체계는 ‘[초기면접]-[욕구사정]-[급여계획 수립]-[서비스제공 및 점검]-[평가]-[종결]’의 단계를 거치지만, 공단이 수행하는 이용지원업무라는 보다 포괄적인 관점에서 보자면 장기요양 수급자의 사망 혹은 유효기간 종료 시까지 사례관리가 종결될 수 없으며, 또한 최초상담 시 이미 인정조사와 함께 기본적인 욕구조사와 개인별장기요양이용계획서 제공이 본격적인 사례관리의 전 단계에 실시된 상태에서 상담이 시작된다는 점에서 일반적인 사례관리 체계와는 차이가 있다.

장기요양 사례관리의 체계를 확장해보면, 다음 그림에서 보는 바와 같이, 「노인장기요양보험법」 제 27조에 따라 수급자가 인정서와 개인별장기요양이용계획서를 공단으로부터 발급받고, 장기요양기관은 개인별장기요양이용계획서를 바탕으로 수급자에게 급여제공계획서를 작성하여 제공하는 것으로 본격적인 사례관리를 위한 준비단계가 시작된다고 볼 수 있다.

공단은 케어조정자로서 수급자의 기능상태와 욕구를 재사정하고 필요시 개인별장기요양이용계획서를 재작성하여 발급하며, 기관에서 작성하여 제공한 급여제공계획서의 내용을 수급자의 욕구, 개인별장기요양이용계획서와 비교검토하고, 실제 급여제공내용을 확인한다. 기관은 사례관리자로서의 케어조정자보다 보다 더 세밀한 욕구사정으로 급여제공계획을 수립하고, 실제 급여제공에 계획이 잘 실현될 수 있도록 관리한다. 이 과정에서, 수급자의 기능상태와 욕구가 변화된 것을 발견하였다면, 수급자를 통하여 케어조정자에게 개인별장기요양이용계획서의 재작성·발급을 요청할 수 있다.

따라서 공단의 케어조정자 역할과 기관의 사례관리자 역할이 모두 수행이 되어야만 비로소 장기요양 사례관리가 이루어진다고 볼 수 있다.

●● 그림 2-13 상담관리와 사례관리



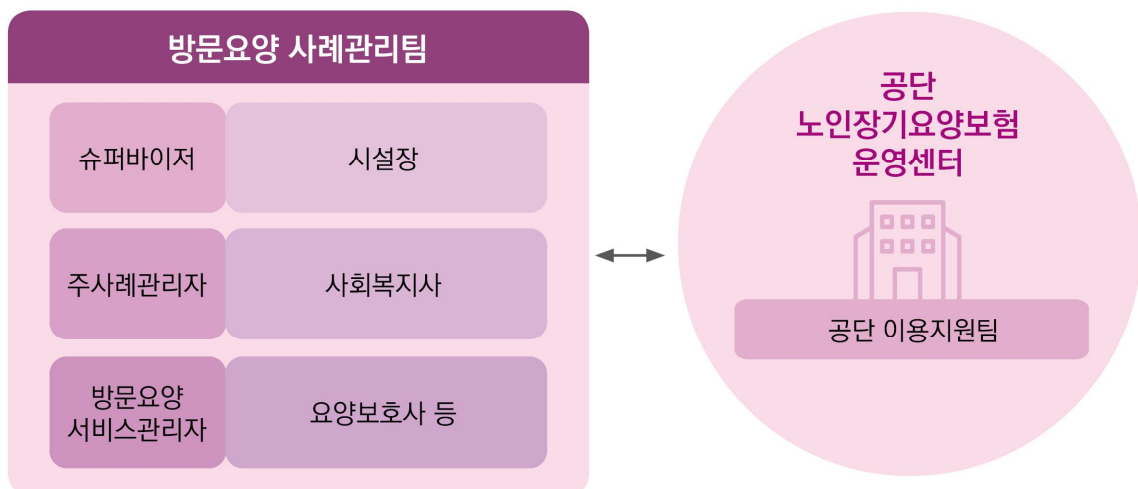
마. 기관 사례관리자의 업무

대표적인 재가급여인 방문요양의 사례관리는 방문요양기관 내 사례관리팀과 공단 노인장기요양보험 운영센터의 이용지원팀과의 협업을 통해 운영하여야 한다.

‘방문요양 사례관리팀’은 시설장, 사회복지사, 간호사, 요양보호사로 구성이 되며, 수급자의 생활환경 및 욕구조사에 기초하여 서비스 제공 계획을 수립하고, 서비스 제공에 대한 지속적인 모니터링을 통한 평가 및 서비스 조정 등을 수행한다.

‘공단 이용지원팀’은 공단의 케어조정자를 중심으로 구성되며, 주요 역할은 장기요양 수급자의 개인별장기요양이용계획서를 최종 확정하고, 서비스 제공 과정에서 복합적 욕구가 있는 수급자에게 방문요양 서비스를 제공하는데 한계가 있거나 위기상황이 있는 경우 사례회의를 통해 원활한 사례관리 진행을 돕는 역할을 담당한다.

●● 그림 2-14 기관 사례관리 운영체계(방문요양)



방문요양기관에서 수행해야 할 사례관리 과정은 ① 접수 및 초기면접, ② 욕구사정, ③ 사례회의 1차(내부회의), ④ 급여제공계획서 작성 및 공단통보(계약 및 조정), ⑤ 서비스 제공, ⑥ 기관 및 공단 이용지원 팀의 점검(모니터링)/제공내용 통보, ⑦ 사례회의 2차(필요시), ⑧ 평가 및 종결/사후관리로 구분해 볼 수 있다.

● 표 2-9 사례관리 실천과정

①	접수 및 초기면접	- 수급자의 장기요양인정서와 개인별장기요양이용계획서 확인 - 사회복지사 초기상담 - 수급자 가능여부 평가(→ 필요시 타 기관정보제공 및 의뢰)
②	욕구사정	건강영역, 신체기능 및 사회생활기능영역, 인지기능 및 행동변화영역, 가족 및 사회관계영역, 주거상황영역, 가족케어능력영역, 수급자의 강점 및 약점, 자원파악
③	사례회의 1차 (내부회의)	- 참석범위: 시설장, 사회복지사, 수급자와 가족, 요양보호사 등 - 회의주제: 욕구사정 공유와 케어플랜수립에 관한 의견수렴
④	급여제공계획서 작성 및 공단통보	- 사례회의(내부회의)를 통해 수렴된 의견을 반영한 급여제공계획 작성 송부 - 사례관리의 목표수립 - 서비스내용과 제공계획수립
⑤	서비스 제공	- 수급자와 서비스 제공 계약 - 급여제공계획에 따른 서비스 진행 - 수급자와 공급자 동의 후 공단통보
⑥	기관 및 공단 이용지원팀의 점검 (모니터링) / 제공내용 통보	- 월 1회 모니터링 - 급여제공내용 모니터링 - 모니터링 결과에 따른 조치 - 이용지원 상담과 모니터링
⑦	사례회의 2차 (필요시)	- 공단 케어조정자, 기관 사례관리자 - 사례회의가 필요한 경우 - 위기상황의 발생, 욕구재사정이 필요한 경우 등 기관 내에서 해결되지 못하는 문제 대상 → 개인별장기요양이용계획서 재작성(필요시)
⑧	평가 및 종결/사후관리	- 목표 달성, 급여제공 결과, 서비스이용자 만족도 등을 평가 - 사후관리계획 수립 - 서비스 중단(예, 거주이전, 요양시설(병원) 입소 등) 시 종결

방문목욕에 대한 사례관리는 수급자의 기능상태에 따라 목욕서비스 제공계획을 수립하고 실행하는 것이 중요한데, 특히, 수급자의 서비스제공 전과 도중, 제공 후의 상태변화를 확인하고 필요한 기록과 조치를 취할 수 있도록 하는 것도 중요하다.

방문간호는 책임자의 사례관리 활동을 통해 수급자의 보건의료 및 간호적 욕구를 파악하고, 이에 대한 개입 필요성에 따라 실제 방문을 통한 제공인력들이 적절한 조치를 취할 수 있도록 관리하는데 중점을 두어야 할 것이다.



2021년도
사회복지사 교육교재



제 3 장



장기요양기관
사례관리실무 기본

1. 초기면접단계	58
2. 사정단계	67
3. 계획수립단계	89
4. 실행단계	104
5. 평가 및 종결 단계	119



03

장기요양기관 사례관리실무 기본

1 초기면접단계

학습목표

- 초기면접의 정의와 내용을 이해하고 설명할 수 있다.
- 초기면접에 요구되는 기본원칙을 설명할 수 있다.
- 초기면접 시의 유의사항을 숙지하고, 실행과정에 따라 수행할 수 있다.
- 초기면접을 위한 실천기술을 이해하고 활용할 수 있다.

가. 초기면접의 개념

초기면접은 사례관리의 최초 과정으로서 인테이크(Intake)라고도 하며, 사례관리자가 클라이언트를 발견하여 새로운 도움 환경에 적응하고 문제해결을 위한 파트너십을 형성할 수 있도록 돕는 초기 접촉(The Initial Contact)단계라고 할 수 있다.

초기면접의 핵심 과업은 서비스 요청에 대한 정보를 수집하여 기관의 사례관리서비스 대상으로의 적합성을 판정하여 수급자를 '선정(Screening)'하는 것이다. 즉, 해당 기관이 본연의 사업범위나 서비스 역량으로 서비스를 제공할 수 있는 수급자인가에 대한 판단이 이루어지는 과정으로, 수급자의 이용자격이나 조건을 파악하여 확정하는 과정으로 이해할 수 있다.

이를 위해 초기면접과정에서 사례관리자는 수급자에 대한 기본 정보를 수집하고 필요한 서류를 기록하는 한편, 기관에 대해서도 기본 정보와 서비스 상황에 대한 전반적인 안내를 함께 제공하여야 한다.

초기면접 과정에서 이루어지는 정보수집활동이나 신뢰관계(라포) 형성은 수급자 선정을 원활하게 수행하기 위한 과정으로, 그 자체가 목적이 아님에 유의하여야 한다. 초기면접과정에서 수급자로 적합하지 않다고 판단되었을 경우는 즉시 관련 정보를 제공하거나 신속하게 외부자원으로 의뢰를 실시하는 것이 보다 바람직하다.

나. 초기면접의 경로

사례관리자가 수급자를 만나게 되는 경로는 다양하다. 현장에서 사례관리자는 수급자를 자신의 기관 혹은 가정방문, 전화면접 등을 통하여 처음 접하게 된다. 사례관리자가 수급자 초기면접을 하게 되는 접촉방법과 경로를 유형화해보면, (1)자기의뢰, (2)의뢰, (3)발굴(아웃리치)로 구분해 볼 수 있다.

1) 자기의뢰

수급자의 직접 요청에 의한 접촉으로, 수급자 스스로 사례관리자를 찾아와 서비스를 의뢰하는 경우를 의미한다. 수급자 신청을 통한 사업(예. 복지관 여가프로그램, 노인일자리사업 등) 참여 시 나타날 수 있는 형태이나 흔하지 않은 방법으로, 특히 장기요양현장에서 초기면접을 위해 수급자가 단독으로 장기요양기관을 찾아오는 경우를 상정하기는 곤란한 측면이 있다. 자기의뢰 방식으로 찾아오는 수급자는 일반적으로 서비스에 대한 참여의지가 크기 때문에 사례관리자의 개입과 변화 유도가 상대적으로 용이할 수 있다는 장점이 있지만, 반면 과도한 요구나 기대를 하는 경우도 있

으므로 초기 면접과정에서 선정기준과 기관에 대한 정보를 명확히 전달하는 것이 필요하다.

2) 의뢰(외부의뢰, 내부의뢰)

외부인 또는 외부기관에 의한 접촉으로, 수급자의 가족이나 이웃, 지역사회 조직과 관련 기관으로부터 지원이 필요한 수급자를 의뢰받는 경우를 의미한다. 가장 빈번한 형태의 접촉 방법으로, 다시 외부의뢰와 내부의뢰로 나누어볼 수 있다. 외부의뢰는 사례관리자가 외부로부터 수급자를 연결 받거나 반대로 의뢰자가 되어 수급자를 외부 자원으로 연결하는 형태다. 내부의뢰는 사례관리자가 속한 조직 내에서 이루어지는 형태로, 기관 내부에서 담당 부서나 팀 간에 이루어지는 의뢰를 의미한다.

3) 발굴(아웃리치, Outreach)

지역사회에서 사례관리자가 잠재적 수급자를 직접 발굴하여 접촉하는 방식으로, 욕구를 가지고 있으나 기관을 찾지 않는 수급자에게 서비스의 접근성을 높이기 위한 적극적인 방법을 의미한다. 효과적인 아웃리치의 수행을 위해서는 잠재적 수급자 발견을 위한 지역사회 정보를 충분히 파악하고 있어야 하며, 발굴한 수급자가 서비스 제공체계 안으로 들어올 수 있도록 격려와 지지가 필요하다. 아웃리치 활동은 비정기적인 것보다는 정기적으로 수행하는 것이 바람직하다.

다. 초기면접의 기본원칙

사례관리자가 초기면접을 수행할 때 수급자와 사례관리자의 신뢰관계 구축을 위해 지켜야할 기본 원칙들이 있다. 바이스텍의 원칙(The Biestek's Principles, 1957)은 초기면접단계에서 사례관리자가 숙지해야 할 원칙으로 수급자나 그 가족에게 상담 지원을 할 때 매우 유용하게 활용할 수 있다(오카다, 2011).

1) 개별화(Individualization, 수급자를 개인으로 파악)

수급자의 생활 욕구나 생활 과제 등이 다른 이용자와 같다 하더라도 그 욕구가 나타나게 된 배경이나 생활 환경 등은 각각 다르기 때문에 그와 관련된 배경과 생활 환경 등을 분석하고 이해해야 한다.

2) 의도적 감정 표현(Purposeful Expression of Feelings, 수급자의 감정 표현을 존중)

수급자가 상담을 받을 때 다양한 감정이 생긴다는 것을 잘 이해해야 한다. 그리고 감정을 쉽게 표현할 수 있는 분위기를 만들어서 수급자의 감정을 정확하게 파악해야 한다. 사례관리자 앞에서 다양한 감정을 표현할 수 있다는 것은 두 사람 사이에 서서히 신뢰 관계가 구축되고 있음을 의미한다.

3) 통제된 정서적 관여(Controlled Emotional Involvement, 자신의 감정을 자각·조절)

수급자의 이야기를 들으면서 여러 가지 감정이 생기게 된다. 이때 사례관리자는 자신의 감정이 어떻게 변화되는지 올바르게 파악하고 적절히 조절하면서 수급자의 이야기에 귀를 기울여야 한다. 사례관리자가 자기 반성을 하거나 수퍼비전(Supervision)을 받는 것은 매우 중요하다. 사례관리자는 수급자 자신 또는 타인에게 해를 주지 않는다면 수급자의 생각이나 행동에 대한 편견을 버리고 먼저 받아들이야 한다. 또한 왜 그런 생각이나 행동을 했는지에 대해 깊이 이해하도록 한다.

- 4) 수용(Acceptance, 수급자의 있는 그대로의 모습을 받아들임)
클라이언트의 장점과 단점, 잠재력과 제한, 바람직한 행동이나 바람직하지 않은 행동, 긍정적 감정과 부정적 감정 등을 가진 실제로 있는 그대로의 모습을 받아들이야 한다.
- 5) 비심판적 태도(The Nonjudgmental Attitude, 수급자를 일방적으로 비난 금지)
수급자는 어떤 일에 실패하거나 간혹 부적절한 말과 행동을 하는 경우가 있다. 이때 사례관리자는 그로 인해 수급자의 인격이나 가능성 등을 부정적으로 판단하거나 일방적으로 질책해서는 안 된다.
- 6) 이용자의 자기 결정(Client Self-Determination, 수급자의 자기 결정을 돕고 존중)
수급자가 결정한 내용이 자신 또는 타인에게 해를 주지 않고 공공 복지에 위반되지 않는다면 사례관리자는 수급자의 능력이나 내용의 타당성을 판단하여 결정하는 데 필요한 정보를 제공한다. 그 결과 어떤 일이 생길 수 있는지 예상하여 수급자의 결정을 돕고 그 결과를 존중하며 지켜본다. 사례관리자는 수급자가 중요한 문제를 스스로 결정했을 때 그 결과를 존중해야 한다. 그리고 자기 결정을 실행하기 위해 수급자와 함께 준비하고 연구해야 한다.
- 7) 비밀 유지(Confidentiality, 비밀유지 및 신뢰획득)
상담을 통해 알게 된 내용을 수급자의 허락 없이 제3자에게 공개하지 않겠다는 약속이다. 그리고 이를 지킴으로써 사례관리자와 수급자 사이에 기본적인 신뢰 관계가 형성될 수 있다. 여기서 ‘비밀’이란 수급자의 개인정보(생년월일, 주소, 출신지, 연락처, 가족 구성, 병명 등), 수급자가 말한 내용, 사례관리자가 기록한 내용 등이다.

라. 초기면접의 실제

1) 기본 관점

초기면접과정에는 사례관리자와 수급자만이 아니라, 가족이나 의뢰인, 또는 후견인이 참여할 수 있다. 이들 간에 문제나 상황에 대한 인식이 서로 다를 수 있으며, 기관과 사례관리자에 대해 요구하는 희망이나 기대하는 역할도 다를 수 있다. 즉, 초기면접 시 사례관리자와 수급자 본인, 가족 등의 입장과 견해의 차이가 발생하기 쉽다.

초기면접의 중심 과업은 수급자 선정에 있으며, 이를 위해서는 주된 욕구에 대해 사례관리자와 수급자, 가족이 동의해야하고 이것이 해당 기관에서 제공할 수 있는 서비스 방향이나 내용과 일치해야 한다. 따라서 사례관리자는 초기면접과정에서 이들의 요구와 반응을 신중하게 파악하고 대응하여야 한다. 의견의 차이가 크다면, 상황을 지켜보며 합의를 유도하거나 기다려야 하는 경우도 있을 수 있다. 또는 의견의 차이를 줄이거나 합의를 할 수 있도록 초기면접을 1회로 한정하는 것이 아니라 필요에 따라 몇 차례로 나누어 진행하는 방식도 고려해볼 수 있다.

2) 초기면접의 과정

가) 초기면접의 기본 절차

초기면접은 사례관리자와 수급자가 상호신뢰를 구축하는 첫 단계로, 장기요양 급여제공에 적합한지를 판단하고, 급여제공을 위한 계약의 여부를 사전에 검토해볼 수 있다는데 중요한 의미가 있다.

초기면접은 이후에 이어질 본격적인 사정단계와는 구분되나, 그 과정에서 기본적인 사정이 시작된다고 할 수 있다. 그 이유는 사례관리자가 초기면접을 통해 해당 기관의 수급자로서 적정

성을 판단할 수 있어야 하기 때문이다. 예를 들어, 상담실에서 수급자가 기다리거나 걸어 들어오는 모습, 수급자와 가정에서 첫 인사를 나누거나 생활하는 모습에 대한 관찰에서부터 초기면접만이 아니라 기초적인 사정이 시작된 것으로 볼 수 있다.

초기면접과정을 진행순서에 따라 보다 세부적으로 정리해보면 다음과 같다.

(1) 자기소개

상담자가 소속된 기관에서 제공할 수 있는 서비스를 안내

(2) 소개경로 확인

누구에게 어떤 내용을 소개받아서 왔는지, 스스로 찾아온 것인지 확인. 소개경로에 따라 상담 동기가 달라 수급자로 맞지 않는 경우도 있음.

(3) 상담장소 설정

수급자와 상담자의 위치(앉는 각도나 거리 등) 정하기. 상담자가 어느 위치에 앉느냐가 중요하기에 상대방의 몸과 마음의 상태에 따라 가장 적당한 거리 파악.

● 그림 3-1 초기면접에서 수급자와 상담자의 앉는 각도와 거리

- 초기면접에 익숙하지 않은 사례관리자가 수급자와 사무실 등에서 면접을 할 때에는 정면을 피해서 약 45도 정도로 마주 앉으면 서로의 직접적인 시선을 피하여 편하게 대화를 나눌 수 있으며, 상황에 따라 다양한 위치에서 진행할 수 있다.



(4) 수급자 정보 수집

수급자의 말을 주의깊게 듣고(경청), 관찰(언어 및 비언어 커뮤니케이션의 모든 정보에 주의를 기울임). 예를 들면 말투의 경우에 목소리의 상태와 변화, 이야기하고 있을 때의 표정, 태도, 앞으로 예상되는 감정이나 태도, 그렇게 해서 알게 된 감정이나 태도가 이야기의 내용과 일치하는지의 여부를 확인. 또한 누구에게(우선 본인, 그 다음으로 가족, 후견인 등) 무엇을 듣는가가 중요하며 꼭 들어야 하는 정보가 아니라면 묻지 않도록 함

(5) 수급자 상황 파악

핵심적인 사항을 찾아내고 자신의 눈앞에 있는 수급자가 지금 어떤 상황에 있는가(포지셔닝) 파악

- 문제를 네 가지로 나누어 상황을 파악(호소/트러블/욕구/요구)
- 인식할 수 있는 것과 숨겨져 있는 것을 파악
- 이용자의 진실성을 파악
- 현실에서 일어난 일(사실)과 감정(이용자가 마음속으로 원하는 간절함)을 이해

(6) 문제를 명확히 도출

문제의 핵심과 주변 문제를 분명히 구분. 욕구의 발견과 대처 또는 해결을 위한 우선순위 정하기

- (7) 공통된 인식 공유
수급자와 사례관리자의 문제파악 방법 혹은 욕구 맞추기
- (8) 지원목표(과제) 설정
지금 해결할 문제와 앞으로 일어날 수 있는 문제를 구분.
- (9) 지원방법 결정
누가, 어떤 과제를, 어떤 방법으로, 언제까지 해결할 것인지 계획. 수급자가 할 수 있는 일과 지원자가 해야 하거나 도와줄 일을 구분하고 이때 수급자의 자기결정을 최대한 존중
- (10) 향후 지원계획 확인
지원계획은 과제 달성의 진전에 따라 평가하고, 수정해 나아갈 수 있음을 설명
- (11) 마무리(종결)
전문가 지원에는 항상 시간적 제약과 일정한 룰이 있으므로 좋은 헤어짐으로 마무리.

나) 장기요양기관(방문요양)의 적용

장기요양기관(방문요양)에서 이루어지는 초기면접의 과정의 주요 제공방법을 살펴보면 다음과 같다.

- (1) 기관 이용에 대한 상담접수 및 필요시 방문일정 결정
이용을 원하는 수급자나 가족 등의 관련 문의를 전화, 내방 등을 통해 접수. 수급자에 대한 기본적인 사항(장기요양 등급인정 여부, 기초생활보장수급권자 자격 여부 등)을 체크
- (2) 초기면접(Intake) 과정
관리지침에 따라 담당자가 초기면접 수급자를 선정. 수급자나 가족이 제출한 장기요양 인정서 및 개인별장기요양이용계획서에 기재된 사항에 대해 충분히 숙지. 기타 면담일지 등을 토대로 수급자와 가족의 기본 정보와 수급자의 신체 및 정신적 기능 파악.
- (3) 기관의 기본정보 및 특성 설명하고, 방문목적 및 경로 등 파악
수급자 정보수집에만 집중하지 말고, 이와 관련한 기관정보를 충분히 제공함으로써 상호 신뢰관계(라포) 형성. 기관 기본정보 및 이용안내 브로슈어와 책자 활용가능.
- (4) 수급자 및 가족 욕구(Needs) 파악
수급자나 가족이 주로 호소하는 어려움, 어려움이 발생한 배경, 누구와 어려움을 상의하는지 등을 파악. 상담과정에서 수급자와 가족의 삶을 존중하고, 이들이 그들의 어려움이나 문제를 해결하기 위해 노력해온 나름대로의 과정을 존중하는 자세 필요. 경청은 수급자나 가족이 하는 말을 주의 깊게 들어주고, 수용적 입장에서 인정해 주는데서 시작
- (5) 수급자 및 가족의 문제·기대를 기록
기관에서 사용하는 초기면접지, 초기상담기록지 등 양식을 활용하여 가능한 수급자의 관점에서 진술문의 형태로 기록. 이를 통하여 사례관리자가 변동되더라도 똑같은 질문을 할 필요가 없으며, 대화의 이면에 숨은 수급자나 가족의 욕구를 파악 가능



point

초기 상담지는 다양한 양식들이 사용되고 있으나, 내용의 작성은 사례관리자의 언어보다는 피상담자의 말을 '진술문'의 형태로 그대로 기록하는 것이 바람직하다
(예. 이동지원이 필요함. → “짧은 거리도 걷기가 어려워요”)

- (6) 해당기관의 이용자로 선정(Screening)되었다면, 서비스제공 및 이용을 위한 계약과정 진행 및 필요사항 등 안내
계약은 효과적인 서비스를 위한 관계를 형성하는 과정이며, 이용자에게 기관이 제공하

는 서비스의 내용과 그 한계에 대한 정보 제공. 계약서와 각종 필요서류(장기요양인정서, 개인별장기요양이용계획서 등)를 확인하고, 수급자의 성명, 성별, 생년월일, 등급현황, 건강상태현황, 의료서비스 욕구 파악에 있어서 필요한 정보를 수집



point

계약 시 필요 서류: 장기요양인정서, 개인별장기요양이용계획서 등



주의

신원확인 및 관계 증명을 위한 서류 접수 시 주민등록번호 수집에 유의해야 한다. 가급적 생년월일을 기재.(2014년 8월 7일부터 법령상 근거없이 주민번호를 불필요하게 수집하는 행위 금지. 「개인정보보호법」 제 24조 2항)

수급자 서비스제공 개시 예정일자 등을 최종 결정. 계약서 작성 후, 기관과 수급자(보호자)가 각각 1부씩 계약서 보관



point

시작일자, 준비물 등은 구두만으로 안내하는 것보다는 안내자료를 작성하여 전달하는 것이 바람직하다.

(7) 필요시 이용에 따른 승인절차 구비

수급자가 기초생활보장수급권자 등일 경우 계약체결 사항에 대한 내용을 반드시 관할 시·군·구청장의 승인 필요.

(8) 요양요원 인력상황 등 서비스제공이 어렵다면 그 이유를 충분히 설명하고 타 기관으로의 안내 혹은 자원의뢰

서비스제공이 어려운 이유를 충분히 이해할 수 있도록 설명하여, 기관이나 상담자에게 거절당했다고 생각하는 등 부정적인 의심이나 불필요한 오해를 하지 않도록 함

다) 초기면접을 수행하는데 있어, 유의사항을 정리해보면 다음과 같다.

- (1) 초기상담 시 프라이버시를 보호하고 원활한 의사소통 가능한 별도의 장소를 선택한다.
- (2) 사례관리 과정에서 초기상담의 필요성·목적·과정에 대해 수급자와 가족에게 설명한다.
- (3) 수급자 정보를 파악하는데 급급하기 보다, 우선 기관에 관한 정보를 충분히 제공한다.
- (4) 충분한 시간을 가지고 수급자와 가족이 겪고 있는 어려움과 문제를 진술하도록 돕는다.
- (5) 수급자와 가족의 문제를 노출해야하는 부담과 불안감을 최소화할 수 있도록 감정을 안정시켜주는 것이 필요하다.
- (6) 급여계약을 체결할 때에는 수급자별 급여제공계획을 수립하고 수급자 또는 그 가족의 동의를 받아야 한다(「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제 6조제2항).

마. 초기면접과 기록

1) 초기면접의 기술

사례관리의 첫 단계인 초기면접과정에서는 수급자가 본인과 주변의 문제와 요구를 충분히 전달할 수 있도록 불안을 최소화하고 감정을 안정시켜 주는 노력이 중요하다. 이를 위해 적용해볼 수 있는 기술들을 ‘면접기술’과 ‘관계형성기술’로 구분하여 살펴보고자 한다.

가) 면접기술

초기면접에 적용해볼 수 있는 대표적인 면접기술로 소개기술, 경청기술, 피드백 기술을 들 수 있다.

(1) 소개기술

사례관리자가 수급자를 만나게 되는 과정에서 소속기관과 사례관리자 자신에 대해 알리는 기술이다. 방문요양서비스의 특성 상, 수급자는 낯선 사람을 자신의 거주공간에 맞이해야 한다는 부담이 있을 수밖에 없다. 사례관리자 자신과 기관에 대한 소개와 업무 내용에 대해 명료하게 설명하는 한편, 너무나 사무적으로 느껴지지 않도록 친근하고 쉬운 말로 설명하도록 하는 노력이 중요하다. 필요하다면 기관과 사업에 대한 소개를 담고 있는 자료를 함께 활용하는 것도 효과적이다.

(2) 경청기술

수급자의 말을 주의 깊게 듣고 인정하는 것을 의미한다. 여기에서 유의해야 할 것은 단순히 수급자의 말이나 주장을 잘 들어주거나, 감정이입을 하는 행위를 의미하는 것은 아니라는 점이다. 경청은 크게 2가지 단계로 구분되는데, 수급자의 말을 듣고 수용하는 인정(Acknowledgement)과 수급자의 주장을 받아들이는 동의(Agreement) 단계다. 중요한 것은 수급자의 말이나 주장을 인정하더라도, 반드시 동의할 필요는 없으며 바람직하지도 않다는 점이다. 이러한 측면은 실천적으로 2가지 의미를 가지는데, 초기면접과정에서 수급자의 말과 그동안의 경험, 노력을 존중하는 자세를 가지고, 수급자의 말과 주장에 대해 선불리 평가를 하거나 비판을 해서는 안 된다는 것이다.

Tip!

초기면접에서 경청은 인정(Acknowledgement)과 동의(Agreement)의 순서로 진행하되, 반드시 동의해야 하는 것은 아니라는 점에 유의하도록 한다. 예를 들어, 수급자가 청소나 식사 등 일상생활을 수행할 수 있음에도 이를 할 수 없다고 주장할 경우, 수급자가 이러한 생각을 하고 있다는 것을 인정하되, 이를 평가하여 비판적으로 접근하거나 반드시 수급자나 사례관리자의 판단에 동의하도록 할 필요는 없다. 초기면접과정의 목적이 수급자로서의 적합성을 판정하기 위해 다양한 정보를 수집하는데 있기 때문이다.

(3) 피드백 기술

수급자가 의사표현을 정확히 할 수 있도록 격려하는 방법이다. 대표적인 피드백 기술로 의역 또는 전환법(Paraphrasing)이 있는데, 수급자의 말을 사례관리자의 말로 바꾸어 다시 묻고 확인하는 것을 반복하는 기술이다. 이러한 과정을 통해 클라이언트의 욕구를 확인하고 사례관리자와 수급자의 이해를 명확히 할 수 있다.

나) 관계형성기술

사례관리자와 수급자 간의 신뢰구축기술과 질문기술로 나누어 설명해볼 수 있다.

(1) 신뢰구축기술

사례관리자와 수급자간의 사례관리 과정 진행을 위한 협력관계, 파트너십을 형성하는데 핵심적인 사항이다. 사례관리자는 수급자가 가진 문제나 요구에 관심을 가지고 있다는 점을 언어 또는 태도를 통해 충분히 전달할 수 있어야 한다. 이때 바로 수급자의 문제나 요구를 직접적으로 질문하고 파악하고자 하는 태도보다는 친숙한 분위기에서 수급자의 일상이나 가족에 대한 관심에서부터 시작하여 차츰 확대해나가는 방향이 바람직하다. 대화의 과정에서 사례관리자의 역량으로 대응하거나 책임질 수 없는 질문이 나오더라도 무리하게 답변을 하는 것보다는 솔직하게 표현하는 것이 신뢰관계 형성에 도움이 되며, 수급자가 부정적 태도나 반응을 보이더라도 사례관리자에 대한 개인적인 감정이 아니며, 함께 극복하고 회복하여야 할 부분임을 이해하고 설명하도록 한다.

(2) 질문기술

초기면접과정 전반에서 사례관리자가 수급자의 정보를 수집하기 위해 이루어지는 의사소통의 방식이다. 구체적인 질문의 방법으로 크게 개방형 질문과 폐쇄형 질문으로 구분해 볼 수 있다.

개방형 질문은 수급자가 평소 가지고 있는 자신의 생각이나 감정을 자유롭게 표현할 수 있도록 질문하는 방법이다. 수급자에게 충분한 의사표현을 할 수 있는 기회와 선택권을 준다는 측면에서 장점이 있으나, 반면에 의사표현이 원활하지 않은 수급자의 경우에는 적용하기 어렵다는 단점이 있다.

폐쇄형 질문은 수급자에게 몇 가지 선택적인 응답이 가능하도록 질문하는 방법이다. 단순한 단답형 질문(이름, 생일, 주소 등)이나 선택형 질문(예/아니오, 1번/2번 등)이 있으며, 인지나 언어기능이 저하된 수급자에 대한 질문에 활용도가 높으나, 예외적인 사항에 대한 정보를 얻기가 어려우며 자칫 따지는 듯한 상담으로 받아들여질 수 있다는 단점이 있다.

2) 초기면접지

사례관리자는 초기면접 시의 내용을 구체적으로 기록해 두어야 한다. 초기면접지의 기록에 있어 지켜야 할 사항을 정리해보면 다음과 같다.

가) 초기면접지의 내용에 기록하는 수급자 또는 가족의 요구나 문제, 도움요청 내용은 진술자의 표현 그대로 기록하는 원칙이다.



이를 '진술문'이라고 하는데, 수급자가 한 말과 표현, 태도를 그대로 기록하는 방식이다. 이렇게 할 경우 초기면접과정에서 파악하지 못했던 수급자의 요구(Want) 이면에 숨겨진 욕구(Needs)를 발견할 수 있으며, 만약 중간에 사례관리자가 변동되더라도 중복된 질문이나 답변을 하는 일을 방지할 수 있다.

나) 초기면접지 작성과정에서 수급자 여부에 대한 판단이 명확해질 경우, 초기상담의 중지 여부를 결정하거나 필요한 조치(정보제공, 자원연계 등)를 취한다.

다) 초기면접과정을 통해 수급자로 선정된 경우, 이후 연결할 사례관리 과정과 내용을 설명하고 동의를 받는 것이 바람직하다.

- 사례관리에서 수급자의 동의가 중요한 이유는 무엇보다 사례관리의 과정이 장기적인 만큼 수급자의 의지가 필수적이며, 수급자의 협조 없이는 실질적인 변화목표와 성과를 달성하기 어렵기 때문이다.

일반적으로 초기면접지는 각 기관의 특성이나 운영하는 사업의 특성을 반영하되, 수급자의 전반적인 상황을 포괄적으로 이해할 수 있는 것이면 좋다. 일반적인 내용은 다음과 같다.

- 초기면접 관련 정보: 일시, 면접자, 피면접자, 면접경로, 상담장소 등
- 수급자 기본 정보: 성명, 주소, 질환, 주부양자, 기능상태, 자격사항 등
- 도움 요청 내용: 주요 문제와 욕구, 수급자 요구와 희망 등
- 서비스 내용: 서비스 유형, 서비스 비용 등
- 면접자 평가: 기관의 사례관리서비스 대상으로 적합 여부 판정

● 표 3-1 초기면접지(예시)

일 시			접수번호		
피면접자	☐ 본인 ☐ 가족 ☐ 기타		면접자		
면접경로	☐ 본인요청 ()		☐ 사례관리자의 발굴		
	☐ 타 기관 의뢰 ()		☐ 기관 내부의뢰()		
	☐ 주민 의뢰 ()		☐ 기타()		
상담장소	☐ 가정 ☐ 내방 ☐ 전화 ☐ 지역사회 기관()				

수급자 성명			생년월일		
수급자 주소			장기요양인정번호		
수급자 주 질환	질환명:		장기요양등급		
주 부양자 정보	성 명:		인정유효기간		
	관 계:				
	연락처:				
재가급여 (월 한도액)	월당	원	본인부담금(율)	재가: %	
				시설: %	

개인별 장기요양 이용 계획서	장기요양 문제	장기요양 목표		장기요양 필요영역		장기요양 필요내용
	유의사항					
	수급자 희망급여					
이용자 욕 구	주된 호소내용	본 인		가 족 (주 부양자)		
	희망하는 서비스	서비스 이용 목적		희 망 서비스 내용		
	희망하는 서비스 이용계획					

개인별장기요양이용계획서 상의 이용계획 및 이용					
급여종류	횟 수		장기요양급여비용	본인부담금	
	주		원	원	
	월		원	원	
합 계			원	원	
이용계획 및 비용의 변경 필요 유무			☐ 변경 필요 ☐ 변경 불필요		
복지용구					

면접자 평가		
	대상 판정	☐ 대상(긴급/일반) ☐ 비 대상(정보제공/의뢰:)

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

2 사정단계

학습목표

- 사정의 정의와 내용을 이해하고 설명할 수 있다.
- 사정단계에서 요구하는 기본원칙을 설명할 수 있다.
- 실제 사정을 위한 다양한 척도를 숙지하고, 절차에 따라 수행할 수 있다.
- 사정단계의 실천기술을 이해하고, 활용할 수 있다.

가. 사정의 개념

사정(Assessment)은 사례관리자가 수급자의 복합적 욕구를 파악하여 구체화하고, 이후 합의과정을 통해 계획 및 실행 단계로 연결하는데 기본적인 목적이 있다.

사정단계의 핵심 과업은 계획수립을 위한 사전단계로서 수급자의 욕구를 체계적으로 파악하는 것이다. 즉, 초기면접이 수급자의 주관적인 희망이나 요구(Want)를 중심으로 파악하는 활동이라면, 사정은 전문가인 사례관리자가 객관적인 욕구(Needs)를 구체화하는 과정이라고 할 수 있다.

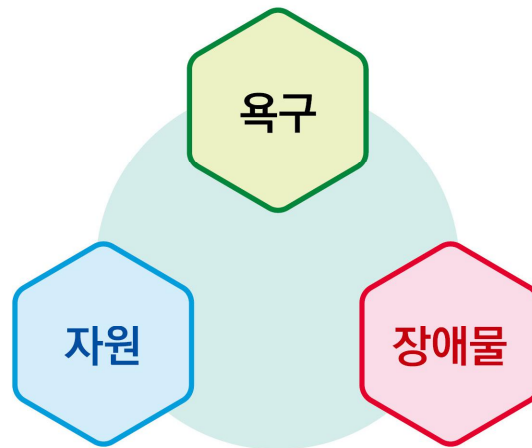
사례관리자는 사정단계에서 초기면접단계에서 수집한 자료와 함께, 기관이나 사례관리자의 특성에 따라 전문적인 사정도구를 활용하게 된다. 이때 사정도구들은 모든 수급자에게 공통적으로 활용하는 기본적인 것이 될 수도 있으며, 또는 개별 욕구에 대응하여 선택적으로 적용하는 내용이 될 수도 있다.

또한 사정은 초기면접과 계획수립단계의 중간에 기본적으로 위치한 활동이나, 실행과정에서 수급자의 신체, 정신, 사회적 측면 등 상태변화가 있다면 이를 재사정(Reassessment)하여, 계획의 변경과 수립에 반영할 수 있도록 하는 역할을 가지고 있기도 하다.

나. 사정단계의 내용

일반적으로 사정과정은 욕구사정 또는 욕구조사로 불릴 만큼, 욕구를 중심으로 한 활동이지만, 이는 사정 대상(영역)의 일부로 수급자가 가진 자원과 문제, 장애물에 대한 다차원적인 사정과 이를 종합하는 활동이 필수적이다. 이를 통해 사례관리자는 수급자의 욕구에 대응하는 한편, 자원을 최대한 활용하고 장애물을 제거하는 등의 활동을 계획에 반영하여 실행할 수 있게 된다. 이렇듯 사정은 수급자의 욕구사정, 자원사정, 장애물사정의 3가지 영역으로 구분할 수 있으며, 이들을 종합한 다차원적인 접근이 중요하다.

●● 그림 3-2 사정의 3가지 영역



1) 욕구사정

가) 욕구(Needs)의 개념

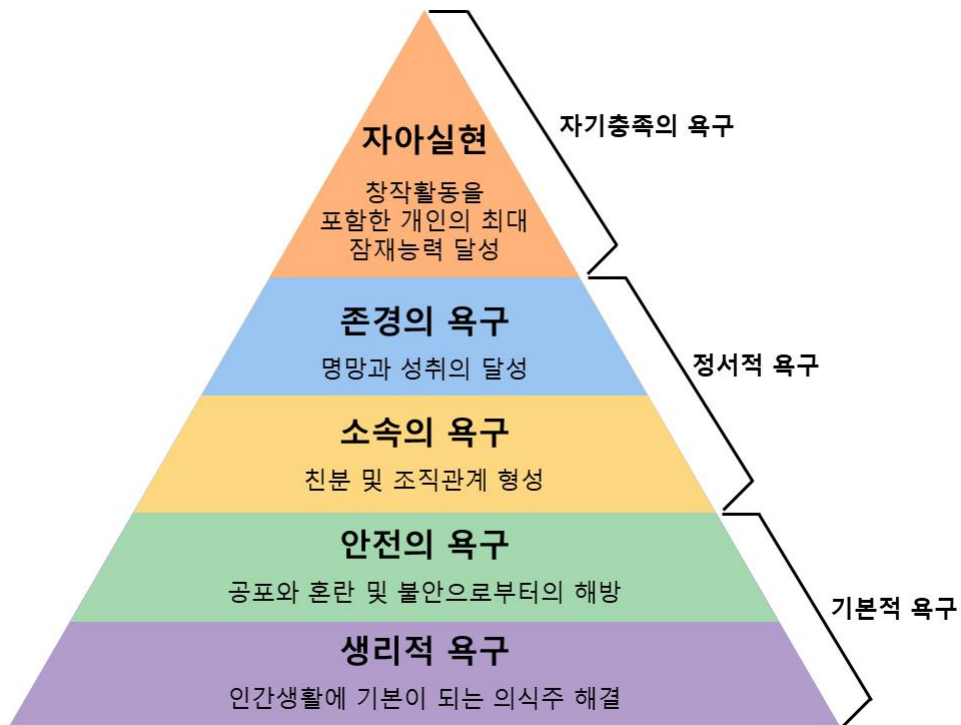
전문가로서 사례관리자가 판단한 객관적인 필요도를 의미한다. 반면, 요구(Want)는 수급자가 판단한 주관적인 희망, 문제(Problem) 등 해소 또는 제거해야 할 대상을 의미한다. 욕구사정은 주로 수급자나 가족과의 직접 대면을 통한 자료수집의 방식으로 진행되며, 이때 사례관리자는 수급자의 욕구에 대한 중립적인 입장을 견지하는 한편, 이를 구체적으로 확인하는 노력이 필요하다. 사례관리에 있어, 욕구는 수급자의 단순한 요구와는 구별되며 사례관리자가 수급자에 대한 필요도를 반영한 결과이며, 사례관리의 계획수립은 요구가 아닌 욕구에 기반한 것이어야 한다는 점에 유의하여야 한다.

나) 욕구의 내용

욕구사정의 대상이 되는 욕구 영역과 내용은 다양하게 정의된다.

우선, 인간의 기본욕구에 대한 설명으로 매슬로우(Abraham H. Maslow)의 욕구단계론(Theory of Need Hierarchy)이 가장 많이 알려져 있다. 인간의 근본적인 욕구는 크게 5가지 욕구로 구성되며, 가장 기본적인 것으로 생리적 욕구(Physiological Needs)에서, 안전욕구(Safety Needs), 소속의 욕구(Belongingness and Love Needs), 존경의 욕구(Esteem Needs), 자아실현 욕구(Self Actualization Needs)로 발전한다. 작동원리는 결핍과 충족의 과정으로 하위 욕구가 어느 정도 만족되어야(Relatively Well Gratified), 차상위계층의 욕구가 나타나는 것으로 설명하고 있다.

● 그림 3-2 매슬로우(Maslow)의 욕구단계설



한편, 목슬레이(Moxley, 1995)는 수급자의 욕구의 영역에 대하여 크게 소득, 주택 및 보호처, 고용 및 직업, 건강 및 보호, 정신건강, 사회적 관계 및 인간 상호적 관계, 여가선용과 휴식, 일상활동 관련 어려움, 이동수단, 법적 욕구, 교육, 기타의 12가지로 분류하고 있다. 욕구사정의 대상이 되는 욕구의 영역을 소득과 주택에서 여가와 교육에 이르기까지 다양하게 본 것이다.

● 표 3-2 욕구의 영역

① 소득	⑦ 여가선용과 휴식
② 주택, 보호처	⑧ 일상 활동 관련 어려움
③ 고용, 직업	⑨ 이동수단
④ 건강, 보호	⑩ 법적 욕구
⑤ 정신건강	⑪ 교육
⑥ 사회적 관계, 인간 상호적 관계	⑫ 기타

※ 주: 목슬레이(Moxley, 1995) 재인용

미국의 간호학자 고든(Gordon)은 노인에 대한 사정 영역으로 크게 6가지를 제시하고 있다. ①건강(건강한 생활을 지원하기 위한 관점), ②안전(안전한 생활을 지원하기 위한 관점), ③자립지원(현재 가지고 있는 능력을 최대한 발휘할 수 있게 지원하는 관점), ④안심(안심할 수 있는 시간을 확보하기 위한 지원을 위한 관점), ⑤개별성(그 사람의 본연의 생활을 지속적으로 지원하기 위한 관점), ⑥지원체제(상호 협력을 지원하기 위한 관점)가 그것이다.

● 표 3-3 노인에 대한 사정의 6가지 영역

① 건강	건강하게 생활할 수 있도록 지원한다.
② 안전	안전하게 생활할 수 있도록 지원한다.
③ 자립지원	현재 지니고 있는 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원한다.
④ 안심	안심하며 즐겁게 생활할 수 있도록 지원한다.
⑤ 개별성	그 사람의 본연의 모습과 생활을 지속할 수 있도록 지원한다.
⑥ 지원체제	가족과 다양한 사회자원은 서로 협력하여 지원한다.

이처럼 사례관리와 사정과정에서 어디까지를 욕구의 범위와 내용으로 볼 것인가라는 문제를 일률적으로 말하기는 어렵다. 현실적으로는 기관의 유형과 제공하는 서비스의 내용, 소속된 사례관리자의 관점이나 전문분야에 따라 다를 수밖에 없는 것이 사실이다.

2) 자원사정

가) 자원의 개념

수급자가 가진 개인의 성격이나 태도, 자신감과 같은 내적 자원과 함께, 개인과 가족을 넘어선 외부의 공식적 비공식적 자원들을 포함한다.

자원에 대한 사례관리는 기본적으로 모든 사람은 문제를 해결할 수 있는 강점을 가지고 있고 이를 활용하는 것이 효과적이라고 보는 강점관점과 개인과 가족뿐만 아니라 이들을 둘러싸고 있는 지역사회와 문화, 그리고 클라이언트에게 영향을 주는 사회구조와 법, 제도 등의 거시적 환경까지 사정과 개입의 대상으로 보는 생태체계적 관점을 가지고 접근한다. 즉, 사례관리자는 수급자가 할 수 없는 것보다는 하고 있는 것, 가지고 있지 않은 것보다는 가지고 있는 것을 발견할 수 있어야 하며, 수급자를 둘러싼 지지체계에 존재하는 다양한 자원을 파악할 수 있어야 한다.

나) 자원의 내용

내부자원과 외부자원으로 나눌 수 있다.

내부자원은 수급자가 지닌 장점으로, 욕구 대응이나 문제 해소와 관련한 개인의 성격이나 능력, 태도나 자신감 등을 의미한다. 가족의 경우도 수급자에 대한 정서적 지지를 내부자원으로 볼 수 있다. 외부자원은 개인이나 가족의 범위를 넘어서는 자원을 의미하며, 비공식(Informal) 자원과 공식(Formal)자원으로 구분해 볼 수 있다. 공식적 자원은 지역사회에서 공식적인 제도나 사업에 의해 운영되는 기관이나 서비스들로, 이웃이나 친구, 민간조직 등 비공식적 자원과는 구별된다. 자원사정과정에서 자원을 파악하기 위해 흔히 사용하는 도구로는 가계도(Genogram)와 생태도(Eco-map Source)가 있다.

3) 장애물 사정

가) 장애물의 개념

수급자의 욕구 또는 문제해결을 방해하고 있는 것으로, 개입을 통해 제거 또는 해소해야 할 대상을 의미한다. 장애물사정을 통해 수급자가 가진 내적, 외적 장애물을 발견하고, 이를 제거함으로써 스스로 욕구를 충족시킬 수 있는 역량과 자원을 갖추도록 지원하는데 목적이 있다.

나) 장애물의 내용

내부 장애물과 외부 장애물로 구분해볼 수 있다.

내부 장애물은 수급자가 반복적인 욕구좌절과 문제에 봉착하면서 지니게 된 낮은 자존감과 자

기효능감, 또는 학습된 무기력, 비관 등을 의미한다.
 외부 장애물은 외적 환경으로 인해 수급자 개인이 겪게 되는 어려움이나 장애를 포함한다.
 벨로&밍크(Ballev&Mink)는 클라이언트가 일단 특정 유형의 내부장애를 갖게 되면 모든 문제 상황에서 그것들을 일반화하게 된다고 보았을 뿐 아니라 일반화의 종류도 다양하다고 주장한다. 예를 들면, 공격적 행동 혹은 접근 방식 같은 문제해결 방식을 사용하는 내부장애를 갖고 있는 클라이언트의 일반화는 클라이언트 스스로가 완전히 다른 새로운 종류의 경험을 하기까지는 이 같은 대처 방식을 지속적으로 사용한다는 것이다(한국사례관리학회, 2014).

● 표 3-4 내부 장애물의 유형

유형 구분	범 주	경험내용
비관주의	인생 경험	끊임없이 좌절을 경험했으며, 중요한 사람으로부터 기본적으로 사랑스러운 존재가 아니라는 메시지를 받아 왔다. 아동기 학대의 가능성이 크다.
	결 론	얼마나/어떻게 하든지 항상 잘못되어 있다.
	감정 상태	침체, 무관심, 비관적, 허탈함
	행동 상태	무기력, 후퇴, 퇴행
비판주의	인생 경험	비관론자와 유사함
	결 론	항상 불공평한 대접을 받아 왔으며 더 이상 그런 대우를 받을 필요가 없다.
	감정 상태	분노, 실패감
	행동 상태	비판적, 공격적, 트집 잡기
운명주의	인생 경험	유년기에 불안한 삶 즉, 좋은 경험과 나쁜 경험을 다 가지고 있지만 근거는 두려움이 있다.
	결 론	인생은 혼란스럽다. 그리고 예측 불가능하다.
	감정 상태	걱정
	행동 상태	충동적, 무질서, 계속되는 위기감
냉소주의	인생 경험	배신을 통한 실망 경험
	결 론	나를 이용할 것이다. 나만 자급자족할 것이다.
	감정 상태	외로움
	행동 상태	절제, 지나친 독립심, 거리감, 거부

※ 자료: 한국사례관리학회. 2014. 사례관리론

다. 사정의 기본원칙

사정을 할 때는 기본적인 원칙을 염두에 두고 진행하는 것이 중요하다. 그렇지 않으면 제공자 중심의 획일적이고 추상적인 내용이 될 가능성이 높다.

1) 수급자(클라이언트)의 욕구에 기초

사례관리의 목적은 수급자 본인의 입장에서 다양한 사회자원 등을 연계하여, 최대한 이득을 주는 것이다. 따라서 수급자의 입장에서 욕구를 관찰해야 하며, 이러한 관찰된 욕구의 뒤편에 또 다른 욕구나, 숨겨진 욕구, 잠재적 욕구까지도 사정해야 한다.

2) 수급자 욕구에 대하여 종합적이고 포괄적이며 과학적 근거나 논리에 입각

수급자 욕구는 앞에서 설명한 것처럼 매우 다양하고 복잡하기 때문에 단편적이거나 단락적인 사항이 아닌 심신의 기능과 사회적 환경까지 종합적이고 포괄적으로 파악하는 것이 중요하다.

3) 여러 관련 전문분야가 상호제휴하고 연계

수급자의 상황을 종합적이고 포괄적으로 사정하기 위해서는 의료, 보건, 복지, 영양, 건축 등 전문가가 참여하여야 하며, 직접적으로 참여가 어려운 전문분야에 대해서는 관련 전문가와 긴밀한 연계를 통하여 정보와 조언 등을 얻어야 한다.

4) 임파워먼트의 관점에서 수급자와 전문가가 적극적으로 참여

수급자의 부정적인 것만이 아닌 아직 남아있는 능력이나 기능을 최대한 활용하고 수급자 개인의 자존감을 높이기 위하여 임파워먼트의 시점에서 사정을 진행할 필요가 있다. 또한 사례관리자의 가치와 철학, 처지와 역량, 기회비용, 수급자와의 관계를 생각하여 잘 도울 수 있는 요구를 선정하는 것도 고려한다(김세진, 2014)

5) 내용이 구체적

사정이 구체적이지 못하면 케어플랜도 구체적일 수 없고, 그렇게 되면 실행에 있어서도 추상적이 되어 효과성 있고 실현가능한 지원을 할 수 없다.

라. 장기요양의 욕구사정 내용

이와 같이 수급자에 대한 욕구조사 및 욕구사정은 수급자에 대해 기본사항에서부터 수급자의 상태에 대한 다양한 영역의 정보수집(신체기능, 사회생활기능, 인지기능, 행동변화영역, 간호처치영역, 재활영역, 복지요구에 대한 요구, 형태, 시력 및 청력 평가, 질병 및 증상), 생활력, 환경 및 자원에 대한 정보수집 등을 바탕으로 면밀히 분석되어야 하는 과정이다.

실제로 노인장기요양보험제도에서는 인정조사 실시 과정에서 이러한 정보가 수집되어 등급판정의 근거자료로 활용되며, 수급자의 욕구에 대한 부분은 개인별장기요양이용계획서에 담아 수급자에게 제공된다. 기관은 이를 바탕으로 세부적인 수급자의 상태와 욕구를 파악하기 위하여 급여종류별로 기관의 특성에 맞는 양식을 사용하고 있다.

장기요양기관평가에서는 수급자에 대한 욕구사정(평가)을 연 1회 이상 정기적으로 실시하며, 특히 욕구평가 8개 항목(신체상태, 질병상태, 인지상태, 의사소통, 영양상태, 가족 및 환경상태, 주관적 욕구, 자원이용)에 대해 욕구평가를 실시하도록 하고 있고 이를 평가기준으로 설정하고 있다. 단 항목별 욕구사정이 체크리스트로 작성된 경우 판단근거를 제시하도록 하고 있고, 총평에서 종합소견을 서술형으로 작성하도록 가이드라인을 설정해 두고 있다.

장기요양욕구를 가진 수급자의 구체적인 욕구조사 및 사정을 하기 위해서는 사례관리자 및 서비스 제공기관 능력 여부에 관계없이 일정 수준의 수급자의 상태를 제시해 줄 수 있는 표준화된 사정도구의 개발과 활용이 필요하다. 영역별 사정되어야 하는 구체적 내용에 대해 살펴보면 다음과 같다.

1) 질병상태

장기요양욕구를 가진 수급자를 대상으로 하는 심층적 욕구사정에서 기본적으로 파악해야 하는 사항이다. 질병상태에서 살펴보아야 하는 영역은 질병 및 증상(과거 병력, 현 진단명, 질병으로 인한 증상), 필요한 간호처치, 운동 및 관절 제한 유무, 마비, 구축, 욕창 유무 등에 대한 정보 수집이 요구된다.

2) 영양상태

질병상태 외의 건강정보로서, 치아 및 구강위생 상태, 영양섭취 상태(식사형태, 식사 시 문제점),

배설활동 상태(소변 및 대변 양상, 배설활동 문제점)에 대해 파악하고 판단근거에는 현 상태와 수급자가 자립적으로 할 수 있는 부분과 도움이 필요한 부분을 구체적으로 파악한다.

3) 신체상태(일상생활수행능력 및 수단적일상생활수행능력)

신체기능 및 사회생활기능 상태에 대한 자립정도 파악이 필요하다. 이러한 기능상태 파악은 수급자의 장기요양 문제 및 욕구파악에 있어 중요한 정보인데 일상생활수행능력(ADL), 수단적일상생활수행능력(IADL)에 대한 객관적 정보수집이 요구된다. 특히 이 단계에서는 판단근거에 수급자가 할 수 없는 동작과 할 수 있는 동작이 무엇인지를 명확히 파악하여야 하며, 수급자에게 어떤 방법으로 도움을 주면 스스로 생활동작을 할 수 있는지에 대해 면밀히 파악하는 것이 요구된다.

4) 인지상태

인지기능상태와 관련된 항목과 행동변화와 관련된 항목 유무를 파악하여 수급자의 생활상 문제를 초래하고 있는 인지 및 행동변화 내용을 상세하게 파악한다. 이 영역의 판단근거에서도 수급자의 현 상태와 잔존능력, 가능한 부분과 불가능한 부분에 대한 정보 수집이 요구되며 이를 바탕으로 각각의 영역별 주요문제 및 욕구를 도출한다.

5) 의사소통상태

수급자의 의사소통 상태를, 유형별 의사소통장애가 있는지, 의사소통능력 상태는 어떠한지, 발음 능력 상태는 어떠한지, 청취능력이 어떠한지를 파악하여 가능한 부분과 불가능한 부분에 대해 수집하여 영역별 주요문제 및 욕구를 도출한다.

6) 가족관계 및 환경상태

수급자의 가족관계 및 가족 돌봄 고충에 대한 정보수집, 사회관계 및 사회적 지지상태 파악, 주거 상태를 파악하는 것이 요구된다. 우선 가족관계 및 가족 돌봄 고충 파악을 위해서는, 우선 수급자 가족관계에 대한 정보로서 수급자에 대한 정보를 수집하여 기록하며, 주수발자에 대한 정보 등을 파악하고 가족구성원과의 관계 및 가족구성원과의 관계 정도를 파악할 수 있는 가계도를 작성하도록 한다. 또한 수급자 가족의 돌봄 고충을 파악하기 위한 정보를 수집하도록 한다. 이 외에도 사회적 관계 및 사회적 지지망 파악을 위해 외부와의 관계성을 파악하여 이를 바탕으로 관련된 주요 문제 및 욕구를 도출하여 기록한다.

7) 자원이용영역

수급자 문제상황에 대한 욕구사정 만이 아니라 공식적, 비공식적 자원 이용에 관련된 정보 수집이 요구된다. 현재 어떠한 사회자원을 이용하고 있는지, 현재 이용하고 있는 상황에서 문제점은 무엇인지, 향후 어떠한 사회자원의 이용이 필요한지를 구체적으로 파악하여 기록한다.

8) 주관적 욕구

수급자와 가족이 호소하는 주관적 욕구로서 수급자와 주수발자 각각의 주된 호소내용, 희망하는 서비스 내용에 대해 파악하여 기록하되, 수급자와 수급자 가족은 현재 상황을 어떻게 이해하고 있는지, 이 상황을 어떻게 바꾸고 싶은지, 어떤 생활을 하고 싶은지를 파악하여 기록한다. 이 외에도 수급자의 생활력, 생활리듬, 기호 및 선호하는 것에 대해 정보를 수집하여 기록한다.

9) 종합정리(총평)

마지막으로 영역별로 수집된 정보는 정리하여 총평에 서술하여 기록하되, 영역별로 파악된 장기요양 문제 및 욕구를 기록한다. 특히 여러 영역의 문제 및 욕구는 우선순위를 정하여 기록하고 주요 문제와 장기요양필요영역(신체활동지원, 인지활동지원, 정서지원, 가사 및 일상생활지원 등), 구체적인 욕구로 제시하도록 한다. 욕구에는 어려움이 있는 구체적 상황의 문제를 해결한 후 목표와 결과를 함께 제시하도록 한다. 특히 종합의견에는 사례관리자의 전문적 판단을 기반으로 수급자의 표현된 욕구와 표현되지 않은 욕구 및 활용가능한 자원의 유무와 활용 능력에 대해 기술하고 그에 따라 해결방법에 대해 기록한다.

마. 사정의 실제

1) 사정단계의 관점

사례관리자는 사정단계에서 수급자에 대한 강점관점을 유지할 수 있어야 하며, 이들을 둘러싼 환경을 포함한 생태체계관점을 견지하는 것이 중요하다. 또한 특정 욕구만이 아닌 다양하게 표출되는 욕구들에 대해서도 다면적 관점을 적용하여 포괄적으로 바라볼 수 있는 자세가 필요하다.

가) 강점관점

수급자 수준(Level)과 관련하여 강점관점에 근거하여 수급자에 대한 사정을 진행하여야 한다. 수급자가 처해있는 부정적 감정이나 문제를 외면하라는 것은 아닌, 그들이 이미 가지고 있는 역량과 가능성에 주목해 보는 것이며 이를 사정과정에서 구체적으로 발견할 수 있어야 한다는 점이다. 사정단계에서 발견된 수급자의 강점은 이후 이어질 사례관리 계획수립과 실행의 제반 진행과정에서 수급자의 적극적인 참여를 이끌어내기 위한 활동에 적극 활용하도록 한다.

나) 생태체계 관점

외부환경 체계 수준(Level)과 관련하여 수급자와 주변의 지지체계를 폭넓게 살펴볼 수 있어야 한다. 성공적인 사례관리의 진행을 위해서는 수급자 개인을 넘어 이들과 연결된 자원과 지지 체계에 대한 포괄적인 사정단계가 필요하다.

다) 다면적 관점

수급자는 복합적인 욕구를 가지고 있으므로, 이에 대한 사정활동 역시 다면적 관점에서 접근하는 것이 기본이다. 특히, 장기요양의 대상이 되는 노인은 신체·정신·사회적으로 변화 또는 퇴화의 과정에 있으므로, 예를 들어 신체적인 측면만을 중심으로 사정단계를 진행하는 것은 제한적일 수밖에 없다.

2) 사정단계의 과정

가) 사정단계 기본절차

초기면접을 통해 선정된 수급자에 대해 실시하는 과정으로 수급자 개인의 복합적인 욕구를 평가하여 객관화함으로써 이후 계획수립과 실행과정으로 연결하게 된다는 점에서 중요성을 가지고 있다.

(1) 초기면접 과정 및 결과에 대한 숙지

초기면접단계에서 작성한 기록지를 기초로 수급자의 전반적인 상황에 대해 파악한다.

(2) 욕구에 대응한 사정기록지 및 도구 적용

사정기록지에는 수급자의 복합적인 욕구를 파악할 수 있는 단계적인 내용들이 포함되어야 하며, 기관이나 사례관리자에 따라 다양한 전문 사정도구를 사용할 수 있다.

(3) 사정내용의 종합정리

수급자의 신체, 정신, 사회적 욕구는 물론, 외부와 내부의 자원과 장애물을 정리하여 종합적인 소견을 작성한다.

(4) 사정결과 재확인

잘못 기재되거나 누락된 내용은 없는지 점검한다.

나) 장기요양기관의 기본 절차

사정단계에서 진행하게 되는 과정을 장기요양기관(방문요양)을 중심으로 정리해 보면 다음과 같다.

(1) 초기단계에 활용한 서류들과 함께, 기관에서 사용하는 사정기록지 준비

기관의 특성에 따라 실제 사용하는 사정기록지의 양식이 다양하나, 사정단계에서 요구되는 기본적인 사항들을 충분히 포함할 수 있도록 한다.

(2) 수급자 및 가족의 장기요양욕구 파악

수급자가 말하는 호소 및 희망에 따른 주관적인 욕구(Want)와 사정과정을 통해 사례관리자가 판단하는 객관적 욕구(Needs)를 혼동하지 않도록 한다.



point

사례관리는 욕구에 기초한 활동으로 수급자 욕구의 이면에 있는 욕구를 발견하는데 중점을 두도록 한다.

주요 욕구사정 내용(재가급여 평가매뉴얼(2020) 평가기준 참고)



point

욕구사정 항목

1. 신체상태: 일상생활동작 수행능력 등
2. 질병상태: 과거병력, 현 진단명 등
3. 인지상태: 인지기능 등
4. 의사소통: 청취능력, 발음능력 등
5. 영양상태: 음식섭취 패턴, 치아상태, 배설 양상 등
6. 가족 및 환경상태: 가족상황, 거주환경, 수발부담 등
7. 주관적 욕구: 수급자 또는 보호자가 호소하는 욕구
8. 자원이용 욕구: 의료기관, 사회복지기관, 그 외 서비스 기관 등

(3) 수급자의 욕구 외, 내·외부 자원과 해소해야 할 문제·장애물 종합적 파악



point

자원파악의 대표적 방법(생태체계적 관점에서의 접근)

1. 가계도(Genogram): 3대에 걸친 가족의 구조를 한눈에 파악할 수 있도록 고안된 사정도구
2. 생태도(Eco-map Source): 지난 3개월을 기준으로 클라이언트나 가족을 중심으로 어떻게 환경체계들과 네트워크가 이루어지고 있는지를 확인하는 사정도구

(4) 낙상위험도, 욕창위험도, 인지기능상태 파악(재가급여 평가매뉴얼(2020) 평가기준)

타당한 평가도구를 사용하여 수급자 상태(신규수급자의 경우 급여개시 전 까지 실시)



point

평가도구 예시

1. 낙상위험 평가도구(예시): Huhn의 낙상위험도 평가도구
2. 욕창위험 평가도구(예시): Braden scale 평가도구
3. 인지기능검사도구(예시): 한국형 간이정신상태검사K-MMSE

(5) 욕구사정과정에서 도출된 사정결과들을 기초로 종합의견 작성

욕구사정과정에서 제시된 욕구를 영역별로 정리하여 제시한다. 욕구사정 항목별 또는 총평에 판단근거가 명확히 나타나도록 작성한다.

장기요양을 중심으로 사정단계를 수행하는데 있어 유의사항은 다음과 같다.

- 수급자에 대한 주요한 정보로 국민건강보험공단이 작성하여 제공하는 개인별장기요양이용계획서를 적극적으로 활용하도록 한다.
- 개별적인 사정과정에서 취득한 개인 정보의 기록 및 관리, 목적 이외의 사용이나 외부 유출 등에 유의하도록 한다.
- 해당 기관에 소속된 직원이 작성하도록 한다.
- 수급자에 대한 종합적인 욕구사정을 연 1회 이상 정기적으로 실시한다.
- 신규수급자는 급여개시 전까지 실시한다.
- 수급자의 낙상위험도, 욕창위험도, 인지기능상태를 연 1회 이상 정기적으로 파악한다.
- 장기요양급여는 장기요양인정서의 장기요양급여의 종류 및 내용에 따른 개인별장기요양이용계획서(장기요양 필요 영역 및 장기요양 단기목표, 중장기목표, 장기요양 필요 내용, 수급자의 희망급여, 개인별장기요양이용계획 및 비용, 유의사항 등)에 따라 필요한 범위 안에서 적절하게 제공하여야 한다(「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제3조 적정급여제공 등)

바. 사정단계와 기록

1) 사정단계의 기술

사정단계에서 사례관리자는 수급자의 욕구를 전문가로서 지닌 지식과 기술, 직관에 근거하여 판단하는 경우도 있으나, 주로 공식화된 전문 사정도구를 함께 사용하는 경우가 많으며, 기관의 유형이나 사업 분야, 수급자의 특성에 따라 다양한 전문도구들이 현장에서 개발·활용되고 있다. 객관성을 가진 척도를 이용한 결과물은 사례관리과정에서 전문가들 간의 의사소통은 물론, 수급자와 가족에 대한 설명과 협조를 구하는데도 도움이 된다.

2) 사정도구 사례

가) 가계도(Genogram)와 생태도(Eco-map Source)

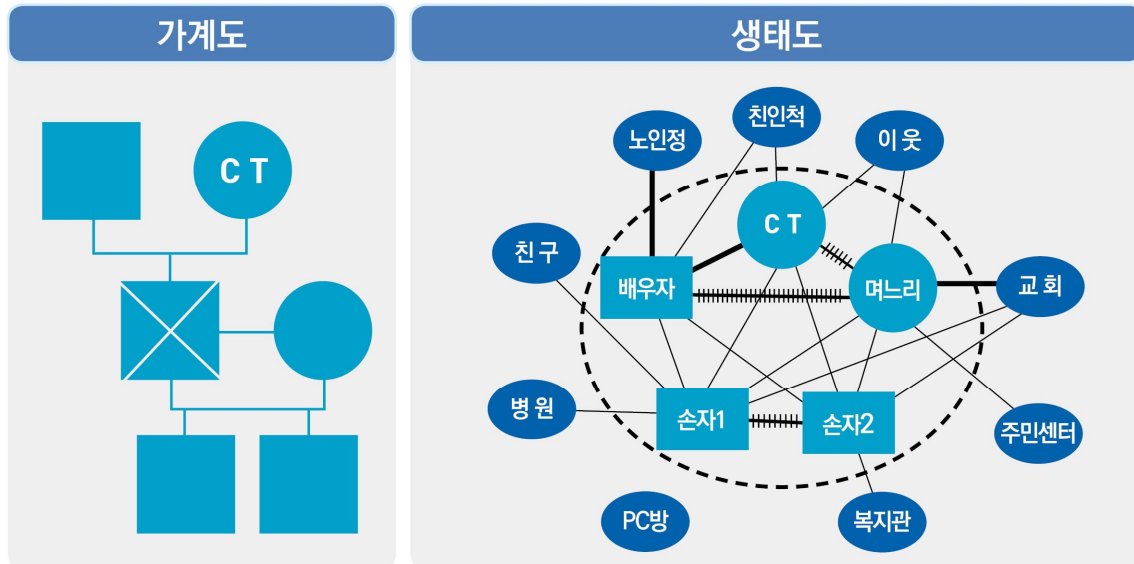
사례관리과정에서 수급자와 가족, 외부의 자원과 지지체계를 파악하기 위해 가장 빈번하게 사용되고 있는 전통적인 도구라고 할 수 있다.

가계도는 수급자의 가족구조를 한눈에 파악할 수 있도록 해주는 사정도구라고 할 수 있다. 수급자와 가족이 가지는 유형적인(Visible) 구조와 이들 사이의 무형적인(Invisible) 관계를 함께 파악해 볼 수 있다. 즉, 눈에 보이는 부분과 보이지 않는 부분을 함께 파악해내는 것이 핵심이다. 보통 가계도는 수급자를 중심으로 3대에 걸친 가족구조로 표현하는 것이 기본이다. 다만, 장기요양 수급자와 같이 주된 대상이 노인인 경우는 수급자와 배우자, 그리고 자녀와 손자녀로 구성되는 것이 일반적일 것이다. 실제 가계도를 작성할 때 사용하는 부호나 작성 방식은 기관이나 사례관리자에 따라 다소 다르게 표현될 수 있으나, 기본적인 작성 방법은 동일하다고 보아도 무방하다.

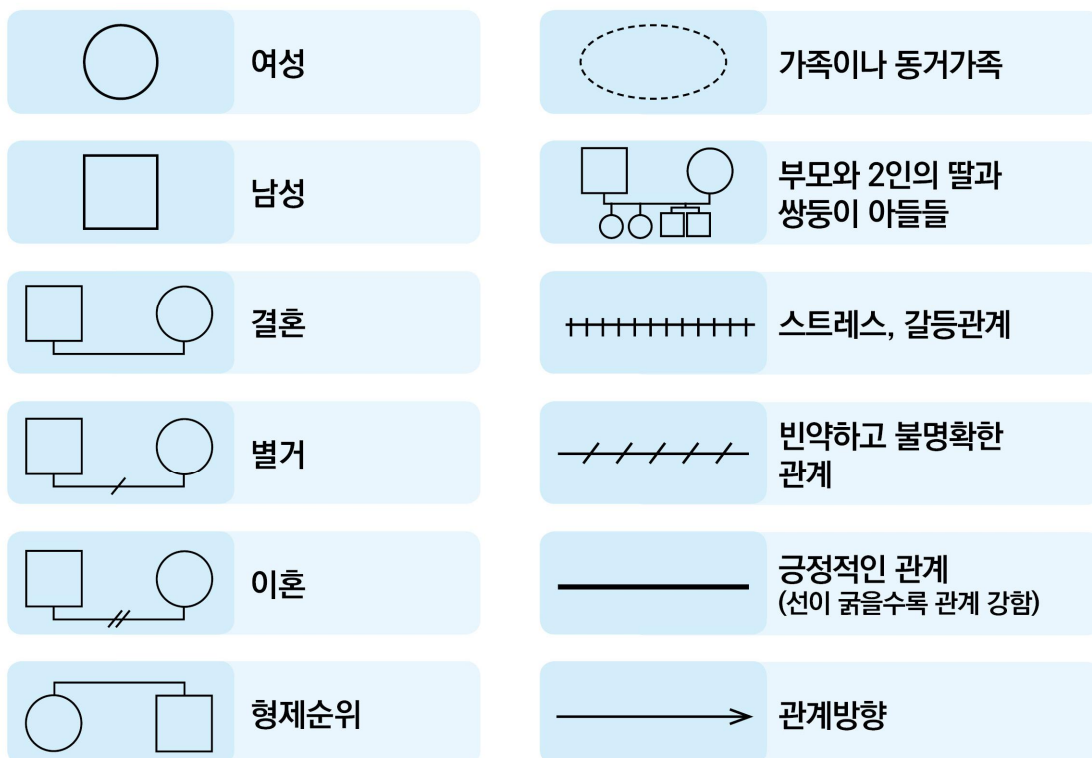
다음으로 생태도는 수급자와 가족을 중심으로 하여 이들과 관계를 맺고 있는 내부 및 외부자원과 지지체계의 양과 질을 확인하는 사정도구라고 할 수 있다. 생태도는 보통 지난 3개월간의 상황을 기초로 작성하는 것이 기본이며, 생태도 상에 표시한 자원과 지지체계는 기관이나 조직일 수도 있으며, 특정 개인을 나타내는 것일 수도 있다. 수급자를 중심으로 연결된 선은 그 관계의 강도와 방향은 물론 관계의 질(긍정적 관계, 부정적 관계)을 표현하는데 활용할 수

있다. 이러한 생태도를 활용하여 사례관리자는 수급자를 둘러싼 내부와 외부의 자원과 장애물을 사정하고, 이를 활용 또는 제거하기 위한 계획을 수립할 수 있다.

●● 그림 3-4 가계도 및 생태도 양식사용(예시)



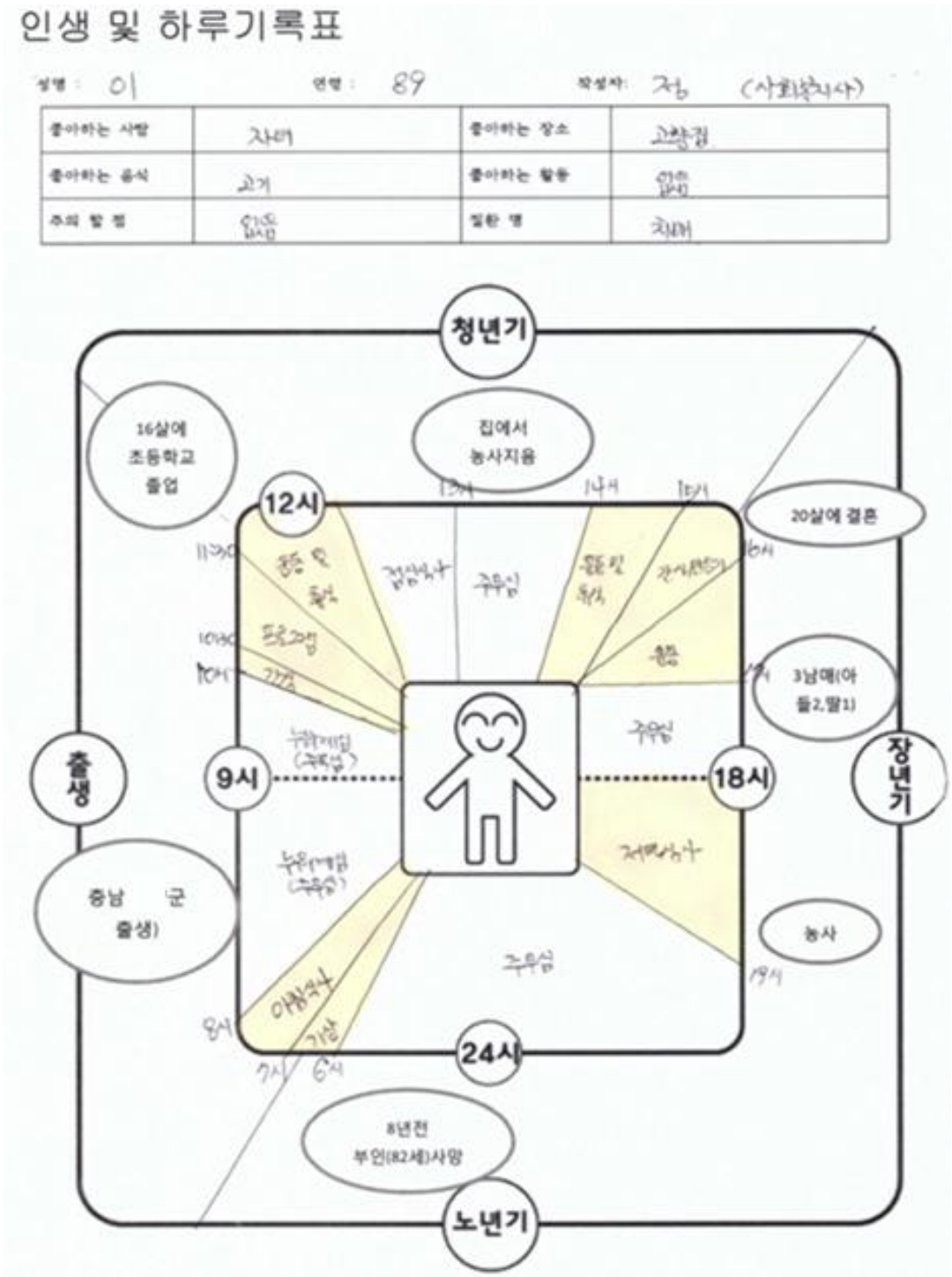
●● 그림 3-5 가계도와 생태도의 상징들



나) 과거력과 24시간 일과표

수급자의 생활의 태도와 습관, 방식은 오랫동안 축적된 개개인의 특성(Personality)이라고 할 수 있으며 이러한 개개인의 특성을 무시하고 장기요양기관의 방침이나 장기요양요원들의 의향대로 급여를 제공해서는 좋은 결과를 얻을 수 없고 만족도도 낮기 쉽다. 따라서 이러한 개개인의 특성에 큰 영향을 미치는 과거력과 취향, 기호 등을 파악해 두는 것은 매우 중요하다. 다음 표는 장기요양현장에서 간편하게 수급자들의 인생과 하루일과를 이해할 수 있도록 제작한 것이다.

●● 그림 3-6 인생 및 하루기록표(예시)



● 표 3-5 사정기록지(예시 1)

작성년월일: 년 월 일

작성자:

사례관리 대상자 개인사항								
관리번호		성 명		종 교		주민등록번호		
수급자 분 류	☐ 일반 ☐ 기초수급 ☐ 차상위 ☐ 국가유공자 ☐ 기타() ☐ 장애유무 ☐ 유() ☐ 무 ☐ 독거 ☐ 부부 ☐ 자녀가족 ☐ 친척 등 ☐ 조손 ☐ 기타()							
	주 소					전화번호		
	가족사항	관 계	성 명	생년월일	직 업	종 교	동거여부	비 고
신체상태 욕구사정	일 상 1. ADL 및 기능적 움직임&연하: [MBI-56] Moderate assist Lt. shoulder에 pain 호소로 움직임 제한 보이시나 Rt.와 같이 기능적인 움직임 보이시는데 어려움 없으 심. 간단한 ADL 잘 수행하시나 대소변에 조절에 큰 어려움 보이심. 2. 지각&인지: [CDR-1] 의사소통 가능하시나 지남력 및 기억력에 두드러진 인지저하 보이심 3. 심리&사회&기타: [GDS-6단계] 대변을 만지는 불결행동 보이시나 다른 큰 문제행동은 나타나지 않으심.							
	기 능 1. 관절가동력 및 근력: 양측 상지-부분제한 있음.(Bt. Sh)/Normal. 양측 하지-제한없음/Normal 2. 균형능력: Sitting-Good, Standing-Good 3. 기능적 동작: 대부분 독립적으로 가능함 4. 이동능력: w/c 이동(워커 보행 가능하나, 낙상이 우려되어 휠체어로 이동) 5. 통증/기타: 목, 양측 어깨, 허리, 양측 무릎의 통증 호소. Both Sh. Flex 90 ↑Pain							
질 병 욕구사정	3등급 치매 * 00대학교 병원 진단서(2013.3.8. 발행) - Communicating hydrocephalus(교통성수두증) - Pure hypercholesterolemia(순수과 콜레스테롤혈증) - Other specified urinary incontinence(요실금) - Atypical dementia Alzheimer's type(알츠하이머형치매) * 2008년경 00의료원에서 Rt어깨(낙상으로) 인대 파열되어 인대연결수술 2011년부터 치매증상발병함(00의료원에서 치매 진단) 2013년경 봄에 00병원에서 뇌수종수술							
인지상태 욕구사정	1) 정신상태: 보호자 의견으로 치매를 판정 받았으나, 장기기억력과 지남력(가족)은 가능하나 단기기억력은 저 하된 상태임. 상황판단력과 지남력(장소, 시간)은 거의 저하되어 있는 상태이며, 담당자가 대면중에도 엉뚱 한 대답과 불안정한 모습으로 배회하려고 주변을 살피는 모습을 발견할 수 있었음. 2) 감정: 보호자의 의견으로 온순하고 내성적인 성품이라 감정표출은 없다는 의견을 주었음. 다만, 해안지방출 신이라 말투가 거칠고 간헐적인 폭언이 있다는 의견을 주었음.							

〈이어서〉

의사소통 욕구사정	1) 청취능력 담당자와 대면하면서 소리와 자극에 대해 반응하는 것을 확인할 수 있었음. 2) 발음능력: 언어사용은 원활하다고 판단됨
영양상태 욕구사정	1. 밥과 일반반찬으로 제공하며 섭취량 및 섭취상태 양호 2. 정상체중의 103.9%로 정상체중을 잘 유지하고 있으며 꾸준한 섭취 안내
가족 및 환경적 욕구사항	1) 생활방식: 타 기관에서 방문요양서비스 이용하였고, 자녀들의 왕래로 생활을 영위하였음. 2) 친구관계: 현재 건강상태로 인해 외부와의 관계는 단절되었음. 3) 가족상황: 배우자는 25년전 질병으로 사별하였고, 슬하에 1남 2녀의 자녀가 있으며 가족간의 왕래는 원활하게 이뤄지고 있음. 주로 큰 딸과 막내 아들이 어르신 외래진료, 경제적인 부분을 지원하였음. 4) 거주환경: 입식생활 유지
수급자 (보호자) 호소 욕구사정	1) 수급자: 친구를 사귀고 싶다는 의사를 표현함. 2) 보호자: 문화행사, 인지훈련을 적극 지원받고 싶다는 의사를 표함.
자원이용 욕구사정	1) 외부자원: 산책과 말벗의 욕구가 있어 정기적으로 방문하는 개인 자원봉사자를 통하여 진행함이 필요하다고 사료됨 2) 병원진료: 00의원을 통해 정기검진과 복약을 지원받고 있었음.
총 평	이용초기 타인의 방문에 대한 불안증과 초조로 인해 주변을 배회하는 증상이 일시적으로 발생되었으나, 이내 점차 안정화 되어가는 모습을 발견할 수 있음.
비 고	
가계도	재사정 시 가계도 불필요
생태도	재사정 시 생태도 불필요

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-6 사정기록지(예시 2)

1) 질병 상태 (해당란에 ✓ 표기 후 판단근거 기입, 영역별 장기요양문제 및 욕구 도출)				
① 질병 및 증상	과거 병력	(, ,)		
	현 진단명	(, ,)		
	질병으로 인한 주요 증상 (복수 ✓ 체크)	☐ 발작 ☐ 숨참 ☐ 손발저림 ☐ 섬망 ☐ 기타()	☐ 부정맥 ☐ 어지러움 ☐ 피로감 ☐ 체중감소 ☐ 해당 없음	☐ 호흡곤란 ☐ 불면증 ☐ 통증 ☐ 주야역전
	판단근거			
② 필요 간호처치	필요처치 (복수 ✓ 체크)	☐ 기관지 절개관 간호 ☐ 흡인 ☐ 산소요법 ☐ 당뇨발간호	☐ 욕창간호 ☐ 경관영양 ☐ 암성통증간호 ☐ 기타()	☐ 노노관리 ☐ 장루간호 ☐ 투석간호 ☐ 해당 없음
	판단근거			
③ 운동 및 관절 제한 유무	해당장애 (복수 ✓ 체크)	(운동장애) ☐ 우측 상지 ☐ 좌측 상지 ☐ 우측 하지 ☐ 좌측 하지 ☐ 해당 없음 (관절제한) ☐ 어깨관절 ☐ 팔꿈치관절 ☐ 손목 및 수지관절 ☐ 고관절 ☐ 무릎관절 ☐ 발목관절 ☐ 해당 없음		
	판단근거			
④ 마비, 구축, 욕창, 통증 등	마비	☐ 유 ☐ 무	부위 ()	상태 ()
	구축	☐ 유 ☐ 무	부위 ()	상태 ()
	욕창	☐ 유 ☐ 무	부위 ()	상태 ()
	통증	☐ 유 ☐ 무	부위 ()	상태 ()
	판단근거	* 욕창 있을 경우 욕창위험도 사정 추가 실시		
질병 상태 관련 주요문제 및 욕구				
2) 영양상태 (해당란에 ✓ 표기 후 판단근거 기입, 영역별 장기요양문제 및 욕구 도출)				
① 치아상태 및 구강위생	치아상태	☐ 양호 ☐ 불량 ☐ 의치 ☐ 치아 없음		
	구강 위생상태	☐ 양호 ☐ 불량		
	판단근거			
② 영양섭취	식사형태	☐ 미음 ☐ 죽 ☐ 일반식 ☐ 당뇨식 ☐ 경관식 ☐ 기타()		
	식사 시 문제점	☐ 식욕 저하 ☐ 저작 곤란 ☐ 연하곤란 ☐ 소화 불량 ☐ 구토 ☐ 기타() ☐ 해당 없음		
	판단근거			
③ 배설활동	소변 양상	☐ 요실금 ☐ 빈뇨 ☐ 잔뇨감 ☐ 기타() ☐ 해당 없음		
	대변 양상	☐ 변실금 ☐ 변비 ☐ 잔변감 ☐ 기타() ☐ 해당 없음		
	배설활동 문제점	☐ 화장실 이동 거부 ☐ 기저귀 거부 ☐ 요의·변의 있으나 화장실 이동 지원 필요 ☐ 화장실 이동은 가능하나 착·탈의 및 위생지원 필요 ☐ 기타() ☐ 해당 없음		
	판단근거			
영양상태 관련 주요문제 및 욕구				

〈이어서〉

3) 신체 상태 (해당란에 해당 도움 정도 표기 후 판단근거 기입, 영역별 장기요양문제 및 욕구 도출)		
① 일상생활동작 수행능력	도움 필요 항목과 도움 정도 (완전자립 ○, 부분도움 △, 완전 도움 ×) ☐ 옷 벗고 입기 ☐ 세수하기 ☐ 양치질하기 ☐ 목욕하기 ☐ 식사하기 ☐ 체위변경하기 ☐ 일어나 앉기 ☐ 옮겨 앉기 ☐ 방밖으로 나오기 ☐ 화장실 사용하기 ☐ 대변 조절하기 ☐ 소변 조절하기 ☐ 머리 감기 ☐ 기타() ☐ 해당 없음	
	낙상위험 유무 ☐ 유 ☐ 무 * 낙상위험 있을 경우 낙상위험도 추가 사정 실시	
	판단근거	
일상생활동작 수행능력 주요문제 및 욕구		
② 수단적 일상생활동작 수행능력	도움 필요 항목과 도움 정도 (완전자립 ○, 부분도움 △, 완전 도움 ×) ☐ 청소하기 ☐ 식사 준비하기 ☐ 빨래하기 ☐ 금전관리 ☐ 물건사기 ☐ 전화 사용하기 ☐ 교통수단 이용하기 ☐ 근거리 외출하기 ☐ 몸 단장하기 ☐ 안전관리하기 ☐ 건강관리 ☐ 기타() ☐ 해당 없음	
	판단근거	
수단적 일상생활동작 수행능력 주요문제 및 욕구		
4) 인지 상태 (해당란에 ✓ 표기 후 판단근거 기입, 영역별 장기요양문제 및 욕구 도출)		
① 인지기능 변화	해당장애 (복수 ✓ 체크) ☐ 단기 기억장애 ☐ 지시 불인지 ☐ 계산 못함 ☐ 날짜 인지 ☐ 상황판단력 인지 ☐ 하루일과 이해 못함 ☐ 장소 인지 ☐ 의사소통전달 ☐ 인물 인지 ☐ 나이, 생년월일 인지 ☐ 기타() ☐ 해당 없음	
	판단근거	
인지기능관련 주요문제 및 욕구		
② 행동장애 유무	해당장애 (복수 ✓ 체크) ☐ 망상 ☐ 서성거림, 안절부절 ☐ 환각, 환청 ☐ 의미없거나 부적절한 행동 ☐ 길을 잃음 ☐ 돈, 물건 감추기 ☐ 슬픈 상태, 울기도 함 ☐ 폭언, 위험 행동 ☐ 부적절한 옷 입기 ☐ 불규칙 수면, 주야혼돈 ☐ 밖으로 나가려함 ☐ 대소변 불결행위 ☐ 도움에 저항 ☐ 물건 망가트리기 ☐ 식사거부 ☐ 쓸데없이 간섭하고 참견 ☐ 화기관리 불안 ☐ 불리불안 ☐ 이유없이 고함침 ☐ 부적절한 성적행동 ☐ 이식증 ☐ 과도 집착 ☐ 기타() ☐ 해당 없음	
	판단근거	
행동변화관련 주요문제 및 욕구		

〈이어서〉

5) 의사소통 영역(해당란에 ✓ 표기 후 판단근거 기입, 영역별 장기요양문제 및 욕구 도출)									
① 의사소통장애 유무	해당장애 (복수 ✓ 체크)	☐ 시각 ☐ 청각 ☐ 의사전달 ☐ 발음 능력 ☐ 해당 없음							
	의사소통능력 (복수 ✓ 체크)	☐ 모두 이해하고 의사 표현함 ☐ 가끔 이해하고 의사를 표현함 ☐ 대부분 이해하고 의사를 표현함 ☐ 거의 이해하지 못하고 의사 전달 못함 ☐ 해당 없음							
	발음능력 (복수 ✓ 체크)	☐ 정확하게 발음이 가능함 ☐ 웅얼거리는 소리로만 함 ☐ 간혹 어눌한 발음이 섞임 ☐ 전혀 발음하지 못함 ☐ 해당 없음							
	청취능력 (복수 ✓ 체크)	☐ 들리는지 판단 불가능하다. ☐ 큰 소리는 들을 수 있다. ☐ 거의 들리지 않는다. ☐ 정상(보청기 사용 포함). ☐ 보통의 소리를 듣기도 하고 못 듣기도 한다.							
	판단근거								
의사소통관련 주요문제 및 욕구									
6) 가족 및 사회관계영역(해당란에 ✓ 표기 후 판단근거 기입, 영역별 장기요양문제 및 욕구 도출)									
① 가족 관계 및 가족 돌봄 고충	수급자 결혼 여부	☐ 기혼 ☐ 미혼	수급자 동거인	☐ 독거 ☐ 부부 ☐ 부모 ☐ 자녀 ☐ 손자녀 ☐ 친척					
	배우자 생존 여부	☐ 생존 ☐ 사망		☐ 친구 ☐ 이웃 ☐ 기타()					
	주수발자 유무	☐ 유 ☐ 무	주수발자의 수급자와의 관계	☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 자부 ☐ 사위 ☐ 형제자매 ☐ 친척 ☐ 손주 ☐ 조카 ☐ 기타()					
	주수발자 직업 유무	☐ 유 ☐ 무	가계도						
	주수발자 건강상태	☐ 양호 ☐ 불량							
	주수발자 동거여부	☐ 동거 ☐ 비동거							
	수급자에 대한 주수발자의 지원 내용	☐ 가사 ☐ 경제 ☐ 정서 ☐ 이동 ☐ 안부확인 ☐ 기타							
	주수발자의 케어의욕 유무	☐ 유 ☐ 무	주수발자 외 협력자 유무	☐ 유(수급자와의 관계:) ☐ 무					
	주수발자의 고충	☐ 유 ☐ 무	고충 내용						
	판단근거								
② 사회관계 및 사회적 지지 관련	외출 빈도	☐ 일 1회 이상 ☐ 주 1회 이상 ☐ 월 1회 이상 ☐ 안함	사회적 지지 자원						
	외출 동행인	☐ 혼자 ☐ 가족 ☐ 기타()							
	외출 장소	☐ 의료기관 ☐ 종교기관 ☐ 행정기관 ☐ 경로당 ☐ 복지관 등 ☐ 수퍼 ☐ 사적모임 ☐ 기타()							
	사회적 관계 고충	☐ 친인척관계 갈등 ☐ 친인척관계 소원 ☐ 친인척관계 단절 ☐ 이웃 관계 갈등 ☐ 이웃 관계 소원 ☐ 이웃 관계 단절 ☐ 기타()							
	판단근거								
가족 및 사회관계 주요 문제 및 욕구									

〈이어서〉

③ 주거 상황	주거유형	☐ 단독주택 ☐ 다세대주택 ☐ 아파트 ☐ 빌라 ☐ 주상복합 ☐ 기타 ()			
	자가여부	☐ 자가 ☐ 전세 ☐ 월세 ☐ 기타()	엘리베이터 유무	☐ 유 ☐ 무	
	주차장 여부	☐ 유 ☐ 무	주거공간 상태	☐ 양호 ☐ 불량	
	주거지 내 물리적 장애 여부	☐ 유 ☐ 무	구체적 장애 공간 및 요소 ☐ 주방시설 열악 ☐ 위생환경 열악 ☐ 도배,장판 열악 ☐ 냉,난방 열악 ☐ 전기,가스 열악 ☐ 상하수도시설 열악 ☐ 지붕노후(누수) ☐ 벽, 담 등 노후 ☐ 주택 내 이동 곤란 ☐ 기타()		
	주거 상태	☐ 양호 ☐ 불량	개보수 필요 부분 ☐ 긴급보수 필요 ☐ 폭염취약 ☐ 한파취약 ☐ 환기 부적절 ☐ 채광부족 ☐ 협소한 공간 ☐ 약취 및 불결 ☐ 기타()		
주요문제 및 욕구					
7) 자원이용(구체적 사항 기입 및 해당란에 ✓ 표기)					
자원이용 상황	현재 사회자원 이용 상태 (복수 ✓ 체크)	☐ 방문간호 ☐ 방문목욕 ☐ 주야간보호 ☐ 단기보호 ☐ 복지용구 ☐ 시설급여 ☐ 해당사항 없음		생태도	
	현재 사회자원 이용의 고충	☐ 지역사회기관의 일상생활지원서비스 (말반찬지원, 급식지원, 생활용품지원 등) ☐ 신체건강 및 보건의료서비스 ☐ 정신건강 및 심리 ☐ 주거 관련 ☐ 문화 및 여가 관련 ☐ 안전 및 권익 보장 관련			
	향후 사회자원 이용 필요성 (복수 ✓ 체크)	☐ 방문간호 ☐ 방문목욕 ☐ 주야간보호 ☐ 단기보호 ☐ 복지용구 ☐ 시설급여 ☐ 해당사항 없음			
	판단근거				
주요문제 및 욕구					
8) 주관적 욕구(구체적 사항 기입 및 해당란에 ✓ 표기)					
① 수급자의 호소와 욕구	주된 호소 내용				
	희망하는 서비스 내용				
② 주수발자의 호소와 욕구	주된 호소내용				
	희망하는 서비스 내용				

〈이어서〉

③ 수급자의 생활력				
④ 수급자의 생활리듬				
⑤ 수급자의 기호 및 선호				
총평(앞의 욕구사정표에서 제시된 욕구를 영역별로 정리하여 제시)				
영역별 도출된 장기요양필요문제 및 욕구	장기요양 필요 문제 및 욕구		장기요양 필요 영역	
	예시: 개인 위생관리 어려움		예시: 신체활동지원, 개인활동지원, 정서지원, 치매관리지원, 인지활동지원, 일상생활지원	
종합 의견				
작성자 및 작성 일자	작성자 성명		작성 일자	

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-7 사정기록지(예시 3)

질환 사항						
현재병력	순환기	☐ 고혈압	☐ 심장질환	☐ 혈관성질환	☐ 빈혈	☐ 인공심박기
	근골격계	☐ 디스크	☐ 골절	☐ 인공관절	☐ 류마티스	☐ 골다공증
		☐ 절단	☐ 통풍	☐ 선천성기형	☐ 퇴행성관절염	
	신경계	☐ 두부손상	☐ 파킨슨병	☐ 마비/장애		
		☐ 뇌혈관성질환(뇌경색)		신경염/신경증		
	호흡기계	☐ 천식	☐ 기관지질환	☐ 폐렴	☐ 결핵	
		☐ 늑막질환	☐ 만성기침	☐ 객담		
	안 과	☐ 백내장	☐ 녹내장	☐ 망막질환	☐ 각막염	
		☐ 안구건조증	☐ 안검하수증			
	이비인후과	☐ 편도선염	☐ 축농증	☐ 비염	☐ 인/후두염	
		☐ 중이염	☐ 난청	☐ 고막손상		
	비뇨기계	☐ 신장질환	☐ 요도방광염	☐ 전립선질환		
		☐ 투석	☐ 요실금			
	피부과	☐ 피부염	☐ 대상포진	☐ 조갑무증		
☐ 화상		☐ 욕창				
소화기계	☐ 위장질환	☐ 간/담도질환	☐ 대장/항문질환			
	☐ 황달	☐ 소화불량				
내분비	☐ 당뇨병	☐ 갑상선질환				
정신과	☐ 우울증	☐ 불면증	☐ 치매			
산부인과	☐ 유방질환	☐ 자궁/난소질환	☐ 자궁적출	☐ 질염		
기타질환	☐ 알콜중독		☐ 기타()			
병 력 추가설명						
통 증	종 류	☐ 무통	☐ 급성	☐ 만성	☐ 국소	☐ 전신
	강 도	☐ 약	☐ 중	☐ 강	☐ 부정확	
보장구		☐ 휠체어	☐ 자팡이/워커	☐ 보청기	☐ 돋보기/안경	
		☐ 틀니		☐ 기타()		
투약	번호	현재 복용약	복용기간	병원명	진료주기	병원동행인
	1					☐ 없다
	2					☐ 있다()
	3					
건강상태		☐ 정상	☐ 요주의	☐ 이상		
서비스 지원필요		☐ 최대한 필요	☐ 부분 필요	☐ 불필요		
소 건						
추 가 측정도구	도구명		측정결과		첨 부	
	예) ADL, IADL, 임파워먼트 척도 등					

〈이어서〉

정신건강 사항						
치매	측정도구명	예) K-MMSE	측정결과	예) 19점	첨부	예) 검사지.pdf
	서비스 지원필요여부	☐ 최대한 필요 ☐ 부분 필요 ☐ 불필요				
	소 건					
우울증	측정도구명	예) K-BDI	측정결과	예) 20점	첨부	예) 검사지.pdf
	서비스 지원필요여부	☐ 최대한 필요 ☐ 부분 필요 ☐ 불필요				
	소 건					
경제 사항						
월평균 수입액		☐ 정부지원(만 원) ☐ 후원금(만 원)	☐ 본인수입(만 원) ☐ 기타(만 원)	☐ 자녀도움(만 원)		
월평균 지출액		☐ 월세(만 원) ☐ 의료비(만 원)	☐ 공과금(만 원) ☐ 식료품비(만 원)	☐ 연료비(만 원) ☐ 기타(만 원)		
경제상태		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하				
서비스 지원필요		☐ 최대한 필요 ☐ 부분 필요 ☐ 불필요				
소 건						
영양 사항						
식사 여부		☐ 아침 ☐ 점심 ☐ 저녁				
식사 준비		☐ 본인 ☐ 자녀 ☐ 기타() ☐ 외부기관 (☐ 도시락 ☐ 밑반찬 ☐ 영양식 ☐ 기타)				
저작 상태		☐ 양호 ☐ 불편 ☐ 불량				
연하 상태		☐ 양호 ☐ 불편 ☐ 불량				
영양 상태		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하				
서비스 지원필요		☐ 최대한 필요 ☐ 부분 필요 ☐ 불필요				
소 건						
사회관계			강점관점			
약도			주변환경(사진)			
종합의견						

〈이어서〉

작성방법	
항 목	작성방법
현재병력	○ 현재 가지고 있는 질병 정보를 선택하여 기입함 - 순환기, 근골격계, 신경계, 호흡기계, 안과, 이비인후과, 비뇨기계, 피부과, 소화기계, 내분비, 정신과, 부인과, 기타질환 분류별로 선택가능하며 다중 선택 가능함
병 력 추가설명	○ 병력에 대한 추가 정보를 기입함
통 증	○ 통증의 종류와 강도를 선택하여 기입함
보장구	○ 휠체어, 지팡이/워커, 보청기, 돋보기/안경, 틀니, 기타 사용 보장구를 선택하여 기입함
투 약	○ 복용하는 약의 종류, 기간, 처방병원, 진료주기 등을 기입함
건강상태	○ 전반적인 건강상태에 대하여 정상, 요주의, 이상 구분 중 선택하여 기입함
서비스지원 필 요	○ 건강상태에 따른 서비스 지원필요성을 최대한필요, 부분필요, 불필요 구분 중 선택하여 기입함
소 건	○ 전반적인 소견을 작성함
추 가 측정도구	○ 노인 욕구조사(사정)에 사용되는 기타 측정(사정)도구와 결과를 입력하고 결과서, 소견서 등 첨부 가능
정신건강 사 항	○ 치매 - 측정도구명, 측정결과, 결과 첨부 - 서비스지원필요여부(최대한필요/부분필요/불필요) 구분 중 선택 - 치매 관련 소견 작성 ○ 우울증 - 측정도구명, 측정결과, 결과 첨부 - 서비스지원필요여부(최대한필요/부분필요/불필요) 구분 중 선택 - 우울증 관련 소견 작성
경제사항	○ 월평균 수입액, 월평균 지출액, 경제상태, 서비스지원필요여부를 선택하여 기입하고 소견 작성
영양사항	○ 식사여부, 식사준비, 저작상태, 연하상태, 영양상태, 서비스지원 필요 여부를 선택하여 기입하고 소견 작성
사회관계	○ 수급자의 사회관계에 대한 의견 작성
강점관점	○ 수급자의 강점, 즉 문제해결에 있어 긍정적인 영향을 줄 수 있는 관점 의견 작성
약 도	○ 필요한 경우, 수급자 거주지의 약도를 첨부함 (주소정보로 찾아가기 어려운 경우)
주변환경 (사진)	○ 필요한 경우 수급자 거주지의 주변환경 정보를 첨부함
종합의견	○ 조사(사정) 종합 의견을 작성함

※ 자료: 보건복지부, 사례관리 서식 표준, 민-관 정보공유시스템 구축 사업

3 계획수립단계

학습목표

- 계획수립의 정의와 내용을 이해하고 설명할 수 있다.
- 계획수립단계에서 요구하는 기본원칙과 과정을 설명할 수 있다.
- 계획수립을 위한 다양한 도구를 숙지하고, 절차에 따라 적용할 수 있다.
- 계획수립단계의 실천 기술을 이해하고, 활용할 수 있다.

가. 계획수립의 이해

1) 계획수립의 개념

사정단계의 결과를 기초로 달성하고자 하는 변화 목표를 명확히 제시하고, 이를 달성하는 데 필요한 전략과 방법으로 서비스를 구성하는데 기본적인 목적이 있다. 즉, 계획수립의 핵심과업은 변화 목표를 설정하는 것으로, 하위의 세부목표 간의 우선순위를 설정하고 실현하기 위해 투입되어야 할 서비스들을 체계적으로 연결하는 과정이라고 할 수 있다. 특히, 계획수립을 통해 만들어진 계획을 ‘개별 서비스 계획(Individualized Service Plan; ISP)’이라고도 하는데, 그만큼 사례관리에 있어 계획수립활동이 수급자의 개별성을 중시하고 이에 기초하고 있기 때문이다.

계획수립단계에서는 각 서비스들을 담당할 제공자를 설정하여 각자의 역할을 명확히 인식할 수 있도록 하며, 이들이 공통된 변화목표를 향하여 개입 활동을 수행할 수 있도록 방향을 제시할 수 있어야 한다. 또한 계획수립단계에서 제시한 변화목표와 그 하위 세부목표들은 실행 과정을 거쳐 그 달성도를 평가하는데 까지 연결된다는 점에서 중요성을 가지고 있다. 따라서 계획수립단계는 전체를 조망하는 보다 폭넓은 관점에서 접근하는 것이 바람직하다.

2) 계획수립의 기본 원칙

가) 계획수립과정에 수급자가 참여

계획수립은 수급자의 욕구에 기초한 개별화에 중점을 둔 것으로 계획수립의 제반과정에 수급자의 의견을 참고하여야 한다.

나) 다양한 자원을 계획에 포함

가용한 자원들로서 각 서비스들 간의 적정구성(Assuring The Availability of An Appropriate Mix of Long-Term-Care Service)을 확보하는 것이 매우 중요하다. 수급자는 복합적 욕구를 가지고 있는 만큼, 단일 서비스가 아니라 다양한 서비스로 대응할 수 있어야 하며, 보건의료복지분야의 다양한 직종과 조직이 함께 참여하는 팀 접근(Team Approach)도 바람직하다.

다) 달성하고자 하는 목표를 명확화

계획수립을 통해 도출하는 목표는 변화목표로 현재의 의존적 상황을 극복하고 새로운 변화를 유도할 수 있는 것이어야 한다.

라) 수급자 장점을 최대한 활용한 계획수립

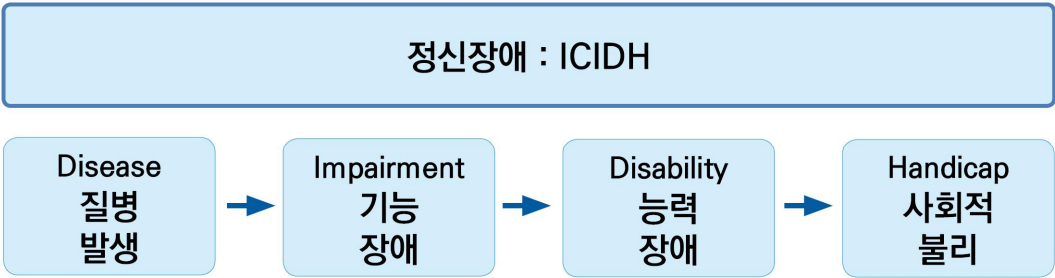
수급자의 제한점이나 문제보다도 그들이 가진 장점에 주목하여야 하며, 특히 일상생활수행이 어려운 기능장애가 있는 경우는 평소의 생활패턴을 고려하되 그들이 가진 잔존기능을 최대한 발휘하여 제한적이나 자립을 지원할 수 있는 내용으로 구성하는 것이 바람직하다.

- 마) 개입과정에서 인권을 반드시 확보
계획수립의 결과물이 지나치게 실적 중심이 되지 않도록 하고, 궁극적인 목적이라고 할 수 있는 수급자의 인격을 존중하고 자기다운 생활을 유지할 수 있도록 윤리적으로 배려하였는지를 살펴보아야 한다.

나. 계획수립의 실제

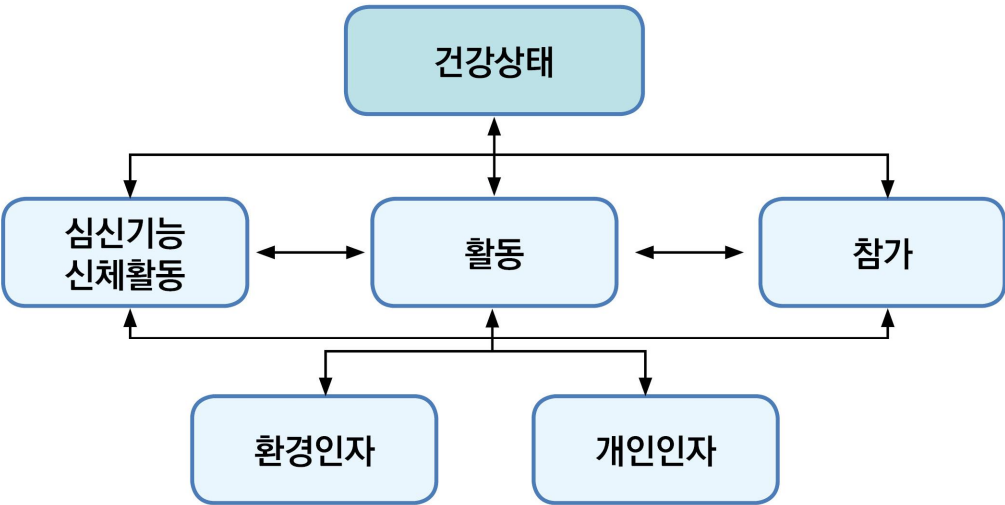
- 1) 계획수립의 관점
가) 장애에 대한 관점
과거의 국제장애분류(ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicap)에서는 질병 등으로 기능장애가 발생하면 능력장애로 이어지고 이것이 결국은 사회적 불이익으로 귀결되므로, 질병을 치료해야 한다는 흐름을 담은 단순한 질병모델이었다.

●● 그림 3-7 국제장애분류(ICIDH) 이미지



2001년부터 국제기능·장애·건강분류 ICF(International Classification of Functioning, Disabilities and Health)의 개념이 도입되었다. ICF는 생태학적·시스템적 관점을 기본으로 하고 있으며, 질병이 있어도 활동과 참가를 하고 있다면 건강한 상태로 판단한다. 수급자의 건강 상태는 이용자의 심신기능·신체구조, 수급자가 실시하는 다양한 활동, 수급자가 다양한 일에 참가하고 있는 상태 등이 상호작용을 하고 영향을 주고받는다.

●● 그림 3-8 국제기능·장애·건강분류의 구성 요소들의 상호작용



※ 출처: 세계보건기구(WHO), 국제기능·장애·건강분류 ICF; 국제장애분류 개정판

따라서 사례관리자는 한 가지 요인 즉, 심신기능과 신체기능이나 개인인자에만 중점을 두지 말고 전체적인 심신기능 및 신체기능, 활동, 참가, 환경, 개별 인자의 상호작용과 영향을 파악하고 계획을 수립하여 개별지원을 실시해야 한다.

나) 임파워먼트(Empowerment) 관점

파울로 후레이레(Paulo Freire)가 제창한 이론으로 수급자 스스로 여러 가지 일들을 결정하고 다양한 사회자원을 활용해 생활 과제를 해결하면서 자신이 생활주체라는 것을 실제로 경험할 수 있는 상황을 만들어내는 것을 의미한다.

이 관점은 수급자의 자존감을 높이는 방법으로 매우 가치가 높다. 그리고 사례관리자가 임파워먼트를 염두에 두고 성공적으로 사례관리를 진행하려면 수급자의 강점(Strengths)에 주목함과 동시에 협력관계 속에서 생활 과제를 해결하는 것을 목표로 삼아야 한다.

수급자의 잠재력을 최대한 활용하여 스스로 결정할 수 있도록 유도하고 지원해야 하며 경우에 따라 수급자가 결정한 내용을 실행하기 위해 사례관리자가 대변자가 되어 사회자원들을 조정하면서 그것이 실현될 수 있도록 노력하는 것이 중요하다.

다) 강점관점

사정단계와 마찬가지로 계획수립에서도 수급자의 강점(Strengths)을 최대한 활용하는 방향으로 견지하여야 한다. 보통 수급자 개인의 강점이란 수급자의 장점, 특성, 잠재력, 자원(가족, 친구, 이웃의 사회적 도움과 그 네트워크 등)을 가리킨다. 강점에는 개인, 집단, 지역이라는 수준이 있으며 각 수준별로도 강점이 존재한다고 본다. 집단이나 지역의 잠재력이나 변화 가능성을 찾아내면 그것을 수급자 지원으로 연결해볼 수 있는 것이다. 강점관점은 사례관리자가 수급자 개인의 강점을 찾아내는 것은 물론, 가족이나 지역의 잠재력을 찾아내어 활용하는데 유용성을 지니고 있다.

따라서 사례관리자는 수급자의 과거에 초점을 맞추지 말고 현재 상황이나 가까운 미래를 염두에 두는 한편, 수급자의 결점이나 병적인 증상보다는 잠재적인 강점에 초점을 맞추어 지원해 나가는 자세를 지녀야 한다.

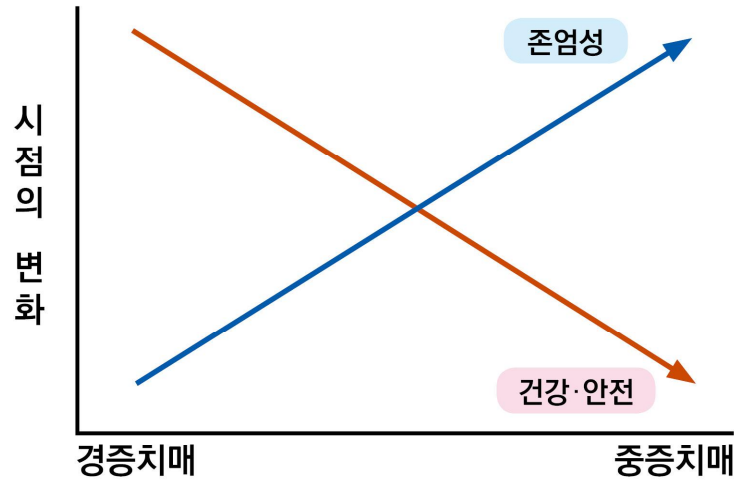
라) 옹호(Advocacy)의 관점

강점의 기본 개념이 수급자의 임파워먼트를 진행하기 위해 싸울 발견하는 과정이라면 옹호는 임파워먼트의 싸울 키우는 과정이라 할 수 있다. 옹호는 일반적으로 ‘수급자를 위한 대변’이나 ‘수급자의 권리를 옹호’하는 활동이다. 구체적으로 말하면 옹호란 사례관리자가 대변자가 되어 사회자원을 이용해 수급자의 생활 욕구가 충족되도록 지원하는 것을 가리킨다. 그 결과 이용자의 생활에서 다양한 권리(예를 들어, 서비스를 받을 권리, 지역 사회에 참가할 수 있는 권리 등)를 지킬 수 있게 된다.

마) 존엄성과 건강·안전의 상호관계에 대한 관점

계획수립의 과정에서 사례관리자가 수급자에 대한 개입방법과 내용을 결정할 때, 우선적으로 수급자의 상태를 파악하고 이에 따른 존엄성과 건강·안전의 상호관계를 이해하고 반영하고자 하는 노력이 중요하다. 수급자의 상태에 따라 개입계획에서 존엄성을 보다 중시할 것인지, 아니면 건강이나 안전의 문제에 보다 집중할 것인지를 선택할 수 있다.

●● 그림 3-9 상태의 진행에 따른 케어 시점의 변화



2) 장기요양기관에의 적용

가) 사정단계를 통해 얻은 자료를 바탕으로 사례회의 실시

수급자의 다양한 욕구를 충족시키기 위한 방안 등을 논의하고, 그에 따라 급여계획을 변경하여 적절한 서비스를 제공하기 위한 회의로, 수급자의 초기상담에서 종결 및 사후관리에 이르는 사례관리의 전 과정에 대한 협의 및 조정이 이루어지는 과정이다.

사례회의는 개별 방문요양기관에서 진행하는 내부회의 형태로 진행하며 욕구조사 및 욕구사정을 통해 수급자의 주요 문제가 무엇인지 구체화된 이후 실시한다.

사례회의는 내부회의로 시설장, 사회복지사, 요양보호사와 수급자 및 가족이 참석할 수 있다. 사례회의의 세부적인 운영절차는 다음과 같다.

●● 표 3-8 사례회의의 세부적인 운영절차

1	사례관리자는 개별 사례에 대한 사례회의 진행에 필요한 자료 설명 및 근거자료를 준비하여 회의를 원활하게 할 수 있도록 준비한다.
2	사례회의를 진행하는 사례관리자는 사례회의에 상정하는 수급자에 대한 사례회의 일자를 조정하여 팀 구성원에게 알리고 회의를 진행한다.
3	사례관리자는 초기면접지, 욕구사정기록지를 참고로 욕구조사 및 욕구사정 과정에서 파악한 수급자의 장기요양 주요 문제, 욕구, 장기요양 필요 영역에서 기록된 내용을 팀 구성원이 공유한다.
4	공유된 정보에 대해 욕구사정기록지를 점검하여 누락된 사항이 없는지, 거론된 문제점에 대한 서비스 제공이 수급자의 장기요양 욕구 해결에 도움이 되는지, 생활의 질 향상에 도움이 되는지를 논의한다.
5	해결해야 할 과제의 우선순위에 대해 논의한 후, 각 욕구에 대한 장기요양목표를 설정하고 장기요양 필요영역과 장기요양 필요내용에 대해 협의한다.

나) 급여제공계획 상의 목표 도출 및 우선순위 설정

충분한 협의과정을 통해 수급자(가족)와 '합의된 목표'를 도출한다. 수급자의 주관적 요구(Want)나 객관적 욕구(Needs)의 시급성, 중요성, 달성용이성 등을 고려하여 목표들 간에 우선순위를 설정한다. 목표는 긍정적인 언어와 구체적인 행동으로 설정하는 것이 바람직하다.



급여제공계획의 수립 방향

1. 계획수립은 개별화에 중심(Individualized Service Plan: ISP)을 두고 달성하고자 하는 변화 목표를 명확히 하며, 변화 목표를 달성하는 데 필요한 전략, 방법으로서의 서비스를 구성해 가는 논리적인 과정임을 이해하기
2. 각 서비스들 간의 적정구성(Assuring The Availability of An Appropriate Mix of Long-Term-Care Service)을 확보하기
3. 수급자의 생활패턴을 고려하고 잔존기능을 최대한 발휘할 수 있는 내용으로 구성하기
4. 수급자의 인격을 존중하고, 자기다운 생활을 유지할 수 있도록 윤리적으로 배려하기
5. 관련근거: 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제3조(적정급여제공 등)

다) 세부 서비스내용 및 일정 등 결정

급여제공계획서는 수급자 욕구를 우선으로 작성하되, 건강 또는 안전 등 사유가 있는 경우는 변경된 내용을 반영하여 작성할 수 있도록 한다. 제공하는 급여는 특정 급여유형에 편중되지 않고 다양한 급여유형이 포함되도록 한다.

라) 급여제공계획과 비용, 사례관리자의 정기방문 등 상세설명

적절한 급여종류 및 이용횟수, 급여이용절차 및 방법, 제공목적 등을 안내한다. 월한도액과 급여비용 및 본인부담금을 안내하고, 비급여 대상 및 항목별 비용을 설명한다. 수급자와 가족에게 적정급여 제공 확인을 위해 정기적으로 방문할 것을 알리고, 사전에 협조를 부탁한다. 수급자(가족)의 욕구나 기능상태 변화에 따라, 필요시 변경될 수 있음을 알린다. 급여제공계획서는 보관하여 서비스 제공 과정에서 수급자(가족)가 활용할 수 있도록 안내한다.



수급자에 대한 급여제공계획 설명

1. 수급자 강점에 초점을 맞추어 어떠한 서비스를 어떻게, 어떤 목적으로 제공할 것인지 설명
2. 급여범위를 명확히 안내하고, 이를 벗어난 요구에 대해 서비스불가사유 사전에 숙지시키기
3. 수급자를 위해 무엇보다 가족의 참여와 지지가 중요함을 인식시키기

마) 수급자(가족)의 동의 후, 공단 통보

수급자(가족)에게 급여제공계획에 대한 확인 서명을 받는다. 확인서명을 받을 수 없는 경우, 반드시 급여계획서를 우편발송하고 보호자에게 우선으로 안내하며 작성한 계획서와 동의서는 수급자(가족)와 관리자가 각각 한 부씩 보관한다.



동의를 수급자(가족)가 대등한 관계로, 계획의 실천을 위해 참여하고 책임을 지한다는 의미가 있음을 이해한다.

바) 수급자의 욕구 및 기능상태 등 변화가 있어 조정이 필요한 경우, 급여제공계획 재작성

급여제공계획의 변경이 필요한 경우(수급자 기능상태 및 욕구 변화, 수급자 및 보호자 요구 등) 그 사유를 기록한다.



「노인장기요양보험법 시행령」 제13조(장기요양급여의 제공) ⑤ 장기요양기관은 장기요양급여의 제공 중 수급자 심신의 기능상태, 수급자의 욕구 및 장기요양등급 등이 변경된 경우에는 지체 없이 이를 반영하여 장기요양급여 제공 계획을 다시 작성하고, 수급자의 동의를 받아 그 내용을 공단에 통보해야 한다.

다. 계획수립과 기록

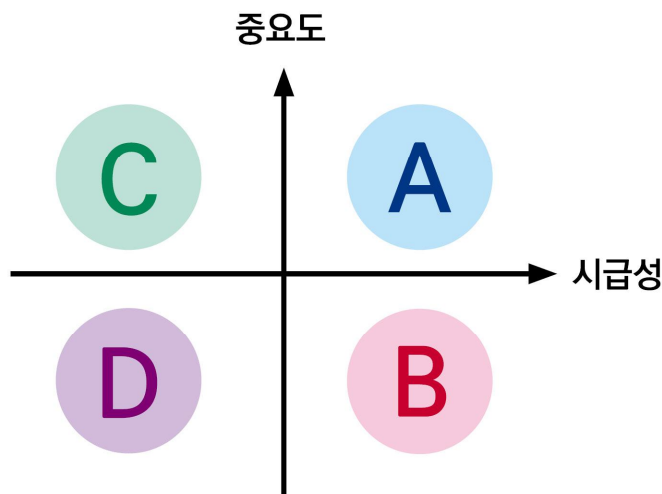
1) 계획수립의 기술

사례관리자는 계획수립이 가지는 업무의 목적과 의미를 이해하고, 수급자 및 자원과의 협력적 관계 속에서 이를 구체화하기 위한 실천적 기술을 발휘할 필요가 있다.

가) 욕구에 기반한 우선순위 설정

수급자가 가지고 있는 다양한 욕구들 모두에 대해 대응하는 것은 곤란하며, 이중 시급성과 중요성을 고려하여 우선순위를 부여해 볼 수 있다. 가장 우선순위가 높은 것은 중요성과 시급성이 모두 높게 평가된 욕구(A)일 것이며, 다음으로는 둘 중에 하나가 높게 평가된 욕구(B, C)를 설정해 볼 수 있다. 다만 주의할 것은 중요성도 시급성도 낮게 평가된 욕구(D)는 후순위로 위치시키기 보다는 주요 욕구에서 제거해야 한다는 점이다. 그밖에 장기요양 수급자와 같이 기능상태에 제한이 있는 경우는 중요도나 시급성 외에 달성가능성 등을 추가로 고려하여 설정하는 것이 바람직하다. 우선순위가 정해진 욕구 중에서 3가지 정도를 선정하여 변화목표로 연결하는 것이 일반적이다.

●● 그림 3-10 우선순위 설정



나) 단기·장기목표 구분으로, 단계적 접근

우선 장기목표는 사례관리를 통해 달성하고자 하는 최종적인 변화내용을 표현한다. 이는 '수급자의 언어'로 기술하는 것이 좋은데, 그 이유는 수급자의 인식을 반영하고 있으며, 이해와 동기를 이끌어내는 데도 효과적이기 때문이다(예. 집밖에 나가 사람들과 이야기하고 싶다). 단기목표는 장기목표를 향해 가는 사례관리의 과정에서 기대하는 변화내용을 표현하도록 한다. '사례관리자의 언어'로 기술하는 것이 일반적인데, 보다 구체적이고 실천적인 행동을 담고 있어야 하기 때문이다(예. 주야간보호 프로그램 참여 및 외출빈도 향상). 단기목표는 장기목표를 부분화(Partializing)하여 보다 용이하게 해결하도록 조각낸 것으로 볼 수 있으며, 단기목표의 반복적인 달성과정은 결국, 장기목표의 달성이라는 결과로 이어지는 위계적 구조를 가진다.

다) 수급자의 주체로서의 인정 및 긍정적 표현 사용

목표는 수급자를 객체가 아닌 주체(주어)로 표현하는 것이 원칙이다. 또한 부사나 형용사 등 불분명하거나 주관적인 표현을 피하는 것이 바람직하며(예. 적극적으로, 가능한, 충분히 등), 특히 부정적인 언어(예. 흥분하지 않기)보다는 긍정적인 언어(예. 안정적인 감정 지니기)로 기록하여야 한다.

변화목표는 수급자가 주체

예를 들어, '식사준비 및 도움/안전손잡이 설치'는 제공자가 실시하는 수단으로 이 자체가 목표가 될 수는 없다. 따라서 이를 통해 기대되는 변화인 수급자의 '안정적 식생활 유지/이동 편의성 향상'이 목표로서 보다 적합하다.

라) 평가를 고려한 변화목표 설정

변화목표는 이후 실행과정을 통해 평가로 연결된다는 점을 강조한 바 있다. 예를 들어 사례관리의 성과는 변화목표(예. 이동편의성 향상)의 달성도(예. 이동 편의성 향상이 되었는가)를 통해 평가 가능하다.

마) 비공식 인력의 활용

계획수립 과정에서 실행담당자를 선정할 때 주의할 것은 공식적인 인력 외에도 수급자와 가족 등 비공식적 인력을 실행담당자로 우선적으로 고려할 수 있어야 한다는 점이다. 이처럼 비공식적 인력이 중요한 이유는 사례관리의 근본적인 목적이 수급자의 장점을 활용하고 역량을 강화하는 것에 있기 때문이며, 사례관리계획에 의한 개입활동이 이루어지지 않는 시간이나 또는 사례관리가 종결된 이후에도 비공식적 인력에 의한 지속성과 책임성을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 그밖에 수급자가 이전에 경험한 담당자이거나 외부 자원일 경우, 수급자의 경험과 선호도를 함께 고려하는 것이 이후의 실행과정을 보다 원활하게 수행할 수 있는 방법이기도 하다.

2) 계획수립 관련 양식 및 기록

●● 표 3-9 장기요양급여 제공 계획서(방문요양, 방문목욕, 방문간호)

■ 노인장기요양보험법 시행규칙 [별지 제11호의3서식] <개정 2021. 6. 30.>

장기요양급여 제공 계획서(방문요양, 방문목욕, 방문간호)

※ 뒤쪽의 작성방법 및 유의사항을 읽고 작성하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 적지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호		접수일					
①수급자	수급자 성명	생년월일					
	전화번호(휴대전화번호)						
	장기요양등급	장기요양 인정번호					
	장기요양 인정유효기간	개인별장기요양 이용계획서 번호					
②동의자	성명	수급자와의 관계					
	전화번호(휴대전화번호)	동의일					
③장기 요양기관	장기요양기관명	장기요양기관기호					
④ 급여제공 계획 작성	장기요양급여 종류	장기요양급여 계약일	장기요양급여 계약기간	장기요양급여 제공 계획서 적용기간	작성일	통보일	
	방문요양						
	방문목욕						
	방문간호						
⑤급여제공계획 내용							
목표	방문요양						
	방문목욕						
	방문간호						
급여종류	장기요양 필요영역	장기요양 세부목표	장기요양 필요내용	세부 제공내용	횟수	시간	작성자

종합의견	총괄 확인자						
「노인장기요양보험법」 제27조 및 같은 법 시행령 제13조, 같은 법 시행규칙 제21조의2에 따라 수급자의 장기요양급여 제공 계획서 내용을 국민건강보험공단에 통보합니다.							
년 월 일							
장기요양기관의 장(대표자) (서명 또는 인)							
동의자 (서명 또는 인)							

국민건강보험공단 이사장 귀하

● 표 3-10 장기요양급여 제공 계획서(작성예시)

장기요양급여 제공 계획서				장기요양기관명	00재가복지센터
				장기요양기관번호	
				급여종류	방문요양
수급자 성명	000	생년월일		계약일자	
장기요양 등급	0등급	장기요양 인정유효기간		계약기간	
개인별장기요양 이용계획서 번호		급여적용기간		작성일	
목 표	1. 현재 신체기능상태의 유지 2. 지원을 통한 수단적 일상생활활동의 수행 3. 청결 유지				

장기요양 필요영역	장기요양 세부목표	장기요양 필요내용	세부제공 내용	횟수	시간 (분)	작성자
신체활동지원	청결한 생활을 유지할 수 있다	옷 갈아입히기	옷 준비하고 갈아입혀주고 뒷정리 하기 등 대부분 도움	수 시	5	
		세면해주기	침상에서 세면도구 준비하여 얼굴 씻겨주고 닦아주기	일 1회	5	
		몸 씻어주기	샤워준비와 몸 씻어주고 물품 정리하기	주 1회	20	
		머리 감겨주기	욕실 이동 및 전적인 머리감기 도움 및 정리	주 1회	10	
		머리 단장	머리빗기 및 손질	일 1회	5	
일상생활지원, 환경관리	개인위생청결을 위한 서비스 제공, 균형잡힌 식사 준비 및 제공	취 사	식재료 준비, 밥짓기, 반찬준비, 설거지, 행주삶기, 음식물 분리수거 등	일 1회	30	
		세 탁	수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁	일 1회	20	
		청소 및 주변정돈	수급자가 거주하는 방, 거실, 화장실 청소, 이무자리 정돈 등	일 1회	30	
		장보기	식료품, 약품, 의류 등 생활필수품 구매 등	주 2회	20	
개인활동지원	외출 시 이동 부축도움주기 등 동행	외출 시 동행	외출 시(산책 등) 부축 또는 동행(차량이용 포함)하고 책임귀가	주 3회	25	
		병원동행	병원진료를 위한 외출 시 부축 또는 동행하고 책임귀가			
종합 의견	관절 구축이나 근력 약화를 방지하기 위해 꾸준한 관리가 필요 이동 시 낙상에 유의하는 서비스 제공 외상생활 하시므로 정기적인 체위변경과 욕창예방을 위한 서비스 제공하기					

위의 급여제공계획에 대해 상세히 들었음을 확인합니다

20**년 0월 0일

확인자

서명 또는(인)

「노인장기요양보험법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 수급자의 장기요양급여 제공계획서 내용을 국민건강보험공단에 통보합니다

20**년 0월0일

장기요양기관의 장(대표자):

(서명 또는 인)

국민건강보험공단 이사장 귀하

※ 본 양식은 기관포털(전산)에서 출력 시 제공되는 양식임

● 표 3-11 사례회의 기록지 양식(예시 1)

성 명		생년월일	
장기요양등급	등급	인정유효기간	
월 한도액	1월 당 원	본인부담금(율)	%

주요 장기요양 문제 및 욕구		서비스 제공 목표		서비스 제공 영역	
		장기목표	단기목표	서비스 제공유형	서비스 제공내용
방문요양 관련					
재가급여 관 련					
복지, 보건, 문화, 권익보장 관련					

방문요양서비스 이용계획 및 비용			
급여종류 및 내용	횟수(회/월)	장기요양급여비용(원)	본인부담금(원)
합 계			

방문요양서비스 외 타 사회자원 이용계획 및 비용			
급여종류 및 내용	횟 수	서비스 이용 비용	본인부담금
방문요양의 재가급여			
시설급여			
복지 및 보건, 문화, 권익보장서비스			

사례관리기관 및 담당자	기관명:	작성일:	담당자:
서비스 이용계획 변경 필요여부 (통합사례회의 필요여부)	☐ 필요(변경 사유:)		☐ 불필요
방문요양서비스 외 타 사회자원 연계 및 의뢰 필요	공단의 타 서비스 의뢰	☐ 필요	☐ 불필요
	관련기관 서비스 의뢰	☐ 필요	☐ 불필요

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-12 사례회의 기록지 양식(예시 2)

구 분	세부내용
회의일시 참가자	• 사례회의가 진행된 일시 기록 • 사례회의의 참가자 기록
회의제목	• 사례회의 목적 또는 사례회의에서 논의된 주요 내용과 관련된 제목 설정 예 시 - 첫 사례회의 - 모니터링 사례회의 - 수급자 선정을 위한 사례회의 - 재사정 결과 논의 및 계획 수립을 위한 사례회의 - 첫 사례회의 결과 수급자 현황 파악 및 서비스 개입방안 논의
회의내용	• 사례회의 진행시기에 따라 유형 분류 1) 첫 번째 사례회의 ① 문제 및 욕구 분석 초기상담, 인적정보관리, 개인별장기요양이용계획서를 기반으로 욕구조사, 사정을 통해 파악된 수급자 및 가족의 문제 및 욕구에 대한 종합정리 및 분석 ② 장기/단기목표 수립 사례회의를 통해 장기/단기목표를 수립 ③ 수급자 선정 여부 판단 사정 결과를 통해 해당 방문요양기관의 사례관리 수급자 선정여부를 판단하여 기술 ④ 타기관으로의 의뢰 여부 판단
회의결과	• 사례회의 결과, 수급자 및 가족에게 제공될 구체적인 서비스 계획 정리 - 서비스명, 연계기관, 제공주기, 제공방법 등 서비스 제공 전략을 포함한 계획 정리

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-13 사례회의 기록지 양식(예시 3)

사례회의구분		☐ 내부사례회의 ☐ 통합사례회의 ☐ 기타()	
사례관리번호		수급자명	
회의 차수		회의 일시	
작성자		소속 기관	
회의 제목			
회의 내용			
회의 결과			
참 석 자	내부 참석자	소속: 직책: 성명:	
	외부 참석자	소속: 직책: 성명:	
차기 회의 예정일시		()차:	

〈이어서〉

작성방법	
항 목	작성방법
사례회의구분	○ 내부사례회의, 통합사례회의, 기타 회의 구분 선택 및 작성
사례관리번호 수급자명, 회의차수, 회의일시	○ 사례회의 대상의 사례관리번호, 수급자명, 회의차수, 회의일시 기록
작성자, 소속기관	○ 작성자명, 소속기관을 기록
회의제목	○ 사례회의의 주요 안건을 요약하여 작성
회의내용	○ 사례회의의 주요 내용을 작성, 세부 작성방법은 정해져 있지 않으며, 사례별, 회의내용별 정리
회의결과	○ 회의 내용 중 결정사항, 협조사항, 향후 추진사항 등을 중심으로 간략하게 요약
⑥내부참석자	○ 기관 내부참석자를 기록
⑦외부참석자 (수행기관 종사자 등)	○ 회의 안건 관련 외부 유관기관 참석자, 사례관련인(예, 사례관리수급자, 가족, 복지위원), 희망복지지원단, 시군구 및 읍면동의 유관부서 담당자 등 기록
⑧외부참석자 (외부전문가)	○ 사례 슈퍼비전 제공 등의 목적으로 참석한 외부전문가를 기록
⑨차기회의 예정일시	○ 차기 사례회의가 필요할 시, 차기회의의 일정을 협의하여 기록

※ 자료: 복지부, 사례관리 서식 표준, 만-관 정보공유시스템 구축 사업.

● 표 3-14 서비스제공계획 및 점검표(예시)

[illegible]

본인은 년 월 일부터 상기와 같은 서비스 이용에 동의하며, 적극적으로 변화 노력에 동참할 것을 약속 합니다. 또한 더 나은 생활지원을 위해 협력하는 기관들과 본인 및 가족의 기초정보 및 서비스진행과정에 대한 정보를 공유하는 것에 대해 동의합니다.

20 년 월 일 성 명: (인)

20 년 월 일 사례관리자: (인)

〈이어서〉

작성방법	
항 목	작성방법
사례관리번호	○ 접수 시 생성된 해당 사례관리번호 기입
수급자명	○ 직접적으로 서비스를 수혜 받을 가구원의 이름으로, 서비스 수혜 주체가 가구 단위인 경우나 파악이 어려운 경우에는 세대주의 이름을 기록함
사례관리자 및 소속기관	○ 사례관리 수급자를 담당하고 있는 사례관리자의 성명과 소속기관을 기록함
성과목표 (단기목표, 장기목표)	○ 다양한 서비스제공을 통해 궁극적으로 변화를 가져오기 위한 영역 및 각 영역별 변화의 양과 질에 대한 기대치를 기록함 - (단기목표) 사례관리시작 이후 적어도 3개월 이내에 달성 가능한, 성취의 수월성에 대한 고려뿐만 아니라 장기목표를 달성하기 위한 과정적 목표 설정을 위해서도 활용 가능함. 단기목표 설정으로 가능한 부분은 행동이나 인식의 변화보다는 새로운 지식이나 정보의 습득, 이를 통해 새로운 자원의 활용 등 궁극적인 행동변화에 영향을 미치는 생활조건적 변화를 목표로 할 때 더욱 적절함 - (장기목표) 단기목표 달성을 통해, 혹은 단기목표와 무관하게 3~6개월 이상의 개입노력을 통해 변화를 가져올 수 있는 영역, 행동이나 태도의 변화를 도모하기 위한 목표로 적절함. 서비스목표는 장, 단기라는 시간적 구분 및 목표달성의 수월성, 복잡성 등에 대한 종합적 고려를 통해 설정하되, 목표를 제시하는 이유는 사례관리과정을 통해 궁극적으로 수급자와 그 가족에게 기대되는 측정 가능한, 혹은 객관적으로 판단이 가능한 변화 상태를 규정하는데 있음
욕구영역별 개입목표	○ 장단기 목표를 영역별로 재구분하여 기록함
서비스명	○ 서비스목표에 따라 제공되어야 할 서비스 자원 및 시설의 구체적인 내용을 기록함
우선순위	○ 아래와 같은 기준에 의거하여 수급자와의 합의에 기반하여 설정함 - 수급자의 근로 저해 요소로 판단되는 주요 문제 중에서 단기간 내 제거 가능한 것 - 보호수급자가 가장 중요하다고 인식하거나, 수급자의 삶에 당장의 위험을 끼칠 가능성이 있는 긴급한 것 - 작은 것, 달성하기 쉬운 것으로 구체적이며 명확하고 행동적인 것, 수급자의 생활에서 현실적이고 성취 가능한 것 - 서비스가 미뤄질 경우 다른 욕구영역에까지 새로운 문제 유발 혹은 욕구발생 가능성이 높은 것
개입시기	○ 우선순위와 함께 사례관리의 효율적 추진을 위해 서비스가 적시에 이루어질 필요가 있음 - 긴급성, 현실적 개입가능시기 등을 고려하여 각각의 서비스 내용별로 1주일이내, 한 달 이내, 3개월 이내 등 예상개입시기에 설정하여 시간제한적인 개입활동이 이루어질 수 있도록 함
서비스기간 및 횟수	○ 서비스의 충분성과 연관되어 있음. 즉 서비스를 통해 기대되는 성과를 도출하기 위해 얼마만큼의 서비스가 제공될 필요가 있는지, 그 투입량에 대한 잠정적 계획의 의미를 지님. 그러나 외부기관에 의뢰하여 서비스를 제공하는 경우는 그 기관의 서비스제공지침에 의존할 수밖에 없으므로 그 기관의 서비스 제공 지침을 고려하여 서비스기간 및 횟수를 구체적으로 기록함
서비스 제공기관 및 담당자	○ 실제로 서비스제공의 일차책임을 수행하는 기관의 담당자명을 파악, 기록하여 주기적인 모니터링 채널을 구축하도록 함
점검방법	○ 점검이 이루어진 방법에 대한 기록으로, 수급자의 내방 또는 전화, 방문, 시스템 등 점검 방법을 기술함
이행여부	○ 해당 서비스가 계획된 기간 동안 계획된 횟수로 제공되고 있는지 확인하여 제공횟수를 기입
변경내역	○ 서비스 계획 대비 변경된 서비스 내역을 기록함
변경사유	○ 서비스 계획 대비 서비스 제공의 차이가 발생한 원인 및 사유를 기록함
수급자 상태 점검 결과	○ 해당 서비스 제공으로 인하여 나타난 수급자의 변화의 정도와 내용을 중심으로 기술하며 수급자의 환경 및 중대한 욕구의 변화가 있는 경우 해당 내용을 기록함
서비스이용 및 참여에 대한 동의	○ 서비스제공계획에 따라 서비스 이용과 수급자 참여에 대한 동의 서명을 받도록 함

※ 자료: 복지부, 사례관리 서식 표준, 민-관 정보공유시스템 구축 사업.

4 실행단계

학습목표

- 실행단계의 개념과 목적을 이해하고 설명할 수 있다.
- 실행단계와 관련한 다양한 실천 내용을 숙지하고, 절차에 따라 수행할 수 있다.
- 실행단계의 실천 기술을 이해하고, 활용할 수 있다.

가. 실행의 이해

1) 실행의 개념과 목적

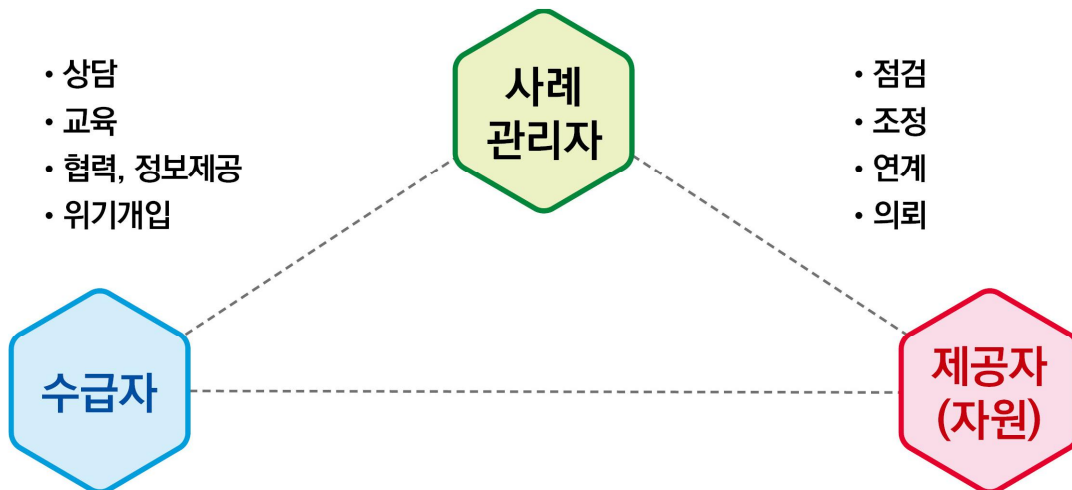
수립된 계획에 따라 수급자의 욕구에 대응한 개별화된 서비스가 적절하게 제공되도록 지원하는데 기본적인 목적이 있다. 실행 및 점검단계를 수급자에게 단순히 서비스를 전달하는 과정으로 파악해서는 곤란하며, 사례관리자와 수급자, 실행 담당자 간에 상호 관계성 속에서 이해해야 한다. 실행을 통해 수급자가 자신의 욕구를 충족시키는 물론, 이를 가능한 자신의 능력으로 지속할 수 있도록 지원하고 강화하는 활동을 의미하기 때문이다.

사례관리자는 수립된 계획에 기초한 실행과정에서 제공되는 다양한 개입활동의 양적, 질적 적정성을 점검하여 필요할 경우, 조정을 실시하여야 한다. 또한 수급자의 욕구 및 상태변화가 파악되었을 경우는 신속히 필요한 조치를 제공하도록 한다.

2) 실행의 내용

사례관리의 실행단계에서는 사례관리자와 수급자, 서비스 제공자(자원) 등 참여주체 간에 다양한 상호작용이 일어나게 된다. 계획수립단계에서 제시된 변화목표 달성을 위해 이들 주체들은 각자의 역할과 기능을 담당하게 된다. 사례관리자를 중심으로 실행단계에서 이루어지는 직접 및 간접 실천의 내용과 기술을 차례로 정리해 보면 다음과 같다.

● 그림 3-11 실행단계의 참여 주체와 실천내용 및 기술



가) 직접실천(사례관리자-수급자)

실행단계에서 직접실천은 사례관리자와 수급자의 면대면(Face to Face) 관계를 기본으로 사

례관리자가 실시하는 직접 개입 활동을 의미한다. 수급자에 대한 상담, 교육, 협력 및 정보제공, 위기개입 등의 활동이 여기에 속한다고 할 수 있다.

(1) 상담(Counseling)

단순한 정보제공이나 격려를 넘어 수급자에게 문제해결을 위한 구체적인 해법(Solution)을 제공하는 실천활동이다. 즉, 상담은 명확한 목적 하에 이루어지는 의도된 과정으로 단순히 수급자의 말을 듣거나 의견을 제시하는 활동과는 구분하여야 한다.

예를 들어, 수급자가 서비스 제공자나 자원에 대해 거부감을 가지고 있다면, 서비스제공자나 자원에 대한 기본적인 인식과 접근성을 향상시키기 위한 목적으로 상담을 실시하여, 수급자 내부의 부정적 장애물을 제거하고 자신감을 회복시키는 한편, 자원에 대한 새로운 정보와 관점을 획득하게 하는 등의 활동을 의미하는 것이다.

(2) 교육

사례관리의 실행단계에서 교육은 사례관리자가 자립적인 일상생활의 수행이 가능하도록 수급자의 관련 지식과 기술, 태도를 향상시키기 위한 활동을 의미한다. 이때 교육은 단순한 결과물의 전달이 아니며, 수급자가 문제해결을 위한 능력과 방법을 습득할 수 있도록 하고 그 능력을 향상시키는데 초점이 있다. 이를 위해 사례관리자는 코칭과 역할연습, 집단교육 등 다양한 교육방법을 적용해 볼 수 있다.

과업능력의 향상

예를 들어, 외출을 원하나 하지기능이 저하되어 외출을 할 수 없는 노인이 있다고 하자. 교육은 노인의 하지기능을 치료하여 문제 자체를 해소하는 것이 목적은 아니다. 교육은 노인의 욕구를 인정하고 동기를 부여하는 한편, 휠체어나 이동보조기의 사용법을 익히도록 하여 외출하기라는 과업을 자립적으로 수행할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

(3) 협력 및 정보제공

협력은 수급자가 욕구를 충족하기 위해 자원을 획득하거나 문제해결기술을 향상하는 등 제반과정에서 사례관리자로서 함께하는 활동이라고 할 수 있다.

가장 대표적인 협력의 방법은 사례관리자의 대처방식을 모델링하도록 일종의 본을 보여주는 것인데, 예를 들어 지역사회 복지관과 같은 자원에 접근하기 어려운 상태라면, 사례관리자가 수급자와 함께 몇 차례 동행(동반서비스: Traveling Companion)함으로써 수급자가 스스로 수행할 수 있는 역량을 기르도록 하는 것이다.

정보제공은 수급자에게 유용한 정보를 구조화하여 제공하는 활동을 의미한다. 이때 중요한 것은 단순히 나열된 정보를 있는 그대로 전달하는 것이 아니며, 수집된 정보를 수급자의 욕구와 상태수준에 따라 분류하고 재가공하여 전달하여야 하는 것이다. 이를 위해 정보의 내용을 언어만이 아니라 그림이나 동영상 등의 형태로 가공하여 제시할 수도 있다.

(4) 위기개입활동

위기상황에 처한 클라이언트를 대상으로 신속한 개입을 통해 안정된 상태로 회복시키는 활동이라고 정의할 수 있다. 위기상황에 처한 수급자는 극심한 혼란 속에서 대응력이 저하되는 경험을 하게 되고, 이것이 장기화하면 욕구좌절과 실패감으로 낮은 자존감과 부정적 정서가 고착화되기 쉽다.

사례관리자의 신속한 위기개입활동을 통해 수급자의 인지적 회복을 돕고 문제해결을 위한 자원을 연계하는 등의 활동을 수행하게 된다. 다만, 유의할 것은 위기개입활동은 위기발생 이전 상태로의 회복과 안정을 의미하는 것이며, 그 이상을 추구하는 것은 아니라는 점이다. 즉, 위기 발생 이전의 상태가 수급자에게는 익숙하고도 안정된 상태로, 만약 개입과

정에서 그 이상의 개선을 향한 개입이 필요하다면 위기개입 종료 후에 별도의 사례관리를 시작하는 것이 바람직하다.

위 기

위기란 주거 상실, 중요한 타인의 사망, 소득상실 등 어떤 사건이 사람들이 지니고 있는 일상적인 문제해결 방식을 압도하는 사건이 발생했을 때, 클라이언트가 어떤 상황에 대해 효과적으로 대처하기가 불가능하거나 무력한 상태로 남겨졌을 때를 의미한다(Dixon, 1979; Barten, 1987; 한국사례관리학회, 2014).

나) 간접실천(사례관리자-제공자(자원))

실행단계에서 간접실천은 사례관리자와 수급자 사이에 이루어지는 직접 접촉을 통한 활동은 아니나, 제공자(자원)나 외부 지지체계에 대해 실시하는 간접 개입활동을 의미한다.

(1) 점검(Monitoring)

사례관리자가 수립한 계획에 따라 실행과정이 제대로 진행되고 있는지 확인하는 절차라고 할 수 있다. 점검을 통해 사례관리자는 서비스 제공자나 자원의 양과 질이 방향을 잃지 않고 적절한 수준으로 유지되고 있는지, 수급자의 상태나 욕구변화가 있는지 파악하여 적절히 대응할 수 있게 된다.

점검의 기술로는 방문, 전화 접촉 등 인터뷰를 통한 질적 점검, 각종 척도 및 도구 활용, 기록지 등을 통한 양적 점검방법이 있다.

(2) 조정(Coordination)

점검결과를 반영한 것으로, 계획에 의한 서비스가 보다 적절한 수준으로 제공될 수 있도록 개입하는 활동이라고 할 수 있다. 조정은 수급자의 욕구와 상태 변화에 초점을 두고 진행되어야 하며, 조정된 결과물은 수급자에게 사전 동의를 받고 실제 실행에 반영되어야 한다.

(3) 연계(Linkage)

사례관리자가 계획에 정해진 서비스를 제공할 수 있는 적정 제공자와 자원을 선택하여 수급자와 연결하는 활동을 의미한다. 흔히 연계를 중개(Brokering)라고도 하는데, 사례관리자가 자원을 분석하여 정리하고(자원목록 작성 및 관리), 수급자가 자원목록에서 자원을 선택하도록 도와(자원목록 설명 및 선택), 자원에 대한 협의 및 연결(사전 협의절차 및 계약)을 실시하는 등의 활동을 포함한다.

사례관리자가 실제 연계에 활용할 수 있는 자원이 되기 위해서는 단순히 알고 있는 정도가 아니라, 공식적인 협약을 통한 의뢰체계가 형성되어 있어야 하며, 특히 자원 내에 존재하는 실무자나 종사자들과의 접촉점(Contact Point)이 작동되어야 한다.

(4) 의뢰(Referral)

사례관리과정이 종결(Exit)된 수급자를 별도의 외부 자원으로 연결하는 활동을 말한다. 다만, 현장에서는 의뢰를 폭넓게 이해하여 사례관리를 받고 있는 수급자를 외부의 전문가 또는 전문 기관에 연결하는 연계활동과 혼용하여 사용하는 경우가 있으므로 주의하도록 한다.

나. 실행의 실제

1) 기본관점

장기요양현장에서의 실행은 급여제공계획서에 근거하여 진행하는 것이 중요하다. 수급자에 대한 인정조사 결과 도출된 개인별장기요양이용계획서에 기초한 급여제공계획서는 계획수립과정에서는 물론, 실행 즉 서비스 제공과정에서도 기준이 되며, 점검(모니터링)과 조정(코디네이션)의 근거가 되기 때문이다. 실행단계에서 사례관리자가 견지하여야 할 관점을 정리해보면 다음과 같다.

● 표 3-15 실행단계에서 사례관리자가 견지하여야 할 관점

- ① 급여제공계획에 따라 서비스 제공되도록 종사자를 교육하고, 정기적인 모니터링 실시
- ② 수급자가 '하고 있는 것'은 지속 유도하고, '할 수 있는 것'은 스스로 가능하도록 지원
- ③ '할 수 없는' 장애요인보다 강점을 발견하고, 이를 유지·증진하도록 하는데 중점
- ④ 제한적이거나 수급자의 자립을 유도하고 그 과정에서 인권을 최대한 보호
- ⑤ 수급자의 복합적인 기능상태 및 욕구변화가 있다면, 서비스의 수준을 조정하여 제공
- ⑥ 급여제공의 모든 과정에서 수급자와 가족의 참여와 개입을 보장
- ⑦ 장기요양급여 외에도 가능한 지역사회자원 발굴·연계 노력

2) 과정 및 절차

실행단계에서 직접 서비스 제공인력은 계획된 서비스를 차질 없이 수급자에게 전달하는 것이 중요한 역할이나, 사례관리자는 이렇게 제공되는 서비스의 양과 질이 당초 계획에 비추어 적정한지를 점검하고, 수급자의 상태나 욕구변화 등이 있어 필요할 경우에는 조정을 수행하는 활동이 주를 이루게 된다. 장기요양기관이 실행단계에서 수행할 수 있는 사례관리 활동의 과정을 정리해보면 다음과 같다.

가) 재가장기요양기관(방문요양)

(1) 사례관리 업무는 사례관리를 통해 수립된 계획이 실행되는 장소가 기관 내부가 아닌 외부(수급자의 가정)라는 점에서 가장 큰 차이가 있다.

수급자의 가정을 사례관리자나 서비스 제공자인 요양보호사의 관점에서 보자면 서비스 제공을 위한 작업 환경으로 공적 공간이 되지만, 수급자나 가족의 관점에서 보자면 가정은 사적인 공간으로 개인에 대한 존중과 프라이버시 보호가 중요할 수밖에 없다. 사례관리자는 이러한 참여자의 특성과 입장을 고려하여 사례관리 업무를 수행하여야 한다.

우선, 본격적인 실행 전 준비단계로 사례관리자는 급여제공계획서에 따라 서비스가 제공될 수 있도록 담당 제공인력에 대해 급여제공계획을 교육한다.

(가) 수급자(가족)의 기능상태와 욕구, 생활환경, 가족구성 등에 관하여 충분히 교육한다.

수급자의 질병, 복용약품 등 보건의료적 욕구와 배우자, 자녀 등 가족구성, 심리정신 상태 등 사회심리적 욕구에 대하여 충분히 숙지하도록 하며 동거가족이나 이웃이 있을 경우, 연락처 등을 공유한다.

(나) 담당 장기요양요원(요양보호사 등)에게 작성된 급여제공계획을 설명한다. 급여제공계획의 내용과 목표를 인지시키고, 해당 장기요양요원의 담당 업무내용을 설명하여 급여제공방법을 숙지하도록 한다. 또한 급여제공계획서에 따른 급여제공의 중요성과 급여제공기록지의 작성 방법을 교육하며, 수급자(가족)의 부당한 요구에 대한 대응과 응급시 대처방법 및 노인학대예방·신고 방법 등을 숙지시킨다.

(다) 담당 장기요양요원의 의견을 청취하여, 기타 설명이나 보완할 사항이 있는지 판단하

여 반영한다. 급여제공계획의 실천과정에서 팀워크를 이루어 참여할 수 있도록 장기요양요원 간 이해와 의견교환 기회를 제공한다.



point

- 수급자(가족)의 기능상태나 욕구변화, 특이사항이 있을 경우에는 관리자에게 즉시 알리도록 지도한다.
- 적정급여 제공 확인을 위한 정기적인 가정방문이 예정되어 있으며, 그 목적과 방법을 이해하도록 설명한다.

(2) 다음으로 사례관리자는 본격적인 서비스 제공을 실시하고 이에 대한 점검활동을 수행한다. 사례관리자는 매월 정기적으로 수급자의 가정을 방문하여 급여제공계획에 근거한 적정 서비스 제공 여부를 모니터링 한다.

(가) 방문 전에 수급자(가족)에게 미리 연락하여 일정을 알리고, 가족이 함께 참여할 수 있도록 유도한다.

(나) 상담기록지 등 필요서류와 옷차림을 점검하고 신분증을 착용한 후 방문한다. 주거환경, 독거여부, 주 수발자 등 지지체계의 변화를 파악하고 생활환경과 위험 및 사고예방, 안전을 위한 조치가 필요한 부분을 확인한다.

(다) 장기요양요원이 제공한 서비스 제공내용에 대해 모니터링을 실시한다. 급여제공계획에 따라 급여가 제공되었는지 여부를 확인하고 제공된 급여의 세부적인 서비스 내용과 수준, 제공량을 함께 파악한다.



point

- 수급자(가족)의 입장과 함께 장기요양요원의 위치나 역할, 근무여건과 애로사항도 균형적으로 살펴보도록 노력하기
- 모니터링 과정에서 문제가 발견될 경우, 그 원인을 우선적으로 파악해 보기

(라) 급여제공계획서 상의 필요영역, 목표, 필요내용 등을 비교하여 달성도를 평가한다. 수립한 목표의 달성 여부, 우선순위의 변동 가능성 등을 판단하고 수급자(가족)와 상담을 통해 추가로 필요한 서비스나 요구, 불편사항이 없는지 확인한다.

(마) 수급자의 기능상태나 욕구 등에 변화를 파악하고, 필요시 급여제공계획을 변경한다. 질병이나 건강상태의 변화 여부(호전, 유지, 악화)와 해당 기능을 파악하고 특이사항을 기록한다. 신체나 인지상태에 현저한 변화가 있는 경우, 병원, 보건소 등에서 검사, 진료 등 필요한 서비스를 받도록 연계하며 필요시 등급인정유효기간을 확인하여, 개인별장기요양이용계획서 재발급, 인정조사신청 등 조치를 취한다.

나) 기관 및 공단 이용지원팀(케어조정자)의 점검(모니터링) 활동

보험자인 공단의 모니터링과정은 사례관리자와 수급자를 대상으로 이루어진다. 사례관리자를 대상으로는 사례관리 실행계획이 계획대로 이행되고 있는지, 수급자에게 제공되는 서비스가 적합한지 등을 점검하며, 수급자를 대상으로는 수급자가 사례관리 과정에 적극적으로 참여하며 만족하고 있는지, 수급자가 충족해야 할 욕구의 내용과 수준이 변화되고 있는지를 확인한다.

핵심내용

- 수급자별 상담주기별 모니터링
- 서비스제공내용, 급여제공계획 이행여부 모니터링
- 모니터링 결과에 따른 조치
- 이용지원 상담과 수급자의 만족도와 변화 점검

- (1) 서비스 제공기관에 대한 점검사항: 수급자의 기능상태와 욕구를 반영한 서비스 제공계획 수립 및 제공의 적절성 등
- (2) 사례관리 수급자에 대한 점검사항: 사례관리를 통한 수급자의 변화정도(수립된 성과목표 일치성, 수급자의 삶의 변화), 수급자가 연계된 서비스에 실제로 참여하는 정도, 서비스 내용의 적절성, 서비스 양의 충분성, 서비스의 품질과 이에 대한 수급자의 만족도, 서비스의 제공방법의 적절성 등, 서비스제공 계획 수정 필요 여부
- (3) 점검에 따른 조치

● 표 3-16 점검에 따른 모니터링 결과

모니터링 결과	조치내용
- 수급자를 둘러싼 환경의 변화가 발생하여 재검토가 필요한 경우 - 서비스가 진행되면서 심각한 신규 욕구 또는 문제가 발생한 경우	재사정
- 서비스의 양 또는 횟수에 대한 수급자가 변경 요청 시 - 사회복지사의 판단 결과 서비스의 양 또는 횟수의 변경이 필요한 경우 - 욕구(목표)에 따른 서비스의 내용 및 종류 변경이 필요한 경우 - 서비스 제공자(장기요양기관)의 여건 변화로 서비스 제공이 어려운 경우	서비스 계획 재수립
- 수급자의 상황이 사례관리 서비스가 필요하지 않을 정도로 호전된 경우 - 수급자가 시설입소 등 타 기관 서비스 이용으로 이전한 경우 - 수급자의 이사, 연락두절 등으로 사례관리 진행이 어려운 경우 - 수급자가 1개월 이상 지속적인 사례관리 서비스를 거절 또는 포기하는 경우	종결평가

다) 공단과의 사례회의

수급자에게 위기상황이 발생하였거나 욕구 재사정이 필요한 경우, 서비스 계약기간이 만료되는 등 필요한 경우에 공단과의 사례회의를 개최할 수 있다.

핵심내용

- 공단 케어조정자, 기관 사례관리자, 지역사회 복지자원 담당자 참여
- 사례회의가 필요한 경우 개최
- 위기상황의 발생, 욕구재사정이 필요한 경우 등 기관 내에서 해결되지 못하는 문제
- 공단과의 사례회의를 개최하는 이유와 목적에 대한 합의

다. 실행단계와 기록

1) 실행단계의 기술

가) 기록

행정과 서비스 제공 과정에서 발생하는 정보 행위와 결과 등을 재생 가능한 형태로 저장하는 것, 즉 문서화하는 것을 의미한다.

기록의 내용은 장기요양서비스 제공 현장의 특성에 따라 다양하게 나타나고 있지만, 기본적으로는 수급자의 욕구, 상황, 서비스 결정과 제공 과정, 결과 등을 중심으로 이루어진다. 기록은 다양한 수급자의 욕구와 문제를 해결하도록 돕기 위한 서비스의 책임성을 높여 주며 사례관리자와 제공자의 원조기술을 증가시켜 서비스의 질을 향상시켜준다는 점에서 매우 유용하다. 특히 사례관리자와 서비스 제공자는 서비스를 기록하고 설명하며 평가함으로써 수급자와 기관 및 사회에 대한 법적·윤리적 책임을 지게 된다.

기록의 목적	
• 장기요양서비스 제공 활동의 문서화 • 사례의 지속성 유지 • 슈퍼비전의 활성화 • 행정적 자료	• 효과적인 서비스를 위한 모니터링 • 전문가 간 의사소통의 활성화 • 수급자의 정보 공유 • 조사연구를 위한 자료 제공

기록의 유형은 크게 과정기록, 요약기록으로 나누어볼 수 있다.
우선, 과정기록(Process Recording)은 상담하는 동안 일어난 모든 내용을 있는 그대로 시간적 흐름에 따라 대화 형태 그대로 기록하는 것이다. 수급자가 말한 내용, 행동하고, 관찰하고, 추측한 것을 기억할 수 있는 한 모두 기록한다.

● 표 3-17 과정기록의 예시

면 접 내 용	사회복지사 코멘트
• 사회복지사: 어르신 안녕하세요? • 수급자: 예	
• 사회복지사: 지난번 요양보호사 선생님이 다녀 간 후로 어떤 변화가 있었나요? • 수급자: 그게 그러니까(한숨을 쉬고) 고생은 하는데 내가 움직일 수 없으니 달라진 게 별로 없어요. 그래도 정성껏 도와주니 감사하지요	어르신이 식사 후 소화가 더딘 상태에서 질문을 하여 조금하게 질문한 것으로 보인다.
• 사회복지사: 아, 예, 워낙 오랫동안 누워 계셨으니 욕창도 있고 드시는 것도 죽으로 드시니 활동하기 힘들셨겠네요? • 수급자: 왜 요양보호사가 자주 오지는 않나요?	어르신이 자주 귀찮듯이 대하고, 따지듯이 대답하는 걸 보니 기관에 불만이 있는 것으로 보인다.
• 사회복지사: 요양보호사는 정해진 시간에 오기로 약속이 되어 있고, 어르신 뿐만 아니라 다른 가정도 방문해야 해서 일정을 쉽게 바꿀 수 없어요.	기관의 입장을 설명할 때는 어르신이 이해 가능한 수준으로 쉽고 편안한 분위기에서 설명을 잘 해야겠다.

요약기록(Summary Recording)은 자주 사용하는 기록의 형태로서 시간의 경과에 따라 변화된 상황, 개입활동, 중요한 정보 등을 요약하여 기록하는 것이다. 사례가 장기간 지속될 경우 유용하며, 주로 수급자에게 일어난 변화에 초점을 두어 기록한다. 주로 초기 상담, 의뢰, 종결 시에 많이 사용한다.

● 표 3-18 요약기록의 예시

- 일련번호 2019-36 ◦ 이름: 김요양 ◦ 성별: 남 ◦ 나이: 86세
- 접수일: 2019. 0. 0
- 주소: 서울시 ㅇㅇ구 XX로 000번지
- 전화번호: (주택) 02-000-0000 (핸드폰) 010-XXXX-XXXX
(아들) 010-XXXX-XXXX (딸) 010-XXXX-XXXX
- 담당: 박00 요양보호사 ◦ 작성일자: 2019. 0. 0
- 제시된 문제: 뇌경색으로 인한 혈관성 치매와 왼쪽 편마비
2019년 4월 20일 큰아들이 본 기관을 방문하여 부친의 문제를 상담함. 5개월 전 갑작스런 뇌경색 증상으로 인근 대학 병원에서 급한 수술을 하였고, 5개월 정도 입원 치료를 하였음. 초기에는 화장실도 혼자 다닐 수 없었지만 5개월 재활 치료한 후 불편하지만 보행은 가능하고 화장실도 혼자 다닐 수 있음. 다만 왼팔 마비가 심하여 혼자 옷 입기, 양 말신기를 제대로 하지 못함. 공간 인지 능력이 저하되어 낯선 환경에 가면 길을 쉽게 잃어버림. 퇴원 후 가정으로 돌아와 생활하고 있으나, 아내도 관절염과 약간의 우울증상이 있어서 남편 김요양님을 돌보는데 한계가 있음. 김요양님의 자녀는 아들 2명, 딸 3명이 있으며 모두 결혼하여 독립적인 생활을 하고 있고, 5남매 모두 부모와는 자동차로 최소 1시간 거리와 최대 6시간 거리에 거주함. 요양 4등급을 받아서 방문요양서비스를 이용하고자 함.

장기요양서비스 현장에서 서비스를 제공하는 방법이 다양한 것처럼, 기관마다 서비스의 강조점이 다르고 전달방식 등이 상이하므로 기록의 유형이나 내용도 다양하다.

나) 슈퍼비전

주로 행정, 교육, 지지라는 3개 기능으로 나누어 설명하고 있다.

- (1) 행정적 슈퍼비전은 올바르고 효과적인 기관 정책 및 절차 이행의 엄수를 보장하고 인력(사회복지사나 요양보호사)에게 업무를 적절히 수행할 수 있는 작업 배경을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. 세부 과제로는 직원 채용과 선발, 배치, 업무 계획과 평가, 의사소통 촉진, 행정적 완충과 변화 대행 등이 있다.
- (2) 교육적 슈퍼비전은 인력의 지식과 기술 향상 등 업무 능력 개선이 목적이므로 인력을 가르치고 학습을 촉진하며 정보를 제공하고 경험과 지식을 공유하고 문제 해결을 원조하는 것을 의미한다.
- (3) 지지적 슈퍼비전은 인력의 사기와 직무 만족도를 향상시키기 위해 스트레스 유발 상황을 방지하고 스트레스를 해소하도록 도우며, 책임을 공유하고 신뢰를 형성하며 관점을 공유하는 것이다.

다) 기록지

실행단계에서 활용하는 기록 양식지를 제시해보면 다음과 같다.

● 표 3-19 장기요양급여 제공기록지(방문요양)

■ 노인장기요양보험법 시행규칙 [별지 제12호서식] <개정 2019. 6. 12.>

장기요양급여 제공기록지(방문요양)

수급자 성명		생년월일		장기요양등급		장기요양인정번호				
장기요양기관명				장기요양기관기호						
일정 관리	제공 시간	()년 월/일	/	/	/	/	/	/	/	
		총시간	분	분	분	분	분	분	분	
		시작시간	:	:	:	:	:	:	:	
		종료시간	:	:	:	:	:	:	:	
서 비 스 제 공	신체 활동 지원	개인위생(옷갈아입기, 세면, 구강청결, 몸단장 도움 등)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		몸 씻기 도움	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		식사 도움 (영양관리 등)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		체위변경	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		이동 도움(보행, 보장구사용 등 도움)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		화장실이용하기	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		제공시간	분	분	분	분	분	분	분	
		인지활동 지원	인지자극활동	분	분	분	분	분	분	분
		일상생활 함께하기	분	분	분	분	분	분	분	
	인지관리 지원	인지행동변화 관리 등	분	분	분	분	분	분	분	
	정서지원	의사소통 도움 등 말벗, 격려	분	분	분	분	분	분	분	
	가사 및 일상생활 지원	식사준비, 청소 및 주변정리 정돈, 세탁 등	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		개인활동지원 (외출시 동행 등)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		제공시간	분	분	분	분	분	분	분	
	변화 상태	신체기능	①호전 ②유지 ③악화	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③
		식사기능	①호전 ②유지 ③악화	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③
		인지기능	①호전 ②유지 ③악화	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③	①②③
		배변변화	대변 실수 횟수	회	회	회	회	회	회	회
소변 실수 횟수			회	회	회	회	회	회	회	
특이 사항	/									
	/									
서명	장기요양요원 성명 (서명)									
	수급자 또는 보호자 성명 (서명)									

● 표 3-20 사례관리 서비스 진행일지 양식(예시)

방문요양 사례관리 서비스 진행일지					
성 명			생 년 월 일	. .	
장기요양등급	등급		발 급 일	. .	
장기요양기관명			장기요양기관기호		
담당자			사례관리 시작일		
서비스 제공 진행일지					
번호	날짜 (기간)	직/간구분	서비스명	주요내용	처리결과
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-21 사례관리 상담일지 양식(예시)

방문요양 사례관리 상담일지()			
수급자		상담수급자	관계:
상담자		상담시간	년 월 일 시 분 ~ 시 분
상담주제			
상담내용			
상담자 의견			

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-22 사례관리 모니터링 양식(예시)

방문요양 사례관리 모니터링									
수급자 성명		생년월일		장기요양등급		장기요양인정번호			
장기요양기관명		장기요양기관기호		담당자		점검일자			
○ 서비스 이행 및 목표 성취 정도 평가									
단 기 목 표	서비스 명	서비스 기 간	횟 수 (회 / 1주당)	기관 / 담당자	점 검 방 법	이 행 여 부 (회 / 1주 당)	변 경 내 용	변 경 사 유	목 표 성 취 정 도
									0 1 2 3
									0 1 2 3
									0 1 2 3
									0 1 2 3
									0 1 2 3
									0 1 2 3
○ 수급자의 욕구 및 환경 변화 평가									
구 분	내 용					평가 및 조치			
욕구 변화									
환경 변화									
○ 서비스 제공자에 대한 평가									
구 분	내 용					평가 및 조치			
사회복지사									
요양보호사									
○ 모니터링 결과									
담당자 의견						☐ 유지 ☐ 서비스 계획 재수립 ☐ 재사정 ☐ 종결평가			

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-23 사례관리 과정 기록지(예시)

사례관리 과정 기록지				
사례관리 번호	수급자명		사례관리자	
일시	접촉방법	접촉대상	내용	소요시간 (분)

사례관리과정기록지 작성방법	
항 목	작성방법
사례관리번호	○ 수급자의 사례관리번호 기입함
수급자명	○ 사례관리 수급자 이름을 기입함
사례관리자	○ 주사례관리자 이름을 기입함
일 시	○ 각 과정의 일시를 기입함
접촉방법	○ 각 과정의 접촉방법을 기입함(전화,방문 등)
접촉대상	○ 사례관리가구의 수급자, 가족 등 접촉 수급자를 기입함
내 용	○ 사례관리 수행 내용을 기입함
소요시간(분)	○ 수행 소요 시간을 기입함

※ 자료: 복지부, 사례관리 서식 표준, 민-관 정보공유시스템 구축 사업

● 표 3-24 타 기관 서비스 의뢰서(예시)

타 기관 서비스 의뢰서			
작성 일자		담당자	
소속		연락처	
의뢰기관		의뢰날짜	
의뢰기관 담당자		의뢰기관 연락처	
서비스 수급자 성명		전화번호	(집) (H.P.)
주소			
가구유형			
수급자 요구서비스			
주 의뢰 문제		의뢰 서비스	
첨부 내용			

〈이어서〉

서비스의뢰서 작성방법	
항 목	작성방법
작성일자	○ 서비스 의뢰서 작성 일자 기록
담당자, 소속, 연락처	○ 사례관리담당자명, 소속, 연락처 작성
의뢰기관, 의뢰기관 담당자, 연락처	○ 서비스 의뢰기관명, 의뢰기관 담당자, 연락처 작성
의뢰날짜	○ 서비스 의뢰일자 기록
서비스수급자 성명, 연락처, 주소	○ 의뢰수급자 정보 작성(서비스수급자 성명, 연락처, 주소)
가구유형	○ 현 거주 상황에 대한 정보를 통해 가구유형을 선택 - (소년소녀가구) 부모나 친인척이 없이 형제자매만 살고 있거나, 소년소녀 1인만 살고 있거나, 부양능력 없는 친인척과 형제자매가 함께 살고 있는 가구 - (독거노인가구) 65세 이상 노인 1인이 홀로 사는 가구 - (조손가구) 부모세대 없이 조부모와 손자녀로 구성된 가구 - (한부모가구) 편부·편모와 자녀 등 한부모와 자녀로 구성된 가구 - (새터민가구) 탈북자 가구 - (공동체가구) 혈연이 아닌 여러 사람이 모여 공동체를 형성하는 가구 - (노인부부가구) 부부 중 1인이 65세가 넘는 노인인 가구 - (청장년1인가구) 65세 미만 성인 단독 가구 - (부부중심가구) 부부 중심으로 부모 또는 자녀 등으로 구성된 가구 및 부부로만 구성된 가구 - (미혼모부가구) 법적인 혼인관계가 아닌 상태에서 모(부)-자녀로 구성된 가구 - (장애인가구) 가구 구성원 중에 장애인이 있는 경우, 타 가구분류와 중복 체크 가능 - (다문화가구) 국제결혼 등을 통하여 외국인 가구구성원이 있는 가구유형으로써 기본가구 유형과 별도로 체크 - (기타) 위 분류 이외의 가구유형인 경우 구체적인 가구 형태를 기록
수급자 요구서비스	○ 수급자가 요구하는 서비스 기록
주의뢰문제, 의뢰서비스	○ 주 의뢰 문제(욕구) 및 의뢰서비스 작성
첨부내용	○ 의뢰대상 및 문제에 대한 참고자료 기록

※ 자료: 복지부, 사례관리 서식 표준, 민-관 정보공유시스템 구축 사업.

5 평가 및 종결 단계

학습목표

- 평가 및 종결단계의 개념과 목적을 이해하고 설명할 수 있다.
- 평가 및 종결단계의 주요 내용을 숙지하고, 절차에 따라 적용할 수 있다.
- 평가 및 종결단계의 실천 기술을 이해하고, 활용할 수 있다.

가. 평가 및 종결의 이해

1) 평가 및 종결의 개념

급여제공계획에 따라 실시한 서비스의 과정과 성과를 평가하여 계획수립에 환류하거나 종결하는 데 기본적인 목적이 있다.

‘평가’는 사례관리자가 사정결과에 기반해 계획한 변화목표가 적정한 실행과정을 통해 실제로 달성되었는지를 확인하는 활동이라고 할 수 있다. 주의할 점은 평가가 종결 직전에 이루어지는 일시적인 단계가 아니라, 초기면접단계에서부터 사정과 계획수립, 실행 단계에 이르기까지 지속적으로 이루어지는 하나의 과정(Process)으로 이해해야한다는 점이다.

즉, 평가는 [계획(Plan) - 실행(Do) - 평가(See)]의 전체 흐름에서 파악하여야 하며, 이는 계획수립단계에서 설정한 변화목표와 실행과정에서의 관련 개입활동이 가장 중요한 평가의 대상이 되기 때문이다.

‘종결’은 사례관리자가 그동안의 사례관리 활동을 마무리하는 과정이라고 할 수 있다. 사례관리는 다양한 이유로 종결될 수 있다. 사례관리 수급자의 상태가 개선되어 더 이상 서비스가 필요하지 않게 되거나, 반대로 악화되어 다른 외부 기관으로 의뢰가 이루어질 수도 있다. 또는 수급자의 거주지가 바뀌거나 사망하는 경우도 종결의 사유가 될 수 있다. 그 외에도 수급자가 사례관리를 더 이상 받기를 원하지 않거나, 사례관리자가 소속된 기관의 사유로 서비스가 중단되는 경우도 있다. 종결이 모든 사례관리활동의 완전한 끝을 의미하는 것은 아니라는 점에 유의하여야 하는데, 종결 시 수급자의 상태에 따라 타 서비스로의 의뢰나 사후관리 절차로 연결된다.

2) 평가와 종결단계의 내용

가) 평가

실행과정을 대상으로 한 과정평가(또는 실적평가)와 실제 개입활동의 결과로서 변화목표의 달성도와 내용을 대상으로 한 성과평가로 구분해 볼 수 있다.

(1) 과정평가

사례관리의 개입 과정을 평가 대상으로 하는 것으로, 보다 세부적으로는 사례관리의 과정에 작성한 내용이나 실제 투입된 자원과 서비스의 종류와 양, 사례관리 전반을 지원하는 운영체계에 대한 평가를 실시할 수 있다.

일반적으로 과정평가는 실적평가라고 불릴 만큼, 수급자의 욕구에 대응하여 제공한 서비스와 개입활동이 계획에 제시된 양이나 질에 적정한 수준으로 전달되었는지를 파악하는 것이 핵심이라고 할 수 있다. 즉, 장기요양 수급자에게 특정 유형의 서비스를 주 3회 2시간씩 제공하는 것을 계획하였다면, 그 계획대로 충분히 서비스의 내용과 양이 제공되었는지를 평가하는 것이다. 장기요양 분야는 서비스 제공을 통한 변화목표의 달성이라는 성과

가 단기간에 명확하게 나타나지 않는 경우가 일반적인 만큼, 과정 또는 실적 평가도 중요하게 살펴보아야 한다.

(2) 성과평가

사례관리의 개입활동에 따른 결과와 변화내용을 중점으로 두고 실시하는 평가 활동이다. 성과는 그 수준에 따라 변화(Change), 결과(Outcome), 영향(Impact)으로 구분해 볼 수 있는데, 변화가 목표와 관련한 측정결과의 증감을 의미한다면, 결과는 이러한 변화가 충분히 기대한 목표치에 도달하였는지를 나타낸다. 그리고 영향은 당초 계획수립의 결과로는 상정하지 않았으나 이로 인해 나타난 긍정적 또는 부정적 파급 효과에 해당한다.

사례관리에 의한 개입활동을 통해 다소 변화가 있었다라도, 그것이 변화목표에 제시한 수준의 개선이라고는 부를 수 있을 만큼 충분한 결과가 아닐 수 있다(예를 들어, 해열제를 투여하여 열이 내렸으나, 정상체온의 범위에는 다다르지 못한 상태). 사례관리를 통해 달성한 결과가 기대하지 않았으나 추가적인 영향을 나타낼 수도 있다(예를 들어, 정상체온이 되어 조기에 직장에 복귀하게 된 경우).

따라서 사례관리자는 성과를 변화, 결과, 영향의 차원으로 구분하여 접근하는 것이 사례관리의 성과를 보다 체계적으로 평가할 수 있는 방법이 된다. 보통 변화와 결과는 객관적인 지표로 계량화하여 측정하며, 영향은 주관적인 사례에 대해 질적으로 기술하는 방식을 취하는 것이 일반적이다.

성과평가의 방법으로 자주 사용하는 것이 수급자에 대한 서비스 만족도 조사이며, 계획에서 제시한 변화목표의 달성도, 사례관리 전후의 수급자 욕구나 영역의 변화도 성과평가의 중요한 측정 대상이다. 이상의 방법은 주로 사례관리과정에 참여하는 수급자를 중심으로 한 것으로, 그밖에도 사례관리자의 업무만족도와 직무능력감, 지역사회 자원의 만족도와 역량을 평가해 볼 수도 있다.

● 표 3-25 성과평가의 내용 및 기준

평가 내용	평가기준	양 식
서비스 만족도	수급자가 사례관리 과정에서 받은 서비스에 얼마나 만족하는가	서비스 만족도 조사표 개방형 질문
목표 달성의 정도	수급자가 서비스 계획 시에 세운 목표가 얼마나 잘 달성되었는가	사례관리 계획 및 평가표
욕구 수준의 변화	수급자가 접수 시에 보인 욕구의 수준이 종결이나 점검 시에 얼마나 개선 변화되었는가	사례관리 계획 및 평가표
개입 영역의 변화	수급자의 변화 목표 확인	해당 척도 문제해결 정도 평가양식
사례관리자의 업무만족도와 직무능력감	서비스를 제공하는 사례관리 실무자인 사회복지사 측면에서의 성과 파악	업무만족도 양식 직무능력감 양식
지역사회 자원의 만족도와 연계 역량	사례관리 활동에 참여한 지역사회 내 다양한 자원 측면에서의 성과 파악	지역자원실무자의 사례관리 만족도 양식, 자원연계능력

가장 바람직한 사례관리의 평가방법은 과정(실적)평가와 성과평가를 함께 진행하는 것으로, 이때 구조화된 설문이나 측정도구에 의한 양적 평가와 초점집단면접(Focus Group Interview)나 심층면접을 통한 질적 평가를 병행하는 것이다.

나) 종결(Exit)

사례관리를 통해 기대한 변화목표가 달성되었거나 주거지 이전 또는 사망 등의 사유로 더 이상 서비스 제공이나 개입활동이 필요하지 않을 경우, 사례관리 과정을 종결할 수 있다. 종결 단계에서는 아래와 같은 사례관리자의 활동이 요구된다.

- 사례관리의 종결 시기로서 적절한지에 대한 판단
- 수급자와 제공자의 감정과 정서적 반응에 대한 지원
- 종결 후 개입 효과의 유지와 강화 방안 모색
- 필요 시 외부의 타 자원으로 의뢰
- 사후관리의 기간과 방식 결정, 수급자에 대한 안내
- 종결 사유와 과정, 종료일 등 문서로 기록 등

사례관리자가 수급자를 종결할 경우, 사전에 '종결면접(Exit Interview)'를 실시하는 것이 바람직하다. 종결면접을 통해 수급자는 갑작스런 종결에 대해 정서적인 안정과 존중을 받고 있다는 인식을 얻게 되며, 사례관리과정에서 획득한 변화를 유지할 수 있는 방법을 탐색해 볼 수 있고 사후관리에 대한 동의도 얻을 수 있다.

다) 사후관리(Follow-up Service, After Care)

서비스 종결 이후 일정 기간을 두고 종결 이후의 변화 상황과 안정화 여부를 모니터링하고 재개입 필요성을 조기에 판단하기 위해 수행하는 활동이다,

즉, 사례관리서비스 종결 후 수급자의 상황에 대한 후속적인 점검으로 사례관리서비스 종결 후 수급자가 변화를 어느 정도 유지하고 있는가 모니터링 하여 수급자의 변화된 상태를 유지할 수 있도록 지원하고 위기상황으로의 재발을 예방한다. 사후관리에서 점검할 주요 사항을 다시 정리해 보면 다음과 같다.

- 종결 후 일정기간 변화지속 및 변화상황의 안정화 여부
- 새로운 욕구나 문제의 발생 및 재개입 필요성 여부
- 위기 상황으로의 재발 방지 및 예방 등

사후관리는 사례관리실천 과정에서 간과되기 쉬운 과정이지만, 사례관리의 영향을 평가하고, 개입을 통한 변화의 유지를 확인하거나, 종결이나 의뢰의 적절성을 판단할 수 있는 중요한 과정이다. 상대적으로 전문적 기술이 많이 요구되지는 않지만 매우 가치 있는 과정이므로 간과되지 않도록 유의해야 한다(굿네이버스·한국사례관리학회, 2010)

나. 평가 및 종결단계의 실제

- 1) 평가단계에서 실제 수행할 평가방법은 아래 제시한 평가의 구조(5W1H)를 기준으로 다양하게 개발하여 적용해 볼 수 있다.

● 표 3-26 평가의 구조

① 주체 (Who)	누가 평가를 할 것인가에 대한 결정으로 제공자(기관) 또는 이용자가 될 수도 있으며, 외부의 전문가나 기관, 지역사회 대표, 조정(관리)자 등이 담당할 수 있다. 장기요양기관의 사례관리자 외에도 서비스 이용자인 수급자나 가족, 또는 서비스 제공자인 장기요양요원이 평가 주체가 될 수도 있다.
② 시점 (When)	평가는 사후에 실시하는 것으로 생각하기 쉬우나, 평가는 사례관리의 전체적인 흐름에서 파악하여야만 한다. 본격적인 실행 전에 실시하는 사전 평가와 실행 도중에 실시하는 도중 평가, 실행을 마친 후 실시하는 사후평가로 나누어 볼 수 있다. 이들의 추이를 종합적으로 파악하는 활동은 사례관리의 방향성을 유지하고, 수급자의 변화를 종합적으로 이해하는데 도움을 준다.
③ 장소 (Where)	어느 곳에서 실시할지 결정이 필요하다. 평가를 진행하는 장소에 따라 평가의 방식이나 도구도 달라질 수 있다. 예를 들어, 노인요양시설이라면 기관 내부에서 종사자와 입소자를 대상으로 평가를 실시하는 것이 기본이지만, 주 보호자인 가족이나 지역사회 자원 담당자에 대한 평가를 위해 기관 외부로 평가의 장소로 선택할 수도 있다.
④ 대상 (What)	제공자나 기관, 이용자와 가족은 물론, 사례관리자 자신이나 조정(관리)자, 외부의 지역사회 자원 등이 될 수 있다. 예를 들어 장기요양서비스에 대한 만족도를 이용자나 가족을 대상으로 조사하거나, 서비스를 제공한 장기요양요원이나 사례관리자를 대상으로 업무만족도나 직무능력감 등을 조사할 수 있다.
⑤ 방법 (How)	평가를 어떻게 할 것인가의 문제로, 주로 양적·질적 방법을 선택하거나 병행하여 적용해 볼 수 있다. 대표적인 양적평가의 방법은 구조화된 설문지나 전문 측정도구를 활용하는 형태가 있으며, 질적평가 방법에는 특정 사례에 대한 면접방식을 중심으로 특정 그룹에 대한 초점집단면접(FGI)이나 개인에 대한 심층면접을 진행해볼 수 있다.
⑥ 이유 (Why)	평가를 왜 하는가라는 부분에 대한 사례관리자의 인식은 매우 중요하다. 주된 평가의 이유를 정리해 보면 다음과 같다. - 윤리성: 무엇을 어떻게 제공하였는가의 문제 - 책임성: 공적 지원에 대해 목표 달성도를 증명할 책임 - 가시성: 활동을 외부에 제대로 알리는 것 - 지속성: 확대는 물론, 유지, 축소, 중지의 근거 - 효과성: 관리자가 활동의 효과성·적합성을 인식할 수 있는 유일한 방법 - 환류성: 참여 기관과 직원에 대한 평가와 사기 앙양의 도구

2) 평가 및 종결단계의 과정과 절차

가) 수급자의 욕구와 변화목표에 따라 서비스가 적절히 제공되었으며, 기대하는 변화 목표를 달성하였는지 확인한다.

- ‘과정평가’로 급여제공계획에 따라 계획한 서비스의 종류와 양이 실제로 충분히 제공되었는지를 평가
- ‘성과평가’로 급여제공계획에서 수립한 변화목표의 달성 여부와 수준을 평가
- 수급자나 가족과의 상담을 통해 추가로 필요한 서비스나 요구, 불편사항 없는지 확인



point

평가란 사례관리자에 의해 형성되고 조정되는 서비스 계획, 구성요소, 활동 등이 어떠한 효과가 있는지의 여부를 측정하는 과정을 말하는 것으로, 수급자에 관한 서비스와 개입계획에 관한 평가, 목표달성에 관한 평가, 사례관리 서비스의 전반적인 효과성에 관한 평가, 수급자(가족)의 만족도에 관한 평가 등이 그 내용이 된다.



주의

- 수급자(가족)의 입장과 함께 장기요양요원의 위치나 역할, 근무여건과 애로사항도 균형적으로 살펴보도록 노력하기
- 점검 및 평가 과정에서 문제가 발견될 경우, 그 원인을 우선적으로 파악해 보기

나) 평가결과와 함께 수급자의 기능상태나 욕구 등의 변화내용을 파악하고, 이를 급여제공계획에 반영하여 변경한다.

- 서비스 제공과정에서 수급자의 상태변화나 충족되지 않는 욕구가 있는지 파악
- 질병·건강상태의 변화 여부(호전, 유지, 악화)와 해당 기능을 파악하고 특이사항을 기록



신체나 인지상태에 현저한 변화가 있는 경우, 병원, 보건소 등에서 검사, 진료 등 필요한 서비스를 받도록 연계한다.

다) 변경 급여제공계획을 국민건강보험공단에 통보하고 기타 필요한 조치를 취한다.

- 필요시 등급인정유효기간을 확인하여, 개인별장기요양이용계획서 재발급, 인정조사신청 등 조치를 취할 수 있다.

라) 서비스 계약기간이 종료될 시, 서비스 이용 연장 여부에 대한 의사를 보호자와 면담하고 계약 연장 의사를 확인한다.

마) 수급자나 가족이 서비스 종결을 원하면 종결확인서를 작성하여 서비스 이용을 공식적으로 종료하고, 만약 서비스 연장을 원할 경우에는 서비스 연장 계약서를 재작성 한다.

- 종결확인서 또는 종결보고서에는 종결사유, 서비스 제공 요약, 수급자 변화사항, 사례관리자 의견, 사후관리계획이 포함될 수 있다.
- 서비스 이용의 종결은 크게 일시적 종결과 영구적 종결로 구분할 수 있고, 이는 수급자의 건강상태 변화, 거주지 이전 등 다음과 같은 사례에 따라 발생할 수 있다.



종결이 요구되는 경우

- 노인의 건강상태 악화로 의료기관 치료가 필요한 경우
- 일시적으로 타 장소에 거주할 경우
- 전염성 질환으로 인해 직원의 안전성이 확보되지 않는 경우
- 노인이 사망한 경우
- 거주지를 이전하는 경우
- 노인이 서비스를 거부하는 경우
- 병원 입원이나 타 장기요양기관에 계약(입소) 할 경우
- 기타 기관의 서비스종결회의를 거쳐 합당한 종결사유 발생시

바) 서비스 종결에 따라 수급자의 관련 기록 및 양식을 정리하고 사례관리 과정에 참여한 종사자들에게 종결 과정을 공유한다.

- 종결은 사례관리의 활동을 마무리하는 과정으로, 사례관리 및 서비스제공 과정에 기록한 자료와 양식을 기관에서 규정한 업무절차에 따라 정리한다.
- 종결을 경험하는 입소자나 가족 만이 아니라, 제공과정에 참여한 종사자의 정서적 반응에 대해서도 관심을 가지고 정리할 필요가 있다.

사) 의뢰 및 연계기록지를 작성하여 제공한다.

- 건강상태가 악화되었거나 타 입소시설 및 병원으로의 이동을 원하는 경우 지역 내 다양한 보건복지 자원정보를 제공하고 원활히 의뢰 및 연계될 수 있도록 지원해야 한다.



연계기록지 사본(부분)에는 작성일자, 수급자명, 등급, 심신기능 상태, 제공한 급여 등이 포함되며, 단, 사망 또는 종료하지 않고 병원에 입원한 경우는 연계기록지를 작성하지 않는다.

아) 정기적인 사후관리(Follow-up)를 실시한다.

- 서비스 종결 이후 일정 기간을 두고 종결 이후의 변화 상황 안정화 여부를 모니터링하고 재개입 필요성을 조기에 판단하기 위해 수행한다.
- 사후관리기록에는 사후관리 과정을 통해 파악한 정보와 종결의 확정 혹은 재개입 여부 판단에 필요한 정보가 포함되어야 한다.

다. 평가 및 종결단계와 기록

1) 평가 및 종결단계의 기술

가) 평가

평가는 특정한 시기를 기준으로 정기적으로 실시하는 것이 원칙이다. 보통 최소 1년에 1회 이상을 실시하는 것이 기본으로, 반기 또는 분기별로 실시할 수도 있다. 평가 결과는 재사정단계를 거쳐 새로운 계획수립에 환류하여 반영되거나 종결과 사후관리 활동으로 연결되기도 한다.

평가의 가장 핵심적인 대상은 계획수립단계에서 제시한 변화목표의 달성도이다. 우선순위에 따른 목표의 달성 여부와 정도를 기록하고 해당 목표 달성 관련한 서비스를 연장할 것인지, 아니면 변경할 것인지를 결정하여야 한다.

그밖에 사례관리의 평가단계에서 이용자에 대한 만족도 조사, 사례관리자에 대한 업무만족도나 직무능력감, 지역사회 자원 담당자에 대한 사례관리 만족도 등을 평가해 볼 수 있다.

나) 종결

사례관리자는 종결을 결정한 사유를 명확히 기술하여야 한다. 그동안의 제공과정에서 실시한 서비스의 내용과 성과와 함께, 초기 시점의 수급자 욕구와 문제의 상황과 종결 시점의 상황에 대한 변화내용을 간략히 정리한다.

종결에 따른 사례관리자의 의견을 총평형식으로 작성하고 사후관리 계획을 명확히 작성한다. 종결과정에서 수급자에게는 사례관리 과정에서 체득한 변화와 성취의 동력을 계속 유지하고 강화하도록 지지하는 한편, 이용자가 필요 시 다시 만날 수 있음을 알리고 허락받도록 한다. 또한 반드시 사례관리에 따라 서비스를 제공한 인력과 외부 자원으로 참여한 담당자에게도 종결 과정과 그 내용을 알리고 공유하는 것도 잊어서는 안 된다. 마지막으로 그동안의 사례관리와 서비스 제공 과정에 작성한 자료와 양식에 대해 정리하여 보관한다.

다) 사후관리

사후관리 단계의 기록은 관찰 기간과 빈도를 정하고 실시하도록 하며, 사후관리 과정에서 파악한 정보와 이에 따른 조치사항에 대한 정보를 중심으로 정리한다. 정기적인 사후관리 활동을 통해 사례관리자는 종결시점에서 기대한 변화가 지속되고 있는지, 어떠한 욕구나 문제가 발생하였는지를 살펴보고, 필요 시 의뢰나 재개입 활동을 실시하게 된다.

사후관리의 기록에는 사후관리를 실시한 시기와 접촉대상(수급자, 가족, 기타 등), 현재 상황에 대해 파악한 내용이 포함되어야 하며, 사후관리의 조치사항을 재개입, 타 기관 의뢰, 종결 확정, 기타 등으로 구분하여 표기하여야 한다.

2) 관련 양식 및 기록지

● 표 3-27 사례관리 만족도 평가(예시)

사례관리 만족도 평가							
영역	문항	질문	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
계약과정	1	사례관리 계약서 작성 시 중요한 사항에 대해 충분히 설명해 주었다. (계약내용, 기간, 비용, 손해배상책임, 개인정보보호, 급여 내용 및 이용방법 등).					
	2	계약시 귀하의 의견이 충분히 반영되었다.					
사례관리과정	3	사례관리과정이 계약대로 정확히 진행되었다					
	4	사례관리 과정에 편안하게 참여할 수 있었다.					
	5	나는 사례관리 과정에 참여하면서 존중받았다					
	6	나는 사례관리 과정에 참여한 것이 유익했다.					
	7	나는 앞으로도 적극적으로 참여할 것이다.					
사례관리내용	8	방문요양 서비스는 만족스럽다.					
	9	나는 방문요양 서비스를 지속해서 이용할 것이다.					
	10	연결된 자원은 나의 욕구해결에 도움이 되었다					
	11	나는 연결자원을 지속해서 이용 할 것이다.					
요양보호사만족도	12	요양보호사는 나의 의견을 잘 듣는다.					
	13	요양보호사는 나의 욕구를 잘 이해하고 있다.					
	14	요양보호사는 나를 존중하였다.					
사회복지사만족도	15	사회복지사는 나의 의견을 잘 듣는다.					
	16	사회복지사는 나의 욕구를 잘 이해하고 있다.					
	17	사회복지사는 나를 존중하였다.					
결과만족도	18	내 생활에 긍정적인 변화가 있다.					
	19	나는 앞으로 더 나아질 것이라고 기대한다.					
	20	앞으로도 현 급여 기관을 계속 이용하고 싶다					
기타 의견							
작성일: 년 월 일 작성자:							

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-28 사례관리 종결보고서(예시)

사례관리 종결보고서								
수급자 성명		생년월일		장기요양등급		장기요양인정번호		
장기요양기관명				장기요양기관기호				
담당자				작성일자				
접수일	초기상담	육구사정	1 차 사례회의	care plan 수립	서비스 제공	모니터링	2 차 사례회의	종결일
단기성과 목표				장기성과 목표				
번 호	목표내용	성과내역		번 호	목표내용	성과내역		
1				1				
2				2				
3				3				
수급자의 변화								
종결심사의견								
종결심사결과								
종결유형	☐ 계약중지(철회) ☐ 계약만료 후 재계약 철회 ☐ 목표 달성 및 상황호전 ☐ 타 기관(시설)로 이전 ☐ 이주 ☐ 사망 ☐ 기타_____							
사후관리계획								

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-29 급여제공평가(예시)

입주자 성명	김**	생년월일	19**-**-**	입주일	20**-**-**
급여제공기간		등 급	3등급		
인정유효기간		평가작성자		평가일	20**-**-**
간 호 종합평가	- 치매로 인한 감정변화 관찰 관리중 - 갑상선 기능저하에 따른 이용 관리중 - 변비로 인한 불편함이 없도록 관리중 - 배회로 인한 낙상 예방 관리 필요함			복 지 종합평가	- 실버체조, 원예치료 등 프로그램에 참여율은 높으 시나, 실행중, 실어증으로 인해 관심을 갖지 못하 심으로 산책, 마사지 등 어르신께 적합한 프로그램 으로 정기적인 면에 지원을 제공하고 있음

순 번	4P	11S	70KPI	세부항목	도움정도	목 표	제공율
	서비스 제공자	장 소	빈도 수	1회 소요시간	총 소요시간	급여제공방법	
1	기능증진 프로그램	건강증진 서비스	투약관리	PRN 투약관리		불편함없이 정상적인 생활 유지	()회
	간호(조무)사	생활실		10분		진통제, 소화제, 일반감기약, 이몸관리 약, 정장제 등 일반의약품을 투여한다	
2	기능증진 프로그램	건강증진 서비스	투약관리	투약일지		정확한 투약관리를 통한 건강상태 유지	()회
	간호(조무)사 / 요양보호사	생활실		10분		처방된 정기약을 지시대로 투여하고 점 안액, 점이액 등을 사용 관리한다	
3	여 가 정서프로	여가지지 서비스	특별공연	특별공연		일상생활의 활력소 제공	% ()회
	사회복지사	강 당	1회 / 1월	60분	60분	예술전문 봉사단의 공연을 함께 즐길 수 있는 시간을 가질 수 있도록 한다. (프로그램: 가요마당, 금가루, 한가락 공연 등)	
4	여가·정서 프로그램	정서지지 서비스	특별행사	특별행사		행사에 따라 의미를 알아보고 함께하여 시설 내 즐거운 생활 유도	% ()회
	사회복지사	강당	1회 / 3월	60분	60분	봄 맞이 요리대접 및 외부 자원봉사 연 계 프로그램 등 특별행사를 기획 및 실 시한다	
5	가족지지 특화 프로그램	특화지원 서비스	가 을 운동회	가 을 운동회		다른 어르신들과 협력적인 관계형성 및 옛 기억의 회상으로 행복함 추구	% ()회
	사회복지사/ 요양보호사/ 간호(조무)사 /물리치료사	강 당	1회 / 12월	120분	120분	마을 별 대항전 등을 통해 가을운동회 를 실시한다	
6	여가·정서 프로그램	여가지지 서비스	지역사회 행사참여	지역사회 행 사		지역행사 참여를 통한 사회적응 훈련 기회 제공	% ()회
	사회복지사	강당	1회 / 12월	60분	60분	지역사회에서 주최하는 행사에 참여하 는 기회를 가진다 (프로그램: 지역사회축제, 박람회 방문, 가족음악회 등)	
7	여가정서 프로그램	여가지지 서비스	가요무대 시 청	가요무대 시 청		일상의 무료함을 달래며 활력소를 제공	% ()회
	사회복지사 /요양보호사	생활실	1회 / 1주	60분	60분	흘러간 옛 노래 영상을 시청하시면서 여가선용을 한다.	

※ 본 양식은 법정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-30 사례관리종결 및 평가기록지(예시 1)

사례관리종결 및 평가 기록지														
일 자					회의장소									
수급자 성명					종결일									
종경유형		☐ 결과목표달성 ☐ 수급자의 기능변화 및 안정화 ☐ 수급자의 비협조적 태도 및 서비스 거부 ☐ 수급자의 퇴소 ☐ 수급자의 사망 ☐ 기타()												
서비스 목표														
사례관리 평 가		서비스 종류	필요성			효과성			효율성			달성정도		
			상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
복 지	평 가													
간 호	평 가													
물 리 치 료	평 가													
영 양	평 가													
서비스 모니터링														
수급자	서비스 만족도	☐ 매우만족			☐ 만족			☐ 보통			☐ 족정불가			
	신체기능유지 및 증진	☐ 저하			☐ 유지			☐ 향상			☐ 해당없음			
	인지 및 정신 기능 증진	☐ 저하			☐ 유지			☐ 향상			☐ 해당없음			
	문제행동 변화양상	☐ 증가			☐ 유지			☐ 개선			☐ 해당없음			
	생활수준 향 상	☐ 저하			☐ 유지			☐ 향상			☐ 해당없음			
사례관리	서비스 제공자의 협력정도	☐ 상			☐ 중			☐ 하						
	자원활용의 적절성	☐ 상			☐ 중			☐ 하						
	보호계획의 적정성	☐ 상			☐ 중			☐ 하						
종결 후 수급자 요양보호사														
복 지														
간 호														
물리치료														
영 양														
비 고														

※ 본 양식은 번정서식 혹은 공단지정양식이 아니며, ○○방문요양기관의 양식을 관리책임자의 동의를 얻어 예시로 재구성한 양식임

● 표 3-31 사례관리종결 및 평가기록지(예시 2)

사례관리종결 및 평가기록지								
사례관리 번 호				수급자명			종결평가 일자	
종결평가 담당자				소 속			연락처	
요 청 일 자	인 적 정 보	육 구 조 사	사례회의	제공계획	서비스 점 검	종결평가		
단기성과 목표				장기성과 목표				
번 호	목표내용	성 과 구 분	성과내역	번 호	목표내용	성 과 구 분	성과내역	
1				1				
2				2				
3				3				
사례관리자 의 견 (담당자 의견)								
수급자(가족) 변 화								
종결평가 의 견 (특이사항 /사후관리)								
종결평가 결 과	☐ 재조사(사정) ☐ 종결							
종결 유형	☐ 장기목표 달성 ☐ 단기목표 달성 ☐ 상황호전()							
	☐ 거절이나 포기 ☐ 연락두절 ☐ 이사 또는 사망 ☐ 자체종결							

〈이어서〉

종결평가서 작성방법	
항 목	작성방법
사례관리 번호, 수급자명	○ 수급자의 사례관리번호와 이름을 기입함
종결평가일자, 종결평가 담당자, 소속, 연락처	○ 종결평가 일자와 담당자 이름, 소속, 연락처를 기입함
성과목표 (단기·장기)별 성과내용	○ (목표내용) 수급자와의 상담을 통해 서비스제공계획 수립 시 설정한 장·단기 목표 내용 기록 ○ (성과구분) 전혀 달성하지 못함, 기대수준이하로 달성, 보통수준, 기대한 정도의 목표 달성, 기대 이 상의 목표달성 등 달성여부 및 달성 정도 기록 - 목표별 달성도 : 전혀 달성하지 못함(1점) / 기대수준 이하로 달성(2점) / 보통수준(3점) / 기대한 정도의 목표 달성(4점) / 기대 이상의 목표달성(5점) 등 목표별 달성도 기록 ○ (성과내역) 목표별 성과내용을 기록
사례관리자 의견 (담당자의견)	○ 성과목표 달성 여부 결과를 기초로, 서비스 지속 제공 여부 필요성, 타 기관 의뢰 필요성 등 종결에 대한 담당자 개인의 전문적인 의견을 기술
수급자 (가족)의 변 화	○ 개입을 통해 수급자 및 가족의 변화된 정도를 기술
종결평가 의 견	○ 사례관리 수급자를 둘러싼 이해관계자 간의 사례회의를 통해 수급자의 변화를 유도하고 적절한 보 호 조치가 이루어졌는지 여부를 평가하고 수급자에 대한 종결 여부 논의 결과를 요약하여 기록
종결평가 결 과	○ 수급자를 둘러싼 중대한 환경 및 욕구의 변화가 발생한 경우 욕구 조사를 재차 실시하며, 그 외의 경우 종결 처리
종결유형	○ (장기목표 달성) 수급자의 욕구 및 문제점을 진단하여 당초 수립했던 장기목표 달성으로 판단되는 경우 ○ (단기목표 달성) 수급자의 욕구 및 문제점을 진단하여 당초 계획했던 서비스 계획에 따라 서비스 연계를 완료한 경우 ○ (상황호전) 위기도 조사를 실시한 결과, 사례관리 전후 점수가 @점 이상 향상되고 수급자의 취업 또는 환경 변화로 인하여 상황이 호전되어 더 이상 사례관리 서비스가 불필요한 경우 ○ (거절이나 포기) 서비스에 대한 거부가 지속되는 경우 또는 사례관리 서비스에 대한 동의 이후 계 약에 대해 해지를 요구하여 사례관리 진행의중단이 야기되는 경우 ○ (연락두절) 수급자가 의도적으로 사례관리자를 회피하여 3개월 이상 연락을끊는 경우 ○ (이사 또는 사망) 수급자의 이사로 인해 타 지역으로 사례관리를 이관해야 할 경우 또는 사망으로 인해 더 이상 사례관리를 진행할 수 없는 경우 ○ (자체종결) 기관의 자원·능력의 한계, 사례관리 수급자의 소극적 참여 등

※ 자료: 복지부, 사례관리 서식 표준, 민·관 정보공유시스템 구축 사업.



2021년도
사회복지사 교육교재



제 4 장



장기요양 사례관리 작성실습

1. 사례관리 작성실습(Case1)	134
2. 사례관리 작성실습(Case2)	155



04

장기요양 사례관리 작성실습

학습목표

- 수급자의 욕구사정지 기록방법을 습득할 수 있다.
- 수급자의 생활상의 문제 또는 요구사항을 파악하여 생활 욕구를 도출할 수 있다.
- 생활욕구의 우선순위를 도출하여 목표를 수립할 수 있다.
- 사례관리과정의 사례회의, 모니터링, 종결 등 전반적 기록방법을 연습한다.

※ 제시되는 사례와 양식은 00장기요양기관에서 사용하고 있는 기록양식을 일부 수정하여 연습용으로 제시한 것입니다. 개별 기관에서 사용해야 할 표준기록방법으로 제시된 것이 아님을 알려드립니다.

장기요양 사례관리 작성실습 내용 구성안내

- 두 개의 작성실습 사례로 구성(Case1, Case2)
- 각 사례들은 ①사례개요, ②욕구사정기록지 작성, ③장기요양급여 제공기록지 작성, ④사례회의 진행 및 기록지 작성, ⑤장기요양급여 제공에 대한 모니터링 업무수행일지 작성, ⑥종결에 따른 종결보고서 작성으로 구성
- 첫 번째 사례(Case1)는 이미 작성된 사례관리 과정 전체의 내용을 알아보며, 작성방법 등을 학습
- 두 번째 사례(Case2)는 이미 작성된 ①~③ 내용을 기본으로 욕구도출, 계획수립, 사례회의 진행, 종결보고서 작성을 기관 내 종사자들(시설장, 사회복지사, 요양보호사 등)이 함께 직접 작성 및 실습하며 학습
- 본 장에서 제시된 내용은 각 단계별 사례관리작성 예시로, 표준 작성규칙으로 정형화된 것은 아님. 기관 및 수급자/종사자의 특성에 따라 응용하여 적용할 수 있음

1 사례관리 작성실습(Case1)

1 사례 개요

- 이름: Case1(남, 80세)
- 신체상태
 - 일상생활동작 수행능력(ADL): 14점(36점 만점, 점수-도움필요도 비례관계)
 - 수단적 일상생활동작(IADL): 20점(33점 만점, 점수-도움필요도 비례관계)
 - 신체기능 제한보다는, 주로 인지적인 측면에서 도움 필요
- 질병상태
 - 고혈압, 고지혈증으로 통원진료 및 약물복용 중
 - 협심증으로 약 10년 전 스텐트 삽입술
 - 뇌졸중(뇌경색, 약 8년 전 발병) 으로 약 3달여간 입원 후 퇴원하여 자택에서 생활중
 - 알츠하이머 치매(약 3년 전 진단)로 약물복용 관리 중

- 재활 및 간호처치상태: 관절구축, 절단, 간호 관련 처치상태 등 해당없음
- 인지상태: 9점(15점 만점, 점수-인지저하 비례관계)
 - 판단력, 망상, 환각(환청/환시), 배회, 폭언 등 행동변화 관찰됨
- 의사소통: 의사소통문제 등 해당사항 없음
- 영양상태: 틀니를 사용하지 않으며, 스스로 식사동작 수행 가능
- 주거상황
 - 자가 주택에서 생활 중이며, 호수를 달리하여 배우자, 자녀세대와 같은 건물에 거주
 - 엘리베이터가 없는 다세대주택 2층 거주하며, 지팡이를 붙잡고 아주 천천히 계단을 오를 수 있음
- 가족 및 환경상태
 - 2남 1녀의 자녀가 있으며, 자가(다세대주택)에서 호수를 달리하여 배우자 / 장남세대 / 차남세대와 같은 건물에서 생활 중(경제적 어려움 표현하지 않음)
 - 보호자 및 배우자가 자주 방문하여 수발도움을 주며, 가족(주로 배우자)에게 폭언 등 행동을 보이는 경우가 있음
- 사회관계 및 사회적지지 실태
 - 별도 사회적 자원(종교기관, 지역사회복지관 등) 이용하지 않음
 - 3차병원에서 질병 통원치료만 하고 있음
 - 가족들과 공원 산책을 하는 등 외출을 즐기나, 이외의 이웃들과 교류 없음
- 공식적 자원 이용 현황: 최초 장기요양 인정자이며, 별도의 자원 이용내역 없음
- 수급자 및 보호자 개별 욕구
 - 낮 시간대 방문요양서비스, 사회 관계망 구축을 위한 정보제공 및 서비스 연계 희망

2 욕구사정기록지

욕구사정기록지				작성일	. . .
				작성자	서명(인)
수급자성명	Case1	키	174cm	생년월일	1942.00.00.
인정번호/등급	L00 / 4등급	체중	68kg	성별/연령	남 / 80세

가. 신체상태(ADL, IADL, 일상생활 수행능력)

1) 일상생활능력(ADL, Activities of Daily Living)

※ 표기: x-완전도움 △-부분도움 ○-완전자립

항 목	확 인	항 목	확 인	항 목	확 인					
옷 벗고 입기	○	세수하기	○	양치질하기	○					
식사하기	○	목욕하기	△	체위변경	○					
일어나 앉기	○	옮겨앉기	○	방 밖으로 나오기	○					
화장실 사용	○	대변 조절하기	○	소변조절	△					
낙상위험 유무	☐ 유 ☒ 무									
○ 일상생활동작 수행능력 ... 36점 만점(완전도움(x) 3점, 부분도움(△) 2점, 완전자립(○) 1점) - 14점(목욕하기, 소변조절 부분도움)										
○ 판단근거 - 일상생활동작 수행 대부분 완전자립 - 목욕하기는 일부 도움이 필요하다고 하나, 씻지 않으려 거부하는 행동 있음 - 지팡이를 잡고 거동이 가능하며, 신체 전반적으로 약간 오른쪽 측만이 있음 - 거주하는 자택에 엘리베이터가 없어 계단으로 통행하며, 난간을 잡고 부축을 받는 등 천천히 오름 - 소변조절을 원활하게 하지 못하여 속옷에 소변이 묻어있는 경우나 속옷에 소변을 보는 행동이 주 1회 이상으로 있음										
○ 주요 문제 및 욕구 - 근골격계 질환 등 없어 지팡이 등을 사용하여 실내에서 신체동작 수행 가능하나, 인지저하 등으로 목욕 등 일부 몸 청결 동작에 대한 수발자의 지시도움이 일부 필요 - 소변조절에 어려움이 있어 위생관리에 신경써야하며, 인지저하로 혼자서는 원활한 관리가 어려워 위생관리에 도움 필요함										

2) 수단적일상생활동작(IADL, Instrumental Activities of Daily Living)

※ 표기: x-완전도움 △-부분도움 ○-완전자립

항 목	확 인	항 목	확 인	항 목	확 인
청소하기	△	식사 준비	○	빨래하기	△
금전관리	△	물건 사기	△	전화 사용	○
교통수단 이용	△	근거리 외출	△	몸 단장	△
안전관리	△	건강관리	△		

○ 수단적 일상생활동작 수행능력 … 33점 만점(완전도움(×) 3점, 부분도움(△) 2점, 완전자립(○) 1점) - 20점(식사 준비, 전화사용 외 부분도움)
○ 판단근거 - 치매로 인한 인지저하로 청소, 건강관리, 빨래, 몸단장 등 청결동작을 원활히 수행하지 못하거나 일부 거부하는 증세가 있어, 수발자 등이 지시를 하거나 방법을 알려주는 등 일부 도움이 필요 - 인지저하로 배회를 하거나 길을 잃어버리는 등 근거리와 교통수단을 이용한 외출 등에서, 길을 알려주거나 동행하는 등 도움 필요
○ 주요 문제 및 욕구 - 신체기능적 측면보다는 인지적 측면에서 일상생활에 어려움을 겪는 경우가 다수임 - 간단한 일상생활 수행은 전적인 도움을 주기보다는, 수급자와 함께 수행하는 등 필요함

나. 질병상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

질병 분류	질병 명			
내분비·대사성	☐ 당뇨 ☐ 만성간염	☐ 갑상선질환 ☐ 자가면역질환	☐ 탈수 ☐ 빈혈	☐ 영양상태이상 ☐ 기타()
소화기계	☐ 위염 ☐ 간경변증	☐ 위궤양 ☐ 기타()	☐ 십이지궤양	☐ 변비
순환기계	☒ 고혈압 ☒ 뇌혈관질환	☐ 저혈압 ☐ 기타()	☒ 협심증	☐ 심근경색증
근골격계	☐ 관절염 ☐ 기타()	☐ 요통, 좌골통	☐ 기타 척추질환	☐ 골다공증
신경계	☒ 치매 ☐ 두통 외 통증	☐ 뇌경색 ☐ 기타()	☐ 파킨슨병	☐ 두통
정신·행동장애	☐ 신경증	☐ 우울증	☐ 수면장애	☐ 기타()
호흡기계	☐ 폐결핵	☐ 만성기관지염	☐ 호흡곤란	☐ 기타()
눈·귀질환	☐ 시각장애	☐ 난청	☐ 기타()	
비뇨·생식기계	☐ 전립선비대	☐ 요실금	☐ 만성방광염	☐ 기타()
만성신장질환	☐ 만성신부전증	☐ 기타()		

구 분	질병명
과거병력	고혈압, 협심증, 뇌졸중(뇌경색)
현 진단명	알츠하이머 치매, 고지혈증, 고혈압
○ 판단근거 - 고혈압: 30여 년 전 진단, 최근 측정 시 135/75mmHg 측정됨 - 고지혈증: 로수젯정 10/5mg 복용중(1일 1회 아침 식후 투약) • 투약방법 : 식사와 관계없이 1일 1회 투여. 이 약을 투여하기 전 또는 투여 중인 경우 표준 콜레스테롤 저하식을 지속적으로 해야함. • 부작용 : 비인두염, 소화불량, 근육통이 있을 수 있음	

- 협심증: 10년 전 Stent 삽입
 - 뇌졸중: 8년 전 자택에서 의식이 없는 것을 자녀들이 발견하여 병원으로 옮겼고, 뇌졸중(뇌경색) 진단받아 약 3달여 간 입원 후 퇴원하여 자택에서 생활 중
 - 알츠하이머 치매: 3년 전 진단, 아리셉트, 에빅사, 니셀틸 정(인지기능개선제), 오르필정, 세로켈 정 복용 중
- ① 아리셉트 5mg 1일 1회 취침전 투약
- 투약방법 : 알츠하이머형 치매증상 치료제로 1일 1회 취침전 투여, 구강붕해정으로 혀 위에 놓고 녹여서 물과 함께 복용해야함(물 없이 복용할 수 없음)
 - 부작용 : 소화기계 부작용으로 설사, 구토, 복부장애 등이 나타날 수 있음
- ② 에빅사 10mg 1일 2회
- 투약방법 : 중등도에서 중증의 알치하이머병 치료제이며, 음식섭취와 상관없이 복용할 수 있음
 - 부작용 : 어지러움, 두통, 변비, 졸림 등이 나타날 수 있음
- ③ 니셀틸 정 500mg 1일 2회
- 투약방법 : 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환 치료제이며, 1일 2회 경구투여. 복용을 잊은 경우 생각난 즉시 복용. 그러나 다음 복용시간이 가까운 경우는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용(절대로 두 배의 용량을 복용하면 안됨)
 - 부작용 : 발진, 두드러기, 안면부종 등이 나타날 수 있음
- ④ 오르필정 1일 2회
- 투약방법 : 뇌전증, 부분발작에 뒤따르는 성격 행동장애의 예방과 치료제로 항응고제, 결핵약, 중추신경억제제(감기, 알레르기 치료제인 항히스타민제) 및 기타 신경과 약물을 복용하고 있다면 의사와 상의하여 복용. 복용을 잊은 경우 생각난 즉시 복용. 그러나 다음 복용시간이 가까운 경우는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용(절대로 두 배의 용량을 복용하면 안됨). 두 번 이상 복용을 잊은 경우 의사에게 연락해야 함
 - 부작용 : 간손상이 나타날 수 있음
- ⑤ 세로켈 정 25mg 1일 1회 취침전
- 투약방법 : 정신장애증상 치료제로 취침전 복용
 - 부작용 : 졸림, 어지러움, 두통, 입마름, 무기력, 변비, 소화불량 등이 나타날 수 있음. 졸음이나 어지러움을 일으킬 수 있으므로 자리에서 일어날 때 천천히 일어나며 넘어지지 않도록 조심해야 함

	시 간	약 물	주의사항
투 약	아침 식사 후	로수젯정(고지혈증약) * 식사와 관계없이 1일 1회 투여	• 정신신경계: 졸림, 어지러움, 변비, 기립저혈압, 소화불량이 문제 확인 • 항전간제: 이로 으깨거나, 씹지 않고 알약으로 복용(알약을 가루약으로 만들지 말 것)
	아침/저녁 식사 후	오르필정 1일 2회 투(항전간제) * 간질에 따른 성격, 행동장애	
		에빅사정 1일 2회 투여(중추신경용약)	
		니셀틸 정 1일 2회 투여(순환계용약) * 뇌혈관질환	
	취침 전	아리셉트 1일 1회 투여(중추신경용약)	
		세로켈정 1일 1회 투여(정신신경용약)	

○ 주요 문제 및 욕구

- 치매 등으로 인한 인지저하로 약물복용을 하고 있는 상황이나, 스스로 복약관리가 어려움
- 뇌혈관질환 병력 보유자로, 고혈압 약물복용에 대한 복약관리 등으로 질환 재발예방 필요

다. 재활상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

확 인			
☐ 우측상지	☐ 좌측상지	☐ 우측하지	☐ 좌측하지
☐ 어깨관절(좌/우)	☐ 팔꿈치관절(좌/우)	☐ 손목 및 수지관절(좌/우)	
☐ 고관절(좌/우)	☐ 무릎관절(좌/우)	☐ 발목관절(좌/우)	☒ 해당없음
○ 판단근거 - 전체적인 신체가 우측으로 약간 치우친 측만증세를 보임 - 거동 시 발을 헛딛는 등 불안정함을 보이며, 지팡이를 양 손에 잡고 천천히 거동 가능함 - 우측으로 측만이 있으나, 관절 구축이나 절단 보이지 않음 ○ 주요 문제 및 욕구 - 해당사항 없음			

라. 간호처치상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

확 인			
☐ 기관지 절개관 간호	☐ 흡인	☐ 산소요법	☐ 욕창간호
☐ 경관영양	☐ 통증간호	☐ 장루간호	☐ 도뇨관리
☐ 투석간호	☐ 당뇨발간호	☐ 상처간호	☒ 해당없음
○ 판단근거, 주요 문제 및 욕구 - 간호 관련 처치상태 없음			

마. 인지상태(인지기능저하, 정신상태, 감정, 문제행동 등)

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분		확 인
1	지남력	☐
2	기억력	☐
3	주의집중 및 계산	☐
4	언어적 기능	☐
5	판단력	☒
6	편집증 및 망상	☒
7	환각	☒
8	배회	☒
9	반복적인 활동	☒
10	부적절한 활동	☐
11	언어폭발	☒
12	신체적 공격 또는 폭력행위	☒
13	우울	☒
14	일반적인 불안	☒
15	혼자 남겨짐에 대한 공포	☐

○ 판단근거

- 인지상태 9점 ... 15점 만점

○ 판단근거

- 자신의 물건과 현금을 누군가 가져갔다고 하며 가족, 주변인 등을 의심하는 행동이 잦음
- 실존하지 않는 사람과 대화를 하는 환청과, 환시증세를 월 2~3회 빈도로 보임
- 자택에서 의미없이 돌아다니거나, 현관문을 열고 나가 이웃들이 집에 데려다주는 행동이 월 1~2회 빈도로 보임
최근 1년간 2회 경찰서를 통하여 타 지역에서 집으로 모셔옴
- 날씨, 기온 등에 대하여 정확히 인지하지 못함(화창한 날 우산을 찾거나, 춥다-덥다를 반대로 표현)
- 가족들에게 월 2~3회 이상의 빈도로 폭언을 하거나, 꼬집는 등 감정을 조절하지 못하고 가벼운 폭력행위를 보이거나 사과를 하는 행동이 있음
- 특별한 이유가 없이 식사를 하지 않으려 하거나, 슬픔 등 감정을 조절하지 못하는 행동을 주 1회 이상의 빈도로 보임

○ 주요 문제 및 욕구

- 최근 1년 이내 행동변화의 빈도·강도가 늘어났으며, 80세 이상의 고령 치매질환자로 지속적 인지저하와 행동변화 빈도증가가 예상되며 인지저하 예방을 위한 인지 자극과 정서지원이 필요
- 낮은 사람에게는 화를 내는 등의 행동빈도가 거의 없으나, 가족구성원 등 익숙한 사람에게 감정을 조절하지 못하고 화를 심하게 내거나 욕을 하는 빈도가 잦으며, 점점 빈도가 늘어남(치매 진단 이전에는 이러한 행동을 보이지 않았음)
- 00년 0월 0일 기관 사회복지사가 보호자 동행하여 방문 시, 사회복지사에게는 특별한 감정표현을 하지는 않으나 동석한 배우자/자부에게 신경질투로 감정표현을 하는 행동이 관찰됨(왜 모르는 사람을 집에 데려왔냐는 등 표현)
방문 당시 함께 식사를 하면서 행동관찰 하였으며, 스스로 식사를 하는 것 확인함
- 스스로 길을 찾는데 어려워하는 행동이 있으나, 바깥으로 나가려는 행동을 보임
도어락으로 현관문 교체하였으나, 문 여는 방법을 알고있어 보호자가 이에 대한 우려사항 표현함
- 폭언과 배회, 길 잃음 문제행동으로 2차 사고발생 등 우려되며, 이에 대한 보호자의 지도 및 일상생활 도움이 필요

바. 의사소통

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인
청취능력	☐ 들리는지 판단 불능 ☐ 거의 들리지 않는다 ☐ 큰 소리는 들을 수 있다 ☐ 보통의 소리를 듣기는 하고, 못 듣기도 한다 ☒ 정상(보청기 사용 포함)
의사소통능력	☒ 모두 이해하고 의사를 표현한다 ☐ 대부분 이해하고 의사를 표현한다 ☐ 가끔 이해하고 의사를 표현한다 ☐ 거의 이해하지 못하고 의사 전달 불가
발음능력	☒ 정확하게 발음이 가능하다 ☐ 웅얼거리는 소리만으로 한다 ☐ 간혹 어눌한 발음이 섞인다 ☐ 전혀 발음하지 못한다

○ 판단근거, 주요 문제 및 욕구

- 의사소통 관련 특이사항 없음

사. 영양상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인		
치아상태	■양호 □잔존치아 없음	□불량	□의치(전체 / 부분(상/하))
식사 시 문제점	□식욕저하 □소화불량	□저작곤란 □구토	□연하곤란 ■없음
식사형태	■일반식 □당뇨식	□죽 □경관식	□미음
도구형태	■손가락 □사용불가	■젓가락	□포크손가락
배설양상	■정상 □복부팽만	□설사	□변비
○ 판단근거 - 일부 치아가 소실되긴 했으나, 틀니를 사용하지 않고 스스로 식사동작 수행 가능 ○ 주요 문제 및 욕구 - 보호자가 식사를 차려두거나, 준비해둔 반찬을 꺼내어 먹는 등 가능			

아. 주거 상황

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

주거유형	☐ 단독주택 ☐ 빌라		☒ 다세대주택 ☐ 주상복합	☐ 아파트 ☐ 기타
자가여부	☒ 자가 ☐ 월세	☐ 전세 ☐ 기타	엘리베이터 유무	☐ 유 ☒ 무
주차장 유무	☒ 유	☐ 무	주거공간 상태	☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 보통
거주지 내 물리적 장애여부	☒ 유	☐ 무	세부내용: 현관, 문, 화장실(욕실)에 문턱 있음	
주거 상태	☒ 양호 ☐ 불량	☐ 보통	세부내용: 단차 해소, 복향 등 채광이 조금 부족함	

○ 판단근거

- 자가 주택에서 생활 중(다세대주택이며, 수급자 명의)

- 엘리베이터가 없는 다세대주택이며, 수급자 2층 거주 중(1층 타인 임대)

- 실내에 일부 문턱이 있으나, 거동 시 걸리적거리거나 지팡이 사용이 어려울 정도는 아님

- 기타 주거상태 양호함

○ 주요 문제 및 욕구

- 엘리베이터가 없는 2층에 거주하여, 외출이나 출입 시 지팡이를 붙잡고 계단을 오를 때에 시간이 오래 걸리며 힘들어 하는 경우가 있음

자. 가족 및 환경상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인				
결혼여부	☒ 기혼	☐ 미혼	배우자 생존여부	☒ 생존	☐ 사망
자녀 수	3명 (2남 1녀)				
주 수발자	☒ 유	☐ 무	주수발자 연령	60 세	
주 수발자 관계	☐ 배우자	☒ 자녀	☐ 자부	☐ 사위	☐ 기타()
주 수발자 경제상태	☒ 안정	☐ 불안정	☐ 연금생활	☐ 생활보호	☐ 기타()
동거인	☒ 독거	☐ 부부	☐ 부모	☐ 자녀	☐ 기타()

○ 판단근거

- 배우자와 2남 1녀의 자녀가 있음
- 배우자가 생존하여 있으나, 치매 행동변화 등으로 폭력적인 행동을 보이는 경우가 있어 자가 주택에서 생활하나 층을 달리하여 살고 있음(1층 임대, 2~3층 4개호 가족 거주)
- 수급자 / 배우자 / 장남세대 / 차남세대 같은 건물에서 생활 중
- 폭언 등을 행하는 경우도 있으나 감정을 주체하지 못함에 가족들에 미안함을 자주 표현하며, 홀로 생활하는 방에서 가족사진 등을 보고 있는 등 행동을 자주 보임
- 과거 수급자 개인사업 운영하였으며, 현재까지 경제적 어려움을 표현하지 않음

○ 주요 문제 및 욕구

- 가족, 특히 배우자에게 폭력적인 행동을 보이고 있어 장기적으로 지속될 경우 가족으로부터 제공되는 정서적 지지기반 약화가능성 보임
- 보호자(가족)는 수급자의 행동변화에 대한 적절한 대처방법을 알지 못하여 어려움을 호소
- 같은 건물에 보호자들이 거주하기는 하나, 사회생활에 참여하는 등 낮 시간대에 자리를 비우는 경우도 있어 수급자 수발에 어려움을 겪을 수 있음

차. 사회관계 및 사회적지지 실태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인				
외출빈도	☐ 일 1회 이상	☒ 주 1회 이상	☐ 월 1회 이상	☐ 기타()	
외출 동행인	☐ 혼자	☒ 가족	☐ 기타()		
외출 장소	☐ 마트	☒ 병원	☒ 공원	☐ 기타()	
사회적지지 자원	☐ 이웃	☐ 교인	☒ 기타()	가족 외 부재 ()	
사회적 관계 고충	☐ 친척관계 갈등	☐ 친척관계 소원	☐ 친척관계 단절	☒ 해당없음	
	☐ 이웃관계 갈등	☐ 이웃관계 소원	☒ 이웃관계 단절	☐ 해당없음	

○ 판단근거

- 무교이며, 지역사회복지관 등 특별한 사회적자원 이용하지 않고 있음
- 3차병원에서 정기적인 질병(치매, 고혈압 등) 통원진료
- 간혹 감정을 주체하지 못하는 행동이 있기는 하지만 가족관계는 원만함. 주 2~3회 가족들과 공원 산책을 하는 등 외출을 즐김
- 이웃들과 교류가 없으며, 친인척관계에 문제 없음

○ 주요 문제 및 욕구

- 가족 외에 사회관계가 없으며 인지저하 예방 및 정서지원과, 가족 부재 시 비상상황을 대비하여 수급자가 동의하는 범위 내에서 사회관계망 형성 필요

카. 공식적 자원 이용 현황

구 분	확 인
현재 기준 공식적 자원 이용 실태	- 치매안심센터 등 치매관련 지역사회자원 이용내역 없음 - 보건소, 지역사회복지관 등 서비스 이용내역 없음 - 동 주민센터 등 공적 서비스 이용내역 없음 - 최초 장기요양 인정자로, 장기요양서비스 이용내역 없음
○ 판단근거 - 특별한 취미활동이 있지는 않으며, 혼자 있는 시간에 주로 자택에서 TV를 보며 일과를 보냄 - 보호자(가족)들의 치매에 대한 대처지식이나 교육이수내용 등 없으며, 치매안심센터 등 이용 가능한 공식적 자원에 대한 정보가 없음 - 동 주민센터, 지역 종합사회복지관 등 이용내역 확인되지 않으며, 해당 자원에 대하여 보호자(가족)들이 인지하지 않고 있음 - 장기요양등급판정 올해 최초인정 받았으며, 이전까지 같은 자택 내 거주하는 배우자 및 자녀 등 가족들에게 수발도움을 받았음 ○ 주요 문제 및 욕구 - 가족들의 수발로만 수급자 케어가 이뤄지고 있으며, 지원 가능한 사회자원에 대한 정보가 없고 미 이용하고 있음 - 낮 시간에 배우자가 자주 방문하였으나, 배우자가 외출을 하거나 배우자에 대한 폭언증세가 심하여 방문하지 못하는 날에는 장시간 혼자 있는 상태가 잦아 몸 청결동작 등 원활히 수행하지 못하는 경우가 잦음 - 이에 따라 시간이 지날수록 보호자(가족)들의 수발부담이 커질 수 있으며, 적절한 일상생활도움이 이뤄지지 않을 수 있으므로 사회자원에 대한 정보제공·서비스연계가 필요	

타. 수급자 및 보호자 개별 욕구

※ 표기: 서술형 작성

- 가족, 배우자들이 수발도움을 주기 어려운 낮 시간대(12:00~15:00 등)에 신체활동, 가사도움, 인지활동형 등 방문요양 서비스 희망 - 가족 외 사회적 관계망이 없어 비상시에 대응할 수 있는 사회적 자원 정보제공 및 서비스 연계 - 치매로 인한 인지저하와 행동변화 예방하고, 보호자 등이 효과적으로 대처할 수 있는 방안 마련
--

파. 총평

※ 표기: 서술형 작성

- 80세 4등급 남자 수급자로 배우자와 2남 1녀 가족관계를 가짐
자택건물에 배우자, 장/차남 부부와 동거중이며, 호수를 달리하여 수급자 / 배우자 / 장남 부부 / 차남 부부 거주 중이며, 경제적 어려움을 호소하지 않음
- 약 30년 전 고혈압, 고지혈증 진단받아 약 복용 중이며, 10년 전 협심증으로 스텐트 삽입 시술
8년 전 자택에서 의식을 잃은 상태를 가족들이 발견하여 병원에 입원했으며, 뇌졸중(뇌경색) 진단받아 약 3개월 간 입원 후 퇴원하여 자택에서 생활 중
3년 전 알츠하이머 치매 진단받아 통원하여 정기적 진단·처방 수행 중
- 전체적으로 우측 측만 증세가 있으나 관절구축 및 절단 등 신체적 제한 보이지 않음
지팡이를 양 손에 붙잡고 자택 계단을 천천히 오를 수 있음
- 보호자가 식사를 준비해주거나 냉장고에 챙겨둔 반찬 등을 꺼내서 스스로 식사동작 수행 가능하며, 화장실에서 대소변을 처리하나 속옷이 젖어있거나 소변실수를 하는 등 행동이 주 1회 이상으로 보여 소변실수를 인지할 시 화장실 대야에 속옷을 벗어놓음
- 환시 및 환청 등 환각증세나 가족이나 주변인을 도둑으로 의심하는 등 실제와 맞지 않는 행동을 보이는 경우가 잦음
실내에서 왔다갔다 배회를 하는 행동을 보이며 현관문을 열고 밖으로 나가 이웃이 찾아주거나 경찰서를 통하여 찾아오는 행동이 있어 경찰서 지문사전등록 안내함
- 단독주택(다세대/자가) 2층에서 거주하고 있어 계단을 오를 때에 스스로 수행하기는 하나, 지팡이를 붙잡고 시간이 굉장히 오래 걸리는 등 어려움을 보임
실내에 현관과 화장실 등에 문턱이 조금 있으나, 실내에서 보행기가 필요한 정도의 신체기능저하를 보이지는 않아 지속적인 신체기능저하가 있을 시 조정이 필요함
- 가족들에게 폭언과 가벼운 폭력을 보이는 행동이 있으나, 가족들에게 미안함을 자주 표현하며 가족간 잦은 왕래를 보임
- 수발을 가족들의 도움에만 의존하고 있으며, 별다른 사회적 관계망이 없음
치매질환 등으로 치매안심센터 등 이용 가능한 자원이 있으나, 보호자(가족)들이 별다른 정보를 갖고있지 않으며 이용내역 또한 확인되지 않음
- 자가 주택에서 가족들과 함께 생활하며 자주 왕래하여 수발도움을 주나, 가족들이 사회활동을 하는 낮 시간 등에 방문요양서비스(신체, 가사, 인지, 정서 등) 희망
- 이용 가능한 지역사회자원에 대한 정보 등 연계가 필요할 것으로 보이며, 치매 행동변화 대처 등 보호자에 대한 교육 및 자원연계 필요

3 장기요양급여 제공계획서

장기요양급여 제공계획서

장기요양기관명	00기관
장기요양기관기호	
급여종류	방문요양

수급자 성명	Case1	생년월일	1940.00.00.	계약일자	
장기요양 등급	4	장기요양 인정유효기간	00.00.00. ~00.00.00.	계약기간	00.00.00. ~00.00.00.
개인별장기요양 이용계획서 번호		급여적용기간		작성일	

목 표 ¹⁾	방문요양	1. 잔존기능 유지 및 향상 2. 보호자의 부양부담 완화 3. 정신행동증상에 대한 적절한 대처 4. 정서적 지지로 심리적 안녕
-------------------	------	---

급여종류	장기요양 필요영역	장기요양 세부목표 ²⁾	장기요양 필요내용	세부제공 내용	횟수	시간 (분)	작성자
방문요양	신체활동지원	신체 청결 유지	옷 벗고 입기 지켜보기와 지도	옷 준비하고 옷 갈아입기 단계별 다음 동작을 안내하여 스스로 할 수 있도록 시도하면서 혼자서 어려운 부분 도움	수 시	00	
			세면도움	혼자 할 수 있는 부분은 자립적 수행하도록 격려하고, 할 수 없는 부분은 도움주기	일 0회	00	
			양치질, 몸씻기, 머리감기 도움	양치질, 몸씻기, 머리감기 동작 스스로 하도록 격려하기	주 0회	00	
			화장실 이용 도움	일정한 간격으로 화장실 유도, 요실금 기저귀 등 뒤처리 도움	수 시	00	
	인지활동지원	인지기능 유지 및 향상	인지자극활동, 함께 수행하기	인지기능 향상을 위한 인지프로그램	주 0회	00	
		뇌기능 향상으로 일상생활활동 증진	감각활동 프로그램	인지훈련도구 활용 감각활동 프로그램(신체, 인지기능, 행동변화 대상자 중심)	주 0회	00	
		정신행동증상에 대한 적절한 대처	행동변화에 대한 적절한 대처	행동변화에 대한 적절한 대처(지속적 관찰, 사전 예방 등)	필요시	00	
	정서지원	정서적 지지를 통한 심리사회적 안정	말벗 및 격려 위로 등 정서적 지원	따뜻한 태도로 자존심이 상하지 않도록 배려하며 성취감 고취	일 0회	00	
		가족, 지인, 이웃 등과 관계유지 및 증진	의사소통 및 대인관계능력 향상 훈련	의사표시 방법 등 대인관계능력 도움	필요시	00	

방문요양	일상생활지원, 환경관리	지원을 통한 일상생활 유지	취 사	식재료 준비, 반찬 준비, 설거지 등	주 0회	00	
			세 탁	수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류 등 세탁	필요시	00	
			청소 및 주변정돈	수급자가 거주하는 방, 화장실 청소, 이부자리 정돈 등	필요시	00	
			생활환경 관리(위생적 환경조성, 위험성 제거 등)	비위생적 환경 개선, 위험한 환경요인 개선 등	일 0회	00	
	개인활동지원	외부와 의 소통을 통한 사회적 고립감 감소	외출 시 동행	외출 시 부족 또는 동행(대중교통 등 차량이용 포함)하고 책임귀가	필요시	00	
	지역사회연계	지역사회자원을 연계하여 주보호자 부담 감경	지역사회에 대한 정보 제공 및 이용가능자원 연계	인적, 물적 자원 등 다양한 지역사회자원 연계(치매 안심센터 등록 및 프로그램 이용, 지역 종합사회복지관 프로그램 연계 등)	필요시	00	

종합 의견 ³⁾	- 80세 4등급 남자 수급자로 배우자와 2남 1녀 가족관계를 가짐 - 약 30년 전 고혈압, 고지혈증 진단받아 약 복용 중. 10년 전 협심증으로 스텐트 삽입 수술 - 8년 전 자택에서 의식을 잃은 상태를 가족들이 발견하여 병원에 입원했으며, 뇌졸중(뇌경색) 진단받아 약 3개월 간 입원 후 퇴원하여 자택에서 생활 중 - 3년 전 알츠하이머 치매 진단받아 통원하여 정기적 진단·처방 수행 중 - 전체적으로 우측 측만 증세가 있으나 관절구축 등 신체적 제한 보이지 않으며, 지팡이를 양 손에 붙잡고 자택 계단을 천천히 오를 수 있음 - 식사 등 스스로 수행 가능하며, 화장실에서 대소변을 처리하나 속옷이 젖어있거나 소변실수를 하는 등 행동이 주 1회 이상으로 보여 소변실수를 인지할 시 화장실 대아에 속옷을 벗어놓음 - 가족·주변인을 도둑으로 의심하는 등 실제와 맞지않는 행동 잦음 - 실내에서 왔다갔다 배회를 하는 행동을 보이며 현관문을 열고 밖으로 나가 이웃이 찾아주거나 경찰서를 통하여 찾아오는 행동이 있어 경찰서 지문사전등록 안내함 - 자가 주택에서 가족들과 함께 생활하며 자주 왕래하여 수발도움을 주나, 가족들이 사회활동을 하는 낮 시간 방문요양서비스(신체, 가사, 인지 등) 희망
---------------------	--

위의 급여제공계획에 대해 상세히 들었음을 확인합니다

20**년 00월 00일

동의자

(수급자와의 관계)

(서명 또는 인)

「노인장기요양보험법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 수급자의 장기요양급여 제공계획서 내용을 국민건강보험공단에 통보합니다

20**년 00월 00일

장기요양기관의 장(대표자):

(서명 또는 인)

국민건강보험공단 이사장 귀하

- 1) 여기에서 목표는 장기목표에 해당됨. 장기목표는 수급자의 언어로 제시하며 시급성과 중요성, 달성가능성을 고려하여 목표 우선순위를 결정할 것
- 2) 여기서 목표는 단기목표에 해당됨. 단기목표는 사례관리자의 언어로 제시하며 구체적이고 실천적인 행동을 담고 있어야 함. 긍정적 언어로 제시할 것
- 3) 급여제공 시 유의사항, 수급자의 주요 욕구 및 급여제공계획 방향을 제시함

4 사례회의기록지

사례관리 회의록							
회의명	Case1 사례회의(1차)		회의일자	2021.00.00.		회의시간	
수급자명	Case1	성별/나이	남/80세	생년월일	1940.00.00.	등 급	4
회의장소	기관 내 회의실		참가자	A(시설장), B(사회복지사), C(요양보호사)			
회의내용	1. 수급자 주요 현황 ○ 욕구사정기록지 참조 2. 사례관리 선정이유(문제점) ○ 최초인정 수급자로, 수급자/보호자의 욕구파악 및 서비스 계획수립을 위하여 선정 ○ 치매 행동변화의 빈도가 증가하고 있으며, 실종위험 등 대처방법을 보호자들이 정확히 숙지하고 있지 못하여 수급자/보호자 교육 필요 3. 회의내용 ○ 사회복지사: 수급자 최초인정자로 현재 서비스 이용하지 않고 있다. 서비스 이용 등 관련하여 보호자로부터 서비스 의뢰가 들어와 욕구사정 차 방문을 하고 왔는데, 어떤 서비스를 제공하면 좋을지 다른 분들의 의견을 듣고자 한다. ○ 시설장: 최초 사정 내용을 보면, 혼자서 몸 청결 등 일상생활을 원활히 수행하는데 어려움이 있다고 사료된다. 따라서 보호자들이 주로 자택을 비운다고 하는 주간시간(12:00~15:00) 등에 가사활동, 일상생활 서비스를 제공하면 좋지 않을까 생각한다. 또한 치매질환자로 인지상태가 점점 저하되는 것으로 추론되는데, 적절한 인지자극활동이나 일상생활을 함께 수행하는 서비스도 필요할 것으로 보인다. ○ 요양보호사: 현재 가족 외의 제3자에게는 약간의 신경질적 언행 이외의 폭언과 폭력행동은 파악되지 않았으나, 가족들에게 폭언 및 폭력행동을 보이는 만큼 행동빈도와 강도가 강해질 가능성을 배제할 수 없으며, 배회 등으로 수급자의 일상을 잘 주목하는 것이 중요하다고 생각된다. 또한 보호자가 치매에 대한 정보가 많지 않고 수급자 인지자극활동의 필요성을 크게 느끼지는 못하고 있지만, 보호자의 동의를 얻어 인지자극 및 정서지원 활동이 필요할 것으로 보인다. ○ 사회복지사: 그렇다면 주 5회 빈도로 180분 방문요양서비스 제공으로 급여제공계획을 수립하겠으며, 제공 세부내용에 인지자극활동 60분 가량 편성하여 보호자분께 설명 및 제공동의 의사 확인하도록 하겠다. 그리고 신체활동 자원과 일상생활지원 및 환경관리, 개인활동 자원과 관련한 필요 서비스 내용도 포함하겠다. ○ 시설장: 주보호자가 치매에 대한 지식이 부족하고 지역사회에 설치된 치매안심센터에 등록도 되어 있지 않아 관련한 정보가 없는 것으로 보인다. 사회복지사 선생님이 지역 치매안심센터에 연락하여 구체적으로 제공될 수 있는 서비스를 조사하여 보호자에게 알려주고 가능한 이용할 수 있도록 조치할 필요가 있는지 확인 필요하다. ○ 사회복지사: 치매안심센터 등록 및 프로그램 이용과 더불어, 보호자가 사업장 운영 등으로 돌봄공백 발생하는 시간이 추가로 있다. 이는 방문요양서비스 제공시간 이외에도 발생할 수 있기에, 수급자가 이용할 가능한 지역사회 자원이 있는지 추가로 알아봐 가능할 경우 보호자의 동의를 얻어 자원연계 협의해보겠다. ○ 요양보호사: 수급자는 고혈압 등 기저질환자이며 뇌혈관질환 병력이 있으므로, 방문간호서비스를 제공						

	함이 어떻게 의견을 듣고자 한다. ○ 시설장: 현재 우리 기관에서는 방문간호서비스를 제공하고 있지 않으나, 수급자 건강 및 질환상태로 보면 관련기관으로 연계가 필요할 듯하다. 보호자와 상담 후 의사가 확인될 시, 관내 방문간호기관 목록 등 제공하겠다. 4. 회의결과 ○ 최초 인정자로, 방문요양서비스 주 5회 180분으로 제공(가사지원 및 일상생활지원을 주 서비스로 계획하며, 인지자극활동 60분 편성하여 보호자 의견 수렴) ○ 보호자에게 지역사회 내 이용가능 자원에 대한 정보를 제공하고 이용가능하도록 지원하며, 지역 치매 안심센터 수급자 등록, 보호자의 치매에 대한 대응·대처방법 교육 참석연계, 방문간호서비스 제공 필요여부 등 확인 예정 ○ 보호자가 집을 비우거나 방문요양서비스 제공시간 이외에, 수급자 돌봄 공백을 대체할 수 있는 지역사회자원 모색	
회의 사진		

5 사례관리 모니터링 업무수행 일지(양식)

프로그램관리자 및 사회복지사 업무수행 일지

수급자 성명	Case1	장기요양 등급	4	장기요양 인정번호	L000	수급자(보호자) 성명(인)	
						관리책임자 성명(인)	

○ 서비스 이행 및 목표 성취 정도 평가

단기목표 ⁴⁾	서비스명 ⁵⁾	서비스 기 간	횟 수	기관 / 담당자	점 검 방 법	이 행 여 부	변 경 내 용	변 경 사 유	목표 성취정도
신체활동지원	옷 벗고 입기 지켜보기와 지도	1개월	수 시		현 장	이 행			0 1 2 ✓
	세면도움	1개월	일 0회		현 장	이 행			0 1 2 ✓
	양치질, 몸씻기, 머리감기 도움	1개월	주 0회		유 선	이 행			0 1 ✓ 3
	화장실 이용 도움	1개월	수 시		현 장	이 행			0 1 2 ✓
인지활동지원	인지자극활동, 함께 수행하기	1개월	주 0회		현 장	이 행			0 1 ✓ 3
	감각활동 프로그램	1개월	주 0회		현 장	이 행			0 1 ✓ 3
	행동변화에 대한 적절한 대처	1개월	필요시		현 장	이 행			0 1 ✓ 3
정서지원	말벗 및 격려 위로 등 정서적 지원	1개월	일 0회		현 장	이 행			0 ✓ 2 3
	의사소통 및 대인관계능력 향상 훈련	1개월	필요시		현 장	이 행			0 ✓ 2 3
일상생활지원, 환경관리	취 사	1개월	주 0회		현 장	이 행			0 1 2 ✓
	세 탁	1개월	필요시		유 선	이 행			0 1 2 ✓
	청소 및 주변정돈	1개월	필요시		현 장	이 행			0 1 2 ✓
	생활환경 관리 (위생적 환경조성, 위험성 제거 등)	1개월	일 0회		현 장	이 행			0 1 2 ✓
개인활동지원	외출 시 동행	1개월	필요시		유 선	미이행			0 ✓ 2 3
지역사회연계	지역사회에 대한 정보 제공 및 이용가능자원 연계	1개월	필요시		유 선	이행중			0 ✓ 2 3

4) 장기요양급여제공계획서에 작성된 '장기요양 필요영역' 제시

5) 장기요양급여제공계획서에 작성된 '장기요양 세부내용' 제시

욕구사정	① 신체상태		- 거동 등 일상생활 수행 가능하며, 목욕이나 소변실수 등 몸 청결 동작을 수행하는데 도움이 필요한 상태임 - 사회복지사 방문 당시, 요양요원 서비스 전에 수급자가 소변실수를 하였음을 스스로 인지하여 속옷을 화장실 대야에 담겨둔 상태임을 확인함	
	② 질병		- 고혈압, 고지혈증, 치매	
	③ 인지상태		- 사회복지사 방문 당시 요양요원이 식사준비를 하고 있었으며, 수급자는 실내에서 지팡이를 붙잡고 거동하고 있었으며 어디 가시냐는 질문에 원활히 대답하지 못함 - 사회복지사에게는 특별한 태도를 보이지 않았으나, 요양요원에게는 약간의 신경질투로 말하는 행동 확인됨	
	④ 의사소통		- 의사소통에 문제 없음	
	⑤ 영양상태		- 일반식으로 식사하며, 스스로 식사동작 수행 가능	
	⑥ 가족 및 환경		- 배우자, 2남 1녀, 한 건물에서 배우자와 장/차남 부부 거주 중이나 호수를 달리하여 생활하고 있음	
	종 합		- 수급자 방문요양서비스 1주일 간 이용하였으며, 서비스 제공하는 요양요원에 대하여 큰 불만 표현하지 않음 - 소변실수를 인지하지 못하는 경우도 있으나, 본인 뒤처리를 하여야 한다고 인지하는 경우 옷을 스스로 벗어놓음 - 요양요원에게 신경질투의 말을 섞어서 하는 경우도 있으나, 욕설이나 폭력을 가하는 행동이 아직 관찰되지는 않음 - 첫 서비스 제공으로, 적응을 위하여 참여가능한 가족이 동석하면서 수급자에게 서비스 제공함	
급여제공 계획	급여목표		- 잔존기능 유지 및 향상, 보호자의 수발부담 완화, 인지저하 및 행동변화에 대한 적절한 대처 및 정서지지로 심리적 안정을 취하고 인지저하 예방	
	필요 급여내용		- 목욕 및 세면 등 몸 청결 동작, 일상생활 함께하기, 식사준비 등 가사지원, 생활환경 정돈 등 위생적 환경조성과 위험요인 제거, 인지자극활동 및 정서지원	
	제공방법		- 급여제공 시 일방적 도움보다는 잔존기능(신체·인지) 활용하여 가능한 스스로 수행하도록 일부 지시도움 필요 - 인지자극활동 및 정서지원으로 인지저하 예방 - 행동변화(망상, 환시, 폭언 등)를 예방하거나 조기대응하며, 자존감 보호를 위한 충분한 배려	
인지활동 프로그램 제공 계획	인지자극	필요내용	-	
		제공방법	-	
	신체능력 잔존·유지	필요내용	-	
		제공방법	-	
보호자 상담				- 1주일 간 요양요원의 서비스 제공에서 자녀, 자부, 배우자 등 보호자들이 돌아가면서 동석하였고, 요양요원에 대한 만족도 표현함 - 요양요원 첫 방문 시 약간 거부를 보이는 듯 했으나, 방문 지속될수록 거부감이 낮아지는 것을 보호자들이 느낌 - 서비스 제공시간 이외에도 인지자극활동 등 보호자들도 직접 제공을 희망하여, 인지훈련도구 사용방법 등 안내함

욕구변화	내 용	- 별도의 욕구변화 없음
	평가 및 조치	- 욕구변화 관찰되지 않으나, 아직 라포형성이 완전하지 못한 상태로, 정서지원이나 의사소통 및 대인관계능력 향상에 대한 서비스제공이 원활히 이뤄지지 못함 - 치매안심센터 및 지역사회자원에 관하여 보호자에게 안내하였으며, 가족 간 상의 후 연계 등 고려예정임
서비스 제공자에 대한 평가	사회복지사	- 월 1회 이상 유선/방문 모니터링으로, 서비스 제공계획에 대한 이행여부 유선/현장 확인예정이며, 추가 연계가능한 지역사회자원에 관하여 물색예정
	요양보호사	- 수급자와 라포형성이 충분하게 이뤄지지 않은 상태로, 주로 일상생활도움과 라포형성에 서비스제공 포커스를 맞추고, 지속적인 정서지원 및 인지지원 서비스 제공노력 예정
급여 및 인지활동 프로그램 제공 확인	확인내용	
	조치사항	
	급여제공자 성명(인)*	
방문(상담)일시		. . . (: ~ :)
방문장소*		
급여제공 중 방문여부*		
방문불가 사유*		
방문자 성명(인)		

6 사례관리 종결보고서(양식)

장기요양 인정번호	L000		수급자명	Case1	종결평가 일자	22.00.00.
종결평가 담당자			소 속	00재가복지센터	연락처	000-000-0000
요 청 일 자	인 적 정 보	욕 구 조 사	사례회의	제공계획	서비스 점 검	종결평가
'21.00.00.		'21.00.00.	'21.00.00.	'21.00.00.	'21.00.00 (매월 1회)	'22.00.00.
장기성과 목표						
연 번	목표내용		성과구분 ⁶⁾	성과내용		
1	잔존기능 유지 및 향상		4	- 사례관리대상 선정 당시의 신체/인지기능에서 크게 저하되지 않고 잔존기능을 유지하고 있으며, 일상생활에 일부 혹은 지 시도움으로 수행 가능함 - 다만 기존 잔존기능 활용능력에서 뚜렷한 향상은 보이지 않았지만, 부가적인 저하가 예방된 정도의 목표를 달성		
2	보호자의 부양부담 완화		5	- 방문요양서비스 제공으로 점심식사, 목 청결, 정서지원 등 보호자(가족)의 수급자 부양에 대한 대체시간 충분히 확보되었음을 확인함 - 더불어 지역사회자원(치매안심센터 등) 연계를 통한 방문요양서비스 제공 이외의 시간에 대해서도 부양 대체시간 마련하였으며, 보호자의 높은 만족도 표현 확인함		
3	정신행동증상에 대한 적절한 대처		4	- 라포 형성된 요양요원, 보호자(가족)들에게 욕설을 하는 등 행동은 있었으나, 흥분을 가라앉히게 시간을 두는 등 적절한 대처방법으로 원활히 대처 가능함 - 다만 정신행동증상의 빈도가 눈에 띄게 줄어드는 등 완화가 이뤄지지는 않았으며, 적절한 대처방법을 숙지하고 대응하는 목표달성내용 보임		
4	정서적 지지로 심리적 안녕		4	- 요양요원 지속적 방문 및 라포형성으로 친근감을 표현하며, 폭력 및 폭언이 아닌 대인관계 의사소통능력 양호함 - 관내 치매안심센터 등 통원하면서 이용자들과 원활한 관계 유지하며, 대인관계능력 증진 보임		

6) 기대수준 이상 목표달성(5점), 기대한 정도의 목표달성(4점), 보통수준(3점), 기대수준 이하 목표달성(2점), 전혀 달성하지 못함(1점)

단기성과 목표			
연 번	목표내용	성과구분	성과내역
1	신체활동지원	4	- 잔존기능을 활용하여 옷 갈아입기, 몸 청결동작에서 기능저하를 보이지 않고, 보호자(가족 및 요양요원)의 지시 및 일부도움으로 수행 가능함 - 다만 온전히 신체기능활동을 혼자 수행하는 정도까지 기능향상은 보이지 않았으며, 잔존기능을 유지하는 정도의 목표를 달성
2	인지활동지원	4	- 인지자극활동 수행으로 인지저하 추가진행을 예방하고, 폭언 등 행동변화에 따른 적절한 대처가 원활히 이뤄짐 - 다만 정신행동증상 빈도가 눈에 띄게 줄어들거나 인지기능의 향상이 관찰되지는 않았으며, 잔존기능을 유지하는 정도의 목표를 달성
3	정서지원	5	- 잔존기능 충분히 활용하고, 스스로도 일상생활을 수행할 수 있다는 정서적 지원 등으로 우울감을 표현하지 않으며, 자존감과 성취감을 느낀다고 수급자가 표현하는 등 목표달성이 확인됨 - 관내 지역사회자원(치매안심센터 등) 이용 시에도 타 이용자들이나 지역사회 이웃들에게 대인관계능력에서 원활함을 보이는 등 모습 관찰됨
4	일상생활지원, 환경관리	5	- 요양요원의 서비스제공을 통하여 세탁, 취사, 청소 등 위생적이고 위험성 없는 환경조성 되었으며, 일방적인 도움이 아닌 수급자의 신체/인지적 잔존기능을 최대한 활용한 '일상생활 함께하기' 도움을 통하여 서비스 제공이 되지 않는 때에도 수급자 스스로 가능한 범위 내에 환경관리 이루어지고 있음
5	개인활동지원	4	- 병원 통원 등 외출 시 요양요원의 도움으로 외출/귀가 수행하고 있음 - 인지저하 등으로 자주 다니던 길이지만 방향 등을 헛갈려하는 경우가 종종 확인되어 지시도움과 일부 부축도움으로 외출 및 귀가 가능
6	지역사회연계	5	- 지역사회자원(치매안심센터 등록 등)으로 가족과 함께 참여하는 일부 프로그램에 동석하는 등 적극적인 이용의지 보임 - 함께 프로그램 참여하는 이용자/가정과 원활한 인간관계를 맺으려는 노력을 보이고 있으며, 이외에 관내 종합사회복지관에서 진행하는 지역사회행사 등에도 꾸준히 참여하고 싶다는 의사 확인함
사례관리자의 견 (담당자 의견)			- 장기요양등급 최초인정 이후 약 1년 간 방문요양서비스 제공되었고, 서비스 제공을 위한 욕구사정 당시보다 신체/인지기능의 저하 보이지 않음(신체/인지활동지원, 개인활동지원 각 성과구분 4점으로, 목표 달성) - 요양요원과 라포형성 원활히 진행되었으며, 정서지원에 따라 타인과의 대인관계능력에서 원활함을 보이며 새로운 인간관계 다수 형성으로 비상연락망 등 체계 구축 - 일상생활에서 일방적인 도움이 아닌, 잔존능력을 최대한 활용한 도움으로 장기요양서비스 제공이 이뤄지지 않는 상황에서도 스스로 수행가능한 범위 안에서 일상생활능력 수행하려는 행동 보임(정서지원, 일상생활지원 각 성과구분 5점으로 목표 이상 달성) - 치매안심센터 등 지역사회자원 연계하였으며, 수급자와 보호자 모두 이용에 만족을 표하며 적극적인 지역사회 참여를 희망하고 있음(지역사회연계 성과구분 5점으로 목표 이상 달성) - 수급자와 보호자 개인사정으로 타 지역으로 이사 결정되어, 현 장기요양기관에서의 서비스 종결함 - 00도 00시(이사 지역) 국민건강보험공단 지사에 관할지역 내 장기요양기관 목록 요청하여 보호자에게 장기요양기관 관련 정보제공

보호자(가족) 변 화	- 수급자 돌봄 공백이 없어져서 배회를 한다거나 실종될 수 있는 안전사고 문제 해결되었으며, 수급자가 수발하기 어려운 시간대에 장기요양서비스 제공 등으로 청결 및 위생상태 제고되었음 - 인지활동 및 정서지원으로 수급자의 본의 아닌 행동변화에 대한 자존감 하락을 예방하였으며, 보호자에 게도 지역사회자원을 활용한 치매질환자 대응방법 숙지로 가족 내 적절한 대응태도 갖추 - 지역사회 내 관계망 구축으로 수급자의 정서지원기반 마련하였으며, 비상연락망 구축으로 보호자들의 수발부담 및 돌봄 공백에 대한 불안감 덜음
종결평가 의견 (특이사항 /사후관리)	- 수급자는 1년 이상의 서비스를 이용하면서 심신상태가 안정되고 인지적 상태도 잘 유지되는 등 기대한 정도의 목표를 달성되는 시점이었으나, 이사로 인해 서비스 기관을 변경해야 하는 상황이 되었음 - 이사지역에 대한 장기요양기관 정보를 보호자에게 제공하였고, 서비스연계 요청서 작성 및 보호자 제공 으로 향후 이용하게 될 장기요양기관에서도 서비스제공에 공백을 최소화 하도록 노력함 - 더불어 보호자 동의하에 향후 서비스계약기관에 기존 서비스제공 및 수급자 상태 정보 제공하여 서비스 이전에 따른 돌봄 공백 최소화
종결평가 결 과	☐ 재조사(사정) ☒ 종결
종결 유형	☐ 장기목표 달성 ☐ 단기목표 달성 ☐ 상황호전() ☐ 거절이나 포기() ☐ 연락두절 ☒ 이사 또는 사망 ☐ 자체종결

2 사례관리 작성실습(Case2)

1 사례 개요

- 이름: Case2(여, 62세)
- 신체상태
 - 일상생활동작 수행능력(ADL): 22점(36점 만점, 점수-도움필요도 비례관계)
 - 수단적 일상생활동작(IADL): 24점(33점 만점, 점수-도움필요도 비례관계)
 - 우측 편마비 질환자로 우측 상하지 대부분의 관절에서 일부 구축 관찰됨
 - 이로 인한 실내거동, 일어나 앉기 등 일상생활 동작에 일부 어려움이 있으며, 대소변을 보고 뒷처리를 깨끗하게 수행하기 어려움
- 질병상태
 - 뇌출혈 약 7년 전 발병하여 이후 우측 편마비 및 언어장애
 - 치매(6년 전 진단), 고혈압(10년 전 진단), 당뇨(5년 전 진단)으로 약물복용 관리 중
 - 변비가 있기는 하나, 관장이 필요한 정도는 아니며 주 1회 빈도 대변을 봄
- 재활상태
 - 우측 편마비로 우측 상지(어깨, 팔꿈치, 손목, 수지), 하지(고관절, 무릎, 발목)에 일부 구축을 보임
 - 지팡이를 붙잡고 천천히 실내거동은 가능하나 혼자서 외출을 하기는 어려움
- 간호처치상태: 해당없음
- 인지상태: 5점(15점 만점, 점수-인지저하 비례관계)
 - 지남력, 단기 기억력, 집중력, 판단력 등 일부 저하 있으며, 언어장애로 간단한 단어나 신체표현 등으로 상대방과 의사소통
- 의사소통
 - 청취능력에 저하를 보이지는 않으나, 뇌출혈 발병 이후 언어장애로 발음능력 저하 보임
 - 상대방의 말을 대부분 이해하며, 자신의 의사를 간단한 단어 등으로 표현해 상대방과 의사소통 수행함
- 영양상태
 - 치아상태 양호하며, 좌측 상지를 움직여 스스로 숟가락질 하여 식사 수행
 - 당뇨 질환자로 당뇨식으로 식사관리
- 주거상황
 - 본인 명의 자가주택에서 거주하고 있으며, 경제적 어려움을 호소하지 않음
- 가족 및 환경상태
 - 기혼자이며 2남의 자녀가 있으나, 배우자와 차남 약 15년 전 사망하여 현재 독거로 생활중

- 장남내외가 월 1회 이상의 빈도로 방문
- 집성촌에 거주하여 주변에 친인척 다수 거주하고 있음
- 사회관계 및 사회적지지 실태
 - 기독교 신자로 교회에 매번 방문하기 어려운 경우가 있으며, 매일 새벽(6am)마다 방에서 혼자 새벽기도 수행
 - 마을 친인척, 교인들이 자주 수급자 집에 방문하여 말벗 등 해주며 비상연락체계 형성하였으나, 독거세대로 일부 돌봄 공백 존재
 - 동네 친척들과 주 1~2회 빈도로 관내 병원 통원하여 재활/물리/작업치료 받음
 - 보호자(자녀)들 동행으로 고혈압, 당뇨, 치매 등 3차병원 통원진료
- 공식적 자원 이용 현황
 - 주민센터, 종합사회복지관 등 기타 지역사회자원 이용내역 없음
 - 마을 이장님 주관으로 종합사회복지관에 사례관리대상 의뢰하였으나, 65세 미만자이며 차상위/기초생활수급자 세대가 아닌 점 등 고려하여 사례관리 대상자로 선정되지는 않음
 - 65세 미만자로 장기요양등급 인정받아, 약 1년 간 방문요양서비스 이용 중
- 수급자 및 보호자 개별 욕구
 - 수급자 및 보호자 방문요양서비스 이용 희망

2 욕구사정기록지

욕구사정기록지				작성일	.	.	.
				작성자	서명(인)		
수급자성명	Case1	키	150cm	생년월일	1960.00.00.		
인정번호/등급	L00 / 3등급	체중	55kg	성별/연령	여 / 62세		

가. 신체상태(ADL, IADL, 일상생활 수행능력)

1) 일상생활능력(ADL, Activities of Daily Living)

※ 표기: ×-완전도움 △-부분도움 ○-완전자립

항 목	확 인	항 목	확 인	항 목	확 인
옷 벗고 입기	△	세수하기	△	양치질하기	△
식사하기	○	목욕하기	×	체위변경	○
일어나 앉기	△	옮겨앉기	△	방 밖으로 나오기	△
화장실 사용	△	대변 조절하기	○	소변조절	△

낙상위험 유무 ☒유 ☐무 (낙상위험도 측정결과: 17점)

- 일상생활동작 수행능력 ... 36점 만점(완전도움(×) 3점, 부분도움(△) 2점, 완전자립(○) 1점)
- 22점(목욕하기 완전도움, 옷 갈아입기 및 실내거동 등 신체기능활동 부분도움)
- 판단근거
- 뇌출혈 후유증(우측 편마비) 질환자로 전반적인 일상생활 수행능력이 저하됨
- 기존 서비스 이용자이며, 이전 욕구사정 당시에 비하여 거동, 일어나 앉기 등 신체기능을 활용한 일상생활 수행능력 저하됨
- 지팡이를 붙잡고 부축을 받아 천천히 실내거동 가능하나, 수발자가 없는 상황이나 방에서 이동하는 상황에서는 주로 무릎으로 기어서 이동함
- 옷을 갈아입거나 세수 및 화장실 뒤통리 등 몸 청결동작을 원활히 수행하기 어려워하고, 목욕동작을 스스로 수행하지 못함
- 변비가 있으며 변의를 인지하여 스스로 화장실에서 대변을 처리하나, 요실금 증세가 주 3~4회 빈도로 있음
- 주요 문제 및 욕구
- 주된 문제는 우측 편마비에서 오는 일상생활 수행능력의 지장이며, 거동이나 체위변경 등 신체기능을 활용하는 행동들에 부분적인 도움 필요함
- 요실금과 대소변 뒤통리 처리에 어려움으로, 옷을 갈아입거나 씻는 등 청결동작에 도움 필요

2) 수단적일상생활동작(IADL, Instrumental Activities of Daily Living)

※ 표기: ×-완전도움 △-부분도움 ○-완전자립

항 목	확 인	항 목	확 인	항 목	확 인
청소하기	×	식사 준비	○	빨래하기	×
금전관리	△	물건 사기	×	전화 사용	○
교통수단 이용	△	근거리 외출	△	몸 단장	△
안전관리	×	건강관리	△		

- 수단적 일상생활동작 수행능력 ... 33점 만점(완전도움(×) 3점, 부분도움(△) 2점, 완전자립(○) 1점)
 - 24점(청소, 안전관리, 물건사기, 빨래 완전도움 필요하며, 대부분 일상생활에 도움 필요)
- 판단근거
 - 대부분 우측 편마비로 인하여 청소하기, 안전관리, 물건사기, 빨래 등 원활한 수행에 문제가 있으며, 교통수단을 이용하거나 근거리를 외출하는데에 일부 수발자의 도움 필요함
- 주요 문제 및 욕구
 - 편마비로 인한 신체기능 제한에서 대부분 어려움이 발생함
 - 인지상태 저하와 관절구축 등을 예방하기 위하여, 전적인 수발도움을 주기보다는 최대한 신체/인지 잔존기능을 활용하여 수급자와 함께 수행하는 일상생활지원이 필요

나. 질병상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

질병 분류	질병 명			
내분비·대사성	☐ 당뇨 ☐ 만성간염	☐ 갑상선질환 ☐ 자가면역질환	☐ 탈수 ☐ 빈혈	☐ 영양상태이상 ☐ 기타()
소화기계	☐ 위염 ☐ 간경변증	☐ 위궤양 ☐ 기타()	☐ 십이지궤양	☐ 변비
순환기계	☒ 고혈압 ☒ 뇌혈관질환	☐ 저혈압 ☐ 기타()	☒ 협심증	☐ 심근경색증
근골격계	☐ 관절염 ☐ 기타()	☐ 요통, 좌골통 ☐ 기타()	☐ 기타 척추질환	☐ 골다공증
신경계	☒ 치매 ☐ 두통 외 통증	☐ 뇌경색 ☐ 기타()	☐ 파킨슨병	☐ 두통
정신·행동장애	☐ 신경증	☐ 우울증	☐ 수면장애	☐ 기타()
호흡기계	☐ 폐결핵	☐ 만성기관지염	☐ 호흡곤란	☐ 기타()
눈·귀질환	☐ 시각장애	☐ 난청	☐ 기타()	
비뇨·생식기계	☐ 전립선비대	☐ 요실금	☐ 만성방광염	☐ 기타()
만성신장질환	☐ 만성신부전증	☐ 기타()		

구 분	질병명
과거병력	뇌출혈
현 진단명	뇌출혈 복합장애(언어, 운동), 치매, 당뇨, 고혈압, 변비

○ 판단근거

- 뇌출혈: 7년 전 발병으로, 이후 우측 편마비 및 언어장애
- 치매: 6년 전 혈관성으로 진단받았으며, 에빅사 정 복용 중(10mg 1일 2회)
 - 투약방법 : 중등도에서 중증의 알치하이머병 치료제이며, 음식섭취와 상관없이 복용할 수 있음
- 고혈압: 약 10년 전 진단받았으며, 노바스크정 복용 중(10mg 1일 1회)
이전 욕구사정과 금번 욕구사정에서 측정 시 정상혈압 측정됨
 - 투약방법 : 혈압 하강제로 1일 1회 투여하며 의사와 상의 없이 복용량을 바꾸거나, 중단해서는 안됨
 - 부작용 : 혈압강하에 의한 어지러움이 나타날 수 있으므로 자리에서 일어날 때 천천히 일어나며 넘어지지 않도록 조심해야 함. 부종, 어지러움, 두통 등이 있음
- 당뇨: 5년 전 진단받았으며, 듀비에 정, 제미로우 정 복용 중
- ① 듀비에정 0.5mg 1일 1회
 - 투약방법 : 혈당조절을 향상시키기 위한 약으로 식사와 관계없이 투여할 수 있음
 - 부작용 : 혈압강하에 의한 어지러움이 나타날 수 있으므로 자리에서 일어날 때 천천히 일어나며 넘어지지 않도록 조심해야 함. 부종, 어지러움, 두통 등이 있음
- ② 제미로우 정 1일 1회
 - 투약방법 : 당뇨병과 고지혈증을 동시에 치료하는 복합제임. 향상시키기 위한 약으로 식사와 관계없이 투여할 수 있음
 - 부작용 : 소화불량, 설사, 변비 등이 나타날 수 있음
- 변비: 주기적 관장을 할 정도로 심하지는 않으며, 주 1회 빈도로 대변을 봄

	시 간	약 물	주의사항
투 약	아침 식사 전	노바스크정 1일 1회(혈압강하제)	• 혈압강하제(노바스크정) : 자몽주스를 마실 경우 혈압강하 효과가 증가되어 혈압이 떨어질 수 있어 같이 복용하지 않음 • 당뇨병용제: 식사 시간과 상관없이 복용 가능
		듀비에 정 1일 1회(당뇨병용제)	
		제미로우 정 1일 1회(당뇨병용제)	
	아침식사 전 / 저녁식사 후	에빅사 정 1일 2회(중추신경용약)	

○ 주요 문제 및 욕구

- 뇌혈관질환 병력이 있으며, 치매진단 등으로 지속적 인지저하가 예상되어 약물복용 관리 필요

다. 재활상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

확 인			
■우측상지	□좌측상지	■우측하지	□좌측하지
■어깨관절(☞/●)	■팔꿈치관절(☞/●)	■손목 및 수지관절(☞/●)	
■고관절(☞/●)	■무릎관절(☞/●)	■발목관절(☞/●)	□해당없음
○ 판단근거 - 우측 편마비증세를 보이며, 우측 상하지 전체 관절에 일부 구축이 있음 - 지팡이를 붙잡고 수발자의 부축을 받아 천천히 거동 가능 - 재활에 대한 본인의사가 있어, 관내 병원을 주 2회 통원하며 재활/물리/작업치료 등 받고 있음 ○ 주요 문제 및 욕구 - 해당사항 없음			

라. 간호처치상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

확 인			
☐ 기관지 절개관 간호	☐ 흡인	☐ 산소요법	☐ 욕창간호
☐ 경관영양	☐ 통증간호	☐ 장루간호	☐ 도뇨관리
☐ 투석간호	☐ 당뇨발간호	☐ 상처간호	☒ 해당없음
○ 판단근거, 주요 문제 및 욕구 - 간호 관련 처치상태 없음			

마. 인지상태(인지기능저하, 정신상태, 감정, 문제행동 등)

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분		확 인
1	지남력	☒
2	기억력	☒
3	주의집중 및 계산	☒
4	언어적 기능	☒
5	판단력	☒
6	편집증 및 망상	☐
7	환각	☐
8	배회	☐
9	반복적인 활동	☐
10	부적절한 활동	☐
11	언어폭발	☐
12	신체적 공격 또는 폭력행위	☐
13	우울	☐
14	일반적인 불안	☐
15	혼자 남겨짐에 대한 공포	☐

○ 판단근거
- 인지상태 5점 ... 15점 만점

○ 판단근거
- 시간 및 장소에 대한 지남력이 저하되어 현재 거주하는 곳이 자택이 아닌 과거에 살던 장소나 다른 곳이라고 대답하는 행동이 잦음
- 단기기억력 저하를 보이며, 한 가지 일에 몰두하기 어려워하는 인지저하를 보임
- 언어장애로 완전한 문장으로 본인의 의사를 표현하기 어려워하며, 간단한 단어나 신체표현 등으로 본인의 의사를 어렵게 표현함

○ 주요 문제 및 욕구
- 혈관성 치매 질환자로 약 6년 전 진단받았으나, 아직 큰 인지저하를 보이지는 않으며 단기기억력 및 지남력 등 일부 인지저하증세를 보임
- 언어장애로 타인과의 의사소통에 일부 지장을 갖고 있으며, 이로 인한 우울감 및 일상생활 어려움을 예방하기 위한 인지자극/정서지원 필요

바. 의사소통

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인		
청취능력	☐ 들리지 않는지 판단 불능 ☐ 보통의 소리를 듣기는 하고, 못 듣기도 한다	☐ 거의 들리지 않는다	☐ 큰 소리는 들을 수 있다 ☒ 정상(보청기 사용 포함)
의사소통능력	☐ 모두 이해하고 의사를 표현한다 ☐ 가끔 이해하고 의사를 표현한다	☒ 대부분 이해하고 의사를 표현한다 ☐ 거의 이해하지 못하고 의사 전달 불가	
발음능력	☐ 정확하게 발음이 가능하다 ☐ 간혹 어눌한 발음이 섞인다	☒ 웅얼거리는 소리로만 한다 ☐ 전혀 발음하지 못한다	
○ 판단근거, 주요 문제 및 욕구 - 청취능력에 저하를 보이지 않음 - 상대방의 말을 대부분 이해하며, 자신의 의사를 표현 가능하나 언어장애로 시간이 오래 걸리며 간단한 단어나 몸동작 등으로 의사소통 가능			

사. 영양상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인		
치아상태	■양호 □잔존치아 없음	□불량	□의치(전체 / 부분(상/하))
식사 시 문제점	□식욕저하 □소화불량	□저작곤란 □구토	□연하곤란 ■없음
식사형태	□일반식 ■당뇨식	□죽 □경관식	□미음
도구형태	■손가락 □사용불가	□젓가락	□포크손가락
배설양상	□정상 □복부팽만	□설사	■변비

○ 판단근거

- 치아상태나 연하/저작운동에 저하가 없음

- 당뇨 질환자로 당뇨용 쌀밥 등 당뇨식으로 식사

- 우측 편마비로, 좌측 상지를 움직여 손가락질로 식사 가능

○ 주요 문제 및 욕구

- 당뇨 관련 식사조절 및 식단관리가 필요

- 치아상태 양호하며, 손가락으로 스스로 식사 가능하나 식사준비 등 도움 필요

아. 주거 상황

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

주거유형	☒ 단독주택 ☐ 빌라		☐ 다세대주택 ☐ 주상복합		☐ 아파트 ☐ 기타	
자가여부	☒ 자가 ☐ 월세	☐ 전세 ☐ 기타	엘리베이터 유무		☐ 유 ☒ 무	
주차장 유무	☒ 유 ☐ 무		주거공간 상태		☒ 양호 ☐ 불량	☐ 보통
거주지 내 물리적 장애여부	☒ 유 ☐ 무		세부내용: 창고 등 일부 장소에 문지방이 높음			
주거 상태	☒ 양호 ☐ 불량	☐ 보통	세부내용: 단독주택이며, 주거상태 양호함			

○ 판단근거

- 본인 명의 자가주택에 거주하고 있으며, 생활공간 등 거주환경 양호함
- 뇌출혈 발병 전 개인사업을 하고 있었으며, 경제적 어려움을 겪지 않음
- 집성촌에 거주 중으로, 친척들이 자주 방문하고 있음

○ 주요 문제 및 욕구

- 집성촌에 오래도록 거주하고 있으며, 주변 친척 및 이웃과 교류가 잦아 비상연락체계 지속적 유지
- 단독주택에 거주중이며, 난방시설 및 생활환경 양호함

자. 가족 및 환경상태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인				
결혼여부	☒ 기혼 ☐ 미혼	배우자 생존여부		☐ 생존 ☒ 사망	
자녀 수	2명 (2남 0녀)				
주 수발자	☒ 유 ☐ 무	주수발자 연령		43 세	
주 수발자 관계	☐ 배우자 ☒ 자녀	☐ 자부 ☐ 사위	☐ 기타()		
주 수발자 경제상태	☒ 안정 ☐ 불안정	☐ 연금생활 ☐ 생활보호	☐ 기타()		
동거인	☒ 독거 ☐ 부부	☐ 부모 ☐ 자녀	☐ 기타()		

○ 판단근거

- 기혼자이나, 약 15년 전 배우자 사망하여 독거로 생활 중
- 2남의 자녀가 있으나, 차남은 약 15년 전 사망하였으며 월 1회 이상의 빈도로 장남내외가 방문

○ 주요 문제 및 욕구

- 특별한 경제적 어려움 호소하지 않음
- 사망한 가족(배우자, 차남) 이야기를 할 때에 소극적으로 표현하는 면이 있으나, 이로 인한 우울증세 등 관찰되지 않음
- 주 보호자인 자녀내외가 월 1회 빈도로 수급자에게 방문하나, 일정이 어려운 경우도 있음
- 타지에 거주하면서 지속적인 수발도움을 주어야 하는 것에 대한 일정부분 어려움 호소함

차. 사회관계 및 사회적지지 실태

※ 표기: □에 표시 후 상세내용에 기술

구 분	확 인			
외출빈도	☐ 일 1회 이상	☒ 주 1회 이상	☐ 월 1회 이상	☐ 기타()
외출 동행인	☐ 혼자	☐ 가족	☐ 기타(이웃, 친척, 가족 등)	
외출 장소	☐ 마트	☒ 병원	☐ 공원	☐ 기타(마을회관 등)
사회적지지 자원	☒ 이웃	☒ 교인	☐ 기타()	
사회적 관계 고충	☐ 친척관계 갈등	☐ 친척관계 소원	☐ 친척관계 단절	☒ 해당없음
	☐ 이웃관계 갈등	☐ 이웃관계 소원	☐ 이웃관계 단절	☒ 해당없음

○ 판단근거

- 기독교 신자로, 교회에 방문하기 어려운 경우가 종종 있으며 매일 새벽(6am)마다 방에서 새벽기도를 하고 있음
- 이웃주민, 친척, 교인 등이 자주 방문하여 말벗을 해주며, 건강상태 악화 등 발생 시 가족(장남내외)에게 비상연락체계 유지하고 있음
- 고혈압, 당뇨 치매 등 가까운 3차병원 보호자(자녀) 동행하여 통원하여 진료
- 동네 친척들과 함께 관내 병원 통원하며, 주 1~2회 빈도로 재활/물리/작업치료 받고 있음

○ 주요 문제 및 욕구

- 독거로 생활하고 있지만, 이웃이나 친척 등 주변인과의 교류가 잦음
- 주변인과의 교류가 잦지만, 독거로 생활하면서 돌봄공백이 발생하게 되므로 공식적 자원 등을 활용한 돌봄공백 최소화 필요(보호자는 월 1회 이상의 빈도로 방문)

카. 공식적 자원 이용 현황

구 분	확 인
현재 기준 공식적 자원 이용 실태	- 동 주민센터 등 공적 서비스 이용내역 없음 - 마을 이장님 주관으로 관내 종합사회복지관에 독거세대로 현황파악 하고 있으며, 현재는 독거노인 세대 혹은 차상위/기초생활수급자 세대로는 선정되지 않아 사례관리대상자로 선정되지는 않음 - 65세 미만자로 1년 전 장기요양등급 인정받아 최근 1회 갱신하였으며, 방문요양서비스 이용 중

○ 판단근거

- 특별한 취미활동이 있지는 않으며, 혼자 있는 시간에 주로 자택에서 TV를 보며 일과를 보냄
- 보호자(가족)들의 치매에 대한 대처지식이나 교육이수내용 등 없으며, 치매안심센터 등 이용 가능한 공식적 자원에 대한 정보가 없음
- 동 주민센터, 지역 종합사회복지관 등 이용내역 확인되지 않으며, 해당 자원에 대하여 보호자(가족)들이 인지하지 않고 있음
- 장기요양등급판정 올해 최초인정 받았으며, 이전까지 인근에 거주하는 친인척들로부터 일부 일상생활에서 도움을 받음

○ 주요 문제 및 욕구

- 마을 이장님의 의뢰로 관내 종합사회복지관에 자원연계 시도하였으나, 65세 미만자에 경제상태 양호하여 사례관리 대상자 선정 등 불가(복지사각지대)
- 약 1년 전 마을 이장님 주관으로 보호자 등에게 제도 관련 안내하였으며, 보호자 동의 하에 장기요양등급 신청 및 인정받아 최근 1회 갱신하였음
- 현 기관에서 방문요양서비스 약 1년 째 이용 중

타. 수급자 및 보호자 개별 욕구

※ 표기: 서술형 작성

- 독거중인 수급자로, 보호자가 방문하기 어려운 시간대(평일 낮 등)에 방문요양서비스 희망(주야간보호, 시설은 아직 수급자/보호자(자녀) 모두 이용의사 없음)
- 현재 주로 가사도움, 병원동행 등 제공하고 있으며 병원진료 일부 날에 180분 이상 방문요양(480분) 희망함

파. 총평

※ 표기: 서술형 작성

- 62세 3등급 여성 수급자로 약 15년 전 배우자 사망하여 독거로 생활하고 있으며, 2남의 자녀가 있었으나 차남도 15년 전 사망하여 현재 1남의 자녀만 있음
장남 내외는 월 1회 이상의 정도의 빈도로 수급자에게 방문함
과거 개인사업을 운영하였으며, 현재에도 경제적인 어려움을 호소하지는 않음
- 7년 전 뇌출혈 발병하여 이후 우측 편마비 및 언어장애를 갖고 있으며, 6년전 혈관성 치매 진단받아 약물 복용 중
고혈압 및 당뇨 질환자로, 약물복용 및 주기적 병원통원으로 진단 및 관리받고 있음
변비증세를 보이거나 주기적으로 관장을 할 정도로 심각하지 않음
- 우측 편마비 증세가 있어 우측 상하지 등 전반적인 관절에 구축을 보이며, 지팡이를 붙잡고 보호자에게 부축을 받아 천천히 거동 가능함(실내에서 수발자가 없는 상황에서는 주로 무릎으로 기는 방식으로 이동함)
물리치료 등 수요가 있는 마을 친척들과 관내 병원에 통원하면서 재활, 물리, 작업치료 주 1~2회 빈도로 받고 있음
- 우측 편마비 질환자로 전반적인 일상생활 수행능력이 저하되어 있으며, 거동이나 일어나 앉기 등 대부분의 신체기능 활동에 부축도움이 필요함
몸 청결동작이나 옷 갈아입는데에 편마비증세로 어려움이 있으며, 대소변을 인지하여 스스로 화장실에서 대변을 주 1회 빈도로 처리하나, 요실금으로 주 3~4회 소변이 속옷에 새는 경우가 있음
좌측 상지를 움직여 식사동작 스스로 수행 가능하며, 당뇨식으로 식사를 함
- 시간 및 장소에 대한 지남력이 저하되어 현재 거주하는 곳이 자택이 아닌 과거에 살던 장소나 다른 곳이라고 대답하는 행동이 잦으며, 단기 기억력과 집중력 저하를 보임
- 언어장애로 완전한 문장으로 본인의 의사를 표현하기 어려워하며, 상대방의 말을 거의 대부분 알아들어 간단한 단어나 짧은 문장 혹은 신체표현 등으로 본인의 의사를 표현함
- 집성촌 거주 중으로 동네에 거주하는 가까운 친척들이 자주 방문하여 인간관계를 맺고 있으며, 마을 이장님이 장기요양 등급을 신청하도록 정보제공 해주는 등 보호자에 준하게 챙겨주고 있음
기독교 신자로 교회에 가기 어려우나 자택에서 매일 새벽기도를 하는 등 종교활동에 대한 참여의사가 높으며, 수발자가 없이 자택에서 혼자 보내는 시간 주로 TV를 보면서 보냄
이장님 주관으로 지역 종합사회복지관에 사례관리 등 도움을 줄 수 있는지 의뢰하였으나, 65세 이상 독거세대도 아니며 차상위/기초생활수급자 등 경제적 어려움을 호소하는 세대까지는 아니라 자체 사례관리 대상자로는 선정되지 않음
주기적으로 종합사회복지관에서 유선/대면상담을 하는 등 모니터링 관리중임
- 65세 미만자이나 노인성질환(뇌출혈, 치매)로 장기요양등급 인정되어 본 기관에서 1년째 방문요양서비스 기존 이용 중인 수급자 장기요양등급 상향조정은 없었으나 관절구축이 조금씩 진행되거나 신체활동능력, 일상생활능력이 조금씩 저하되는 것으로 보인다는 서비스 제공 요양요원의 소견을 들음
- 인지저하가 심하지는 않으나 이전 사정 시 보다 단기 기억력 등 일부 저하된 증세를 보이며, 따라서 독거로 거주하는 수급자이므로 기저질환(당뇨, 고혈압 등) 약물복용관리에 어려움이 예상됨
- 현재 주 수발자인 장남내외는 방문요양서비스 이용만 희망하고 있으며, 병원진료 동행을 하는 일부 날에 180분 이상 방문요양(480분) 방문요양 희망함(주야간보호, 시설이용 보호자/수급자 모두 희망하지 않음)

◆ 직접 작성해보기: ‘수급자의 욕구도출’

- 제시된 ‘사례개요’와 ‘욕구사정기록지’를 기반으로, 수급자의 욕구도출 실습

3 수급자의 생활상의 문제 또는 욕구 도출해보기

가. Case2의 상황(작성양식)

Tip!

다음과 같은 중항목을 고려하여 이용자의 상황 정리 가능

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| ① 신체상태(건강, 질병) | ② 일상생활수행능력 | ③ 인지상태 |
| ④ 의사소통능력 | ⑤ 전체적 하루일과 | ⑥ 생활에 대한 의지 |

○ 작성예시

- (신체건강상태) 뇌출혈 발병 후, 우측 편마비 질환자로 전반적인 관절에 일부 구축을 보임
요실금 증세 주 3~4회 빈도로 있음
- (일상생활수행능력) 편마비로 화장실 뒤처리, 몸 청결 등 동작에 어려움이 있음
실내거동은 지팡이를 짚어 천천히 가능하나, 외출동작을 원활히 수행하기 어려움
- (인지상태) 치매 질환자로 폭력행동이나 망상 등 심각한 행동변화를 보이지는 않으나, 단기기억력 등 일부 인지능력에 저하를 보임
- (의사소통) 뇌출혈 이후 언어장애를 겪고 있으며, 완전한 문장으로 자신의 의사를 표현하는데 어려움이 있으나, 상대방의 말을 이해하고 본인의 의사를 간단한 문장이나 몸짓 등으로 스스로 표현 가능함
- (하루일과) 종교활동에 대한 의사가 있으나 매년 교회에 방문하기 어려워, 매일 아침마다 자택에서 새벽기도를 함
독거세대로 생활하나 집성촌에 거주하여 인근에 거주하는 친인척들이 자주 자택에 방문하여 말벗이나 간단한 일상생활 도움을 줌
이외의 혼자 있는 시간대에는 주로 TV를 보면서 시간을 보냄
- (수급자 생활의지) 가끔 자신의 건강상태에 대한 신세한탄이나 푸념 등 표현하는 경우가 있으나, 기본적으로 재활에 대한 의지를 표출하며 대인관계에 대한 의지를 보임

나. Case2의 보호자(가족 등)의 상황(작성양식)

Tip!

아래의 중항목을 고려하여 제시

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ① 보호자의 케어 의지 및 스트레스 | ② 보호자의 건강상태 |
| ③ 보호자의 케어 지식과 기술 | ④ 가족의 케어 협력 상황 |
| ⑤ 보호자 외 조력자 유무 및 정도 | ⑥ 케어 외의 생활문제 유무 |
| ⑦ 보호자의 희망사항 | |

○ 작성예시

- (보호자 의지 및 스트레스) 배우자와 차남은 오래 전 사망하였으며, 현재 직계가족은 장남 내외만 있음
월 1회 빈도로 방문하는 등 보호자의 수급자 케어(수발)에 대한 의지가 확인됨
보호자 면담 시, 타지에 거주하면서 주기적으로 방문하여 수발도움을 주는 것에 대한 일부부담을 표현하기는 하나 심한 스트레스를 받지는 않으며 돌봄공백에 대한 걱정표현으로 보임
- (보호자 건강상태) 주 보호자인 장남내외의 나이는 40대이며, 신체/정신적 특별한 건강이상을 호소하지 않음
- (보호자 케어지식 및 기술) 치매 및 언어장애 등 질환자의 수발에 대한 기술/지식은 확인할 수 없으며, 단순 일상생활 도움을 주는 정도임
- (가족의 협력상황) 주 보호자인 장남내외가 타지에 따로 거주하고 있으나, 월 1회 빈도로 방문하여 수발도움을 주며 그 이상의 빈도는 사회생활 참여 등으로 어려움
- (보호자 외 조력자 유무 및 정도) 집성촌 거주 중으로, 인근에 거주하는 친인척들이 자주 방문하고 있으며 주로 말벗을 하고 간혹 병원동행 등 외출에 도움을 줌
지역사회복지관 등 지역자원 과거/현재 이용이력 없음
- (케어 외의 생활문제) 주거환경과 경제적으로 특별한 어려움을 호소하지 않음
- (보호자 희망사항) 현재 이용하고 있는 방문요양서비스 지속적 이용 희망하며, 요양원 등 입소 희망하지 않음

다. Case2의 공식 및 비공식 지원의 이용상황(작성양식)

Tip!

아래의 중항목을 고려하여 제시

- ① 과거 및 현재 이용 서비스
- ② 비공식자원(친족, 이웃, 종교)과의 관계·지원
- ③ 공식적 자원(보건소 등)과의 관계·지원

○ 작성예시

- (공식/비공식자원 과거/현재 이용현황) 기독교 신자이나 편마비 등으로 매년 교회에 방문함에 어려움이 있어 주로 자택에서 새벽기도를 수행하며, 인근에 거주하는 친분있는 신자들이 가끔 방문하여 말벗 등 관계 맺고 있음
마을 이장님 의뢰로 지역사회복지관에 사례관리 대상으로 의뢰하였으나, 독거노인 및 저소득층 등 대상에 해당되지 않아 사례관리대상으로 선정되지는 않았으며 종종 모니터링을 하는 정도로만 결정되어 현재 방문요양서비스 이용 중
- (비공식자원 관계) 교회에서 주기적인 도움을 받지는 않으며, 신도들과의 대인관계 유지 중
집성촌에 거주하여 친인척들이 자주 방문하여 말벗을 해주거나 간혹 재활치료 등의 목적으로 병원에 동행함
- (공식자원 관계) 동 주민센터, 지역사회복지관 등 지역사회자원 이용내역 없음
장기요양인정자로 방문요양서비스 이용 중

※ 작성내용 자가점검

항 목	점검 항목
초기상담의 충실성	○ 초기상담 시 수급자 및 가족의 건강 및 요양욕구를 비롯하여 다양한 욕구를 파악했는가? - 수급자의 가계도, 생활환경, 가족상황 등 - 다각적인 정보원을 활용하고 있는가? 이때 사례관리 수급자의 동의를 받았는가? - 비공식적 지지체계가 무엇이 있는지 지지수준에 대해서 확인했는가? ☞ 수급자의 주 호소에만 초점을 두지 않고, 방문요양기관의 서비스에 국한하지 않고, 수급자와 가족의 삶의 다양한 영역의 어려움을 탐색하였는가?

4 수급자의 문제 및 요구를 생활욕구로 전환하기

가. Case2의 생활욕구 도출하기(작성양식)

Tip!

생활욕구로의 전환은 구체적으로 무엇이 문제이고, 어떻게 하기를 원하고, 무엇 때문에 곤란한지를 명확하게 문장으로 기술
→ (예시) A하기 때문에 B가 힘들다, C 때문에 D가 곤란하다, 도출한 사항에 대해 전문가로서 사례관리자가 판단한
객관적인 필요도를 제시

○ 작성예시

- 우측편마비 등 신체기능 활용능력 제한으로 몸 청결, 외출 등 일상생활에 어려움이 있음
→ 신체기능 및 일상생활에 대한 수발도움 필요
- 일부 대인관계 유지하고 있으나, 언어장애 등으로 타인에게 자신의 의사를 원활히 표현하는 등 의사소통 및 대인관계에 일부 제한이 있음
→ 의사소통문제로 향후 사회성/자존감 등 저하될 우려가 있으며, 수급자에 대한 정서지원과 언어장애 질환자에게 맞는 대인관계훈련을 통해 자존감 향상이 필요
- 뇌혈관질환 병력이 있으며 현재 편마비질환자로, 지속적인 관절구축과 근력저하 등 예상됨
→ 관절구축 진행 예방을 위한 재활훈련 및 통원치료 지원 필요
- 독거세대로 이웃 및 친인척들이 자택에 방문하기는 하나, 돌봄공백 발생으로 위급상황 등 발생 시 빠른 대처에 제한이 있음
→ 방문요양서비스 이외의 지역사회자원 연계 필요

※ 작성내용 자가점검

항 목	점검 항목
욕구사정의 충실성	○ 대상의 잠재적인 욕구와 표현된 욕구를 구분하였는가? - (잠재적 욕구) 상식적 혹은 사회적 삶의 기대수준과 현재 상태의 차이로 나타난 결핍 혹은 부족한 상황을 자원이나 서비스를 통해 해결 혹은 충족되어야 할 필요성 - (표현된 욕구) 수급자가 자신의 문제해결 혹은 욕구를 충족하는데 도움이 된다고 믿고 있거나 가능한 방법이라고 알고있어서 도움을 요청하는 내용 ○ 표현된 욕구 이외의 욕구가 있는지 고려해보고 검토하였는지?

나. 도출 생활욕구 중 우선순위가 높은 욕구를 3개 제시하고, 목표 수립하기(작성양식)

Tip!

중장기목표 설정은 사례관리를 통해 달성하고자 하는 최종적인 변화내용을 표현하되, '수급자(수급자)의 언어'로 기술
단기목표 설정은 중장기목표를 향해가는 사례관리의 과정에서 기대하는 변화내용을 표현하되, '사례관리자의 언어'로 기술

도출한 생활욕구 (우선순위 별 제시)	단기목표	장기목표

○ 작성예시

도출한 생활욕구 (우선순위 별 제시)	단기목표	장기목표
① 신체기능 지원 및 일상생활에 대한 수발도움	• 장기요양급여계약을 통한 방문요양 서비스 이용으로 원활한 일상생활 수행	• 일상생활에서의 낙상예방 및 안전한 환경 조성
② 대인관계에서 의사소통 문제로 사 회성/자존감 저하가 우려되며, 언 어장애 질환자에 적합한 대인관계 훈련 필요	• 정서지원 및 의사소통능력 훈련을 통한 대인관계능력 향상 및 정서적 지지	• 심리적 안녕 및 삶의 질 향상
③ 편마비증세 및 관절구축 악화에 대 한 재활치료 희망	• 일상생활에서 잔존기능 활용 및 재 활치료로 관절구축 예방	• 잔존기능 유지 및 악화 예방

※ 작성내용 자가점검

항 목	점검 항목
목표설정은 적합한가?	○ 욕구사정 내용에 맞춰 목표가 설정되었는가? - 욕구사정과 관련없이 목표가 설정되었는지 검토 필요 ○ 측정가능하고 실현가능한 목표가 설정되었는가?

5 장기요양급여 제공계획서

가. 장기요양급여 제공계획서(양식)

장기요양급여 제공계획서

장기요양기관명	00기관
장기요양기관기호	
급여종류	방문요양

수급자 성명		생년월일		계약일자	
장기요양 등급		장기요양 인정유효기간	00.00.00. ~00.00.00.	계약기간	00.00.00. ~00.00.00.
개인별장기요양 이용계획서 번호		급여적용기간		작성일	

목 표	방문요양	
-----	------	--

급여종류	장기요양 필요영역	장기요양 세부목표	장기요양 필요내용	세부제공 내용	횟수	시간 (분)	작성자
방문요양							

종합 의견	
-------	--

위의 급여제공계획에 대해 상세히 들었음을 확인합니다

20**년 00월 00일

동의자 (수급자와의 관계) (서명 또는 인)

「노인장기요양보험법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 수급자의 장기요양급여 제공계획서 내용을 국민건강보험
공단에 통보합니다

20**년 00월 00일

장기요양기관의 장(대표자): (서명 또는 인)

국민건강보험공단 이사장 귀하

나. 장기요양급여 제공계획서(작성예시)

장기요양급여 제공계획서						장기요양기관명	00기관
						장기요양기관기호	
						급여종류	방문요양
수급자 성명	Case2	생년월일	1960.00.00.	계약일자			
장기요양 등급	3	장기요양 인정유효기간	00.00.00. ~00.00.00.	계약기간	00.00.00. ~00.00.00.		
개인별장기요양 이용계획서 번호		급여적용기간		작성일			
목 표	방문요양	1. 잔존기능 유지 및 악화 예방 2. 낙상 예방 및 안전한 환경 조성 3. 심리적 안녕 4. 삶의 질 향상					
급여종류	장기요양 필요영역	장기요양 세부목표	장기요양 필요내용	세부제공 내용	횟수	시간 (분)	작성자
방문요양	신체활동지원	도움을 받아 개인위생관리, 신체적 잔존기능 유지 및 악화 예방	옷갈아입기 도움	상하의 끼우기, 단추 채우기 등 도움	필요시	00	
			세면도움	얼굴과 목, 손씻기 사용물품 준비 및 정리	일1회	00	
			양치질 도움	칫솔질, 입 행구기 등 도움	일1회	00	
			머리감기 도움	머리감기 및 말리기	필요시	00	
			손발톱깎기	손발톱깎기 및 정리	필요시	00	
		체위변경 기능향상	체위변경 지켜보기와 지도	혼자서 체위변경 가능한 부분까지 지켜보고 도움주기	필요시	00	
		낙상 예방 및 안전한 이동	보행 도움(부축, 지켜보기 등)	부축하여 안전하게 이동 도움	필요시	00	
		스스로 화장실 사용가능	화장실 이동도움	화장실 이동 및 뒷정리 등 도움	필요시	00	
		규칙적 약 챙겨먹기	정확한 시간 복용도움	시간에 맞추어 약챙겨주기 등 복용 도움	일1회	00	
		관절구축 예방	관절구축 예방 운동	실버체조, 근력운동 등	일1회	00	
	인지활동지원	인지기능 훈련을 통한 잔존능력 개발 및 유지	인지활동 프로그램	인지훈련도구를 활용한 일인지활동프로그램	주3회	00	
	정서지원	의사소통 능력 향상, 정서적지지	의사소통 도움(발음연습, 필담 등)	대화, 편지 등의 방법으로 수급자의 욕구파악 및 의사전달 대행 등	일1회	00	
			욕구파악을 위한 관찰(행동, 소리, 동작 등)	언어적 표현이 힘든 경우 욕구파악을 위한 관찰(행동, 소리 등)	일1회	00	

	일상생활지원, 환경관리	깨끗하고 위생적 환경조성 및 위험한 환경요인 제거, 도움을 받아 일상생활능력 향상	취사	식재료 준비, 밥짓기, 반찬준비, 설거지 등	필요시	00	
			세탁	수급자의 옷, 양말, 수건 등 세탁	필요시	00	
			청소 및 주변 정돈	수급자가 거주하는 방, 거실, 화장실 등	필요시	00	
	개인활동지원	도움을 받아 신체관리	외출 시 동행	외출 시 부축 또는 동행(대중교통 등 차량이용 포함)하고 책임귀가	주2회	00	
			병원 동행	병원 진료를 위한 외출 시 부축 또는 동행하고 책임귀가	필요시	00	
			산책동행(도움)	산책을 위한 부축 또는 동행하고 책임귀가	필요시	00	

종합 의견	- 65세 미만자이나 노인성질환(뇌출혈, 치매)로 장기요양등급 인정되어 본 기관에서 1년째 방문요양서비스 기존 이용 중인 수급자로, 장기요양등급 상향조정은 없었으나 관절구축이 조금씩 진행되거나 신체활동능력, 일상생활능력이 조금씩 저하되는 것으로 보인다는 서비스 제공 요양요원의 소견을 들음 - 인지저하가 심하지는 않으나, 이전 사정 시 보다 단기기억력 등 더 저하된 증세를 보임 따라서 독거로 거주하는 수급자이므로 기저질환(당뇨, 고혈압 등) 약물복용관리에 어려움이 예상됨 - 현재 주 수발자인 장남내외는 방문요양서비스 이용 희망하고 있으며, 병원진료 동행을 하는 일부 날에 180분 이상 방문요양(480분) 희망함 - 일방적인 수급자에 대한 도움보다는, 잔존기능을 최대한 활용하고 요양요원과 수급자가 서비스를 함께 진행하는 내용을 주로 하여 계획 수립함 - 대인관계에 대한 욕구가 다수 관찰되며, 이에 따라 산책활동을 하거나 외부활동을 하는 서비스 제공계획 수립하였고, 이에 따라 낙상예방을 위한 정확한 부축도움 등 제공이나 추가 복지욕구 활용계획 수립 필요함 - 의사소통능력, 인지기능, 관절구축 악화 예방을 위한 서비스제공이 필요하며, 향후 신체 및 인지건강상태 악화 시 급여제공계획 재수립 예정
-------	--

위의 급여제공계획에 대해 상세히 들었음을 확인합니다

20**년 00월 00일

동의자

(수급자와의 관계)

(서명 또는 인)

「노인장기요양보험법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 수급자의 장기요양급여 제공계획서 내용을 국민건강보험 공단에 통보합니다

20**년 00월 00일

장기요양기관의 장(대표자):

(서명 또는 인)

국민건강보험공단 이사장 귀하

6 사례회의기록지

- ◆ 직접 작성해보기: ‘사례관리 회의록’
 - 제시된 ‘사례개요’와 ‘욕구사정기록지’, ‘장기요양급여 제공계획서’를 기본으로, 사례관리 회의록 작성실습
 - 전제사항: Case2는 65세 미만자로 현 기관과 장기요양 최초급여계약 이후 1년 경과되어 2차 사례회의 진행 중이며, 욕구사정기록지는 기 작성되었음
 - 기관 내 종사자들(시설장, 사회복지사, 요양보호사 등)끼리 역할을 구성하여 직접 모의회의 진행 및 기록 해보며, 뒤의 작성예시와 기록내용 등 비교분석 등
 - ※ 본 장에서 제시된 내용은 각 단계별 사례관리작성 예시로, 표준 작성규칙으로 정형화된 것은 아님. 기관 및 수급자/종사자의 특성에 따라 응용하여 적용할 수 있음

가. 사례관리 회의록(양식)

사례관리 회의록							
회의명	Case2 사례회의(2차)		회의일자	2021.00.00.		회의시간	
수급자명	Case2	성별/나이	여/62세	생년월일	1960.00.00.	등 급	3
회의장소	기관 내 회의실		참가자	A(시설장), B(사회복지사), C(요양보호사), D(간호사)			
회의내용	1. 수급자 주요 현황 ○ 욕구사정기록지 참조 2. 사례관리 선정이유(문제점) ○ 3. 회의내용 ○ 4. 회의결과 ○						
회의 사진							

나. 사례관리 회의록(작성예시)

사례관리 회의록							
회의명	Case2 사례회의(2차)		회의일자	2021.00.00.		회의시간	
수급자명	Case2	성별/나이	여/62세	생년월일	1960.00.00.	등 급	3
회의장소	기관 내 회의실		참가자	A(시설장), B(사회복지사), C(요양보호사), D(간호사)			
회의내용	1. 수급자 주요 현황						
	○ 욕구사정기록지 참조						
회의내용	2. 사례관리 선정이유(문제점)						
	○ 기존 장기요양등급 인정자이며 최근 갱신하여 급여계약 연장을 위한 욕구 재사정 ○ 65세 미만 장기요양인정자로, 기존 다수 질환(뇌출혈, 치매, 고혈압, 당뇨 등) 보유자이나 독거로 생활하여 지속적 건강악화가 예상됨 ○ 최초 욕구사정 당시보다 일부 관절구축 진행이나 기억력 저하 등 인지/신체기능 저하상태가 서비스제공 요양요원을 통하여 확인되며, 추가 서비스제공 및 자원연계 필요성 파악 필요						
회의내용	3. 회의내용						
	○ 시설장: Case2 수급자는 65세 미만자이나 노인성질환 및 기저질환 다수 보유자로, 우리 기관 최초계약 이후 1년 경과되어 연장계약을 위하여 사례회의 대상으로 상정하였습니다. 지난 1년간 서비스제공을 직접 하신 요양요원께서는 수급자의 신체/인지상태 변화내용을 설명 부탁드립니다. ○ 요양보호사: 수급자에게 지난 1년간 방문요양서비스를 제공 하였다. 서비스 투입 당시에도 우측 상하지 대부분의 관절이 구축되었으며, 본인이 재활의지가 커 관내 병원에 통원하면서 재활치료를 받고 있으나 하지쪽에 구축이 비교적 더한 것으로 보이며, 거동에 필요한 도움도 조금씩 커지고 있다. 기존에 발목에 관절구축이 심하지 않아 우측 하지로 땅을 딛는데 큰 어려움을 갖지 않았으나, 최근에는 병원통원 등 외출을 할 때에 지팡이를 붙잡고 부축을 받아도 거동에 어려움을 호소한다. ○ 사회복지사: 수급자와 보호자의 동의를 구한 후, 장기요양 관련 복지용구로 휠체어를 대여하여 외출 시에만 이용하는 방법이 좋을 듯하다. 인지능력은 괜찮은지? ○ 요양보호사: 현재 과도한 행동변화를 보이지는 않으나, 단기기억력이나 지남력 등 인지저하가 서서히 진행되고 있다고 보인다. 금방 본인이 무슨 일을 했는지 깜빡하거나, 어떤 일 등에 집중하지 못하는 빈도가 지난 1개월 내 잦아지고 있는게 느껴진다. ○ 간호사: 수급자는 뇌출혈 병력이 있으며 고혈압 약물 복용자로, 인지저하가 지속적으로 진행된다면 주기적인 약물복용을 잇는 등 뇌혈관질환 재발 가능성이 보인다. 큰 달력에 약봉지를 붙여주어 날짜별로 약물 복용여부를 확인할 수 있도록 하는 등 약물복용지도가 필요할 것으로 파악된다. 또한 진단서 및 처방전 상 약물복용은 현재 과하지 않다고 보인다. ○ 사회복지사: 다음 달 모니터링 시, 기관에서 해당 자료 준비하여 요양요원과 함께 제공 및 교육하도록 하겠다. ○ 요양보호사: 1달 전 장기요양등급 갱신 결과 현재 등급(3등급) 유지하여 2년6개월의 인정유효기간 판정을 받았으나, 인정유효기간 내 등급 변동 가능성이 예상된다. 추가 질환 발병이나, 신체/인지능력 저하가 심해질 시 보호자와 면담하여 등급변경신청도 고려해야할 듯 하다. ○ 사회복지사: 요양요원의 급여제공기록 작성 시, 변동내역 등 발생한다면 기재 바란다. 수급자의 대인관계는 최근 어떠한지? ○ 요양보호사: 장남내와는 월 1회 이상의 빈도로 거의 매주 방문을 하며, 동네에 친인척들이 많아 방문						

	하는 지인이 굉장히 많은 편이다. 과거 다녔던 교인들이 방문하는 경우도 잦다. ○ 시설장: 수급자도 재활에 대한 의지와 대인관계에도 지속적 관심을 보이는 것으로 보아, 자존감이 상하지 않도록 잔존기능을 최대한 활용한 일상생활 도움을 주었으면 하며 혹시 기관 내에서 연계가능한 자원이 한계가 있을 시 공단이나 지자체로 서비스 문의를 할 수 있도록 하겠다. 4. 회의결과 ○ 방문요양서비스 지속 제공 ○ 병원통원 등 외출을 위하여 복지용구(휠체어) 추가 대여이용 가능할지 보호자 의사 확인 후 급여계약 ○ 신체/인지기능 일부 저하를 보여 진행경과에 대한 지속적인 모니터링 필요하며, 기능저하가 심해질 시 욕구 재사정하여 등급변경신청 필요성 확인 ○ 신체/인지 잔존기능을 최대한 활용한 도움으로, 자존감을 배려하며 추가 기능저하 예방 ○ 수급자 대인관계능력 향상을 위한 지역사회 자원 검색	
회의 사진		

7 사례관리 모니터링 업무수행 일지(양식)

프로그램관리자 및 사회복지사 업무수행 일지

수급자 성명	Case2	장기요양 등급	3	장기요양 인정번호	L000	수급자(보호자) 성명(인)	
						관리책임자 성명(인)	

○ 서비스 이행 및 목표 성취 정도 평가

단기목표	서비스명	서비스 기 간	횟 수	기관 / 담당자	점 검 방 법	이 행 여 부	변 경 내 용	변 경 사 유	목표 성취정도
신체활동지원	도움을 받아 개인위생관리, 신체적 잔존기능 유지 및 악화 예방	1년	필요시		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3
	체위변경 기능향상	1년	일1회		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3
	낙상 예방 및 안전한 이동	1년	일1회		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3
	스스로 화장실 사용가능	1년	필요시		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3
	규칙적 약 챙겨먹기	1년	필요시		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3
	관절구축 예방	1년	필요시		현 장	이 행			☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3
인지활동지원	인지기능 훈련을 통한 잔존능력 개발 및 유지	1년	필요시		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3
정서지원	의사소통 능력 향상, 정서적지지	1년	필요시		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3
일상생활지원, 환경관리	깨끗하고 위생적 환경조성 및 위험한 환경요인 제거, 도움을 받아 일상생활능력 향상	1년	일1회		현 장	이 행			☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3
개인활동지원	도움을 받아 신체관리	1년	일1회		유 선	이행중			☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

욕구사정	① 신체상태	우측편마비 상태로 전반적인 신체기능, 일상생활능력에 도움이 필요하며 지팡이를 붙잡고 부축을 받아 거동 가능	
	② 질병	뇌출혈, 혈관성 치매, 고혈압, 당뇨, 변비	
	③ 인지상태	장소 및 시간 지남력, 단기기억력 저하를 보이며 언어장애	
	④ 의사소통	청취능력에 저하를 보이지는 않아 상대방의 말을 대부분 이해하며, 언어장애로 간단한 단어나 짧은 문장을 통하여 본인의 의사를 표현함	
	⑤ 영양상태	좌측 상지를 활용하여 스스로 식사를 하고 있으며, 당뇨식으로 식사를 하고 있음	
	⑥ 가족 및 환경	기혼자이며 2남의 자녀가 있었으나, 배우자와 차남 약 15년 전 사망하였음 주 보호자인 장남내외가 월 1회 이상의 빈도로 방문 집성촌에 거주하여 주변 친인척과 이웃들이 자주 방문함	
	총 합	65세 미만자이나 노인성질환(뇌출혈, 치매)로 장기요양등급 인정되어 본 기관에서 1년째 방문요양서비스 기존 이용 중인 수급자로, 장기요양등급 상향조정은 없었으나 관절구축과 신체활동능력, 일상생활능력이 조금씩 저하 중 인지저하가 심하지는 않으나, 이전 사정 시 보다 단기기억력 등 일부 저하된 증세를 보임 따라서 독거로 거주하는 수급자이므로 기저질환(당뇨, 고혈압 등) 약물복용관리에 어려움이 예상됨	
급여제공 계획	급여목표	신체기능상태 악화방지, 지원을 통한 수단적 일상생활 활동의 수행, 인지 기능 저하 예방 및 잔존능력 유지, 병원이동 등 외출도움	
	필요 급여내용	옷 갈아입기 도움, 세면 및 목욕 등 몸 청결동작 도움, 체위변경 및 보행 등 신체기능활동 도움, 화장실 이용 도움, 관절구축 예방, 인지기능 잔존능력 개발 및 유지, 정서지원, 외출 및 병원동행 등 개인활동 지원	
	제공방법	급여제공 시 수급자의 자존감 보호를 위하여 잔존기능을 최대한 활용하며, 충분한 배려가 필요 향후 건강상태 변동이 예상되는 수급자로, 신체 및 인지상태에 대한 모니터링 필요	
인지활동 프로그램 제공 계획	인지자극	필요내용	-
		제공방법	-
	신체능력 잔존·유지	필요내용	-
		제공방법	-
보호자 상담			현재 주 수발자인 장남내외는 방문요양서비스 이용만 희망하고 있으며, 병원진료 동행을 하는 일부 날에 180분 이상 방문요양(480분) 방문요양 희망함
욕구변화	내 용	별도의 욕구변화 없음	
	평가 및 조치	욕구변화 관찰되지 않으며 장기요양등급 동일등급으로 갱신인정 되었으나, 신체/인지기능에서 최초 욕구사정(서비스 제공 시작시점)보다 일부 저하가 관찰됨 수급자 상태변화에 대하여 요양요원/사회복지사가 지속적인 모니터링 계획이며, 현저한 상태변화 발생 시 보호자의 동의를 얻어 병원진료 및 등급 변경신청 추진 예정	

서비스 제공자에 대한 평가	사회복지사	월 1회 이상 유선/방문 모니터링으로, 서비스 제공계획에 대한 이행여부 유선/현장 확인예정 방문요양서비스 이용중이며 인근에 거주하는 친척, 이웃들이 자주 방문하 기는 하나 독거세대로써 일부 발생하는 돌봄 공백을 채울 수 있는 지역사 회자원 탐색
	요양보호사	매 180분 방문요양서비스 제공에 대한 서비스 제공일지 작성 점진적인 수급자 상태변화가 예상되므로, 서비스 제공내용 및 회수와 더불 어 수급자의 상태/특징변화 중심의 내용 성실히 기재
급여 및 인지활동 프로그램 제공 확인	확인내용	
	조치사항	
	급여제공자 성명(인)*	
방문(상담)일시		. . . (: ~ :)
방문장소*		수급자 자택
급여제공 중 방문여부*		○
방문불가 사유*		
방문자 성명(인)		

8 사례관리 종결보고서

◆ 직접 작성해보기: ‘사례관리 회의록’

- 앞에서 제시된 서식들을 기본으로, 사례관리 종결보고서 작성실습
- 전제사항: Case2는 현 기관에서 약 3~4년 간 장기요양서비스(방문요양 등) 이용하였으나, 건강증세 약화 등으로 등급변경하여 요양원 입소로 보호자(가족) 의사결정 완료됨
- 전제사항을 기본으로 사례관리 종결보고서 기록해보며, 뒤의 작성예시와 기록내용 등 비교분석 등

※ 본 장에서 제시된 내용은 각 단계별 사례관리작성 예시로, 표준 작성규칙으로 정형화된 것은 아님.
기관 및 수급자/종사자의 특성에 따라 응용하여 적용할 수 있음

가. 사례관리 종결보고서(양식)

장기요양 인정번호	L0000		수급자명	Case2	종결평가 일자	23.00.00.
종결평가 담당자			소 속	00재가복지센터	연락처	000-000-0000
요 청 일 자	인 적 정 보	육 구 조 사	사례회의	제공계획	서비스 점 검	종결평가
'23.00.00.		'22.00.00.	'23.00.00.	'22.00.00. ~'23.00.00.	'23.00.00. (매월 1회)	'23.00.00.
장기성과 목표						
연 번	목표내용		성과구분	성과내역		
1	잔존기능 유지 및 향상					
2	낙상 예방 및 안전한 환경 조성					
3	심리적 안녕					
4	삶의 질 향상					

단기성과 목표			
연 번	목표내용	성과구분	성과내역
1	신체활동지원		
2	인지활동지원		
3	정서지원		
4	일상생활지원, 환경관리		
5	개인활동지원		
사례관리자의 견 (담당자 의견)			
보호자(가족) 변 화			
종결평가 의견 (특이사항 /사후관리)			
종결평가 결과		☐ 재조사(사정) ☒ 종결	
종결 유형		☐ 장기목표 달성 ☐ 단기목표 달성 ☐ 상황호전() ☐ 거절이나 포기() ☐ 연락두절 ☐ 이사 또는 사망 ☒ 자체종결	

나. 사례관리 종결보고서(작성예시)

장기요양 인정번호	L0000		수급자명	Case2	종결평가 일자	23.00.00.
종결평가 담당자			소 속	00재가복지센터	연락처	000-000-0000
요 청 일 자	인 적 정 보	육 구 조 사	사례회의	제공계획	서비스 점 검	종결평가
'23.00.00.		'22.00.00.	'23.00.00.	'22.00.00. ~'23.00.00.	'23.00.00. (매월 1회)	'23.00.00.
장기성과 목표						
연 번	목표내용		성과구분	성과내용		
1	잔존기능 유지 및 향상		4	최초 장기요양인정 받아 현 기관에서 방문요양서비스 제공하였으며, 서비스제공 기간 동안 잔존기능을 최대한 활용한 서비스 제공으로 잔존기능 향상은 어려웠지만 기능유지 확인됨 금년 초 뇌출혈 재발병으로 병원 입원기간동안 보호자(자녀) 유선상담 결과, 이전에 비하여 관절구축 및 인지저하가 매우 심해졌으며 퇴원 이후 자택에서 서비스 제공 시 수급자 신체/인지기능 현저히 저하되었음을 확인함 해당 내용들은 서비스 제공기간동안의 잔존기능 저하는 아니며, 질병(뇌출혈) 발병으로 인한 잔존기능 저하이므로 서비스 제공 성과 4점 책정함		
2	낙상 예방 및 안전한 환경 조성		5	편마비 등 신체기능 저하가 있는 수급자로, 낙상예방을 위하여 수급자 상태에 맞는 복지용구(지팡이, 안전손잡이, 휠체어 등) 사용방법 등 안내하여 실내이동 시 불편함이 없도록 환경 조성하였음 지팡이를 붙잡고 수발자의 부축도움으로 거동이 가능하나, 실외 외출 시 어려움을 표현하는 경우가 있어 주로 휠체어로 이동하였음 병원통원 등 대부분의 경우에 요양요원이 동행하여 낙상 예방을 하였고, 보호자에게도 수발도움방법 안내하여 서비스제공 기간 내 낙상으로 인한 사고 발생하지 않도록 예방함		
3	심리적 안녕		5	보호자 외에 인근에 거주하는 친인척, 이웃들이 자주 방문하여 정서지원을 해주었고, 요양요원과의 라포형성도 원활하게 이루어져 독거세대에서 발생할 수 있는 우울감/고독감 예방함 언어장애로 의사소통에 어려움을 가질 수 있어 필담을 할 수 있도록 메모장을 상시 준비해두었고, 자주 사용하는 단어나 짧은 문장을 카드로 준비해주어 직접 발화하는 행동을 꾸준히 연습하고, 발화가 잘 되지 않을 때에 단어카드로 의사를 표현할 수 있도록 지원하여 언어장애로 발생 가능한 자존감 저하 예방함		
4	삶의 질 향상		4	방문요양서비스 제공으로 인한 돌봄 공백 완화와, 일상생활, 정서적 지원 등으로 수급자 만족도 상승 의사표현 확인하였으며, 보호자도 상시 연락가능한 비상연락망 구축에 대한 만족도 확인함 다만 독거생활로 발생하는 일부 공백에 대한 한계가 있음		

단기성과 목표			
연 번	목표내용	성과구분	성과내역
1	신체활동지원	4	잔존기능을 최대한 활용하여 옷 갈아입기, 목욕 및 양치질 등 몸 청결동작 지원하여, 큰 신체기능저하를 예방함 다만 우측 편마비 질환자로, 최초 서비스 제공 시작시기에 비하여 관절구축이 완화되지는 않았으나, 구축정도가 진행되지 않아 성과 4점 책정
2	인지활동지원	5	치매질환이 있는 수급자이나, 단기기억력 등 일부 인지저하 외에 망상/환시 등 행동변화 보이지 않음 방문요양서비스 제공 시 일부시간 인지자극 등 시간 배정하여 서비스 제공 최초 서비스 제공 당시와 비교하여 확연한 인지저하 보이지 않음
3	정서지원	5	언어장애로 일부 의사소통에 어려움을 가지나, 지속적인 의사소통연습과 단어카드 활용 등으로 본인의 의사를 어렵지 않게 표현 가능함 친인척 및 이웃 등 자택에 방문하는 지인들이 많으며, 방문자들과의 의사소통에서 일부 어려움이 있으나, 의사소통방법 안내 등으로 자존감 하락 등 예방함
4	일상생활지원, 환경관리	5	세탁, 청소, 취사 등 지원으로 수급자가 생활하기에 안전하고 위생적인 환경 조성 마련함 일반적인 도움을 주기보다는 좌측 상하지 등 잔존기능을 최대한 활용하여 가능한 범위에서 일상생활을 함께 수행하도록 안내하여, 요양요원이 방문하지 않은 때에도 스스로 일상생활을 수행하려는 적극적인 태도 확인함
5	개인활동지원	4	산책 등 외출에 대한 수급자의 욕구표현이 확인되며, 가능한 범위 내에서 산책 및 외출에 도움을 주어 만족도 표현함 또한 외출, 병원, 산책 동행 시 복지옹구 활용, 부축도움 등 낙상에 대한 예방 철저히 하여 낙상사고 발생하지 않도록 노력하나, 단독으로 잦은 외출에 어려움이 있어 성과 4점 책정
사례관리자의 견 (담당자 의견)		장기요양등급 최초인정 이후 약 3년간 현 기관에서 방문요양서비스 제공하였음 최초 서비스제공 당시에 비하여 관절구축 진행 등 일부 신체기능저하를 보이기는 하지만, 현저한 변화를 보이지는 않기에 성과구분 신체기능/개인활동지원 4점, 이외의 영역 5점 책정함 다만 근래(금년 초) 뇌출혈 재발병으로 약 3개월간 병원 입원하였으며, 보호자 증언에 따르면 우측 편마비가 다소 진행되었으며 인지저하 또한 심하게 되었음이 확인되고 밤에 잠을 이루지 못하며 소리를 지르는 등 행동변화 확인됨 이후 자택으로 복귀하여 서비스 제공 당시에도 질환 발병 이전에 비하여 일상생활 수행능력 현저히 저하되었음을 확인함 이후 공단에 요청하여 등급변경신청 진행하였고, 2등급으로 등급상향 인정되어 보호자(자녀)로부터 독거로 생활하기보다는 요양원 입소 희망의사 있음을 확인, 보호자 거주지역과 인접한 시/군/구에 요양원 입소하기로 의사결정함 공단 문의하여 장기요양기관 평가등급 등 확인 방법 문의하였으며, 노인장기요양보험 홈페이지를 통하여 기관조회방법 보호자에 안내하였고 해당지역 관할 국민건강보험공단 지사로부터 장기요양기관 목록 제공받을 수 있음을 보호자에 안내함	

보호자(가족) 변 화	수발환경이 어려워 부득이 독거로 거주하는 수급자에 대한 걱정을 일부 갖고 있었으나, 방문요양서비스 이용하면서 이에 대한 보호자 불안/걱정 일부 해소됨 수급자 언어장애에 대한 의사소통방법 명확히 알지 못하여 일방적인 수발도움만 주는 경향이 있었으나, 언어장애를 가진 상대에 대한 의사소통방법 숙지하게 되었고 나아가 치매/언어장애에 대하여 보호자가 탐색하는 태도 확인됨
종결평가 의견 (특이사항 /사후관리)	뇌혈관질환(뇌출혈)로 인하여 급격한 건강상태 악화가 있었고, 보호자(자녀)로부터 온전한 돌봄을 받기 어려운 상태가 되어 요양원 입소로 결정되어 사례관리 및 서비스 종결 결정 보호자의 동의하에 향후 서비스 계약기관에 기존 서비스제공 및 수급자 상태 정보 제공하여, 서비스 변화에 따른 원활한 라포형성 및 수급자 욕구파악 등 지원
종결평가 결 과	☐ 재조사(사정) ☒ 종결
종결 유형	☐ 장기목표 달성 ☐ 단기목표 달성 ☐ 상황호전() ☐ 거절이나 포기() ☐ 연락두절 ☐ 이사 또는 사망 ☒ 자체종결

제 5 장



장기요양 사례관리 심화과정① (노인상담과 의사소통)

1. 노인상담의 이해	190
2. 노인상담과정	192
3. 의사소통기술	194
4. 효과적 의사소통을 위한 실제	196
5. 치매노인과의 의사소통	200



05

장기요양 사례관리 심화과정① (노인상담과 의사소통)

학습목표

- 노인의 특성을 이해하고 상담할 수 있다.
- 의사소통의 기본원리를 이해하고 효과적인 의사소통을 할 수 있다.

1 노인상담의 이해

가. 노인상담의 개념 및 필요성

노인은 수많은 정보와 다양한 생활양식에 대한 적응에 어려움을 겪고 있어, 건강하고 활기찬 노년생활을 위해 전문적 개입이 필요하다.

노화로 인한 기능저하, 질병 발생, 과거의 가족이나 지인과의 관계 약화, 가까운 이들의 죽음, 익숙한 환경의 변화 등으로 노인의 신체적·정신적 건강 뿐만 아니라 사회적 활동에서의 문제가 발생하지만 이를 혼자 극복하고 해결하기 어렵다. 노인상담을 통해 노인의 전반적인 어려움을 이해하고 노인의 욕구에 대한 중재를 제공함으로써 노인문제를 해결할 뿐만 아니라 예방하여 성공적인 노후생활을 보낼 수 있도록 할 수 있다. 특히 노인상담은 소외된 노인에게 일차적인 사회관계망 역할을 할 뿐만 아니라 노인의 잠재적 문제를 탐색하여 이를 해결할 수 있도록 지원하고, 노후생활에 필요한 정보와 지지를 제공하며, 노인의 가족에 대해서도 필요한 지지와 서비스를 제공해 줄 수 있으므로 그 필요성은 크다고 할 수 있다.

나. 노인의 특성

성공적인 상담을 위해서는 다음과 같은 노인의 특성을 고려해야 한다.

1) 노인은 경험의 폭이 넓다.

노인은 오랜 삶의 경험을 통하여 다양한 지식을 축적하고 있다. 그 중 삶의 변화에 대한 과정과 결과에 대한 경험은 상담에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 이는 상담에 긍정적인 영향을 미치기도 하지만 때로는 부정적으로 작용하기도 한다. 상담자는 유연한 대처와 전문적 능력을 발휘해야 한다.

2) 노인은 저항이 강하다.

노인의 경우 인생을 살면서 많은 경험을 하였기 때문에 때로는 상담자의 의도에 강한 저항을 보일 수 있다. 즉 노인은 경험적으로 축적한 지식과 다양한 삶의 변수를 통제하고 조절하는 방법에 대한 강한 개인적 신념을 가지고 있어서 이와 상반될 경우 강한 저항을 나타내기도 한다. 그러므로 문화적 차이, 가치관의 차이 등 상담과정의 저항을 민감하게 인식하고 해결해야 한다.

3) 노인은 상담자보다 나이가 많다.

노인상담의 경우 다른 대상자에 비해 나이가 상대적으로 많다. 상담자 입장에서는 노인이 자신을

압도할지도 모른다는 부담을 갖게 되어 노인에 대한 개방적 태도를 보이기 어려워진다. 반면에 노인의 경우 자신보다 삶의 경험이 부족한 상담자가 본인의 문제를 이해해주기 어렵다는 점에서 신뢰를 형성하지 못해 상담자와 대상자 간에 긴밀한 관계를 이끌어내기 어려울 수 있다. 그러나 상담자는 나이와 상관없이 전문가로서 대상자의 문제를 논의하고 전문적인 도움을 줄 수 있는 사람이라는 것을 염두에 두도록 한다.

4) 새로운 삶에 대한 의지와 변화욕구가 상대적으로 약하다.

노인은 자신의 여생이 얼마 남지 않았다는 인식과 신체적·경제적 제약 등으로 인해 새로운 도전에 대해 부정적으로 생각하는 경향이 있다. 즉 새로운 삶을 이루려는 생각보다는 현재의 삶을 이어나가기를 원하는 경우가 많아 변화의 유도가 어려워진다. 따라서 상담자는 노인이 가지는 특성을 충분히 파악하고 노인의 변화를 이끌어내도록 동기를 부여해야 한다.

5) 가족 및 보호자에 대한 의지가 약하다.

우리나라는 전통적으로 노인부양의 근간이 가족이었으나 최근 취업여성 증가, 평균수명의 연장으로 쇠약한 노인 증가, 고부관계나 정서관계 등에서 내포된 가족문제, 또한 노인이 자녀와의 별거를 희망하는 경우가 증가하고 있어 노인상담은 대개 노인가족의 희망과 무관하게 이루어지는 경우가 많다. 더구나 우리나라의 경우 가족문제를 외부로 노출하기 꺼려하는 경향이 있어 보다 깊은 차원에서의 문제 접근 및 해결에 어려움이 있을 수 있다.

6) 노인은 남은 삶에 의미를 부여하지 않으려 하고 죽음과 연결하려는 경향이 있다.

노년기에는 삶을 되돌아보며 정리해야 한다. 즉, 이 말에는 삶에 대한 평가와 더불어 삶을 마감한다는 의미가 있다. 노인에게 죽음은 긴박한 문제이며 노인상담에서는 죽음의 문제가 중요한 상담내용이 되기도 하고, 죽음 관련 상담이 아니더라도 죽음에 대한 강함 관심을 보이기도 한다. 노인은 죽음에 대해 각기 다른 태도와 평가를 보여주므로 상담자는 상담 중인 노인의 특성을 잘 파악할 수 있는 기회를 얻기도 한다. 그러나 죽음에 대한 노인의 의식적·무의식적 태도나 공포는 노인이 가지고 있는 현재의 문제 해결과 진전을 방해할 수 있다.

2 노인상담과정

노인상담은 일반적으로 관계형성, 사정, 중재, 종결의 4단계로 진행된다.

노인과 상담 중에 다음과 같은 노력을 통해 효과적인 상담을 이어나갈 수 있도록 해야 한다. 우선 노인의 신체적 변화에 대해 충분한 지식을 갖추어야 한다. 노인의 시력, 청력 등 감각기능 정도를 확인할 필요가 있다. 또한 노인의 사회적 특성, 가족관계, 인지기능이나 정서기능 정도를 충분히 파악하고 상담 동안 내제된 가족적·사회적 역할갈등 요소도 확인할 필요가 있다.

가. 관계형성단계

관계형성단계에서는 대상자인 노인의 상담에 대한 초기 불안과 거부감을 해소하고 상담의 핵심적 요소가 되는 전문적 관계를 형성해야 한다. 이 단계에서는 친화관계를 조성하고 대상자인 노인의 문제를 제대로 이해하며 상담의 진행방식에 대해 합의를 이루는 과정이 이루어진다.

어느 정도 긴장이 풀리면 노인이 자신의 문제를 이야기할 준비가 되어 있는지 확인한 다음 상담하러 온 동기를 파악하고, 현재 경험하는 문제가 어느 배경에서 발생하게 되었는지 확인함으로써 상담에서 실제로 초점을 맞추어야 할 문제나 증상을 더욱 명확하게 한다. 다음으로 그런 문제가 과거에는 어떠했으며 어떻게 해결했는지 등을 알아본다. 그리고 노인의 문제해결 의지와 동기를 확인한다. 노인에게 상담이 어떤 의미인지, 상담을 통해 무엇을 할 수 있고 노인에게 어떤 도움이 될 수 있는지, 그리고 상담을 통해 해결하고 싶은 다른 문제는 없는 지에 관한 이야기를 충분히 나누어야 한다.

이 단계에서 상담에 대한 비밀보장, 상담기관과 시간, 상담자의 역할 등에 대한 안내 등을 대상자에게 자세히 설명하고 동의를 구한다.

나. 사정단계

대부분의 대상자에게는 어떤 문제가 있지만 사정 단계에서 노인의 문제를 규명하기 위해서는 대상자가 호소하는 문제를 명확하게 이해해야 하며, 이를 위해 핵심이 되는 문제가 무엇인지 파악하는 것이 중요하다.

사정 단계에서는 전반적으로 노인의 신체적·심리적·사회적 기능이 포괄적으로 반영되어야 한다. 노인의 신체적 기능을 사정할 때는 전반적인 건강상태와 일상생활 활동능력에 초점을 두며, 심리적 기능 사정에서는 노인의 성격과 인지 및 정서기능에 초점을 둔다. 그리고 사회적 기능 사정에서는 노인이 주고받는 사회적 지원과 노인의 재정상태 및 사회활동 참여 정도 및 주거환경에 대해 사정해야 한다. 또한 사정에는 어떠한 요소 간의 상호연관성과 한 가지 영역에서의 기능 저하가 다른 기능에 영향을 미칠 수 있는 가능성도 고려해야 한다.

노인의 자원 사정에는 문제해결능력, 필요한 자원과 한계, 성격 등의 측면에서 강점과 취약점을 균형 있게 조사해야 한다. 또한 환경에 대한 사정 시에는 노인의 가족은 물론 친구, 친척, 이웃 등 사회지지 체계의 적절성, 부적합성, 긍정적 측면과 취약한 측면을 모두 사정해야 한다. 이러한 사정에서는 상담자의 경험과 직관에 의존하기 보다는 객관적인 자료수집을 위해 기존에 개발되어 있는 임상평가도구를 노인에 맞게 적절히 사용해야 하며 다차원적인 평가가 이루어져야 한다. 노인의 취약점과 강점을 균형 있게 조사하는 것이 중요하다.

다. 중재단계

중재 단계는 문제해결에 대한 계획을 구체적 행동으로 실천하는 단계이다. 이러한 중재활동의 적절성과 효과를 검토하기 위해 상담자는 중재와 동시에 그 과정을 평가해야 하며, 중재활동으로 인해 발생한 새로운 행동 유형과 태도 등이 노인의 일상적인 유형으로 자리 잡을 때까지는 일시적으로 혼란상태에 놓이게 된다. 따라서 상담자는 중재로 인한 변화가 고정되고 지속될 수 있도록 계속적으로 평가하면서 도움을 제공해야 한다.

라. 종결단계

종결은 급격히 이루어지기 보다는 일정한 과정을 거쳐 서서히 이루어지는 것이 바람직하다. 상담을 종결할 시기가 되면 일반적인 인간관계와 마찬가지로 노인은 그 동안 정들었던 상담자와 헤어지는 것에 섭섭해 하고, 상담자의 도움없이 스스로 자신의 일을 잘 해결할 수 있을까 하는 걱정과 의구심을 가진다. 노인에게서 이런 불안감이 느껴지면 상담이 완전히 종결되기 전에 이 점에 대해 충분한 논의를 진행해야 한다. 즉 상담과정의 여러 단계에서 일어난 변화의 종류와 내용을 재확인하고 요약하는 과정을 통해 종결에 대한 노인의 불안을 비롯하여 부정적인 정서반응을 조절하는 과정이 필요하다. 노인의 자율적인 판단과 결정을 허용하고 격려하는 상담자의 태도와 자세가 중요하다. 이런 과정을 점진적으로 거치면서 노인의 상담자의 도움 없이도 독자적으로 적극적인 삶을 영위할 수 있게 될 것이다

3 의사소통기술

의사소통이란 둘 이상 그 사람들 이상의 사실, 생각, 의견 또는 감정의 교환을 통하여 공통적 이해를 하고 대상자 측의 의식이나 태도 및 행동에 변화를 일으키는 일련의 과정이다. 의사소통이 이루어지기 위해서는 전달자, 전달하려는 메시지, 수용자가 있으며, 메시지는 언어적, 비언어적 기호가 있다.

의사소통이 이루어지기 위해서는 노인의 관심에 집중해야 하는데 이를 위해서 상담자는 노인의 생각과 감정을 충분히 듣고 느끼면서 노인의 입장을 이해해야 한다. 이러한 '경청'은 노인을 적극적으로 관찰하고 이해할 수 있도록 한다. 또한 노인에게 관심을 기울이는 것은 대상자에 대한 존중의 마음을 표현하는 것이다.

이 과정을 통해 노인은 마음을 열고 상대방과 감정적·정서적 관계, 다시 말하면 '신뢰관계'를 형성한다. 또한 자신이 갖고 있는 편견이나 고정관념을 넘어서 노인을 있는 그대로 받아들이는 수용적인 자세, 그리고 자신의 감정을 솔직하게 전달하고 상대방을 속이지 않는 성실한 태도가 필요하다.

처음 대화의 시작은 '일반적인 주제로 시작'하는 것이 좋다. 또한 노인이 자신이 하고 있는 주제를 선택하여 이야기하도록 격려하는 것도 필요하다.

'노인이 표현한 주요 생각을 다시 반복하는 것'은 노인의 말을 듣고 있다는 표현이며, 진술한 내용의 일부를 반복함으로써 노인이 중요한 내용에 집중하게 할 수 있다.

노인이 말에서 명확하게 표현하지 않거나 모호한 생각이 있다면 이를 확인하기 위한 방법으로 '대상자의 말의 의미를 명료하게 다시 묻거나 표현'하게 할 수 있다. 또한 '노인의 생각을 간략한 언어나 새로운 언어로 반복하여 표현하는 것'도 노인의 말을 경청하고 있으며 내용을 이해하고 있음을 표현하는 것이다. 노인이 모호하게 표현한 감정을 명확하게 하는 것으로 노인에게 내용보다는 감정에 초점을 두고 자신의 감정을 수용하고 인정하는데 도움을 줄 수 있다. 노인이 중요한 의미를 함축하고 있는 '내용에 초점을 맞추고' 그 내용을 구체적으로 표현하게 하는 것도 중요하다.

노인이 이야기하는 도중에 끼어들지 말고 계속 대화를 이어갈 수 있도록 "아, 예" 또는 "그렇군요"와 같은 지지적 언어반응이나 고개를 끄덕이는 등의 관심을 보여준다. 또한 질문을 한 후에는 대상자가 생각할 수 있는 시간을 주고 느긋하게 반응을 기다린다.

가. 언어적 의사소통

노인상담을 성공적으로 이끌기 위해서는 노인이 가진 특성을 이해할 필요가 있다. 노인은 신체적·경제적·심리적·사회적인 면에서 다양한 문제를 복합적으로 겪고, 이와 관련된 개인차가 적지 않게 발생하므로 노인의 개인적·상황적 특성을 고려해야 한다. 운동능력이나 인지기능 저하, 감각기능 감소로 인하여 정보를 얻는데 제한이 따르고, 이는 노인이 가진 문제의 해결에 만족스럽지 못한 결과로 이어지게 된다. 그러므로 원활한 의사소통을 위하여 충분한 사정을 통해 상황에 대한 효과적인 대응이 필요하다.

상담과정에서 질문을 할 때는 구체적이고 간결하게 하는 것이 좋다. 질문의 수도 대상자의 상황이나 성격 등을 고려하여 결정하도록 한다. 다그치듯 한 질문이나 너무 많은 질문을 연속해서 할 경우 대상자가 지칠 수 있다. 한 번에 2개 이상의 질문이 주어질 경우 노인은 마지막 질문만 대답하거나 일부 질문을 기억하지 못하는 경우도 있다. 또한 "예" 또는 "아니오"의 답변을 유도하는 폐쇄형 질문 보다는 대상자의 감정, 의도, 욕구를 드러낼 수 있는 개방형 질문을 선택한다. 감정을 다치게 하거나 공격적인 인상을 줄 수 있는 직접적인 질문을 피하고 완곡하고 유연한 표현을 사용하여 대상자가 긍정적으로 상황을 이어갈 수 있도록 한다.

나. 비언어적 의사소통

언어 이외의 머리를 끄덕이는 것, 주먹을 쥐는 것, 손가락을 돌리는 것, 한숨을 쉬는 것 등은 비언어적 행위로 표현하는 의사소통이라 할 수 있다. 특히 인지기능이나 감각기능이 저하되고 신체기능이 원만하지 않은 노인이 표현하는 비언어적 메시지는 언어적 메시지보다 더 많은 정보를 제공하기도 한다.

상담자와 대상자 간에 적절한 눈맞춤이 이루어질 경우 자기표현이 원활히 되고 있음을 의미하거나 과도한 눈맞춤은 불편감을 초래할 수 있고 시선을 다른 곳에만 두려고 하는 경우 상담에 집중하지 못함을 나타내는 것일 수 있다. 얼굴표정을 통하여 감정상태를 파악할 수 있으므로 대상자의 표정이 밝을 경우 상담자도 밝은 얼굴로 응하고, 대상자의 슬픈 표정에 상담자도 마찬가지로 슬픈 표정을 지어 대상자의 정서에 공감하고 있음을 전달한다. 머리를 약간 앞으로 기울이고 상체를 상대방 쪽으로 향하는 자세를 통하여 관심을 기울이고 있음을 알려주고, 적절한 신체적 접촉은 상호작용 촉진을 유도할 수 있다.

상담과정에서 노인의 이야기는 대개 반복적이고 길어지는 경향이 있다. 질문의 내용과는 별개의 사항이 첨가되기도 하고 때로는 이야기의 요지와 멀어지게 되며 같은 내용을 반복적으로 지속하기도 한다. 이런 경우 상담자는 분산된 초점을 요약하고 분명히 하며 상담을 일관된 방향으로 유도하고, 대상자에게는 이야기를 경청하고 있다는 확신을 주어 상담의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

4 효과적 의사소통을 위한 실제

가. 어르신들과 의사소통 시 관심을 전달하는 방법 6가지⁷⁾

표 5-1 관심을 전달하는 6가지 방법

• Smile [미소 짓기] • Forward [노인 앞으로 몸을 숙이기] • Eye Contact [시선 마주치기]	• Open [열린 자세] • Touch [신체 접촉] • Nod [고개 끄덕이며 수긍하기]
---	---

나. 의사소통 기법 적절히 사용

표 5-2 의사소통 기법

언어적 의사소통 기법	비언어적 의사소통 기법
• 경청(노인의 말에 귀 기울이기) • 공감(노인의 말에 공감하기) • 설명(간단하게 설명하기) • 질문 • 자기주장 • 자기공개 • 유머 농담	• 눈 맞춤 • 얼굴표정 • 목소리의 톤과 크기 • 신체움직임/자세 • 공간활용(장소): 거리

다. 의사소통 기본원리 적용

표 5-3 의사소통 예시

1. 얼굴을 마주 보고 눈 맞춤을 유지합니다. 2. 대화 시작 시 어르신의 이름이나 존칭을 부르며 대화를 시작합니다. (부드러운 어조로) “어르신~”, “OO 할머니~” 3. 어떠한 한 가지 문제로 계속 흥분 할 경우에 상황이나 말을 전환시킵니다. 그 이유는 노인들은 기억에 어려움을 겪기 때문에 쉽게 다른 주제로 전환할 수 있기 때문입니다. 4. 언어로 소통이 어려울 때, 비언어적 의사소통 방법을 사용합니다. 눈 맞춤, 얼굴표정, 신체 움직임 / 자세, 목소리 크기와 톤 5. 상대의 말을 경청하고 존중한다. 좋은 행동을 하는 등 때에 따라 칭찬 또는 지지, 격려를 즉각적으로 표현하는 것이 좋습니다. 6. 노인이 혼자 있도록 두지 않고, 자주 대화를 나누며 노인의 속도에 맞춰드립니다.
--

7) 문가비(2021). 노인 언어 및 의사소통 중재 가이드라인 제언: 요양시설 이용자 가족 대상 설문을 중심으로. 대구대학교. 석사 학위

라. 의사소통 개선방법

표 5-4 의사소통 개선방법(예시)

1. 노인과 대화를 시작하기 전에 먼저 주의를 집중시켜주는 것이 좋습니다. 이후 노인이 바로 쳐다보며 당신에게 주의를 집중하는지 확인 후 대화를 시작합니다.	
2. 노인에게 이야기할 때는 음성의 톤을 낮추고 억양을 부드럽게 하여 말하는 것이 좋습니다. 그 이유는 소리를 높이는 것을 화가 나 있다는 신호로 여겨질 수 있기 때문입니다. 적당한 크기를 유지하나 소리의 높이는 낮게 이야기하면 노인성 난청이 있으신 어르신이 듣기가 쉽습니다.	
3. 노인과의 대화 상황에서 주위를 산만하게 하는 소음이나 행동을 제거한 상태에서 의사소통을 하는 것이 좋습니다. 그 이유는 소음이 있거나 말하는 사람이 시선을 끌지 않으면, 노인이 대화 시 주의를 집중하기 어렵기 때문입니다.	
4. 노인의 주의를 집중시키기 위한 방법으로 얼굴 표정이나 손동작을 활용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 노인의 시선을 끌어야 하는 곳이나 물건을 손으로 가리킵니다.	
5. 노인에게 말을 할 때는 짧고 간단한 말과 단순한 문장, 구체적인 어휘를 사용합니다. 이때 대명사 사용은 하지 않는 것이 좋습니다.	
대명사	나, 너, 우리, 자네, 그, 그녀, 아무, 너희, 누구, 여기, 저기, 거기, 이것, 저것, 그것
나쁜 예	좋은 예
“지난 주 월요일에 목욕을 했으니까 오늘 목욕을 해야겠어요. 벌써 일주일이나 지났잖아요”	“오늘 목욕을 해야겠어요”
6. 이야기를 할 때는 노인에게 익숙한 단어(자주 사용하는 단어)를 사용 합니다. 노인이 말씀하실 때 적절한 단어를 생각하지 못할 경우에는 비슷한 표현을 사용하거나 관련된 단서를 제공하여 단어를 떠올릴 수 있도록 도와드리면 좋습니다.	
7. 노인께 질문을 할 때는 한 가지 내용만 물어보고, 질문은 정확하게 반복하여 들려드리는 것이 좋습니다. 이때 질문을 연이어서 하지 않으며, 필요 시 대답하는데 힌트를 주면 좋습니다.	
8. 노인께 어떠한 행동을 요구할 때는 한 번에 한가지씩만 요구합니다. 그 이유는 여러 가지를 이야기할 경우, 노인이 모두 기억하기 어렵기 때문입니다.	
나쁜 예	좋은 예
“목욕을 하신 뒤에 잠옷을 갈아입고 주무세요. 저는 가게에 잠깐 다녀올게요”	“목욕하세요”, “잠옷 입으세요”, “주무세요”
노인에게 너무 복잡한 말이다. 몇 가지를 동시에 하도록 할 경우 노인은 해야 할 일의 종류도 기억하지 못할 뿐만 아니라 일의 내용을 이해 하지 못하여 엉뚱한 행동을 할 위험이 있기 때문이다.	한 가지 과제가 끝나면 하나씩 제시한다.
9. 노인에게 교육을 할 때는 한 번에 한 단계씩 연습하는 것이 좋습니다. 앞서 설명처럼 한 번에 여러 가지를 기억하는 것은 노인에게 어려운 일이므로 무언가를 습득할 때는 한 가지씩 알려주는 것이 좋습니다.	
10. 노인께 이야기를 할 때는 천천히 말하고 응답할 시간을 충분히 기다려줍니다. 대부분의 노인들은 반응이 늦게 나타나기 때문입니다. 반응이 없을 경우 다시 반복하여 말하여 주는 것이 좋습니다.	
11. 노인의 말이 사실과 다르더라도 노인이 표현한 감정을 수용하고 공감해주는 것이 좋습니다.	
노인: (통화 하지 않은 상황) “오늘 우리 손녀한테 전화 왔어~” 가족: (웃으며) “전화 와서 너무 좋으시겠어요~”	
12. 노인의 생각이 잘못된 것이라도 가능한 긍정적으로 반응하고, 거부하는 태도를 보이지 않는 것이 좋습니다.	
13. 노인이 과거를 회상할 수 있도록 사람, 시간, 날씨, 장소 등의 기본적인 현실 상황을 인식시켜줍니다.	
(창을 가리키며) “오늘은 밖에 비가 와요” (시계를 보여주며) “지금은 5시예요” (달력을 보여주며) “오늘은 일요일이에요”	

(TV를 트로트 프로그램을 보고 있는 상황)
 가족: “저 사람은 누구예요?”
 노인: “음, 임웅영”
 가족: “트로트 가수 중에 누가 제일 좋으세요?”
 노인: “탁영”
 가족: “지금 무슨 노래를 부르고 있나요?”
 노인: “잔이야”
 가족: “같이 불러볼까요?”
 노인: (노래를 부른다)

이때, 노인이 기억을 떠올리기 어려울 경우 힌트를 주어 떠올릴 수 있도록 도와줍니다.

14. 노인과 의사소통을 할 때는 시각과 촉각 등 이해를 향상 시킬 수 있도록 다양한 감각을 이용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 그림, 사진, 문자 등 의 상징과 신체를 이용한 제스처를 이용하여 이해를 돕습니다.

마. 나의 의사소통기술

의사소통기술 척도는 일상적인 대화를 나누고 대인관계를 유지하는데 필요한 기본적인 대화기술을 사용하는 것에 어려움을 측정하기 위한 것임. 이 척도는 정신재활 연구소(손명자, 배정규, 1994)⁸⁾ 개발한 질문지로 총 30개 문항, 5점 Likert식 척도이며 하위요인으로는 언어적 대화기술(11문항), 비언어적 대화기술(7문항), 자기주장(8문항), 사고기술(4문항)의 4개로 구성되어 있으며 총점은 150점임(전체 점수가 높을수록 높은 의사소통기술을 가진 것으로 평가할 수 있음)

● 표 5-5 의사소통기술 척도

다음 중 자신의 생각이나 상황과 가장 가깝다고 생각되는 문항을 선택하십시오.

구 분	전혀 그렇지 않다.	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다
1. 나는 다른 사람과 대화할 때 상대방과 시선접촉을 적절히 유지한다.					
2. 나는 대화할 때 상황에 맞는 적절한 얼굴표정을 짓는다.					
3. 나는 대화할 때 상대방을 향하여 편안하고 바른 자세를 취한다.					
4. 나는 대화할 때 상대방과 적절한 거리를 유지한다					
5. 나는 대화할 때 상황에 맞게 고개를 끄덕이거나 적절한 손동작을 사용한다.					
6. 나는 대화할 때 상대방이 알아들을 수 있는 크기로 분명하게 말한다.					
7. 나는 대화할 때 자연스런 억양을 사용하여 적절한 빠르기로 이야기 한다.					
8. 나는 대화할 때 예절을 잘 지킨다.					
9. 나는 전화통화 할 때 예절을 잘 지킨다.					
10. 나는 대화하려고 할 때 상대방이 이야기 할 수 있는 상황인지를 먼저 살핀다.					

8) 손명자, 배정규 (1994). 정신장애인을 위한 좋은 대인관계, 새미래연구소.

구 분	전혀 그렇지 않다.	그렇지 않다	보통	그렇다	매우 그렇다
11. 나는 적절한 화제를 사용하여 대화를 잘 유지한다.					
12. 나는 대화를 마치려고 할 때 상대방의 이야기가 어느 정도 끝나기를 기다린다.					
13. 나는 상대방의 이야기를 들을 때 관심을 기울이고 집중한다.					
14. 상대방의 이야기를 들으면서 잘 이해되지 않거나 궁금한 부분이 있을 때, 상황에 맞는 적절한 질문을 한다.					
15. 나의 생각이나 감정, 견해 등을 이야기 할 때 상대방과의 친분을 고려해서 이야기한다.					
16. 나는 상대방의 행동을 보고 좋은 감정을 갖게 되었을 때 나의 좋은 감정을 솔직하게 표현한다.					
17. 나는 상대방이 나를 칭찬할 때 감사의 마음을 표시한다.					
18. 나는 내가 할 수 없거나 하기 어려운 일이 있을 때 다른 사람에게 도움을 구한다.					
19. 나는 상대방에게 요청할 때, 상대방이 나의 요청을 들어 줄 수 있는 상황인지를 먼저 살핀다.					
20. 나는 상대방이 무리하거나 부당한 요구를 할 때 거절한다.					
21. 나는 중대한 실수를 했을 때 상대방의 감정이 상하지 않도록 사과한다.					
22. 나는 상대방으로 인해 화가 날 때 화난 감정을 침착하고 단호하게 표현한다.					
23. 나는 다른 사람과의 관계에서 나의 생각이나 의견을 주장하고 싶으면서도 눈치나 체면 때문에 이야기하지 못하고 결국 후회하게 된다					
24. 나는 다른 사람과의 관계에서 상대방을 고려하지 않고 내 입장만을 생각하여 나의 요구를 지나치게 강조한다.					
25. 나는 다른 사람과의 관계에서 나의 생각이나 의견, 욕구뿐만 아니라 상대방의 생각, 의견, 욕구도 존중한다.					
26. 나는 대화할 때 다른 사람의 바람이나 욕구를 알아차릴 수 있다.					
27. 나는 다른 사람의 감정을 이해할 수 있다.					
28. 상대방 때문에 내 감정이 상했더라도 그것을 표현하기보다는 오히려 상대방의 감정을 상하게 하지 않으려고 조심한다.					
29. 나는 처음 본 사람이나 낯선 사람에게도 먼저 말을 걸면서 이야기하기를 좋아한다.					
30. 나는 자주 다른 사람의 부탁을 딱 잘라 거절하지 못한다.					

5 치매노인과의 의사소통

가. 치매노인과의 의사소통 특성

치매노인과 의사소통을 하는 것은 다른 사람과 의사소통을 할 때 필요한 공통적 특징을 기반으로 한다. 그러나 치매노인과 의사소통을 하려면 우선 치매의 특성을 잘 파악하고 있어야 한다. 치매노인과 의사소통을 하기 위한 기본적인 관점은 다음과 같다.

1) 개별화 관점에서 할 수 있는 것에 주목한다.

치매노인을 개인으로 파악하는 개별화의 원칙은 치매노인을 이해하는 데 매우 중요한 관점이 된다. 치매노인은 성별, 연령, 가족구성, 출신 지역의 기본 특성은 물론이고 치매의 원인질병이나 그 밖에 장애나 질병, 주거환경, 일상생활동작 및 수단적 일상생활동작 등에 따라 개인차가 있다. 또한 치매돌봄에서 개별화의 중요성은 치매노인이 지금의 생활이나 인생에서 치매를 어떻게 받아들이고, 어떻게 느끼고 있는지 치매인의 입장에서는 개별화의 관점을 갖는 것이다. 치매노인이 자신의 문제를 어떻게 느끼느냐에 따라 의사소통의 방법도 달라져야 한다.

또한 개별화는 치매노인이 할 수 있는 것과 강점, 장점에 초점을 맞추는 것이 중요하다. 치매돌봄은 할 수 없는 것에 중점을 두기 보다는 할 수 있는 것을 포함한 전체적인 시각에서 치매인을 파악해야 한다. 할 수 있는 것이나 장점은 신체적 측면에서 잔존 기능의 활용이라는 의미도 있지만, 치매노인의 의욕과 긍정적인 자세까지 포함한다. 치매노인과의 의사소통은 할 수 없는 것을 보완하는 측면 뿐만 아니라 할 수 있는 것이라는 긍정적인 측면을 활용하여 전체적으로 강화하는 방향성이 중요하다.

2) 치매노인이 주체가 되는 지원

대상자 본인이 과제 해결의 주체가 되는 대인관계의 기본적 관점은 비록 치매가 있더라도 자기결정을 지원한다는 실천을 구체적으로 실행하는 것이기 때문에 매우 중요하다. 이때는 최종적인 결과뿐만 아니라 그 결과에 이르기까지의 모든 과정을 중요하게 여기게 된다. 자기결정 과정이 지원자와의 신뢰관계가 뒷받침된 관계를 통해 수행되는 것이다. 이 관계는 적절한 의사소통을 시도하기 위한 기본 요소가 된다.

3) 신뢰를 바탕으로 하는 관계 형성

치매노인과 연결시켜 주는 관계는 치매돌봄의 필수적인 요소이다. 의사소통은 이 관계를 형성하기 위해서도 활용된다. 관계는 직접적인 관계로 치매노인은 수발자와의 관계를 통하여 스스로 과제를 해결하거나 욕구를 충족하게 된다.

치매노인이 수발자와 연결되어 있다는 느낌은 치매노인과의 의사소통에서 매우 중요한 의미가 있다. 즉, 치매노인은 수발자와의 관계성에 따라 자신이 있을 곳을 가질 수 있고, 또한 자신이 여기에 있다고 존재를 확인할 수 있다. 그것은 상대방의 관계 속에 자신이 있으며, 상대방에게 인정받는 것으로 존재를 확인할 수 있기 때문이다. 치매노인이 대상인 경우에도 수발자와의 관계를 통하여 자신의 존재를 확인할 수 있다는 것은 큰 의미가 있다.

4) 사회환경 속에서 치매노인의 파악하는 관점 갖기

치매노인을 상황속의 사람으로 파악하고, 그 지점에서 의사소통을 활성화 하는 것은 상담지원의

기본적 관점 중에 하나이다. 치매노인은 다양한 사회환경 속의 사람과 상호작용하여 관계하면서 살아가고, 시스템내에서의 사회관계는 신체 변화에 따라 크게 변화한다. 수발자는 사회환경의 맥락 속에 있는 사람으로 인식하는 것이 중요하다.

당사자인 치매노인에만 집중하지 말고 치매노인을 둘러싼 환경에도 눈을 돌려 활동의 범위를 확대시킨다. 최대한 치매노인이 받아들일 수 있는 생활방식을 찾는 것이 중요하며 이 과정에 치매노인과의 의사소통이 활용된다.

나. 치매노인과의 의사소통 기술

치매노인과 상담을 위해서는 의사소통 기술을 활용해야 한다. 대상자인 치매노인의 이야기를 듣고, 이야기를 전개하고, 치매노인의 잠재적 욕구를 깊이 들여다보고, 자기결정을 지원하는 모든 과정에서 전문적인 의사소통 기술이 활용된다. 또한 적절한 의사소통을 통해서 수용, 개별화, 비심판적 태도 등 대인관계의 원칙으로 대표되는 관계 형성을 위한 원칙이나 공감적 이해 등의 실천원칙을 수행한다.

● 표 5-6 치매노인과의 의사소통 기술(예시)

인지저하가 있는 치매노인을 위한 Vera 의사소통 방법

VERA 의사소통 방법은 '인정(Validation) - 감정(Emotion) - 안심(Reassurance) - 활동(Activity)'의 앞 글자를 따서 만든 의사소통 방법이다. 인간중심케어 모델과 인정요법의 영향을 받았으며, 개인을 중요시하며 개인이 가진 사고방식이나 주관의 의미가 있다고 보고 존엄과 긍정적 상호작용을 기반한 사회적 환경을 만드는 것이 목표이다.

VERA 의사소통 방법은 개인의 행동이나 말보다 현재 감정 상태에 더 중점을 둔다. 서비스 제공자는 대상자의 신체적 또는 감정적 요구를 탐색하고 어떠한 현실 직시형 화법이나 의학적 치료를 우선으로 두지 않는다. VERA 의사소통 방법은 다음 네 단계로 구성되어 있으며 실제 임상에서 적용하기 쉽게 구성되어 있다.

- ① 인정(Validation): 치매노인의 행동이나 말에 대한 설명으로써 대상자를 가치 있게 여기고 그들과의 상호작용에 방해가 되는 부정적이거나 도움 되지 않는 추측을 하지 않는 것
- ② 감정(Emotion): 비록 치매노인의 말이 적절하지 않더라도 말에 담겨 있는 감정의 내용을 이해하고 공감하는 것
- ③ 안심(Reassurance): 치매노인이 안전하다고 느낄 수 있도록 말하는 것
- ④ 활동(Activity): 의사소통을 통해 무엇인가를 하는 것으로 서로 연결되고 함께 하기 위해 또는 전환을 위해 수행하는 활동

다. 치매노인 의사소통 기본원칙⁹⁾

● 표 5-7 치매노인과의 의사소통 원칙

남들과 의사소통을 하는 것은 인간의 가장 기본적인 활동 중의 하나입니다. 하지만 치매가 진행되면 언어능력이 서서히 떨어지기 때문에 다른 사람과 대화를 나누고 정서적으로 교감하는 것이 차츰 힘들어 집니다. 치매노인을 돌보는 사람은 이러한 어려움을 극복하기 위해 의사소통의 기본 원칙을 잘 활용하는 것이 도움이 됩니다.

1) 의사소통은 마음을 주고받는 것입니다.

- 의사소통은 단순히 말을 주고받는 것이 아니라, 마음을 주고받으며 관계를 맺는 것이라는 사실을 기억하세요.
- 의사소통능력이 감퇴되더라도 감정은 오랫동안 유지됩니다. 언어능력의 장애가 심한 치매노인도 마음으로는 사랑과 행복을 느낄 수 있고, 이를 표정과 행동으로써 표현할 수 있습니다.

9) 중앙치매센터

- 2) 대화 내용은 간단명료하게 하는 것이 좋습니다.
 - 복잡하고 긴 내용은 한 번에 한 가지씩 구분해서 이야기하는 것이 좋습니다. 한 가지를 얘기한 후 잠시 기다려서 치매노인이 이해했음을 확인한 후에 다음 얘기를 하는 것이 좋습니다.
 - 질문을 할 때에도 한 번에 한 가지씩 묻는 것이 좋으며, “예”, “아니오”로 대답할 수 있도록 묻거나(“산책 다녀오실래요?”), 두 가지 중 한 가지를 선택하도록 묻는 것이 좋습니다(“커피 드실래요? 아니면 주스 드실래요?”).
 - 치매노인이 대화 내용을 잘 이해하지 못할 경우에는 잠시 기다렸다가 다시 한 번 얘기해 보세요. 그래도 이해하지 못한다면 표현을 쉽게 바꾸어서 얘기해 보세요.
- 3) 편안하고 조용하며 차분한 환경을 만들어 주세요.
 - 치매노인들은 긴장하지 않은 상태에서 의사소통을 더 잘할 수 있습니다. 그러기 위해서는 편안하고 차분한 환경을 만들도록 해야 하며, 의사 표현을 위해 애쓰는 환자에게 재촉은 금물입니다.
 - 주의를 산만하게 만드는 소리 및 요소들을 제거하세요. 치매노인은 불필요한 정보를 걸러내는 능력이 저하되어 있기 때문에 주변이 시끄럽거나 산만하면 이해하는데 더 어려움을 겪을 수 있습니다.
 - 너무 춥거나 더운 곳, 너무 어두운 곳, 불편한 의자나 자세 등이 모두 의사소통을 방해할 수 있습니다.
- 4) 말 뿐만 아니라 시선이나 표정, 행동도 중요합니다.
 - 치매가 진행되어 언어기능이 떨어질수록 환자는 비언어적 방법에 많이 의존하게 됩니다.
 - 대화를 할 때는 치매노인을 마주 보고 시선을 마주치며 얘기를 나눕니다. 상대방에게 관심을 기울이고 있음을 나타낼 뿐만 아니라 치매노인이 집중력을 유지하는 데에도 도움이 됩니다.
 - 대화 내용에 어울리는 표정을 짓고, 적절한 몸짓을 사용하세요. 환자가 대화 내용을 이해하기가 수월해 집니다.
 - 중요한 부분에서는 몸을 조금 앞으로 기울여 관심을 보이거나, 고개를 끄덕이거나 저으면서 대화에 적극적으로 반응하는 것이 좋습니다.
- 5) 귀가 잘 들리시나 확인하세요.
 - 우선 치매노인이 당신 목소리를 잘 들을 수 있는지 확인하세요. 노년에는 청력 저하가 매우 흔합니다.
 - 청력이 좋지 않은 노인은 높은 톤보다 낮은 톤이 훨씬 알아듣기 쉬우므로 목소리의 톤은 낮추되, 또박또박 정확하고 크게 말합니다.
- 6) 환자의 마음이 상처받지 않게 배려해 주세요.
 - 치매노인이 잘 표현하지 못할 때 재촉하거나 핀잔을 주기 보다는 환자를 격려하며 끈기 있게 기다려 주세요. 치매노인이 적절한 단어를 찾기 어려워하는 경우 힘겹게 단어를 기억해 내도록 내버려두기 보다는 당신이 직접 그 단어를 말해 주는 편이 더 좋습니다.
 - 치매노인이 틀린 단어를 사용하더라도 치매노인이 말하려고 하는 바를 이해하면 굳이 정확한 단어를 알려주지 않아도 되며, 불필요하게 잘못을 지적하여 자존심을 상하게 하지 않도록 조심해야 합니다.

- 치매노인이 무슨 말을 하는지 이해가 가지 않을 때에는 구체적인 설명을 요청하거나 손가락으로 물건을 가리켜보라고 부탁할 수 있습니다. “거기 이모쿠 좀 다오.”라고 할 때 무슨 뜻인지 이해할 수 없다면 “죄송하지만 이모쿠가 어떤 것인지 말씀해 주시겠어요?”하고 물어보고, “길다란 것”이라고 대답한다면 “그 물건을 가리켜 보세요.”라고 부탁할 수 있습니다.
- 때로는 치매노인이 말하고 있는 내용보다 표현된 감정이 중요할 때가 있습니다. 말하는 것 이면에 감추어진 감정을 살펴보세요. 말씨, 어조, 그리고 다른 행동들이 단서가 될 수 있습니다.



2021년도
사회복지사 교육교재



제 6 장



장기요양 사례관리 심화과정② (자원개발의 이해와 활용)

1. 자원개발의 필요성	206
2. 지역사회자원의 종류	206
3. 지역사회자원 개발	208
4. 지역사회연계를 위한 네트워킹	211
5. 지역사회자원의 관리	217



06

장기요양 사례관리 심화과정②(자원개발의 이해와 활용)

학습목표

- 자원개발의 필요성과 지역사회자원의 종류를 이해할 수 있다.
- 지역사회자원개발의 방법을 이해할 수 있다.
- 지역사회자원 연계를 위한 네트워크를 이해할 수 있다.
- 지역사회자원의 관리에 대하여 이해할 수 있다.

1 자원개발의 필요성

자원개발의 필요성은 사회적 필요를 충족시키기 위한 공공재가 한정되어있기 때문에 언제나 제기되는 문제이다. 자원은 한정된 반면에 수요는 언제나 공급을 초과하므로 자원은 부족한 상태에 놓여있게 되는 것이다. 사회복지기관과 같은 비영리단체들은 부족한 자원을 확보하기 위해 기업, 재단, 모금, 수익사업 등 다양한 외부의 기금원에 의존하고 있다.

사회복지조직이 부족한 자원을 마련하기 위해 정부, 재단, 기업, 교회, 개인 등 다양한 기금원을 찾아 나서고 있다. 이러한 제한된 자원의 문제는 복지조직들에게 ‘자원개발’이라는 과제를 제시하게 된 것이다. 효과적인 자원개발과 함께 개발된 자원의 효율적인 관리와 사용에 대한 책임성(Accountability) 문제가 제기되고 있다.

가정방문급여기관의 경우 서비스를 제공하고 있는 노인의 보건의료, 요양, 돌봄, 주거, 복지 등 다양한 욕구에 부합한 자원을 개발하여 연계한다면 지역사회에 기반하여 노인에게 대한 통합적인 장기요양서비스를 제공할 수 있게 된다. 특히, 지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)에서 추구하는 바와 같이 노인이 건강하게 지역사회 오래 거주하실수 있도록 하기 위해서는 지역의 다양한 자원을 개발하고 활용하기 위한 노력이 필요하다. 따라서 가정방문급여기관도 지역사회에 있는 다양한 돌봄자원을 개발하기 위해 노력할 필요가 있다.

2 지역사회자원의 종류

가정방문급여기관이 활용할 수 있는 지역사회자원은 노인들의 욕구를 충족시키고, 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 다양한 자원을 말하며, 기관이 제공하는 장기요양서비스 실천에 도움이 된다. 특히, 노인친화적 지역사회 자원은 지역사회에서 노인의 계속 거주를 지원하고 노인 친화적 지역사회를 조성하기 위해 필요한 모든 것을 포함한다.

지역사회자원은 인적자원과 물적자원 혹은 공식적 자원과 비공식 자원, 사회적 자원으로 구분할 수 있다. 물적자원은 노인의 욕구충족을 위해 필요한 정부 보조금, 기업이나 단체 협찬금, 시민기부금을 등 각종 현금이나 현물이며 인적자원은 관계기관 담당자, 전문가, 자원봉사자 등을 포함한다. 공식적 자원은 주민센터, 보건소, 소방서, 경찰서와 같은 공공기관 및 교회, 지역사회복지관, 기업 등 민간기관 등이다. 비공식적 자원은 가족, 친구, 이웃, 동료, 후원자, 자원봉사자 등이다.

노인들에게 필요한 지역사회자원을 소득, 주거, 보건의료, 요양·돌봄 등 필요한 욕구 영역별로 다음과 같이 구분해 볼 수 있다. 가정방문급여기관은 지역에 따라서 해당 자원을 발굴하여 목록화하여 서비스를 이용하고 있는 노인들의 욕구에 맞추어 제공할 수 있어야 한다.

●● 표 6-1 노인욕구별 필요한 자원

욕구영역	내 용
소득지원	공공부조, 연금급여 등 경제적 지원안내, 후원금 지원, 의료비 지원, 후원물품 연계 지원, 노인세대 결연
주거지원	케어안심주택·임대주택 등 주거지원, 주거환경개선지원, 이사지원
보건의료	방문진료·방문간호 등 방문의료서비스, 연계 의료기관, 약국, 보건소, 물리 및 작업치료지원
요양·돌봄	장기요양기관, 간병서비스 제공기관, 맞춤형돌봄서비스 제공기관, 건강운동교실, 안부확인 및 말벗지원, 독거노인 돌보미
노인복지서비스	(노인)복지관 여가문화교육서비스, 밑반찬 또는 도시락 지원, 노인보호전문기관, 목욕 및 이미용, 푸드뱅크
정신건강 및 심리·정서지원	치매안심센터, 자살예방센터, 심리상담센터, 정신의료기관, 정신건강복지센터, 알코올전문기관, 가족관계개선 및 치료시설
돌봄지원 인력 및 각종 지원단체	자원봉사자(자원봉사센터), 후원단체, 자원봉사단체, 종교단체, 사회공헌기업, 복지재단 등
문화·여가 및 사회참여	노인대학, 문화프로그램 제공기관, 노인일자리지원기관, 일자리 연계기관, 직업교육 및 훈련기관
법률적 지원	법률소송지원기관, 인권보호기관

3 지역사회자원 개발

가. 지역사회자원 개발

지역사회자원은 지역사회라는 지리적, 공간적 범주에 속하는 자원으로 지역성을 바탕으로 한다. 지역사회자원개발은 기관이 위치한 경우 정부, 기업, 재단 등 지역성과 상관없는 자원의 개발도 중요하지만 가장 중요한 자원중의 하나는 지역자원의 활용이다. 가정방문급여기관이 지역사회자원의 개발을 위해서는 다음과 같은 몇 가지 점에 초점을 두어야 한다.

- 1) 지역사회자원의 개발을 위해서는 지역자원의 조사가 이루어져야 한다. 지역에는 다양한 인적, 물적 자원이 있다. 기관에서 지역자원에 대한 사전 조사 없이 사업 전개 시 자원이 요구될 마다 자원을 구하는 경우 원하는 필요한 자원을 주어진 시간 내에 구하기 힘들다.
- 2) 지역의 기존 네트워크와 자원을 활용하도록 한다. 지역사회에는 이미 확보된 자원과 자원활용을 위한 네트워크가 형성돼있는 경우가 있다. 지역자원을 개발할 때 이들 기존 자원과 네트워크를 활용하면 쉽게 자원 개발을 할 수 있다.
- 3) 자원을 내용과 분야에 따라 분류하도록 한다. 자원은 크게 인적·물적자원으로 구분된다. 인적 자원은 의료, 교육, 법률 등 전문 분야와 일반자원봉사로 나누어 구분될 수 있으며 물적 자원은 업체와 물품 종류, 금액, 유효기간, 보관방법 등 물품의 성격에 나누어 분류되어야 한다.
- 4) 노인의 욕구에 기반한 자원을 개발하도록 한다. 지역사회의 자원은 기관이 서비스를 제공하고 있는 노인의 욕구와 연결될 때 개발이 용이하다.
- 5) 자원의 관리가 체계적으로 이루어져야 한다. 자원의 종류, 양, 자원의 필요 시기, 자원의 보관, 기부자 서비스 등이 체계적으로 이루어져야 한다.

나. 자원동원의 3가지 방식

가정방문급여기관이 지역사회자원을 동원하기 위한 효과적인 방식으로 다음의 3가지가 있다. 즉, 지역사회에 존재하는 사회복지 관련 단체와 같이 기존 조직을 활용하여 기관에 필요한 자원을 발굴하고, 지역주민의 활용을 위해 지역주민이 참여하는 집단조직을 적극적으로 마련하고 참여하도록 설득 한다. 주요 방법은 다음과 같다.

1) 지역사회 조직 및 구조를 활용하거나 강화하는 방식

● 표 6-2 지역사회 활용 및 강화방식

- 지역사회의 기존조직을 활용한다. 각종 시민단체, 전문가단체, 친목단체 등을 동원한다. 조직의 형태에 관계없이 이미 조직활동을 하고 있는 사람일수록 지역사회의 문제해결에 적극적인 가능성이 높다.
- 참여 가능성이 높은 조직과 만나서 동참할 것을 권유하며, 이해관계와 신념을 공유할 수 있는 조직을 발견하여 네트워크를 구성한다. 조직의 자율성을 지키면서 동등한 자격으로 참여하며, 공동의 목표를 강조한다.
- 지역사회 내 지도자를 발견하여 활용한다. 지역사회에서 존경받는 영향력있는 지도자를 발굴하여 협조를 구하면 주민들과 공감대 형성이 가능하다. 또한 갈등요인을 사전에 예방할 수 있는 효과도 있다.

2) 지역주민을 개인 차원에서 설득하는 방식

● 표 6-3 지역주민 설득방식

- 지역주민들을 만나서 그들이 느끼는 문제와 욕구를 확인하고 규명한다.
- 지역주민들이 참여에 소극적이거나 회피하는 경우, 원인을 찾아 극복한다.
- 주민들과 대화시 대화의 중심을 문제와 문제해결에 둬으로써 주민들의 주의를 환기한다.
- 지역주민들의 개인적 선호도를 적극 활용한다.
- 접촉이 개별적이고 직접적인 것이 되도록 노력한다.

3) 지역주민들이 적극적으로 집단활동에 참여하도록 동기부여하는 방식

● 표 6-4 집단활동 동기부여방식

- 주민들과 처음 대면할 때 최소한 모임의 목적에 동의하고 모임활동을 지지해준다.
- 모임참여에 대한 지속적인 동기부여를 해준다.

다. 지역사회 자원개발의 과정

지역사회 자원개발을 위한 과정은 다음과 같이 이루어진다.

1) 해결하고자 하는 문제를 규명하기

지역사회 구성원인 노인의 계속 거주를 위해 요구되는 것이 무엇인지, 무엇을 해결해야 하는지 명확히 하는 일이다.

2) 자원동원 목표 설정하기

해결해야 할 문제를 발견하면 관련하여 목적과 목표를 정한다. 문제를 보는 관점이 다양하듯, 문제해결에 있어서 목표와 방향도 다양할 수 있다. 이에 자원동원 목표 설정을 위해 지역사회 구성원들에게 긍정적인 가치를 주는 용어로 공감이 가도록 체계적, 구체적으로 설정한다.

3) 자원동원 계획수립하기

지역사회 인적, 물적, 사회적 자원을 최대한 동원해 활성화시킴으로써 지역사회의 역동성을 강화하고 상호교류를 촉진시키기 위해 구체적인 전략이 마련될 수 있도록 자원동원 계획 수립을 마련한다.

- 4) 자원을 활용한 실천하기
지역사회 자원개발과 동원 계획이 수립되면 성과 있는 수행을 위해 활동과정을 점검하고 지속적으로 격려하며 지지하면서 자원을 활용한다.
- 5) 활동 평가
자원을 활용한 실천활동에 대해 목적과 목표에 맞게 되었는지 평가를 실시하여 발전적인 방향을 모색한다.

라. 발굴된 자원의 목록화

가정방문급여기관은 지역사회에 존재하는 노인에게 필요한 자원을 가지고 있는 기관을 목록화하고 노인의 욕구에 따라 연계하기 위해 노력해야한다. 기관의 지역사회 자원 목록은 아래표와 같이 욕구구분, 자원명, 사업기간, 주요내용, 지원대상, 담당자 연락처 등을 자세히 기록해 둬으로써 활용이 편리하도록 해야 한다.

표 6-5 지역사회자원 목록표(예시)

기 관 명:							
욕구구분	번호	자원명	사업기간	내용	지원대상	담당자/연락처	비고
		취약계층 환자 물품지원	2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.	독거노인 등 보호자 부재 취약계층 환자에 대한 입원생활에 필요한 물품지원(기저귀, 물티슈, 비닐장갑 등)	독거노인 및 장애인 등 보호자 부재 취약계층		

4 지역사회연계를 위한 네트워킹

가. 지역사회자원 네트워크의 등장

가정방문급여기관의 지역사회자원 네트워크는 지역사회 내 노인돌봄 관련 자원을 유기적인 관계를 구축함으로써 보건의료, 돌봄·요양, 주거, 복지 등 다양하고 복합적인 노인의 욕구에 효과적으로 대응할 수 있는 전략이다. 가정방문급여기관은 네트워크를 통해 지역사회에서 요양서비스 제공기관으로서의 경쟁력을 높일 수 있고, 지역사회는 자원활용의 효율성을 높일 수 있다.

네트워크는 지역사회보장협의체에 민관의 참여를 제도화하였던 것이 원인이 되어 등장하였으며, 사례관리가 공공과 민간에서 실천의 한 방법으로 인식되면서 매우 중요한 사회복지 실천 기술로 인정받기에 이르렀다. 민간차원의 네트워크는 각종 협회, 협의회 형태로 존재하고 있으며, 법령에 의한 네트워크는 현재 지역사회보장협의체의 형태로 민관협력 네트워크로 존재하고 있다.

이러한 배경을 중심으로 살펴본다면 다음과 같다.

- 1) 사회복지에 있어서 지방분권의 강화이다. 지방자치제도의 도입에 따라 지방분권을 강조하여 사회복지도 중앙의 권한을 광역이나 자치단체로 이양하여 권한을 분산하였고, 관중심의 정책에서 민관 공동의 복지정책으로 이어졌으며, 자연스럽게 다양한 집단이나 개인들의 네트워크로 이어졌다.
- 2) 사회복지실천에서 통합적 접근의 필요성 강화이다. 지역사회 복지대상자들의 욕구가 폭발적으로 증가하고 욕구의 종류 또한 복잡하고 다양해지면서 기존의 정부 중심 혹은 관료 중심의 획일적 접근만으로는 대상자의 욕구를 충족할 수 없게 된 것이다. 따라서 서비스를 제공하는 주체들 간에 긴밀한 연계와 소통을 통하여 사례관리적 접근이 필요하게 된 것이다. 한명의 대상자를 놓고 다양한 서비스 제공 주체들이 논의하고 토론하면서 서비스의 질을 향상할 수 있었던 것이다.
- 3) 교통과 정보통신 기술의 발전이 네트워크를 촉진하는 촉매제가 되었다. 네트워크는 개인과 기관이 서로 의사소통하고 교류해야 한다. 우리나라는 세계에서 가장 빠른 인터넷 망이 구축되어 있으며, 언제 어디서나 빠른 속도로 문자나 메일이 가능하다. SNS상에서 다양한 커뮤니티를 구성하여 실시간 의견 교환이 가능하고 문자, 사진, 동영상 등을 언제 어디서나 자유롭게 공유할 수 있는 체계가 구축되어 있다.

나. 개념과 중요성

지역사회 내 조직과 조직, 조직과 개인, 개인과 개인들은 상호작용을 하면서 자신들의 목적달성을 수행을 해나간다. 가정방문급여기관이 사회의 네트워크를 구축한다는 것은 이러한 유기적인 관계를 보다 효과적으로 형성하는 작업이다.

자원연계를 위한 지역사회복지 네트워크는 조직과 개인의 자원과 욕구가 어디에 있으며 이들을 어떻게 상호작용하며 활용할 수 있는지를 파악하는 작업이다. 가정방문급여기관이 지역사회 네트워크를 구축하기 위해서는 사회의 모든 조직, 활동, 관계를 분석하여 이를 사회복지관의 목적과 사업수행에 활용하는 것을 의미한다.

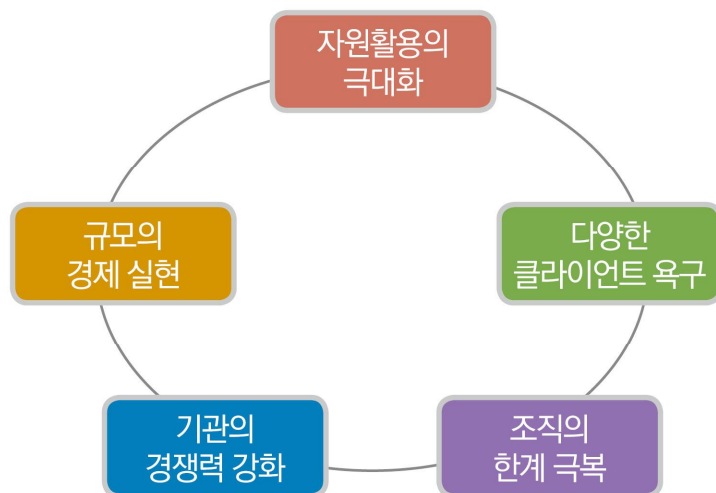
지역사회 네트워크는 일반적으로 의존적인 행위자들간에 다양한 물질적, 비물질적 자원이 연결된 상태와 이를 둘러싼 환경, 그리고 행위자들간의 관계가 지속적으로 유지되는 형태를 말한다(Trevillion, 1999). 또한, 네트워크는 서비스를 제공함에 있어 시너지 효과를 낼 수 있는 중요한 기술이다. 지역사회

회기관이 서비스를 제공하기 위해 관련 있는 조직들과 네트워크를 형성해 놓으면 정보교류, 물품 대여, 행정 서비스 등에 유익이 많다.

지역 내 사회복지자원은 지역적인 편차가 있다. 지역의 편차에 따라 자원이 많은 지역은 많은 기관을 네트워킹하여 활용하고 적은 지역은 적은 기관을 네트워킹 함으로써 기관이 개별적으로 존재했을 때 보다 더 많은 효과성과 효율성을 가져 올 수 있다. 가정방문급여기관이 지역사회에 많은 사람, 다양한 조직과 기관들이 협력하여 서비스를 제공할 때 서비스를 이용하는 노인과 지역주민에게 보다 좋은 서비스를 제공할 수 있다. 네트워크가 중요한 이유를 다음과 같은 이유에서 찾아 볼 수 있을 것이다.

- 1) 지역자원 활용의 극대화이다. 가정방문급여기관들이 개별적으로 서비스를 제공할 수 있지만 지역사회에 있는 기관들과 협력한다면 그 지역의 자원을 보다 더 효율적으로 활용할 수 있다. 관공서 뿐만 아니라 교육 기관, 종교 기관들과 함께 서비스를 개발한다면 지역 사회의 자원 활용이라는 측면에서 긍정적이다.
- 2) 복잡하고 다양한 서비스 이용 노인의 욕구를 해결할 수 있다. 도움이 필요한 노인의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있도록 지역자원을 개발하고 이용하는 것이 필요할 것이다.
- 3) 작은 조직의 한계를 극복할 수 있다. 가정방문급여기관은 인력이나 규모면에서 편차가 심하다. 작은 기관들은 지역사회자원 네트워크를 통해 지역사회 내 자원봉사자나 관련 조직의 도움을 받아 서비스를 제공한다면 매우 유용할 것이다.
- 4) 기관의 경쟁력을 강화할 수 있다. 기관이 외부와 네트워킹 하지 않고 고립되어 있으면 외부의 정보에 둔감해 진다. 새로운 정책, 새로운 제도, 새로운 정보에 어두우면 새로운 서비스를 개발할 수도 없고 변화하는 환경에 적응할 수 없어서 도태될 수 있다. 네트워킹은 가정방문급여기관의 경쟁력을 위해서도 필요하다.
- 5) 규모의 경제를 실현할 수 있다. 지역기관이 공동으로 지역사회복지교육 등을 수행한다면 비용을 절감하면서 진행할 수 있다. 한 기관이 어떤 행사를 한다면 준비과정부터 비용까지 매우 부담이 될 수 있지만 네트워크를 통하여 수행한다면 부담이 줄어들고 비용도 줄어 들 것이다.

●● 그림 6-1 네트워크가 중요한 이유



다. 네트워킹 과정

사회복지기관에서 네트워킹을 할 때는 일반적으로 다음의 과정을 겪는다. 물론 이것은 일반적인 과정이지 반드시 이러한 과정 혹은 단계를 거쳐야 한다는 것은 아니다. 일반적으로 네트워킹 준비, 구성, 실행, 관리 단계를 거치게 된다(김영종 외, 2008). 가정방문급여기관의 지역사회자원 네트워킹에서 다음과 같은 과정을 활용할 수 있을 것이다.

1) 네트워크 준비 단계

1단계 네트워크 적합성 검토하기

지역사회에서 네트워크를 하기 위해서는 네트워크의 적합성 여부를 검토하는 것부터 시작해야 한다. 적합성은 네트워킹의 대상이 우리 기관과 맞는지, 네트워킹 방법이 적절한지를 검토하는 것이다. 이것은 실천가 수준에서 검토하는 수준이라고 할 수 있다.

먼저 대상자와 네트워크 대상으로 맞는지를 검토해야 한다. 기관이 주로 서비스를 제공하는 대상자의 욕구에 맞는 서비스를 제공함에 있어 함께 협력이 가능해야 한다. 또한 기관과 네트워킹을 하여 협력사업을 한다 했을 때 시간, 인력, 자원, 정보 등을 공유하거나 협력할 수 있는 준비가 되어있는지 확인해야 한다. 아무리 좋은 자원이라 하더라도 협력할 준비가 되어 있지 않고 네트워크에 소극적이라면 오히려 소진의 원인이 되기도 한다. 그리고 네트워킹 방법이 적절한지를 살펴야 한다. 네트워킹 방법은 사례회의, 기관방문, 자원공유 등 다양한 방식으로 이루어질 수 있다. 사례회의나 기관방문에 소극적이거나 거부감이 있다면 네트워크 대상으로 적절하지 않다. 반드시 네트워킹으로 대상자를 보호해야 하는지 아니면 네트워크 없이 단일 기관의 서비스로 가능한지를 고려해야 한다. 클라이언트의 욕구와 상관없이 네트워크만 동원한다고 양질의 서비스라고 할 수 없다.

2단계 네트워크 승인받기

네트워킹 승인받기는 기관에서 네트워킹 방법에 대한 승인 가능성을 진단해야 하는 과업과 자신의 기관에 대한 과업 환경을 체크해야 함을 의미한다. 먼저 기관안에서 네트워킹 방법 사용 가능성에 대한 승인은 이 업무를 담당하는 실천가가 조직의 상급자로부터 승인을 받는 것을 의미한다. 이것은 네트워크가 복지기관에서 정당성을 얻는 과정이기도 하다.

그리고 과업 환경을 체크한다는 것은 기관에 영향을 미치는 사회, 문화, 경제적 환경의 조건을 점검해 봐야 한다는 의미이다. 즉, 기관이 가지고 있는 개인, 집단, 자원들이 기관의 미션을 달성하는데 충분해야 하고 타 기관과 네트워킹을 하면서 교환할 수 있는 자원이 충분해야 함을 의미한다. 네트워킹 준비 단계에서 실천가는 세 가지 역할을 하게 된다. 즉 아웃리치, 기획자, 조정자의 역할이다. 실천가는 네트워킹이 가능한 개인이나 기관 자원을 찾아서 협력의 틀을 맺을 수 있어야 한다. 또한 실천가는 과업, 기술들을 기획하고 검토하는 과정에서 기획자의 역할을 하게 되고, 조직 내에서 승인 받으며, 다른 인력들과 시간을 조정하는 등 역할을 하기 때문에 조정가의 역할을 한다고 할 수 있다.

2) 네트워킹 구성 단계

3단계 네트워킹 찾기

네트워킹 찾기 단계에서는 네트워킹 영역 구성을 위해 관련 네트워킹을 찾아야 한다. 이때 네트워킹 영역 구성에 대해 구체적인 내용에 기초해야 한다. 따라서 관련 네트워킹 찾기는 네트워킹 영역에 대한 구상과 함께 이루어져야 한다. 이때는 네트워킹 관련 목록표를 만들어 작성하면 편리하다. 네트워킹할 기관의 목록을 만들어 놓고 그 기관의 인원, 주요 활동, 거리, 협력 가능 사업 등을 조사하여 네트워킹이 가능한지를 살펴보는 것이다.

● 표 6-6 네트워킹 찾기(예시)

기관명	주 소	인 원	주요 활동	거 리	협력 가능 사업	비 고

이렇게 네트워킹 할 기관을 찾았다면 그 기관이 네트워킹의 가능성이 있는지를 검토해야 한다. 위 표의 비교란에 기관별로 기관의 입장에서 이 기관과 왜 필요한지, 어떤 측면에서 특히 네트워킹이 필요한지를 적어 놓는다면 이후 과정에서 참고할 수 있을 것이다.

4단계 네트워킹 접촉하기

기관입장에서 네트워킹을 하고자 하는 기관이 정해지면 관계 맺기, 신뢰형성하기, 상호 호환성 활용 및 형성하기, 계약하기 등이다.

관계 맺기는 앞에서 작성한 리스트에 기초해서 네트워킹을 찾아 나서는 것이다. 관계 맺기를 위해서는 대상이 되는 기관을 방문하여 네트워킹의 목적에 부합하는지 설명도 하고 어떤 이익을 서로 주고 받을 수 있는지 설명과 논의를 하면서 참여를 권하는 것이다. 신뢰를 형성하기는 네트워킹을 성공하기 위해서 매우 중요한 과업이다. 신뢰 형성의 중요한 덕목은 약속을 잘 지키는 것이며 상대를 존중하는 태도이다. 상호 호혜성 활용 및 형성하기는 신뢰형성하기 못지않게 중요한 과업이다. 상호 호혜적이라는 것은 내가 먼저 양보하고 상대방에게 섬김의 자세를 가졌을 때 가능하다. 또한 상대의 인격이나 상대 기관의 미션과 사업을 존중할 때 가능해 진다. 예를 들어 종교가 다른 기관이 상대방의 종교를 존중하고 배려하면 네트워킹을 할 때도 무리가 없다. 그 다음이 계약하기이다. 네트워킹을 제안한 기관과 참여하고자하는 기관 간 간단한 계약을 하는 것이다. 계약하기는 네트워킹에서 수행해야 할 내용에 대해서 합의하는 과정이다.

네트워킹 구성 단계에서 실천가는 정보수집가, 의사소통가, 분석가의 역할을 하게 된다. 네트워킹이 필요한지, 네트워킹하고자 하는 기관에 대한 수많은 정보를 수집해야 한다. 정보를 수집하였다

면 이 정보를 바탕으로 네트워크에 참여할 대상자들과 만나 의논하면서 의사소통해야한다. 이때는 설명하고, 듣고, 설득하는 등의 다양한 방식으로 의사소통해야한다.

3) 네트워크 실행 단계

5단계 네트워크 영역 구축하기

이 단계에서는 네트워크 영역을 정하고, 참여자들간 관계 유형에 대한 합의를 도출하는 것이다. 네트워크 영역을 정하는 것은 문제나 욕구, 대상 집단, 실천 기술, 네트워크 설정 지역, 자원 출처에 대하여 참여자들간 논의하고 합의하는 것이다. 그리고 나서 네트워크에 참여하는 사람들 간 참여 유형을 합의해야 한다.

참여 유형은 대개 협력 유형, 조정 유형, 합작 유형이 있다. 협력 유형은 서로 독자적으로 분리된 조직이 독립적인 프로그램을 기획하고 실행하고자 할 때 형성할 수 있는 방식이다. 이 관계 유형에서는 참여 조직의 독자성을 인정하는 것을 기본으로 한다. 조정 유형은 분리된 조직이 불필요한 중복을 피하고 조직 간 갈등과 낭비를 피하고자 하는 방식을 취하는 형태이다. 이러한 유형은 서비스의 중복을 피하고 전문성의 결합을 통해서 서비스 전달체계의 경제적 효율성을 제고하는 데 목적이 있다. 따라서 정기적인 만남을 통해서 가능하다. 합작 유형은 분리된 각 참여 조직이 단일한 프로그램이나 서비스에 참여하여 동일한 목적을 가지고 연계하되, 자신의 정체성을 유지하면서 자원을 공유하는 형태이다. 이 유형은 각 조직은 자원을 최대한 만들어 서비스의 통합을 꾀한다.

6단계 네트워크 실행하기

네트워크를 구축했다면 이제는 네트워크가 실제로 작동하게 해야 한다. 이 때 과업은 네트워크의 교환의 대칭성 만들기, 기관 성원 지위 결정하기이다.

네트워크 안에 있는 각 기관들은 자원 교환에서 얻는 것과 잃는 것이 발생하게 되는데, 이 것이 균등하게 이루어지지는 않는다. 그래서 네트워킹 과정에서 잃는 것과 얻는 것에 대한 개입이 필요하다. 네트워크 참여 기관에게 자원이나 기회가 공평하게 이루어지면 대칭적이라 하고 그렇지 못한 경우를 비대칭적이라 한다. 네트워크를 이루면서 대칭적이어야 한다. 두 번째 과업이 기관 성원의 지위 결정하기인데 이는 누구를 네트워크에 참여시킬 것인가의 문제이다. 각 기관에서 어떤 지위의 사람을 네트워크에 참여시킬지 결정해야 한다. 실무자가 참여하는 네트워크와 기관의 관리자가 참여하는 네트워크는 성격이나 업무의 내용이 다를 수 밖에 없다. 세 번째 과업은 권위의 위치를 확인하는 것이다. 권위의 위치가 내부에 있는가 아니면 외부에 있는가 하는 것이다. 네트워크 참여 기관들이 운영비를 자발적으로 수렴하여 운영한다면 네트워킹은 스스로 권위를 갖는 내적 권위를 갖게 된다. 그러나 만약 공동 모금회와 같이 외부의 자원으로 네트워킹이 유지된다면 지원하는 단체의 요구를 들어야 하기 때문에 외적 권위를 갖게 된다.

네트워크 실행 단계에서 실천가는 네트워크 영역을 구축하고 실행해야 하기 때문에 조정가 실천가, 협상가의 역할을 하게 된다.

4) 네트워크 관리 단계

7단계 네트워크 갈등 관리하기

네트워크 갈등은 대부분 네트워크 의존성에서 비롯한다. 의존성이 있다는 것은 어떤 한 기관의 영향력이 상대적으로 크다는 것을 의미한다. 어떤 기관이 자원이나 정보를 많이 가지고 있을 때 영향력을 많이 행사하게 되고, 다른 기관은 그 기관에 의존하게 된다. 이것은 지배와 의존이라는 관

계로 변질될 수 있다. 네트워크는 기본적으로 대등한 위치에서 협력해야 한다. 그래서 어느 한 집단이 지배하지 못하도록 균등하게 나갈 수 있는 방법을 찾아야 한다. 네트워크에 참여하는 기관들이 갈등을 최소화 하는 방법은 기회를 서로 균등하게 하도록 하는 것이다. 회의 장소도 순번제로 돌아가면서 하고, 대표도 돌아가면서 맡기도 하는 등 가급적 기회가 고루 주어지도록 하여 어느 한 기관이 독점하는 일이 발생하지 않도록 해야 한다.

8단계 네트워크 유지하기

네트워크를 구축하였다면 목적을 이루어나가도록 잘 유지하는 것이 중요하다. 네트워크가 유지되는 가장 중요한 원칙은 신뢰이다. 상호 신뢰하지 못하면 네트워크는 얼마 가지 못해 무너지게 되어 있다. 신뢰의 기초는 네트워크 참여 기관들이 동등해야 하며, 얻는 것이 가능하면 비슷해야 한다. 어느 한 기관이 더 많은 이득을 취하고 다른 기관은 손해만 본다면 신뢰 관계는 무너지고 네트워크 또한 지속할 수 없다.

네트워킹 관리 단계에서 실천가는 갈등 중재자역할을 하게 된다. 각 기관이 가지는 역할에 대해 중재하면서 발생할 수 있는 갈등을 중재하여야한다. 또한 각 참여 기관들을 참여시키고 네트워킹을 유지하려는 연결자의 역할을 요구하게 된다. 그러기 위해서는 의사소통 기술이 필요하게 된다.

5 지역사회자원의 관리

가정방문급여기관이 서비스 이용노인 등 지역주민이 가지고 있는 다양한 욕구에 능동적으로 대응하기 위해서 지역사회가 보유하고 있는 여러 가지 유형의 민간 자원을 적극 개발하고 체계적으로 관리해야 한다. 기관의 지역사회자원관리의 주요 내용은 다음과 같다.

● 표 6-7 지역사회자원관리 주요내용

- 지역사회 공식·비공식 자원 현황 총괄 관리
- 자원조사 및 자원개발을 통해 통합사례관리의 원활한 지원
- 지속적 자원현황 업데이트로 지역 내 주민 및 관련기관 정보 공유
- 나눔 문화 활성화 등 지역사회 자원 개발 기획·실천

지역사회 자원관리는 전담 직원 운영을 통해 관내 자원에 포함된 기관별로 적절한 역할분담을 수행할 수 있어야 한다. 지역사회 내 주요기관의 역할은 다음과 같다.

● 표 6-8 지역사회 내 주요기관 역할

- 지역 종합사회(노인/장애인)복지관: 지역 내 자원 현황 관리 및 정보 제공, 자원개발 기획 실천, 자원관련 워크숍, 교육 등 연계·협력
- 지역사회보장협의체: 자원정보 공유, 필요 자원개발·발굴 등 협의·실천
- 자원봉사센터: 봉사인력관리, 인적자원 제공 등
- 읍면동: 희망복지지원단 등과 협력하여 읍·면 단위의 자원 관리·발굴 적극 수행

다음과 같이 지역사회자원의 지속적인 발굴과 관리도 필요하다.

● 표 6-9 지역사회자원 발굴 및 관리방법

- 자원발굴조사: 연 1~2회 정기조사, 필요시 수시 조사
- 시스템을 통한 자원 등록·관리: 공공 및 민간 복지자원통합DB 구축, 신규 서비스 자원 등록, 중복자원 및 서비스 수정 및 삭제 등(행복e음 시스템 자료정비)
- 자원점검: 통합사례관리 대상자에게 제공되고 있는 서비스의 모니터링, 자원 내용의 적절성, 질적 수준, 제공방법, 민·관 협력 정도, 누락 및 중복여부 등 자체 평가 시행

효율적인 지역사회자원의 관리방법으로는 ‘지역사회복지 자원 지도’ 활용이 있다. 각 지자체에서 지역사회 내 연계가능한 자원들을 지도화하여 배포하거나 서울시의 경우 ‘공유복지플랫폼’ 등을 운영하고 있으며, 기관에서 자체파악한 자원들을 지도화하여 관리할 시 편리하게 관리 및 공유가 가능하다.

활용방법으로는 수기관리, MS오피스, 구글 지도 등 다양한 Tool의 활용이 가능하다.

참고문헌

- 국가통계포털(www.kosis.kr). 장래인구추계
- 국민건강보험공단(2017). 장기요양 재가급여제공매뉴얼.
- 국민건강보험공단(2019). 2020 한국형 케어매니지먼트 인력양성 교육교재.
- 국민건강보험공단(2019). 방문요양기관 사회복지사 전문화교육 교재.
- 국민건강보험공단(2019). 장기요양 시설급여제공매뉴얼.
- 국민건강보험공단(2020). 장기요양 재가급여제공매뉴얼.
- 김영중·홍현미라·이현주·이혜원·이민영·진재문(2008). 사회복지 네트워크의 이해와 적용, 학지사.
- 문가비(2021). 노인 언어 및 의사소통 중재 가이드라인 제언: 요양시설 이용자 가족 대상 설문을 중심으로, 대구대학교. 석사학위.
- 보건복지부(2017). 사례관리 서식 표준. 민-관 정보공유시스템 구축 사업.
- 보건복지부, 보건사회연구원(2017), 전국노인실태조사.
- 보건복지부, 중앙치매센터(www.nid.or.kr), 치매 현황.
- 사회복지교육연구센터(2019). 지역사회복지론, 나눔의 집.
- 서동민(2018), 노인장기요양보험 욕구조사의 이해. 국민건강보험공단.
- 서동민(2019). 장기요양기관의 사례관리 개념과 절차. 노인요양시설 중간관리자 역량강화과정. 한국보건복지인력개발원.
- 손명자, 배정규(1994). 정신장애인을 위한 좋은 대인관계, 새미래연구소.
- 시라사와 마사카즈 지음, 임효연 옮김(2011). 케어매니저 양성 텍스트북. 노인연구정보센터
- 오정수·류진석(2018). 지역사회복지론, 학지사
- 유애정 외(2018). 장기요양보험 이용지원체계 운영 활성화를 위한 발전과제. 건강보험정책연구원
- 임정기(2015). 복지관점에서의 삶터 요양(Aging in place). 한국장기요양학회 춘계학술대회 '삶터에 서의 요양 caring in place' 발표자료집.
- 중앙치매센터. (www.nid.or.kr/info/new_guide_list2.aspx)
- 한국사례관리학회(2012). 사례관리론. 학지사.
- 한은정·이정면·조정완·김도훈(2012). 장기요양서비스 이용지원체계 개선방안, 국민건강보험공단.
- Binstock, RH, "The financing and organization of long-term care", Public and Private Responsibilities in Long Term Care: Finding the Balance, edited by Walker, Leslie C., Bradley, Elizabeth H., and Wetle, T., The Johns Hopkins University Press, 1998.
- Birkenmaier J, Berg-Weger M & Dewees M The Practice of Generalist Social Work. 2nd ed., Routledge, New York, (2011).
- Corcoran J., Building Strengths and Skills: A Collaborative Approach to Working with Clients. Oxford University Press, Boston, (2005).
- Coulton CJ., Approaches to quality assurance programs, skills for effective human services management. R.C. Edwards, J.A. Yank(Eds). Washington DC:NASW press, 1991; 251-266
- Davey, J., Virginia, J., Ganesh, N. & Mathew, A. Accommodation Options for Older People in Aotearoa/New Zealand, Wellington, New Zealand: NZ Institute for Research on Ageing, 2004.
- Donabedian A., Criteria norms and standards of quality. American Journal of Public

- Health 1981; 71(4); 405-412.
- Doty, P., Liu, K., Weiner, J., Special report: An overview of long term care, Health Care Financing Review, 6(3), 1985.
 - Evashwick, CJ., The Continuum of Long Term Care: An Integrated Systems Approach, Delmar Publishers, 1996.
 - Harris, D. K., Dictionary of Gerontology, New York, NY: Greenwood Press, 1988.
 - Hepworth DH, Rooney RH, Rooney GD, Strom-Gottfried K & Larsen J: Direct Social Work Practice: Theory and Skills. 7th ed. , Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2006.
 - Kane, RA, Kane, RL, and Ladd, RC, The Heart of Long Term Care, Oxford University Press, 1998.
 - Miley KK, O'Melia M & Dubois B: Generalist Social Work Practice: An Empowering Approach. 6th ed., Allyn & Bacon, Boston, 2011.
 - Moxely, D. P. Practice of Case Management. Sage Focus Editions. 1989.
 - OECD, Caring for Frail Elderly: Policies in Evolution, Paris, 1996.
 - Pratt, JR, Long Term Care: Managing across the Continuum, An Aspen Publication, 1999.
 - Rothman. A model of: Toward empirically based practice. Social Work, 36(6). Silver Spring, MD. NASW. 1992.
 - Rapp CA & Goscha RJ: The Strengths Model: Case Management with People with Psychiatric Disabilities. 2nd ed., Oxford University Press, New York, 2006.
 - Sheafor BW & Horejsi CR: Techniques & Guide lines for Social Work Practice. 9th ed., Pearson Education, Inc., Boston, 2011.
 - Timberlake EM, Zajicek- Farber ML & Sabatton CA: Generalist Social Work Practice: A Strengths-Based Problem- Solving Approach. 5th ed., Pearson Education, Inc., Boston, 2008.
 - Wiles, J., Leibing, A., Guberman, N., Reeve, J. & Ruth, A. The Meaning of Aging in Place to Older People. The Gerontologist, Vol. 52, No. 3, 2011, 357-366.
 - Yves Gineste, Rosette Marescotti, 本田美和子, ユマニチュード入門, 医学書院, 2014.
 - Zeithaml, Valerie A. and Mary Jo Bitner, Services Marketing, Mc-Graw-Hill International, 1996.

집필 및 자문

권금주 교수	서울사이버대학교
권자영 교수	세명대학교
서동민 교수	백석대학교
이서영 교수	서울사이버대학교
이용재 교수	호서대학교
임은실 교수	대구보건대학교

발행일	2021년 11월
발행인	김용익
발행처	국민건강보험공단(요양기획실 영양교육부)
주소	강원도 원주시 건강로 32(반곡동) 24층 요양기획실 영양교육부